

Buku Ajar

DETEKSI DINI RISIKO TINGGI MATERNAL – NEONATAL DI PELAYANAN PRIMER

Iin Setiawati • Lilis Suryani • Elsarika Damanik • Niluh Nita Silfia
Nur Afifah Harahap • Sahnawi Marsaoly

Editor: Prof. Dr. Runjati, Bdn., M.Mid.



BUKU AJAR

DETEKSI DINI RISIKO TINGGI MATERNAL- NEONATAL DI PELAYANAN PRIMER

Penulis:

Iin Setiawati, S.Keb., Bd., M.Kes.

Bdn. Lilis Suryani, SST., M.Keb.

Elsarika Damanik, SST., M.Kes., Ph.D.

Niluh Nita Silfia, SST., M.Keb.

Bdn. Nur Afifah Harahap, S.Tr.Keb., M.Keb.

Sahnawi Marsaoly, S.Kep., M.Kes.

Editor:

Prof. Dr. Runjati, Bdn., M.Mid.



Buku Ajar Deteksi Dini Risiko Tinggi Maternal-Neonatal di Pelayanan Primer

Penulis:

Iin Setiawati, S.Keb., Bd., M.Kes.
Bdn. Lilis Suryani, SST., M.Keb.
Elsarika Damanik, SST., M.Kes., Ph.D.
Niluh Nita Silfia, SST., M.Keb.
Bdn. Nur Afifah Harahap, S.Tr.Keb., M.Keb.
Sahnawi Marsaoly, S.Kep., M.Kes.

Editor:

Prof. Dr. Runjati, Bdn., M.Mid.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7756-58-9

Cetakan Pertama: Juli, 2026

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Ajar *Deteksi Dini Risiko Tinggi Maternal–Neonatal di Pelayanan Primer* ini dapat disusun sebagai salah satu referensi pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan, dosen, serta tenaga kesehatan di pelayanan primer. Buku ini disusun untuk mendukung pencapaian kompetensi bidan dalam melakukan deteksi dini terhadap kondisi risiko tinggi maternal dan neonatal melalui pendekatan yang sistematis, berbasis bukti, dan sesuai dengan standar pelayanan kebidanan. Materi yang disajikan menekankan pentingnya kemampuan bidan dalam mengenali faktor risiko, melakukan pengkajian komprehensif, mengambil keputusan klinis secara tepat, serta melaksanakan kolaborasi dan rujukan yang efektif guna meningkatkan keselamatan ibu dan bayi.

Pembahasan dalam buku ini diawali dengan konsep dasar risiko tinggi maternal–neonatal, peran dan kewenangan bidan di pelayanan primer, serta alur kolaborasi dalam sistem rujukan. Selanjutnya, buku menguraikan teknik pengkajian terpadu ibu dan bayi melalui anamnesis terfokus, pemeriksaan fisik, dan validasi data sebagai dasar penetapan masalah dan prioritas asuhan. Materi berikutnya membahas skrining risiko kehamilan, penentuan skor risiko, penyusunan rencana asuhan, deteksi dini tanda bahaya kehamilan, gangguan hipertensi dalam kehamilan, serta deteksi dini infeksi pada kehamilan yang meliputi IMS, ISK, TORCH, dan infeksi lainnya beserta upaya pencegahan penularan. Seluruh materi disusun secara bertahap agar mudah dipahami dan diterapkan dalam praktik pelayanan kebidanan.

Sebagai buku ajar berbasis kompetensi, setiap bab dilengkapi dengan aktivitas pembelajaran *Knows How* dan *Shows How*, contoh kasus, DOPS, portofolio, rubrik penilaian, rangkuman materi, serta tabel *red flags* dan eskalasi untuk memperkuat kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan klinis. Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan pada edisi berikutnya. Besar harapan penulis agar buku ini dapat menjadi sumber belajar yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi bidan dalam mendeteksi risiko tinggi maternal–neonatal secara dini, memberikan asuhan yang tepat, serta mendukung upaya penurunan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi melalui pelayanan primer yang berkualitas.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 KONSEP DASAR RISIKO TINGGI MATERNAL-NEONATAL DAN PERAN BIDAN DI PELAYANAN PRIMER.....	1
A. Definisi, Klasifikasi, Determinan, dan Dampak Risiko Tinggi Maternal Neonatal pada luaran.....	3
B. Peran, Kewenangan, Alur Kolaborasi, dan Batas Rujukan Bidan di Pelayanan Primer.....	8
C. Aktivitas 1 — Knows How	16
D. Aktivitas 2 – Shows How.....	16
E. Rubrik Penilaian	23
F. Portofolio	29
G. Rangkuman Materi	35
H. Tabel Red Flags & Eskalasi.....	36
I. Daftar Pustaka	38
BAB 2 PENGKAJIAN TERPADU IBU DAN BAYI: ANAMNESIS TERFOKUS, PEMERIKSAAN FISIK DAN VALIDASI DATA.....	41
A. Mengumpulkan data anamnesis terfokus ibu dan bayi (janin/BBL sesuai konteks) dengan komunikasi terapeutik.	43
B. Melakukan Pemeriksaan Fisik Dan Memvalidasi Data Untuk Menetapkan Masalah Serta Prioritas Asuhan	48
C. Aktivitas 1 — Knows How	54
D. Rubrik Penilaian dan Kelulusan.....	59
E. Portofolio	61
F. Tabel Red Flags & Eskalasi.....	67
G. Rangkuman Materi	70
H. Daftar Pustaka	71
BAB 3 SKRINING RISIKO KEHAMILAN: FAKTOR RISIKO, SKOR RISIKO, DAN PENENTUAN RENCANA ASUHAN	73
A. Pengertian Skrining Resiko Kehamilan.....	74
B. Faktor Resiko Kehamilan	74
C. Alat yang digunakan untuk penentuan Skor Resiko kehamilan	77

D. Skor Resiko Kehamilan	78
E. Penentuan Rencana Asuhan	79
F. Aktivitas 1 — Knows How	80
G. Aktivitas 2 — Shows How	81
H. Rubrik Penilaian Dan Kelulusan	84
I. DOPS (Does).....	88
J. Portofolio	88
K. Rangkuman Materi	88
L. Daftar Pustaka	90

BAB 4 DETEKSI DINI TANDA BAHAYA KEHAMILAN: PERDARAHAN, NYERI HEBAT, DEMAM, DAN GERAK JANIN BERKURANG 93

A. Konsep Dasar Tentang Tanda Bahaya Kehamilan.....	94
B. Tanda Bahaya Kehamilan	96
C. Aktivitas 1 — Knows How	147
D. Rubrik Penilaian dan Kelulusan	153
E. Portofolio	160
F. Tabel Red Flags & Eskalasi.....	164
G. Rangkuman Materi	166
H. Daftar Pustaka	167

BAB 5 DETEKSI DINI GANGGUAN HIPERTENSI KEHAMILAN: PREEKLAMPSIA, EKLAMPSIA, DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI..... 169

A. Definisi Hipertensi dalam Kehamilan	174
B. Etiologi	174
C. Faktor Risiko Gangguan Hipertensi dalam Kehamilan	175
D. Patofisiologi Gangguan Hipertensi Kehamilan	176
E. Klasifikasi dan Definisi Penegakan Diagnosis Gangguan Hipertensi Pada Kehamilan	178
F. Tanda Dan Gejala Dini Gangguan Hipertensi Dalam Kehamilan (Red Flags).....	180
G. Skrining Dan Deteksi Dini Secara Tepat.....	181
H. Komplikasi.....	182
I. Penatalaksanaan.....	182
J. Asuhan Kebidanan.....	191
K. Rujukan	196
L. Edukasi Kepada Ibu Hamil Dan Keluarga	196
M. Dokumentasi.....	198

N. Aktivitas 1 — Knows How	201
O. Rubrik Penilaian dan Kelulusan	206
P. Tabel Red Flags & Eskalasi.....	220
Q. Rangkuman Materi	222
R. Daftar Pustaka	223
 BAB 6 DETEKSI DINI INFEKSI PADA KEHAMILAN: IMS, ISK, TORCH/INFEKSI LAIN DAN PENCEGAHAN PENULARAN.....	227
A. Pengertian Deteksi Dini Infeksi Pada Kehamilan	229
B. Tujuan Deteksi Dini Infeksi Pada Kehamilan	229
C. Pelaksanaan Deteksi Dini Infeksi	229
D. Penyakit-penyakit Infeksi yang biasa terjadi pada wanita hamil	230
E. Intervensi, Implementasi dan evaluasi Rencana Asuhan	233
F. Edukasi pada Ibu dan keluarga mengenai kondisi ibu hamil	234
G. Aktivitas 1. Contoh kasus	235
H. Rubrik Penilaian Dan Kelulusan	243
I. Rangkuman Materi	253
J. Daftar Pustaka	259
 PROFIL PENULIS	261

BAB 1

KONSEP DASAR RISIKO TINGGI MATERNAL-NEONATAL DAN PERAN BIDAN DI PELAYANAN PRIMER

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL 1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan aspek legal dalam pelayanan maternal-neonatal	CPMK-1; CPMK-6; CPMK-7
CPL 2	Menerapkan komunikasi terapeutik dan kolaborasi dengan ibu, keluarga, dan tim kesehatan.	CPMK-2; CPMK-6; CPMK-7
CPL 3	Menerapkan keselamatan pasien, PPI, dan K3 dalam pelayanan maternal-neonatal di layanan primer.	CPMK-2; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL 4	Menggunakan clinical reasoning untuk pengkajian, skrining, dan deteksi dini risiko maternal-neonatal.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5
CPL 5	Melaksanakan keterampilan klinis dasar untuk tindakan awal, stabilisasi, dan rujukan sesuai kewenangan dan SOP.	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL 6	Menerapkan EBP dasar, edukasi kesehatan, dokumentasi, serta perbaikan mutu program pelayanan maternal-neonatal.	CPMK-3; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK 1	Menganalisis konsep risiko tinggi maternal-neonatal, determinan, serta implikasi etika-legal untuk peran bidan di pelayanan primer.
CPMK 2	Melaksanakan pengkajian terpadu ibu dan bayi (anamnesis terfokus, pemeriksaan fisik, validasi data) secara sistematis dan aman.

CPMK 3	Menerapkan skrining risiko maternal–neonatal (faktor risiko, skor/algoritme) untuk menetapkan rencana asuhan dan tindak lanjut berbasis bukti.
CPMK 4	Menilai dan mendeteksi dini tanda bahaya maternal sepanjang kehamilan–intrapartum–postpartum serta menentukan tindakan awal sesuai kewenangan dan kebutuhan rujukan.
CPMK 5	Menilai dan mendeteksi dini risiko bayi baru lahir/neonatus serta merencanakan intervensi awal dan pemantauan.
CPMK 6	Melaksanakan stabilisasi awal dan proses rujukan maternal–neonatal (indikasi, persiapan, komunikasi rujukan, transport aman) sesuai standar pelayanan primer.
CPMK 7	Mengimplementasikan komunikasi–edukasi keluarga, dokumentasi–pelaporan, dan audit mutu untuk pencegahan serta pengendalian risiko maternal–neonatal.

A. Definisi, Klasifikasi, Determinan, dan Dampak Risiko Tinggi Maternal Neonatal pada luaran.

Kehamilan dan kelahiran merupakan perjalanan penuh harapan bagi ibu dan keluarga. Kehamilan dan kelahiran yang normal menjadi tujuan utama, namun tidak jarang dihadapkan pada tantangan medis yang mengancam jiwa. Peran bidan di pelayanan primer menjadi sangat vital karena sebagai garda terdepan yang mampu membedakan antara proses normal dan kondisi yang membutuhkan penanganan segera. Keselamatan ibu dan bayi dimulai dari deteksi faktor resiko tinggi dari fasilitas pelayanan primer. Fokus utama deteksi dini faktor resiko tinggi adalah bagaimana melakukan skrining yang tepat, kapan melakukan stabilisasi, dan bagaimana menjalankan rujukan yang efektif.

Risiko tinggi maternal neonatal adalah suatu kondisi pada ibu dan bayi yang dapat menyebabkan gangguan Kesehatan atau kematian, baik sebelum, selama, maupun sesudah persalinan (KemenKes RI, 2024).

1. Kegawatdaruratan Maternal

Kegawatdaruratan maternal atau obstetric merupakan suatu kondisi dimana nyawa ibu terancam akibat komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Kegawatdaruratan maternal dapat mengancam nyawa ibu dan juga janin apabila tidak segera ditangani (Siantar et al., 2022)

Dalam *International Classification of Disease* (ICD 10) mengartikan kematian ibu adalah kematian seorang Perempuan yang terjadi saat hamil atau dalam 42 hari setelah akhir kehamilannya tanpa melihat usia dan letak kehamilannya tanpa melihat usia dan letak kehamilannya diakibatkan oleh sebab apapun yang terkait dengan atau diperburuk oleh kehamilannya atau penanganannya tetapi bukan dikarenakan oleh cedera kecelakaan atau insiden tertentu.

2. Kegawatdaruratan Neonatal

Kegawatdaruratan neonatal merupakan sebuah keadaan dimana bayi baru lahir dengan usia <28 hari mengalami sakit kritis dan memerlukan penanganan yang cepat dan tepat. Pengetahuan deteksi dini adalah pencegahan kondisi yang mengancam. Krisis neonatal membutuhkan penilaian dan perawatan yang tepat untuk bayi baru lahir yang kritis dan diperlukan deteksi dini guna melihat perubahan psikologi dan kondisi patologis yang mengancam jiwa jika dapat muncul setiap saat.

Kematian bayi adalah banyaknya atau jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup ada periode waktu yang sama atau kematian yang terjadi pada saat bayi lahir sampai satu hari sebelum hari ulang tahun pertama. Kematian bayi baru lahir satu hari sebelum hari ulang tahun pertama.

Kematian bayi menurut Prawirohardjo dibedakan menjadi beberapa kategori:

- a. Kematian janin (fetal death) ialah kematian hasil konsepsi sebelum dikeluarkan dengan sempurna oleh ibunya tanpa memandang tuanya kehamilan. Kematian dinilai dengan fakta bahwa sesudah dipisahkan dari biunyum janin tidak bernafas atau menunjukkan tanda – tanda kehidupan, seperti denyut jantung, atau pulsasi tali pusat atau kontraksi otot. Kematian janin dibagi menjadi 4 golongan, yaitu:
 - 1) Kategori I yaitu sebelum masa kehamilan mencapai 20 minggu penuh
 - 2) Kategori II yaitu kematian sesudah ibu hamil 20 hingga 28 minggu
 - 3) Kategori III yaitu kematian sesudah masa kehamilan lebih 28 minggu (late foetal death)
 - 4) Kategori IV yaitu kematian yang tidak dapat digolongkan pada ketiga golongan diatas
- b. Kelahiran mati (stillbirth) adalah kelahiran hasil konsepsi dalam keadaan mati yang telah mencapai umur kehamilan 28 minggu (atau berat badan lahir atau sama dengan 1000 gram)
- c. Kematian perinatal dini (early neonatal death) ialah kematian bayi dalam 7 hari pertama kehidupannya
- d. Kematian post-neonatal adalah kematian bayi antara usia 1 bulan hingga 12 bulan

Berdasarkan penyebabnya, kematian bayi dibedakan oleh faktor endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen (kematian neonatal) adalah kejadian kematian yang terjadi pada bulan pertama sejak bayi dilahirkan umumnya disebabkan oleh faktor yang dibawa sejak lahir, diwarisi oleh orang tua pada saat konsepsi atau didapat dari ibunya selama kehamilan. Kematian eksogen (kematian post-natal) adalah kematian bayi yang terjadi antara usia satu bulan atau sampai satu tahun disebabkan oleh faktor yang berkaitan dengan pengaruh lingkungan.

Menurut kemenkes penyebab tidak langsung kehamilan risiko tinggi adalah 4T antara lain:

- a. Terlalu Muda Hamil yaitu melahirkan dibawah usia 20 tahun dengan angka kejadian 5,2%. Berdasarkan hasil review yang telah dilakukan Setyawati, dkk.

2025. Kehamilan remaja dapat meningkatkan Risiko BBLR dan kelahiran premature. Hasil analisis menunjukkan proporsi BBL dan kelahiran premature pada ibu remaja berada pada rentang 9.5-26,6% dan 7.7%-23.64%. Nilai Odds Ratio (OR) kejadian BBLR dan kelahiran premature pada kehamilan remaja berkisar antara 1.15-2.8 dan 1.22-1.9.

- b. Terlalu Tua Hamil yaitu melahirkan diatas usia 35 tahun dengan angka kejadian 4,9%
- c. Terlalu Dekat jarak melahirkan antara kelahiran saat ini dengan sebelumnya dengan angka kejadian 6,1%
- d. Terlalu Banyak atau sering melahirkan dengan angka kejadian 10,3%
(Kartikasari, 2025)

Faktor risiko diatas berkembang seiring dengan kasus yang berlangsung sehingga menambah tinggi angka kejadian kegawatdaruratan maternal dan neonatal pada ibu dan bayi dengan penanganan yang tidak tepat yang di rangkum dalam 3T :

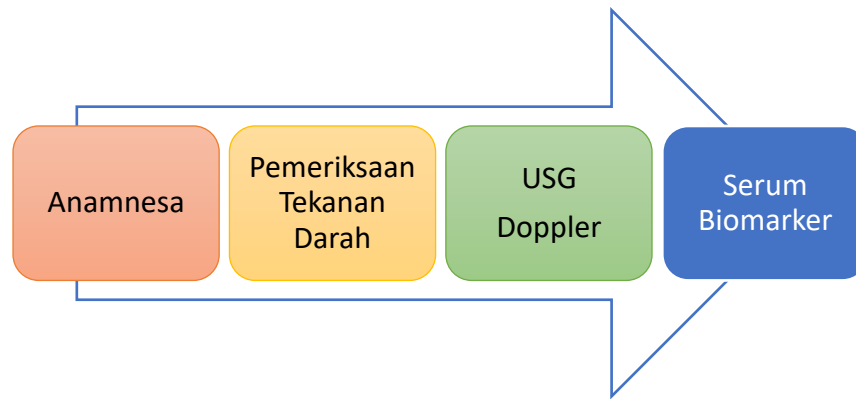
- a. Terlambat Mengambil Keputusan sehingga terlambat dalam mendapatkan penanganan
- b. Terlambat sampai kefasilis Kesehatan karena terkendala transportasi
- c. Terlambat mendapatkan penanganan karena keterbatasan sarana dan sumber daya manusia.

Kegawatdaruratan maternal memiliki cukup kompleks permasalahan mulai dari preeklamsi/eklamsi, perdarahan pada kehamilan dan persalinan, infeksi kasus obstetric. Kegawatdaruratan maternal terjadi setiap saat selama proses kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Dengan asuhan antenatal yang sesuai, mayoritas kasus dapat dideteksi secara dini dan minoritas kasus ditemukan secara tidak sengaja. Skrining bertujuan mengidentifikasi ibu hamil yang tampak sehat yang memiliki risiko signifikan menderita penyakit tertentu. Syarat suatu skrining adalah murah dan mudah dikerjakan.

- a. Deteksi Preeklamsia

Preeklamsi/eklamsi merupakan suatu penyulit yang timbul pada seorang Wanita hamil dan umumnya terjadi pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu dan ditandai dengan adanya hipertensi (140/90mmHg), proteinurine, edema diwajah dan tangan, sakit kepala hebat, gangguan penglihatan, pandangan kabur, nyeri perut bagian atas, mual dan muntah, penurunan jumlah urin.

Metode skrining dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti dibawah ini:



Gambar 1.1: Metode Skring Preeklamsia/eklamsia

b. Skrining perdarahan dalam kehamilan, persalinan, dan nifas

Perdarahan pada kehamilan lanjut dan menjelang persalinan pada umumnya disebabkan oleh kelainan implantasi plasenta baik plasenta letak rendah maupun plasenta previa, kelainan insersi tali pusat, atau pembuluh darah pada selaput amnion dan separasi plasenta persalinan umumnya disebabkan oleh gangguan kontraksi uterus, robekan dinding Rahim atau jalan lahir

c. Perdarahan pada kehamilan lanjut dan persalinan

Perdarahan pada kehamilan lanjut dan persalinan merupakan perdarahan dalam kehamilan yang terjadi setelah usia gestasi di atas 22 minggu. Masalah yang terjadi pada perdarahan kehamilan lanjut adalah morbiditas dan mortalitas ibu disebabkan oleh perdarahan pada kehamilan diatas 22 minggu hingga menjelang persalinan (sebelum bayi dilahirkan), perdarahan intrapartum dan prematuritas, morbiditas, dan mortalitas perinatal pada bayi yang akan dilahirkan.

d. Perdarahan pasca kehamilan

Pada pasca persalinan, sulit untuk menentukan terminology berdasarkan Batasan kala persalinan dan jumlah perdarahan yang melebihi 500 ml, pada kenyataannya, sangat sulit untuk membuat determinasi Batasan pascapersalinan dan akurasi jumlah murni yang terjadi. Berdasarkan temuan diatas maka Batasan operasional untuk periode pasca persalinan adalah periode waktu setelah bayi dilahirkan. Sedangkan Batasan jumlah perdarahan, hanya merupakan taksiran secara tidak langsung dimana disebutkan sebagai perdarahan abnormal yang menyebabkan perubahan

tanda vital (pasien mengeluh lebih, linglung, berkeringat dingin, menggigil, hyperpnea, sistolik <90 mmHg, Nadi >100x/menit, kadar Hb <8g%)

Peran bidan sebagai garda terdepan dalam pelayanan primer adalah dengan skrining dan deteksi dini. Di fasilitas pelayanan primer, focus utama adalah identifikasi cepat menggunakan alat bantu antara lain:

- a. Kartu Skor Poedji Rochjati (KSPR) yang ada dalam buku KIA, untuk mengelompokkan ibu hamil ke dalam kelompok resiko rendah (KRR), risiko tinggi (KRT), atau risiko sangat tinggi (RST).
- b. Buku KIA, sebagai pemantauan berkelanjutan oleh bidan dan keluarga
- c. Pemeriksaan fisik dan penunjang mulai dari pemeriksaan fisik utama sampai laboratorium penunjang utama dan tambahan sesuai hasil deteksi masing masing ibu hamil.

Deteksi dini kegawatdaruratan neonatal yang meliputi faktor – faktor yang menyebabkan kegawatdaruratan neonates, kondisi – kondisi yang menyebabkan kegawatdaruratan neonates, deteksi kegawatdaruratan bayi baru lahir, serta deteksi kegawatdaruratan bayi muda. Beberapa faktor penyebab kegawatdaruratan neonates yaitu: faktor kehamilan yaitu kehamilan kurang bulan, kehamilan dengan penyakit DM, kehamilan dengan gawat janin, kehamilan dengan penyakit kronis ibu, kehamilan dengan pertumbuhan janin terhambat dan infertilitas. Faktor Persalinan yaitu persalinan dengan infeksi intrapartum dan persalinan dengan oenggunaan obat sedative. Faktor bayi antara lain skor APGAR yang rendah, BBLR, bayi kurang bulan, berat lahir lebih dari 4000gr, cacat bawaan, frekuensi pernafasan 2x observasi lebih dari 60x/menit.

Faktor penyebab 4T dan 3T diatas merupakan awal dari terjadinya kegawatdaruratan maternal dan neonatal yang tentunya menjadi faktor risiko berbagai macam komplikasi selama masa kehamilan dan persalinan. Dampak risiko dari faktor faktor diatas antara lain adalah :

- a. Dampak Maternal: Pre Eklamsia, Eklamsia, Perdarahan hebat saat hamil dan post partum, Keguguran
- b. Dampak Neonatal: Perkembangan janin terhamat, Cacat lahir pada bayi, Janin IUFD, Lahir Prematur, Bayi Lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (Restuti, Windi, dkk. 2021)

B. Peran, Kewenangan, Alur Kolaborasi, dan Batas Rujukan Bidan di Pelayanan Primer.

Salah satu agenda utama Sustainable Development Goals (SDGs) adalah menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Keberhasilan SDGs ini tidak dapat dilepaskan dari peran penting pemerintah. Pemerintah memiliki wewenang dan pendanaan untuk melakukan berbagai inovasi, serta ujung tombak penyedia layanan public dan berbagai kebijakan serta program pemerintah. Hingga saat ini, AKI masih dikisaran angka 305 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2025. Dalam rangka menurunkan AKI dan AKB Upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan adalah dengan memastikan bahwa setiap ibu memiliki akses dalam memperoleh pelayanan Kesehatan yang berkualitas, yang meliputi pelayanan Kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan terlatih, perawatan masa nifas bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan apabila terdapat komplikasi, serta pelayanan KB. Adapun upaya Kesehatan ibu meliputi :

1. Pelayanan Kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan imunisasi tetanus bagi Wanita usia subur dan ibu hamil
3. Pemberian tablet tambah darah
4. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin
5. Pelayanan Kesehatan ibu nifas
6. Penyelenggaraan kelas ibu hamil
7. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
8. Pelayanan KB
9. Pemeriksaan HIV dan Hepatitis B

Bidan dalam tingkat pelayanan primer sesuai Undang Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan yang diperbaharui dengan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memiliki beberapa peran penting yaitu sebagai educator, provider, communicator, dan community leader. Dalam peran bidan memiliki tujuan utama menurunkan AKI dan AKB. Dalam risiko tinggi maternal neonatal peran bidan menjadi dasar deteksi dini, peran bidan antara lain :

1. Provider (Pemberi Asuhan) memberi asuhan kebidanan sesuai standar dan melakukan stabilisasi kondisi darurat sebelum rujukan
2. Educator (Pendidik) memberikan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) kepada ibu dan keluarga mengenai tanda bahaya kehamilan dan persalinan
3. Communicator membangun jejaring rujukan yang efektif dengan Rumah Sakit (PONEK) melalui sistem rujukan terintegrasi (SISRUTE)

4. Community Leader menggerakkan Masyarakat (P4K – Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) untuk mendukung pembiayaan, transportasi, dan donor darah bagi ibu berisiko.

Di Indonesia, bidan memiliki peran strategis dalam pelayanan primer. Peran bidan dijalankan dalam kerangka regulasi dan hukum yang ketat karena setiap tindakan medis memiliki potensi resiko hukum jika dilakukan diluar kewenangan atau tidak sesuai kompetensi. Seiring tingginya lulusan pendidikan sarjana dan profesi bidan, evaluasi kompetensi lulusan menjadi kebutuhan. Sejauh mana lulusan mampu mengimplementasikan kompetensi dan kewenangan yang diberikan oleh negara sesuai undang – undang.

Berdasarkan standar profesi, kewenangan bidan sesuai dengan undang undang dalam pelayanan primer adalah sebagai berikut :

1. Asuhan kebidanan ibu hamil mulai dari pemeriksaan kehamilan rutin, imunisasi tetanus toxoid, dan deteksi dini komplikasi
2. Asuhan persalinan normal masuk dalam persalinan normal dengan aman dan bersih
3. Asuhan nifas dan menyusui dari merawat ibu nifas normal dan memberikan konseling menyusui
4. Asuhan bayi baru lahir (BBL) yaitu perawatan tali pusat, pemberian suntikan vitamin K1, dan pemeriksaan ibu fisik dasar.
5. Keluarga berencanaan (KB) yaitu pelayanan kontrasepsi mulai suntik, pil, kondom, IUD/AKDR dan implant
6. Kesehatan reproduksi Perempuan dengan memberikan konseling dan edukasi Kesehatan reproduksi
7. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat yaitu melakukan kegiatan promotive dan preventif Kesehatan ibu dan anak di komunitas.

Sistem rujukan adalah jaringan pelayanan kesehatan, organisasi pelayanan kesehatan yang mengawasi pendelegasian tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara vertikal dan horizontal (permenkes RI, 2012). Menurut *World Health Organization* (WHO), system rujukan (referral system) adalah suatu proses dimana tenaga kesehatan dengan sumber daya terbatas untuk mengobati kondisi klinis (obat, peralatan, kemampuan) pada satu Tingkat system kesehatan mencari bantuan dari kesehatan yang lebih baik, fasilitas atau memiliki sumber daya tertentu pada Tingkat yang sama atau lebih tinggi, atau mengambil alih pengelolaan kasus pasien.

Alur kolaborasi dan batas rujukan bidan di pelayanan primer diatur untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi melalui penanganan yang tepat dan

berjenjang. Bidan berperan sebagai penyedia layanan primer, pendamping, dan educator yang berkolaborasi dengan tenaga medis lain saat kasus melampaui kewenangannya. Alur pelayanan rujukan kebidanan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis, terbagi menjadi dua yaitu :

1. Rujukan horizontal yaitu rujukan kasus antar fasilitas kesehatan setingkat (misal bidan mandiri ke klinik pratama) jika memerlukan pemeriksaan tertentu.
2. Rujukan vertikal yaitu rujukan fasilitas Kesehatan primer ke fasilitas Kesehatan sekunder/tersier seperti RSUD/ RS PONEK) untuk penanganan komplikasi.

Rujukan yang efektif membutuhkan komunikasi antar institusi, tujuannya adalah agar fasilitas yang direkomendasikan mengetahui kondisi pasien dan dapat mengatur perawatan yang diperlukan sebelum pasien datang.

Tujuan system rujukan meliputi :

1. Setiap pasien menerima perawatan dan dukungan dengan kualitas terbaik
2. Dapat memberikan layanan perawatan kesehatan yang unggul sehingga tujuan layanan dapat dipenuhi tanpa mengeluarkan biaya yang tidak perlu, dan dapat mendorong kolaborasi dengan memindahkan pasien atau specimen laboratorium dari unit dengan fasilitas atau specimen laboratorium dari unit dengan fasilitas lebih sedikit ke unit dengan fasilitas lebih.
3. Terwujudnya pemerataan kegiatan kesehatan dan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu untuk meningkatkan mutu, cakupan, dan efisiensi pelayanan kesehatan terpadu.

Keuntungan system rujukan adalah sebagai berikut :

1. Pasien menerima layanan kesehatan sedekat mungkin dengan tempat tinggal mereka. Sehingga proses tindakan akan lebih cepat, terjangkau, dan lebih aman.
2. Peningkatan secara berkala diantisipasi untuk memperkuat pengetahuan dan kapasitas aparatur daerah sehingga lebih banyak kasus dapat ditangani di daerah masing – masing.
3. Mempermudah individu dari pedesaan menerima dan menggunakan tingkat keahlian yang lebih tinggi dan fasilitas yang lebih baik.

Dalam melaksanakan rujukan harus mengikuti standar operasional prosedur agar proses rujukan berjalan dengan baik, meliputi komunikasi dan kesiapan pemberi pelayanan rujukan. Langkah rujukan harus meliputi

1. Identifikasi dengan bidan melakukan pemeriksaan dan mendeteksi komplikasi
2. Stabilisasi bidan memberikan penanganan kegawatdaruratan awal sebelum dirujuk

3. Konsultasi/ kolaborasi bidan menghubungi faskes rujukan (Puskesmas/RS) untuk melaporkan kondisi pasien
 4. Rujukan: pasien dikirim dengan membawa surat rujukan, dokumentasi pendukung (BUKU KIA, partograf, lembar oberserbavasi, dll) dengan pendampingan.
- (KemenKes, 2025).

Dalam system kesehatan nasional terdapat 2 jenis rujukan, yaitu rujukan medis dan rujukan kesehatan:

1. Rujukan medis

Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab terhadap masalah atau situasi medis yang berkembang baik secara vertical maupun horizontal sebagai respon atas kegagalan fasilitas kesehatan dalam memenuhi tuntutan pasien agar dapat sembuh, mampu mengelola secara wajar, dan memulihkan keadaan kesehatan pasien.

Kategori rujukan medis meliputi:

- a. Transfer of specimen (pemeriksaan laborarium), pasokan bahan (spisimen) untuk melakukan analisis yang lebih lengkap laboratorium.
- b. Transfer of patient (konsultasi diagnostic, tindakan) pengobatan, tindakan operatif.
- c. Transfer of knowledge/personel kiriman tenaga medis yang berkualitas untuk meningkatkan layanan kesehatan setempat. Melalui kuliah, konsultasi, diskusi kasus, dan demonstrasi operasi, para professional dikirim ke daerah untuk memberikan informasi dan ketrampilan.

2. Rujukan kesehatan

Hubungan dengan fasilitas yang lebih mumpuni dan lengkap dalam hal pengiriman dan pemeriksaan barang atau sampel. Pemeriksaan dan perlindungan kesehatan seseorang adalah focus utama kutipan ini. Pelaksanaan system rujukan adalah sebagai berikut : pasien yang dirujuk harus diperiksa terlebih dahulu, dan juga harus memenuhi kriteria rujukan. Pasien dirujuk jika satu atau lebih kriteria berikut terpenuhi :

- a. Hasil tes fisik menyimpulkan bahwa itu tidak dapat diatasi
- b. Hasil tes fisik dan pemeriksaan medis yang menyertainya terbukti tidak dapat diatasi
- c. Membuat evaluasi dukungan medis yang lebih komprehensif, meskipun pasien harus hadir untuk pemeriksaan
- d. Jika sudah diobati dan dirawat, maka ditetapkan perlu pengkajian dan pengobatan medis di fasilitas kesehatan yang lebih mampu.

Pedoman rujukan nasional menurut Kemenkes (2012) adalah sebagai berikut:

1. Tingkat rumah tangga: pelayanan kesehatan oleh individu atau oleh keluarga sendiri
2. Tingkat Masyarakat: kegiatan swadaya masyarakat dalam menolong mereka sendiri oleh kelompok peguyuban, PKK, Saka Bhakti Husada, Anggita RT, RW, dan Masyarakat (Posyandu)
3. Fasilitas pelayanan kesehatan profesional Tingkat I : Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Praktik dokter swasta, Bidan, Poliklinik swasta, dll
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Profesional Tingkat II : RS Kabupaten, RS Swasta, Laboratorium Swasta, dll.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Profesional Tingkat III : RS Tipe A dan B serta Lembaga spesialis swasta, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Laboratorium Klinik Swasta

Bidan sebagai tenaga kesehatan harus mampu merujuk ibu atau bayi ke institusi kesehatan rujukan yang sesuai secara tepat waktu. Rujukan yang sesuai dengan prinsip BAKSOKUDA (Kemenkes, 2012).

1. B(idan): pastikan bahwa ibu/bayi/klien didampingi oleh profesional perawatan kesehatan yang berkualitas yang mampu menangani keadaan darurat selama rujukan perjalanan.
2. A (lat: Membawa alat dan perbekalan yang diperlukan (jarum suntik, infus set, pengukur tekanan darah, stetoskop, oksigen, dll)
3. K(endaraan): siapkan kendaraan yang sesuai untuk membawa pasien ketempat rujukan
4. S(urat): surat rujukan yang memuat nama, penyebab, tindakan yang sudah dilakukan, dan obat yang diberikan
5. O(bat-obatan): bawalah obat – obatan yang diperlukan, seperti obat-obatan vital, damping klien selama perjalanan, memberikan informasi kepada keluarga klien kondisi keadaan klien. Menginformasikan keluarga untuk mempersiapkan keperluan klien termasuk dana.
6. DA (rah): Donor darah harus dipersiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan klien saat diperlukan.

Perencanaan rujukan perlu diperhatikan karena juga akan berdampak pada pengambilan Keputusan. Menurut Kemenkes (2012) tahapan perencanaan rujukan adalah sebagai berikut:

1. Rujukan harus mendapat persetujuan dari pasien/anggota keluarga, dan beberapa hal harus dikomunikasikan, antara lain : diagnosis dan tindakan medis yang diperlukan, alasan merujuk ibu, Risiko yang mungkin akan timbul jika rujukan tidak dilakukan, Risiko yang mungkin timbul selama rujukan, waktu yang tepat untuk melakukan rujukan, durasi yang diperlukan untuk merujuk, tujuan rujukan, transportasi yang digunakan, tenaga kesekatan yang mendampingi.
2. Menghubungi pusat pelayanan kesehatan yang menjadi tujuan rujukan dan memberikan informasi kepada petugas kesehatan yang akan menerima pasien sebagai berikut : indikasi rujukan, kondisi ibu dan janin, rencana terkait prosedur teknis rujukan (termasuk kondisi lingkungan dan cuaca ditujuan rujukan), kesiapan sarana dan prasarana ditempat tujuan rujukan, dan pengelolaan yang dilakukan selama dan sebelum pengangkutan.
3. Informasi yang harus dicatat oleh pusat pelayanan kesehatan yang akan menerima pasien adalah : nama pasien, nama tenaga kesehatan yang merujuk, alasan rujukan, kondisi ibu dan janin, pengobatan sebelumnya, serta nama dan profesi tenaga kesehatan pendamping.
4. Pastikan bahwa data tersebut telah didokumentasikan dan diketahui oleh tenaga kesehatan di Puskesmas diaman pasien akan disambut saat berkomunikasi melalui telepon
5. Lengkapi dan kirimkan dokumen – dokumen berikut ibi segera mungkin : formulir rujukan pasien, diagnosis kerja, terapi yang telah diberikan, tujuan tujuan, serta nama dan tanda tangan pemberi pelayanan, fotocopy rekam medis kunjungan antenatal, fotocopy rekam medis kunjungan antenatal, foto copy rekam medis yang berkaitan dengan kondisi saat ini, hasil pemeriksaan pendukung, dokumentasi lain untuk tanggung jawab fidusia, dokumen lain untuk tanggung jawab fidusia.
6. Pastikan ibu yang dirujuk memakai gelang pengenalan, dan bila ada indikasi, tempatkan pasien pada selang infus ukuran 16 atau 18
7. Setelah mendiskusikan kondisi pasien dengan petugas kesehatan dilokasi yang dirujuk, segera mulai penatalaksanaan dan pemberian obat sesuai indikasi. Sebelum pengangkut pasien, semua perawatan darurat dan prosedur resusitasi harus diselesaikan
8. Pastikan bahwa semua alat penelitian dan perlengkapan perjalanan yang diperlukan sudah dikemas, mengingat segudang masalah yang mungkin muncul selama perjalanan, dan selalu siap menghadapi scenario terburuk.
9. Evaluasi Kembali faktor-faktor berikut sebelum merujuk pasien, kondisi pasien secara keseluruhan : tanda – tanda vital pasien (nadi, tekanan darah, suhu, dan

pernapasan), detak jantung janin, presentasi pasien, dilatasi serviks pasien, posisi janin pasien, kondisi ketuban, dan, kekuatan, frekuensi, dan durasi kontraksi Rahim

10. Melengkapi temuan pemeriksaan harus nama praktisi perawatan kesehatan yang melakukan pemeriksaan terakhir, serta tanggal dan waktu pemeriksaan tersebut.

Alur dan Skema Rujukan

Menentukan kegawatdaruratan pada Tingkat kader, bidan desa, puskesmas pembantu dan puskesmas dilanjutkan dengan menentukan tempat rujukan, memberikan informasi kepada pasien dan keluarganya, mengirimkan informasi pada tempat rujukan yang dituju, persiapan pasien, dan mengirimkan pasien ke tempat rujukan serta tindak lanjut pasien.

Alur pelayanan rujukan kegawatdaruratan obstetric dan neonatal adalah sebagai berikut:

1. System rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal mengacu pada prinsip utama kecepatan dan ketepatan tindakan, efesiensi, efektifitas, dan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan fasilitas pelayanan, dan setiap kasus kegawatdaruratan obstetric dan neonatal yang datang ke PONED Puskesmas harus dikelola secara langsung sesuai dengan prosedur dan buku acuan nasional kesehatan ibu dan bayi baru lahir.
2. Setelah kondisi pasien stabil, diputuskan apakah akan dirawat di Tingkat Puskesmas PONED atau dipindahkan ke RS PONEK untuk perawatan lebih lanjut
3. Masyarakat umum memiliki akses langsung kesemua fasilitas perawatan kebidanan dan bayi baru lahir untuk keadaan darurat. Bidan di desa dan polindes dapat memberikan asuhan langsung kepada ibu hamil, ibu bersali, dan ibu nifas, yang datang sendiri atau dirujuk oleh kader Masyarakat.

Kemampuan atau melakukan rujukan ke Puskesmas, PONED dan PONEK sesuai dengan Tingkat pelayanan.

1. Pasien yang datang sendiri ke Puskesmas atau dirujuk oleh kader dan mengalami kegawatdaruratan onbstetri atau neonatal harus distabilkan terlebih dahulu oleh Puskesmas sebelum dipindahkan ke RS PONED atau RS PONEK. Kriteria ini harus dipenuhi agar transfer dapat dilakukan.
2. Fasilitas kesehatan PONED dapat memberikan pelayanan langsung kepada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi abru lahir yang datang sendiri atau yang dirujuk oleh kader, bidan desa, atau puskesmas. Layanan ini meliputi perawatan

kehamilan, perawatan persalinan, perawatan nifas, dan perawatan bayi baru lahir. Asuhan kebidanan, asuhan nifas, dan asuhan ibu nifas merupakan bagian dari pelayanan tersebut, yang juga mencakup kemampuan dalam memberikan asuhan nifas. Puskesmas PONEK mampu menangani sendiri berbagai kondisi atau mengirim pasien ke RS PONEK sesuai dengan kemampuan dan bidan praktik yang diperbolehkan,

3. Rumah sakit PONEK yang buka 24 jam sehari mampu memberikan perawatan langsung kepada ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas, selain memberikan perawatan kepada bayi yang datang sendiri atau dirujuk
4. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah nasional, negara bagian, dan local dibidang manajemen, administrasi, dan keuangan sangat penting untuk pengoperasian layanan kebidanan darurat sangat penting untuk pengoperasian layanan kebidanan darurat dan perawatan neonatal yang efisien. POKJA/Satgas Gerakan Cinta Ibu (GSI) adalah semacam kemitraan fungsional yang melibatkan Lembaga swadaya Masyarakat ditingkat provinsi dan kabupaten, rumah sakit swasta, rumah bersalin, dokter, dan praktik mandiri bidan (PMB) yang berhasil mengkoordinasikan.

Aplikasi Sistem Rujukan

Pemerintah telah melaksanakan berbagai inisiatif operasional dan kebijakan. Salah satu Upaya tersebut adalah pengembangan system informasi kesehatan nasional. Teknologi Informasi system tujuan digital berbasis internet, dan aplikasi yang digunakan saat ini dikenal dengan Sistem Rujukan Terpadu (SISRUTE). Integrated Referral System (IRS) adalah aplikasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan antar fasilitas kesehatan. IRS menggunakan teknologi informasi berbasis internet untuk menghubungkan data pasien dari Tingkat pelayanan yang lebih rendah ke Tingkat pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya. Tujuan IRS untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien sehingga pelayanan cepat tercapai dan lebih efektif. Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2026 kembali mempertegas Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan mengatur mekanisme rujukan yang lebih efisien, berbasis kompetensi/kemampuan fasilitas, dan terintegrasi secara elektronik. PMK ini mencabut aturan lama (PMK 001/002) dan mewajibkan penyesuaian faskes dalam satu tahun. Point penting PMK No. 16 Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Rujukan berbasis kompetensi : Rujukan tidak lagi sekedar benjenjang (Faskes 1 ke 2 ke 3), melainkan disesuaikan dengan kebutuhan klinis pasien, ketersediaan sarana, prasarana, dan tenaga medis di faskes penerima.

2. Wajib Elektronik: System rujukan wajib menggunakan platform elektronik (Sistem Rujukan Terintegrasi)
3. Efisiensi Pelayanan: Faskes penerima rujukan dilarang melakukan pemeriksaan penunjang ulang jika sudah dilakukan di faskes perujuk, guna efisiensi biaya dan waktu
4. Jenis Rujukan: Rujukan Vertikal (antar faskes berbeda Tingkat) dan Rujukan Horizontal (antar faskes satu Tingkat)
5. Rujukan Balik: Pasien dengan penyakit kronis tertentu dapat dikembalikan ke faskes Tingkat pertama untuk pemantauan lebih lanjut
6. Sanksi: Kemenkes dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis atau penurunan/pencabutan status akreditasi bagi faskes yang melanggar ketentuan.

C. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Kasus I:

Seorang perempuan usia 40 tahun, G1P0A1, usia kehamilan 39 minggu, datang ke TPMB pukul 07.00 dengan keluhan mulas teratur sejak malam. Hasil pemeriksaan awal: keadaan umum baik, TD 130/80 mmHg, nadi 86 x/menit, suhu 36,5°C, DJJ 145 x/menit, his 3 kali dalam 10 menit selama 40 detik, ketuban rembes, pembukaan serviks 3 cm, penurunan kepala masih tinggi.

Pertanyaan Diskusi

1. Apa masalah utama pada kasus di atas?
2. Data apa saja yang mendukung analisis Anda?
3. Berdasarkan deteksi dini konseling apakah saat hamil yang harus diberikan bidan?
4. Tanda bahaya apa yang mulai muncul pada ibu dan janin?
5. Apa tindakan awal yang harus dilakukan bidan pada kasus ini?
6. Apakah kasus ini masih dapat ditangani expectant di fasilitas awal, atau perlu eskalasi/rujukan? Jelaskan alasan Anda.
7. Informasi penting apa yang harus disampaikan bidan kepada ibu dan keluarga sebelum tindakan lanjutan atau rujukan?
8. System rujukan apa yang harusnya dipakai dalam kasus diatas?

D. Aktivitas 2 – Shows How

Simulasi/Skill Lab Persalinan Gadar

Fokus urutan Anamnesis + KIE/Konseling + Kolaborasi/Rujukan

Catatan untuk penulis:

- Tidak loncat ke Ujian
- Mahasiswa naik tangga kompetensi

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows/Knows How	Self-check + analisis mini – case
Show How	OSCE Asuhan Gadar

Catatan untuk penulis:

- Karena CP Bab : menjabarkan

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Item (WAJIB LULUS)

- Pencegahan Infeksi
- Anamnesis diperlukan
- KIE/Konseling
- Persiapan pelaksanaan rujukan

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman dan konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen dan Keputusan	Tepat dan jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empati dan jelas	Baik	Kurang	Buruk

Catatan untuk penulis :

- Nilai tinggi tidak menutup kegagalan keselamatan

Template Soal Osce Kebidanan

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Persalinan: Gadar
3	Kasus	KPD di TPMB dengan tindakan awal dan rujukan

No.	Komponen	Isi
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam:
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan usia 40 tahun, G1P0A1, usia kehamilan 39 minggu, datang ke TPMB pukul 07.00 dengan keluhan mulas teratur sejak malam. Hasil pemeriksaan awal : keadaan umum baik, TD 130/80 mmHg, nadi 86 x/menit, suhu 36,5°C, DJJ 145 x/menit, his 3 kali dalam 10 menit selama 40 detik, ketuban rembes, pembukaan serviks 3 cm, penurunan kepala masih tinggi. TUGAS 1. Lakukan perumusan diagnosis sesuai kasus. 2. Berikan KIE singkat kepada ibu/keluarga 3. Jelaskan rencana kolaborasi/rujukan.
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikuti kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian:

No.	Komponen	Isi
		- Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog PS. 2. Jika peserta menyatakan akan melakukan palpasi abdomen/Leopold, penguji memberikan data:- TFU 36 cm- Punggung kiri- Presentasi kepala- Kepala 3/5 di atas PAP 3. Jika peserta meminta hasil pemeriksaan dalam atau interpretasi partograf, penguji memberikan data:- Pembukaan serviks 3 cm menetap selama 4 jam- Serviks edema ringan- Ketuban pecah- Air ketuban bercampur mekonium tipis- Kepala masih tinggi/Hodge II- Moulage ++ 4. Tindakan awal yang diharapkan dari peserta meliputi:- Menilai ulang kondisi ibu dan janin secara cepat- Menjelaskan kondisi ibu secara singkat dan jelas- Memposisikan ibu miring kiri- Menyiapkan/memasang infus cairan sesuai kewenangan dan fasilitas- Menganjurkan atau menyiapkan pengosongan kandung kemih- Melakukan pemantauan DJJ dan tanda vital- Menyiapkan kolaborasi/rujukan segera- Memberikan dukungan emosional dan KIE singkat 5. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 6. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai. INSTRUKSI TAMBAHAN

No.	Komponen	Isi
		1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: PS berperan sebagai ibu inpartu kala I fase aktif. PS tampak cemas, lelah, sesekali meringis saat kontraksi, memegang perut bawah, dan berbicara terputus saat nyeri datang. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif. Bila peserta menyampaikan bahwa ibu perlu dirujuk, PS tampak khawatir tetapi bersedia mengikuti arahan.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu. PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa ibu. Apakah ibu bersedia? PS: Iya, Bu, saya bersedia. Peserta: Apa keluhan utama ibu? PS: Saya mulas kuat dari tadi malam, Bu, tapi belum lahir juga. Peserta: Sejak kapan mulas teratur? PS: Kira-kira sudah 10 jam, Bu. Peserta: Apakah sudah keluar lendir darah? PS: Iya, ada lendir bercampur darah sedikit. Peserta: Apakah air ketuban sudah keluar? PS: Sudah, sekitar 2 jam yang lalu. Peserta: Apakah ibu sudah merasa ingin mengejan? PS: Belum, Bu. Peserta: Bagaimana gerakan bayi? PS: Sejak tadi terasa berkurang, Bu. Peserta: BAK terakhir kapan? PS: Tadi pagi, sedikit sekali. Peserta: Ini kehamilan yang ke berapa?

No.	Komponen	Isi
		PS: Ini kehamilan pertama saya, Bu. Peserta: Ada riwayat darah tinggi, operasi, atau penyakit lain? PS: Tidak ada, Bu. Peserta: Ibu, persalinannya belum maju dan bayi perlu segera ditolong di rumah sakit. PS: Baik, Bu, tolong bantu saya dan bayi saya ya. Peserta: Saya akan melakukan tindakan awal dan menyiapkan rujukan. PS: Iya, Bu. Catatan: Jika ada pertanyaan lain terkait riwayat penyakit, riwayat obstetri-ginekologi, sosial, spiritual, ekonomi, dan ADL, PS memberi jawaban normatif dan tidak mengarah ke diagnosis lain.
10	Kebutuhan manikin	-Phantom abdomen hamil/manekin Leopold - Phantom panggul/serviks untuk simulasi pemeriksaan dalam - Lembar partograf kasus
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin - Mengganti lembar partograf/lembar instruksi bila diperlukan - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa — 1 2. Phantom abdomen hamil/manekin Leopold — 1 3. Phantom panggul/serviks — 1 4. Lembar partograf kasus — 1 set 5. Tensimeter — 1 6. Stetoskop — 1 7. Doppler/Pinard — 1 8. Jam tangan/stopwatch — 1 9. Termometer — 1 10. Sarung tangan bersih — 1 pasang

No.	Komponen	Isi
		11. Handrub — 1 botol 12. Kain penutup/selimut — 1 13. Tisu — 1 pack 14. Infus set dummy — 1 set 15. Cairan RL/NaCl dummy — 1 16. Abocath dummy — 1 17. Formulir rujukan — 1 lembar 18. Lembar jawaban peserta — 1 lembar 19. Pena — 1
13	Penulis	Tidak ada catatan khusus
14	Referensi	Restuti, Windi dkk. 2021. Journal of Midwifery Information (JoMI) Volume 2 No 1 Bulan September Tahun 2021. Kemenkes RI, (2024). Profil Kesehatan Indonesia 2024. Katalog Dalam Terbitan Ke-mentrian Kesehatan RI Kementrian Kesehatan Republik Indonesia: Jakarta. 2024 Republik Indonesia (2023). Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. : Jakarta ; 2023 Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 23 KEMENKES RI. 2025. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/560/2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif Di Rumah Sakit. Jakarta. 2025

E. Rubrik Penilaian

Stase 1: Rujukan kasus KPD kala I laten

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama		
2. Riwayat pengeluaran pervaginam (lendir darah, air ketuban, perdarahan)		
3. Gerak janin		
4. Riwayat obstetri (GPA, usia kehamilan, ANC, persalinan sebelumnya bila ada)		
5. Riwayat kesehatan/komplikasi kehamilan/operasi/alergi/obat-obatan		
6. Aktivitas harian yang relevan dengan kondisi saat ini (asupan makan-minum, BAK terakhir, kelelahan, dukungan keluarga)		

Skoring KOMPETENSI 1

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **6 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4–5 dari 6 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 6 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam		
2. Menjelaskan hasil pemeriksaan dan kondisi ibu/janin dengan bahasa sederhana		
3. Menjelaskan tindakan awal yang sedang/akan dilakukan		
4. Menjelaskan perlunya kolaborasi/rujukan segera		
5. Menenangkan ibu dan melibatkan keluarga/pendamping		
6. Memberi kesempatan bertanya dan menjawab pertanyaan dengan jelas		

Skoring KOMPETENSI 3

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **6 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4–5 dari 6 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 6 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 4. Rujukan

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Informasi kondisi ibu dan janin pada keluarga		
2. Memberikan informasi ibu dan keluarga untuk rujukan		
3. Mempersiapkan system kolaborasi untuk pelaksanaan rujukan		
4. Komunikasi dengan tempat rujukan		
5. Mendampingi ibu untuk melaksanakan rujukan		

Skoring KOMPETENSI 4

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **5 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4 dari 5 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 5 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3

(dicatat di rubrik penilaian)

Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = ----- x 100 =

30

(Kota),

.....

Penguji :

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Konsep Dasar Risiko Tinggi Maternal–Neonatal dan Peran Bidan di Pelayanan Primer

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus KPD dengan KRST
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural. Penilai mengamati tindakan yang dilakukan peserta, lalu memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. Domain yang ingin dinilai adalah penentuan diagnosis, KIE dan persiapan tindakan rujukan	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan penentuan diagnosis, melaksanakan KIE tentang kondisi ibu, dan persiapan rujukan sampai melaksanakan rujukan pasien sesuai alur rujukan
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa melakukan tindakan awal yang aman, cepat, dan sistematis pada penentuan diagnosis, KIE dan persiapan tindakan rujukan dengan tetap berpusat pada keselamatan ibu dan janin serta penghormatan pada asuhan yang bermartabat. WHO menekankan pentingnya asuhan intrapartum yang evidence-based, woman-centred, dan pemantauan kemajuan persalinan yang baik.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang penentuan diagnosis, KIE dan persiapan tindakan rujukan, tetapi dari kemampuannya menilai kondisi ibu-janin, membaca data kemajuan persalinan, melakukan stabilisasi awal, dan menjelaskan kebutuhan kolaborasi atau rujukan.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang sesuai dengan capaian pembelajaran profesi bidan, khususnya	Seorang perempuan usia 40 tahun, G1P0A1, usia kehamilan 39 minggu, datang ke TPMB pukul 07.00 dengan keluhan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus KPD dengan KRST
	pengenalan KPD dengan KRST. WHO menempatkan penggunaan Skor pudji rochjati dan partograf serta identifikasi tanda obstruksi sebagai bagian penting dalam pengelolaan kehamilan dan persalinan	mulas teratur sejak malam. Hasil pemeriksaan awal : keadaan umum baik, TD 130/80 mmHg, nadi 86 x/menit, suhu 36,5°C, DJJ 145 x/menit, his 3 kali dalam 10 menit selama 40 detik, ketuban rembes, pembukaan serviks 3 cm, penurunan kepala masih tinggi.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	mahasiswa diamati saat melakukan prosedur atau rangkaian tindakan klinik tertentu, bukan sekadar berdiskusi tentang kasus. Pada topik ini, keterampilan yang relevan antara lain menilai keadaan umum ibu, tanda vital, DJJ, his, kemajuan persalinan melalui partograf, menilai penurunan kepala, serta melakukan tindakan awal seperti posisi miring kiri, menyiapkan infus, menjaga keseimbangan cairan, dan menyiapkan rujukan. WHO juga mencantumkan keterampilan seperti menilai penurunan kepala, mengenali obstructed labour, memasang dan memantau infus, menjaga keseimbangan cairan, serta pencatatan sebagai keterampilan penting.	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menilai kondisi ibu dan janin, membaca partograf, menyimpulkan dengan diagnose dengan KRST, dilanjutkan dengan memberikan konseling kepada klien dan keluarga tentang kondisi keadaan ibu dan janin, Dimana ibu perlu dilakukan tindakan rujukan dalam mencegah kondisi yang tidak diinginkan saat terjadi persalinan, dikarenakan ibu dalam status KRST dengan inpatu kala I laten dengan KPD
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi pemahaman indikasi tindakan,	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu melihat

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus KPD dengan KRST
	persetujuan tindakan, persiapan pra-prosedur, kemampuan teknis, komunikasi, menentukan diagnose sementara pada klien, melaksanakan KIE, persiapan rujukan, dan pelaksanaan tindakan	kondisi ibu hamil dengan KRST, ketuban pecah dini, usia ibu diatas 35 tahun tensi tinggi.
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah mutu performa nyata mahasiswa saat melakukan tindakan awal. Pada kasus KRST adalah rujukan untuk pelaksanaan persalinan dengan kasus ibu KPD	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa cepat mengenali kondisi gawat, melakukan prioritas tindakan dengan urutan yang benar, menghindari intervensi yang tidak aman, serta segera meminta bantuan atau menyiapkan rujukan.
Umpan balik	Umpan balik dalam DOPS diberikan segera setelah observasi dan berisi apa yang sudah efektif serta apa yang perlu diperbaiki. Form DOPS juga menekankan komentar assessor mengenai kekuatan, area yang perlu ditingkatkan, dan rencana perbaikan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan membaca partograf, tetapi masih perlu meningkatkan ketegasan saat memutuskan eskalasi, ketelitian dalam menilai penurunan kepala, atau kelengkapan penjelasan kepada keluarga.
Keputusan penilaian	Dalam buku ajar ini, hasil DOPS dapat diringkas menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Keputusan ditetapkan berdasarkan ketepatan langkah, keselamatan pasien,	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan tindakan awal secara runtut, aman, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila langkah utama sudah benar tetapi masih memerlukan arahan.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus KPD dengan KRST
	komunikasi, dan kemampuan mengambil keputusan awal.	Mahasiswa dinyatakan remedial apabila gagal mengenali kegawatan, salah menentukan prioritas, atau tidak menyiapkan eskalasi dengan benar.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does karena performanya diamati langsung saat melakukan tindakan klinik. Observasi langsung pada pasien nyata dan umpan balik segera menjadikan DOPS sangat sesuai untuk pembelajaran berbasis kompetensi.	Pada kasus KRST dengan Inpartu KPD, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan tindakan awal kegawatdaruratan persalinan secara langsung, aman, cepat, dan profesional di lahan praktik.

F. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel Portofolio pada Konsep Dasar Risiko Tinggi Maternal–Neonatal dan Peran Bidan di Pelayanan Primer

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus KPD dengan KRST
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada topik Kasus KPD dengan KRST , portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian persalinan, menilai kemajuan persalinan dengan 29rofession, mengenali tanda bahaya ibu dan janin, melakukan tindakan awal, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah menangani ibu bersalin dengan KRST dengan KPD, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan penanganan ibu dengan KRST dan KPD dan tindakan awal pra-rujukan.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus KPD dengan KRST
	laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan penilaian ibu bersalin, stabilisasi awal, dan persiapan rujukan pada kasus partus lama di ruang bersalin.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus ibu Ny "X" usia 40 tahun, G1P0A1, UK 39 minggu, KU baik, TD 130/80 mmHg, nadi 86 x/menit, suhu 36,5°C, DJJ 145 x/menit, his 3 kali dalam 10 menit selama 40 detik, ketuban rembes, pembukaan serviks 3 cm, penurunan kepala masih tinggi. tindakan awal yang dilakukan, dan keputusan rujukan.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan.	Mahasiswa dapat mendiagnosis, adanya KPD, resiko tinggi pada ibu dan bayi dengan ibu KRST, resiko preeklamsi, melakukan penanganan awal rujukan, dan melaksanakan rujukan
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam mengenali KPD dan preeklasi dan menjelaskan rujukan, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam menilai penurunan kepala, interpretasi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus KPD dengan KRST
		ketuban, dan ketegasan saat melakukan eskalasi.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus partus lama, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu menilai kemajuan persalinan, mengenali distosia, dan melakukan tindakan awal secara aman.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu mengenali tanda bahaya, dan mengambil keputusan awal yang tepat pada persalinan bermasalah.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada topik partus lama dan distosia, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik kebidanan nyata.

Tabel Case Report pada Konsep Dasar Risiko Tinggi Maternal–Neonatal dan Peran Bidan di Pelayanan Primer

Komponen	Deskripsi	Contoh pada KRST dan KPD
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang ibu inpartu kala I fase laten dengan KRST, KPD kepala tinggi, kepala dengan tensi tinggi
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data ibu, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan awal yang diberikan, persiapan rujukan, dan perkembangan kondisi ibu serta janin setelah intervensi awal.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ini, mahasiswa menuliskan KRST dengan KPD inpartu kala I laten dengan TD 130/80mmHG dengan kecurigaan preeklamsi dan gawat janin, tindakan awal stabilisasi, dan keputusan rujukan.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu adanya skor KSPR dengan kasus ketuban merembes, tendi darah 130/80mmHG, pernah abortus dengan kondisi KPD, preeklamsi, antisipasi gawat janin sehingga memerlukan penanganan rujukan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada KRST dan KPD
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus partus lama, mahasiswa belajar bahwa pemantauan ibu-janin, dan keputusan eskalasi dini merupakan inti keselamatan dalam asuhan persalinan.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep KSPR, KPD, Preeklamsi, Gawat Janin tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan secara utuh.

Tabel Refleksi Patient Safety pada Konsep Dasar Risiko Tinggi Maternal–Neonatal dan Peran Bidan di Pelayanan Primer

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus dengan KRST dan KPD dengan kepala masih tinggi dan tensi tinggi, mahasiswa merefleksikan bahwa keterlambatan mengenali persalinan kecurigaan komplikasi persalinan dan gawat janin akan menyebabkan perburukan kondisi ibu dan janin.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti salah membaca kasus, tidak meninjau kondisi klien dengan cermat, atau menunda rujukan, dapat berdampak besar pada keselamatan ibu dan bayi.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah KRST, ROJ, KPD, Preeklamsi dan keterlambatan penanganan bila

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
	pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	kemajuan persalinan tidak dipantau dengan benar.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain keterlambatan diagnosis KRST, ROJ, KPD, Preeklamsi, penggunaan stimulasi persalinan yang tidak tepat, dan keterlambatan rujukan.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya tindakan professional deteksi awal dengan pemantauan tanda vital dan DJJ, penilaian 3P, stabilisasi awal ibu, komunikasi cepat kepada keluarga, dan rujukan tepat waktu ke fasilitas yang lebih mampu.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada KPD dan Preeklamsi, pengkajian serial, pengambilan keputusan cepat, dan keberanian melakukan eskalasi adalah bagian penting dari praktik bidan yang aman.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik kebidanan secara berkelanjutan.

G. Rangkuman Materi

Kehamilan dan persalinan merupakan kondisi normal dalam siklus reproduksi Wanita. Proses fisiologis akan berubah menjadi patologis jika kondisi ibu dan janin tidak pada batas normal baik dalam batas pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang. Kondisi kegawatdaruratan pada kehamilan dan persalinan dapat dideteksi dini melalui beberapa metode mulai dari menilai skor pudji rochjati, pemantauan buku KIA, pemeriksaan penunjang, penapisan persalinan. Bidan adalah garda terdepan dalam pemeriksaan dipelayanan primer. Dalam undang undang peran dan wewenang bidan sudah diatur dengan jelas standart kompetensi yang dimiliki. Sesuai peran dan wewenang bidan berhak untuk melaksanakan kegiatan promotive dan preventif untuk mencegah kegawatdaruratan maternal dan neonatal. Deteksi dini risiko tinggi pada ibu hamil merupakan upaya pencegahan komplikasi dalam persalinan. Dengan penilaian tepat mulai dari pemeriksaan fisik, Riwayat obstetri, pemeriksaan penunjang bidan dapat mengambil simpulan untuk diagnosis awal tindakan. Kehamilan dengan resiko sangat tinggi menjadi kewaspadaan utama dalam pelayanan asuhan.

Klien 40 Tahun dengan G1P0A1, UK 39 minggu, KU baik, TD 130/80 mmHg, nadi 86 x/menit, suhu 36,5°C, DJJ 145 x/menit, his 3 kali dalam 10 menit selama 40 detik, ketuban rembes, pembukaan serviks 3 cm, penurunan kepala masih tinggi. Dari kasus diatas penilaian awal diperlukan untuk beberapa kondisi dengan penialain awal ROJ, KPD, Preeklamsi. Dengan melikan komplikasi yang dari deteksi dini pada pada di TPMB hanya diperlukan konseling untuk rujukan dengan alur vertical. Dukungan emosional dan pendampingan saat rujukan diperlukan agar ibu merasa lebih aman dan nyaman.

Alur asuhan singkat :

Ibu inpartu dengan skor KRST – Tensi tinggi – ketuban merembes – Riwayat abortus – Kepala Tinggi → diagnose dengan indikasi KRST KPD Preeklamsi → Konseling KU Ibu dan Janin pada ibu dan keluarga → Stabilisasi Awal dan Dukungan → Menentukan Kebutuhan rujukan → RUJUK

H. Tabel Red Flags & Eskalasi

Konsep Dasar Risiko Tinggi Maternal Neonatal dan Peran Bidan di Pelayanan Primer

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
MATERNAL		
Perdarahan hebt (ante/postpartum)	Menunjukkan risiko syok hipovolemik yang daapt menyebabkan gagal organ meultipel dan kematian dalam hitungan jam	Pasang infus jalur ganda (bolus cairan), pemberian uteoronika, dan segera rujuk ke RS dengan fasilitas bedah/transfusi
Tekanan darah >140/90 + Protein urine /Kejang	Menunjukkan pre-ekelamsi berat atau eklamsia. Risiko stroke hemoragik, solusio plasenta, dan kematian janin	Pemberian Loading Dosen MgSO ₄ (Magnesium Sulfat) untuk menjegak kejang, stabilisasi tensi dan terminasi kehamilan segera di RS PONEK
Demam tinggi + ketuban berbau	Indikator Sepsis Puerperalis atau amnionitis. Risiko infeksi sistemik yang mematikan bagi ibu dan janin	Pemberian antibiotic spektrum luas dosis awal dan evakuasi Rahim (persalinan dipercepat) di fasilitas Kesehatan Tingkat lanjut
NEONATAL		
Bayi Lahir tidak bernafas/ merintih	Indicator hipotermia berat. Bayi kehilangan energi hipogiklemia dan henti jantung	Langkah awal resusitasi (hangatkan psosisikan, isap lender, rangsang taktil) jika gagal lakukan ventilasi tekanan positif
Suhu tubuh <36,5°C	Indikator hipotermia berat. Bayi kehilangan energi dengan cepat, memicu hipogiklemi dan henti jantung	Metode kanguru (kontak kulit ke kulit), oenggunaan incubator, dan pemantauan kadar gula darah secara ketat
Bayi kuning dalam <24 jam pertama	Indikator icterus patologis. Risiko kernicterus	Pemeriksaan kadar bilirubine serum segera dan rujukan untuk fototerapi

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
MATERNAL		
	(kerusakan otak akibat bilirubin)	(terapi sinar) atau transfuse tukar

Form Checklist “Saya sudah bisa...”

Bab: Konsep Dasar Risiko Tinggi Maternal Neonatal dan Peran Bidan di Pelayanan Primer

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian risiko tinggi maternal dan neonatal	☐	☐	
2	Saya sudah bisa menjelaskan 4T penyebab faktor risiko tinggi maternal dan neonatal	☐	☐	
3	Saya sudah bisa menjelaskan 3T penyebab faktor risiko tinggi maternal dan neonatal	☐	☐	
4	Saya sudah bisa menjelaskan dampak risiko tinggi maternal pada kehamilan dan persalinan	☐	☐	
5	Saya sudah bisa menjelaskan dampak risiko tinggi neonatal pada kehamilan dan persalinan	☐	☐	
6	Saya sudah bisa mendeteksi risiko tinggi ibu hamil dengan Skor Pudji Rochyati	☐	☐	
7	Saya sudah bisa mendeteksi risiko tinggi ibu dengan pemantauan buku KIA	☐	☐	
8	Saya bisa menjelaskan peran bidan di pelayanan primer	☐	☐	
9	Saya bisa menjelaskan wewenang bidan di pelayanan primer	☐	☐	

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
10	Saya bisa menjelaskan alur rujukan dari pelayanan primer	☐	☐	
11	Saya bisa menjelaskan Langkah rujukan dari pelayanan primer	☐	☐	
12	Saya bisa menjelaskan konsep rujukan horisontal	☐	☐	
13	Saya bisa menjelaskan konsep rujukan vertical	☐	☐	
14	Saya bisa mendiagnosa rujukan dari sebuah kasus	☐	☐	
15	Saya bisa arah dari rujukan dari sebuah kasus	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

I. Daftar Pustaka

- Kadafi, Bagus. Dkk. 2021. *Pelaksanaan Rujukan Oleh Bidan Kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan Di Kota Bandar Lampung*. JHM Vol. 2 No. 1 April 2021. p-ISSN 2775-8982 e-ISSN 2775-8974.
- Karrikasari, dkk. 2025. Hubungan Risiko 4 Terlalu dan Kepatuhan Antenatal Care (ANC) dengan Komplikasi Persalinan. *Faletehan Health Journal*, 12 (1) 2025) 20-28. www.journal.lppm-stikesfa.ac.id/ojs/index.php/FHJ
- Kemendes RI, (2024). Profil Kesehatan Indonesia 2024. *Katalog Dalam Terbitan Kementerian Kesehatan RI Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. Jakarta. 2024
- KEMENKES RI. 2025. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/560/2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif Di Rumah Sakit*. Jakarta. 2025
- Kementerian Kesehatan RI. (2012). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan*. Jakarta: Kemenkes RI
- Permenkes RI. 2024. *Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan*. Jakarta. 2024.
- Republik Indonesia (2023). *Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. : Jakarta ; 2023

- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan*. Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 23
- Restuti, Windi dkk. 2021. *Journal of Midwifery Information (JoMI) Volume 2 No 1 Bulan September Tahun 2021*.
- Sari, Mita. Dkk. 2025. Peran Dinas Kesehatan dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Aceh Selatan. *The Public Health Science Journal*.
<https://doi.org/10.33221/jikm.v14i04>.
- Setyawati, dkk. 2025. Luaran Perinatal Yang Buruk Pada Ibu Remaja di Negara Berpenghasilan Rendah dan Menengah : Sistematis Review. *Journal of Midwifery Science and Women's Health Vol. 5 No. 3 Tahun 2025*. DOI: 10.36082/jmswh.v5i2.2254
- Siantar, R. L., Rostianingsih, D., Ismiati, T., & Bunga, R. (2022). *Buku ajar asuhan kebidanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal*. Rena Cipta Mandiri.
- WHO .2009. *Pelayanan Kesehatan Anak Di Rumah Sakit*. Jakarta: World Health Organization Country Office for Indonesia.

BAB 2

PENGKAJIAN TERPADU IBU DAN BAYI: ANAMNESIS TERFOKUS, PEMERIKSAAN FISIK DAN VALIDASI DATA

Tabel CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan)

Kode CPL	Deskripsi CPL	Domain
CPL-1	Bertakwa kepada Tuhan YME, menjunjung nilai kemanusiaan dalam praktik kebidanan	Sikap
CPL-2	Menunjukkan sikap profesional, etis, dan bertanggung jawab dalam pelayanan ibu dan bayi	Sikap
CPL-3	Mampu melakukan komunikasi efektif dan empatik pada ibu dan keluarga	Keterampilan Umum
CPL-4	Mampu melakukan pengkajian klinis ibu dan bayi secara sistematis dan aman	Keterampilan Khusus
CPL-5	Mampu menganalisis data klinis untuk menentukan masalah/kebutuhan	Pengetahuan
CPL-6	Mampu mengambil keputusan klinis berbasis bukti (evidence-based practice)	Keterampilan Khusus
CPL-7	Mampu melakukan dokumentasi dan validasi data secara akurat	Keterampilan Umum

Tabel CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

Kode CPMK	Rumusan CPMK	Level Taksonomi
CPMK-1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pengkajian terpadu ibu dan bayi	C2 (Understand)

Kode CPMK	Rumusan CPMK	Level Taksonomi
CPMK-2	Mahasiswa mampu mengidentifikasi data subjektif melalui anamnesis terfokus	C3 (Apply)
CPMK-3	Mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan fisik ibu dan bayi secara sistematis	C3 (Apply)
CPMK-4	Mahasiswa mampu melakukan validasi dan interpretasi data klinis	C4 (Analyze)
CPMK-5	Mahasiswa mampu mengidentifikasi tanda bahaya (red flags) ibu dan bayi	C4 (Analyze)
CPMK-6	Mahasiswa mampu melakukan pengkajian secara aman sesuai standar prosedur	C3 (Apply)
CPMK-7	Mahasiswa mampu mendokumentasikan hasil pengkajian secara tepat dan lengkap	C3 (Apply)

Teori Dasar

Mengumpulkan data anamnesis terfokus ibu dan bayi (janin/BBL sesuai konteks) dengan komunikasi terapeutik.

Pendahuluan

Pengkajian terpadu ibu merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan, memverifikasi, dan menganalisis data bio-psiko-sosio-spiritual ibu pada seluruh periode reproduksi (kehamilan, persalinan, nifas). Pengkajian ini dilakukan secara komprehensif untuk mendeteksi kondisi normal, risiko, maupun komplikasi sedini mungkin. Pendekatan ini selaras dengan rekomendasi pelayanan maternal dari World Health Organization dan pedoman pelayanan kesehatan ibu oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

A. Mengumpulkan data anamnesis terfokus ibu dan bayi (janin/BBL sesuai konteks) dengan komunikasi terapeutik.

1. Konsep Dasar Pengkajian Terpadu Ibu

Pengkajian terpadu berlandaskan prinsip:

- a. Komprehensif
- b. Sistematis
- c. Berkesinambungan
- d. Berbasis risiko
- e. Individual
- f. Terpadu lintas profesi

Tujuan utama:

- Mengidentifikasi kondisi fisiologis dan patologis
- Mendeteksi faktor risiko maternal
- Menentukan diagnosis kebidanan
- Menyusun rencana asuhan

2. Komponen Pengkajian Terpadu Ibu

Komponen pengkajian dibagi menjadi beberapa aspek utama:

a. Identitas dan Data Demografis

Meliputi:

- 1) Nama
- 2) Umur (risiko tinggi <20 tahun atau >35 tahun)
- 3) Pendidikan
- 4) Pekerjaan
- 5) Status perkawinan
- 6) Alamat

Tujuan:

- 1) Mengidentifikasi faktor sosial ekonomi
- 2) Menentukan faktor risiko usia reproduksi

b. Riwayat Kesehatan

- 1) Riwayat Penyakit Dahulu
 - a) Hipertensi
 - b) Diabetes mellitus
 - c) Penyakit jantung

- d) Asma
- e) TBC
- f) HIV/AIDS
- g) Gangguan ginjal
- 2) Riwayat Penyakit Keluarga
 - a) Hipertensi
 - b) Diabetes
 - c) Penyakit genetik
 - d) Riwayat preeklamsia dalam keluarga
- 3) Riwayat Alergi dan Pengobatan

Tujuan:

Mengidentifikasi risiko komplikasi maternal.

c. Riwayat Obstetri

Merupakan komponen utama pengkajian ibu.

- 1) Gravida, Para, Abortus (GPA)
 - a) G (Gravida): jumlah kehamilan
 - b) P (Para): jumlah persalinan hidup
 - c) A (Abortus): jumlah keguguran
- 2) Riwayat Kehamilan Sebelumnya
 - a) Persalinan normal/SC
 - b) Perdarahan
 - c) Preeklamsia
 - d) Bayi BBLR
 - e) Kematian neonatal
- 3) Riwayat Kehamilan Sekarang
 - a) HPHT
 - b) Usia kehamilan
 - c) Keluhan trimester
 - d) Pergerakan janin
 - e) Tanda bahaya

d. Riwayat Menstruasi dan Ginekologi

- 1) Usia menarche
- 2) Siklus menstruasi
- 3) Lama dan jumlah perdarahan
- 4) Nyeri haid
- 5) Riwayat infeksi reproduksi

6) Penggunaan kontrasepsi

e. Pemeriksaan Fisik Umum

- 1) Keadaan Umum
 - a) Kesadaran
 - b) Status gizi
 - c) Tanda anemia
- 2) Tanda-Tanda Vital
 - a) Tekanan darah
 - b) Nadi
 - c) Respirasi
 - d) Suhu
- 3) Pemeriksaan Head to Toe
 - a) Mata (konjungtiva)
 - b) Mulut (kebersihan, anemia)
 - c) Payudara (persiapan laktasi)
 - d) Ekstremitas (edema)

f. Pemeriksaan Obstetri Spesifik

- 1) Inspeksi Abdomen
 - a) Bentuk abdomen
 - b) Striae gravidarum
 - c) Linea nigra
- 2) Palpasi Leopold
 - a) Menentukan presentasi janin
 - b) Letak janin
 - c) Tinggi fundus uteri
- 3) Auskultasi
 - a) Denyut jantung janin (120–160 bpm)
- 4) Pemeriksaan Dalam (bila indikasi)
 - a) Pembukaan serviks
 - b) Penipisan
 - c) Penurunan kepala

g. Pemeriksaan Penunjang

Sesuai rekomendasi World Health Organization:

- 1) Hb (deteksi anemia)
- 2) Golongan darah

- 3) Protein urine
- 4) Gula darah
- 5) Pemeriksaan HIV dan sifilis
- 6) USG (bila tersedia)

h. Aspek Psikologis

Pengkajian meliputi:

- 1) Kecemasan kehamilan
- 2) Ketakutan persalinan
- 3) Dukungan suami
- 4) Risiko baby blues/depresi postpartum

i. Aspek Sosial dan Budaya

- 1) Dukungan keluarga
- 2) Kepercayaan/tradisi
- 3) Akses fasilitas kesehatan
- 4) Status ekonomi

Aspek ini penting dalam menentukan kepatuhan ANC.

j. Aspek Spiritual

- 1) Keyakinan ibu
- 2) Praktik ibadah
- 3) Harapan terhadap kehamilan dan persalinan

Pendekatan spiritual meningkatkan kesejahteraan psikologis ibu.

k. Identifikasi Faktor Risiko

Contoh faktor risiko:

- 1) Usia <20 atau >35
- 2) Grandemultipara
- 3) Riwayat SC
- 4) Anemia
- 5) Hipertensi
- 6) Jarak kehamilan <2 tahun

l. Analisis dan Interpretasi Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk:

- 1) Menentukan diagnosis kebidanan
- 2) Mengidentifikasi masalah aktual

- 3) Mengidentifikasi risiko potensial
- 4) Menyusun rencana asuhan

3. Pengkajian dalam Continuum of Care

Pengkajian terpadu dilakukan pada:

- a. Antenatal Care (ANC)
- b. Intranatal Care
- c. Postnatal Care
- d. Masa interval reproduksi

Pendekatan ini mendukung pelayanan berkesinambungan sesuai standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

4. Sintesis Konseptual

Komponen Pengkajian Terpadu Ibu meliputi:



5. Implikasi Praktik

Pengkajian yang lengkap dan terpadu:

- a. Mencegah keterlambatan diagnosis
- b. Menurunkan risiko komplikasi
- c. Meningkatkan keselamatan ibu
- d. Mendukung keberhasilan persalinan

B. Melakukan Pemeriksaan Fisik Dan Memvalidasi Data Untuk Menetapkan Masalah Serta Prioritas Asuhan .

1. Komponen Pengkajian Terpadu Bayi

a. Data Identitas Bayi

- 1) Jenis kelamin
- 2) Umur/usia neonatal
- 3) Berat badan dan panjang badan

b. Riwayat Kelahiran

- 1) Jenis persalinan
- 2) Usia gestasiss
- 3) APGAR score
- 4) Kondisi saat lahir

c. Pemeriksaan Fisik Bayi Baru Lahir

- 1) Keadaan umum
- 2) Tanda-tanda vital
- 3) Pemeriksaan head to toe
- 4) Refleks bayi baru lahir

d. Status Nutrisi dan Eliminasi

- 1) Inisiasi menyusu dini (IMD)
- 2) Pola menyusu
- 3) Frekuensi BAK dan BAB

e. Adaptasi Bayi Baru Lahir

- 1) Adaptasi pernapasan
- 2) Adaptasi sirkulasi
- 3) Adaptasi termoregulasi

2. Konsep Dasar Pengkajian Neonatal

Karakteristik Bayi Baru Lahir

Bayi mengalami transisi besar dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin, meliputi:

- a. Adaptasi respirasi
- b. Adaptasi sirkulasi
- c. Adaptasi suhu
- d. Adaptasi metabolik
- e. Adaptasi imunologis

Pengkajian harus mampu menilai keberhasilan adaptasi tersebut.

3. Komponen Pengkajian Terpadu Bayi

Pengkajian dilakukan secara komprehensif meliputi aspek berikut:

a. Data Identitas Bayi

- 1) Nama bayi
- 2) Tanggal dan jam lahir
- 3) Jenis kelamin
- 4) Tempat persalinan
- 5) Umur gestasi (cukup bulan/prematur/postmatur)
- 6) Jenis persalinan (spontan, SC, vakum, forceps)

Tujuan:

Menentukan faktor risiko awal neonatal.

b. Riwayat Kehamilan dan Persalinan Ibu

Karena bayi tidak dapat dikaji terpisah dari ibu, maka dikaji:

- 1) Riwayat anemia ibu
- 2) Hipertensi/preeklamsia
- 3) Ketuban pecah dini
- 4) Infeksi maternal
- 5) Persalinan lama
- 6) Gawat janin
- 7) Ketuban hijau (mekonium)

Hal ini membantu memprediksi risiko:

- 1) Asfiksia
- 2) Sepsis
- 3) BBLR
- 4) Prematuritas

c. Penilaian Segera Setelah Lahir

1) Skor APGAR

Dilakukan pada menit ke-1 dan ke-5, meliputi:

Parameter	Skor 0–2
Appearance (warna kulit)	Sianosis–merah muda
Pulse (denyut jantung)	<100 atau >100
Grimace (refleks)	Tidak ada–menangis
Activity (tonus otot)	Lemas–aktif
Respiration	Tidak ada–menangis kuat

Interpretasi:

- 7–10: normal
- 4–6: asfiksia sedang
- 0–3: asfiksia berat

d. Pemeriksaan Fisik Umum

1) Keadaan Umum

- Kesadaran
- Tangisan
- Aktivitas
- Warna kulit

2) Tanda-Tanda Vital

- Suhu: 36,5–37,5°C
- Nadi: 120–160 x/menit
- Respirasi: 30–60 x/menit

e. Pemeriksaan Antropometri

- 1) Berat badan (normal 2500–4000 gram)
- 2) Panjang badan (48–52 cm)
- 3) Lingkar kepala (33–35 cm)
- 4) Lingkar dada

Tujuan:

Menentukan BBLR, makrosomia, atau gangguan pertumbuhan intrauterin.

f. Pemeriksaan *Head to Toe*

1) Kepala

- Bentuk kepala
- Caput succedaneum
- Cephalhematoma
- Ubun-ubun

2) Mata

- Refleks cahaya
- Konjungtiva
- Tanda infeksi

3) Hidung

- Patensi lubang hidung

4) Mulut

- Labioskisis/palatokisis
- Refleks menghisap

5) Leher dan Klavikula

- Fraktur klavikula
- Massa abnormal

6) Dada

- Simetris
- Retraksi
- Bunyi napas tambahan

7) Abdomen

- Bentuk
- Hernia umbilikalis
- Tali pusat (infeksi, perdarahan)

8) Genitalia

- Testis turun (laki-laki)
- Labia mayor menutupi minor (perempuan)

9) Anus

- Patensi anus

10) Ekstremitas

- Kelainan kongenital
- Jumlah jari
- Refleks moro

g. Pemeriksaan Refleks Neonatal

Refleks primitif meliputi:

- Refleks Moro
- Refleks rooting
- Refleks sucking
- Refleks grasping
- Refleks tonic neck

Refleks abnormal dapat menunjukkan gangguan neurologis.

h. Pengkajian Adaptasi Fisiologis

1) Sistem Respirasi

- Pola napas
- Retraksi dada
- Grunting

2) Sistem Kardiovaskular

- Sianosis
- Murmur jantung

3) Sistem Termoregulasi

- Risiko hipotermia
- Suhu aksila

4) Sistem Gastrointestinal

- Mekonium pertama
- Frekuensi BAB

5) Sistem Urinaria

- Waktu BAK pertama (<24 jam)

i. Pengkajian Nutrisi

- Inisiasi menyusui dini (IMD)
- Kemampuan menghisap
- Frekuensi menyusui
- Tanda dehidrasi

Keberhasilan ASI eksklusif sangat ditentukan oleh pengkajian dini ini.

j. Pengkajian Risiko Infeksi

Faktor risiko:

- Ketuban pecah >18 jam
- Ibu demam saat persalinan
- Prematuritas
- Prosedur invasif

Tanda bahaya:

- Lemas
- Tidak mau menyusui
- Demam/hipotermia
- Napas cepat

k. Pemeriksaan Penunjang (Sesuai Indikasi)

Rekomendasi skrining neonatal dari World Health Organization meliputi:

- Skrining hipotiroid kongenital
- Skrining pendengaran
- Pemeriksaan bilirubin
- Pemeriksaan gula darah

l. Aspek Psikososial dan Bonding

Pengkajian mencakup:

- Kontak kulit ke kulit

- Respons ibu terhadap bayi
- Dukungan keluarga
- Interaksi awal ibu-bayi

Bonding yang baik meningkatkan perkembangan psikososial bayi.

4. Identifikasi Masalah dan Diagnosis Neonatal

Contoh diagnosis kebidanan/neonatal:

- a. Bayi cukup bulan sesuai masa kehamilan
- b. BBLR
- c. Asfiksia sedang
- d. Risiko hipotermia
- e. Risiko infeksi

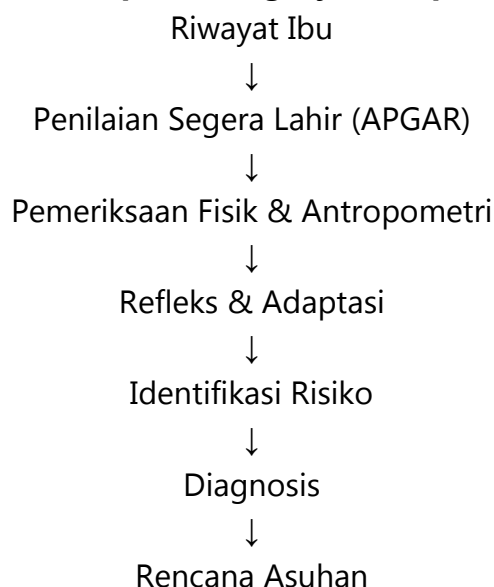
5. Integrasi Pengkajian dalam Continuum of Care

Pengkajian dilakukan:

- a. Segera setelah lahir
- b. 6–24 jam pertama
- c. Kunjungan neonatal (KN1, KN2, KN3)
- d. Masa neonatal hingga 28 hari

Pendekatan ini sesuai dengan standar pelayanan neonatal dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

6. Alur Konseptual Pengkajian Terpadu Bayi



7. Analisis Data dan Identifikasi Masalah

Data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk menentukan:

- a. Masalah aktual
- b. Masalah potensial
- c. Faktor risiko pada ibu dan bayi

Hasil analisis menjadi dasar dalam penetapan diagnosis kebidanan dan keperawatan.

8. Dokumentasi Pengkajian

Pengkajian terpadu harus didokumentasikan secara sistematis menggunakan format yang berlaku, seperti SOAP atau SOAPIE, untuk menjamin kesinambungan asuhan dan aspek legal pelayanan.

9. Penutup

Pengkajian terpadu ibu dan bayi merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pemberian asuhan kebidanan maternitas. Dengan pengkajian yang komprehensif dan terintegrasi, tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan berpusat pada ibu dan bayi.

C. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Seorang ibu, Ny. S (28 tahun), P2A0, hari ke-2 post partum, datang ke BPM bersama bayinya dengan keluhan ASI belum lancar dan bayi jarang menyusu. Hasil pengkajian awal: Ibu mengeluh payudara terasa tegang, Tanda vital dalam batas normal, TFU sesuai masa nifas, Lochea rubra normal, Bayi tampak lemah, Frekuensi menyusu 3 kali/hari dan Refleks menghisap lemah

Pertanyaan / Tugas Mahasiswa:

1. Lakukan pengkajian ibu nifas secara sistematis!
2. Lakukan pengkajian bayi baru lahir secara lengkap!
3. Identifikasi data subjektif dan objektif dari kasus di atas!
4. Analisis masalah yang terjadi pada ibu dan bayi!
5. Tentukan diagnosis kebidanan yang tepat!
6. Jelaskan rencana asuhan/intervensi yang akan diberikan!
7. Berikan edukasi yang sesuai kepada ibu!

Template Soal Osce Kebidanan

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Bayi dan Balita: Gadar
3	Kasus	Deteksi Dini Risiko Tinggi Maternal-Neonatal di Pelayanan Primer 1
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam:
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang ibu, Ny. S (28 tahun), P2A0, hari ke-2 post partum, datang ke BPM bersama bayinya dengan keluhan ASI belum lancar dan bayi jarang menyusu. Hasil pengkajian awal: Ibu mengeluh payudara terasa tegang, Tanda vital dalam batas normal, TFU sesuai masa nifas, Lochea rubra normal, Bayi tampak lemah, Frekuensi menyusu 3 kali/hari dan Refleks menghisap lemah TUGAS Lakukan pengkajian ibu nifas secara sistematis! Lakukan pengkajian bayi baru lahir secara lengkap! Identifikasi data subjektif dan objektif dari kasus di atas! Analisis masalah yang terjadi pada ibu dan bayi! Tentukan diagnosis kebidanan yang tepat! Jelaskan rencana asuhan/intervensi yang akan diberikan! Berikan edukasi yang sesuai kepada ibu!
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian.

No.	Komponen	Isi
		2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikutkan kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS KEPADA MAHASISWA 1. Penguji menyampaikan agar mahasiswa bertindak sebagai bidan yang bertugas di BPM. 2. Menyarankan kepada mahasiswa agar melakukan pengkajian secara sistematis dan terstruktur pada Ibu dan bayi. 3. Penguji menyarankan agar mahasiswa menggunakan komunikasi terapeutik selama interaksi dengan pasien. 4. Penguji menyampaikan agar mahasiswa menjelaskan setiap tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. 5. Penguji meminta mahasiswa agar fokus pada: Pengkajian ibu nifas dan Pengkajian bayi baru lahir 6. Penguji meminta kepada mahasiswa setelah pengkajian: - Sampaikan hasil temuan Anda - Tentukan diagnosis kebidanan - Berikan edukasi yang sesuai 7. Menyampaikan kepada mahasiswa tidak perlu melakukan tindakan invasif. 8. Waktu yang tersedia: 10 menit

No.	Komponen	Isi
		INSTRUKSI KHUSUS UNTUK PENGUJI Amati seluruh proses tanpa banyak intervensi. Gunakan checklist penilaian yang telah disediakan. Berikan nilai berdasarkan: Keterampilan komunikasi Ketepatan pengkajian Kemampuan analisis & diagnosis Hanya memberikan klarifikasi jika mahasiswa meminta data tambahan. Jangan memberi petunjuk atau mengarahkan jawaban. 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: Sampaikan keluhan utama: ASI belum lancar Bayi jarang menyusu. Jawab pertanyaan sesuai skenario (tidak menambah informasi sendiri). Tunjukkan ekspresi cemas ringan terkait kondisi bayi. Jika ditanya: Bayi menyusu ± 3 kali sehari Bayi tampak lemah saat menyusu
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu. PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa ibu dan bayi ibu. Apakah ibu bersedia? PS: Iya, Bu, saya silahkan. Peserta: Apa keluhan utama ibu dan bayinya bu? PS: Bayi nya tidur terus, tampak lemas dan tidak mau menyusu, payudara saya terasa tegang. Peserta: Sejak kapan tidak mau menyusu bu?

No.	Komponen	Isi
		PS: Sejak lahir belum ada menyusui Peserta : apakah saya boleh melakukan pemeriksaan kepada ibu dan bayi? PS: Boleh bu, silahkan Peserta : Saya akan mengukur suhu badan, tekanan darah, pernapasan, Nadi dan payudara Ibu, Suhu ibu sedikit naik (37,5), pernapasan 24 x/menit, Nadi : 84 kali/menit dan payudara ibu teraba keras dan tegang. Peserta: Bayi tampak lemas dan tidak mau menyusui. Catatan: Jika ada pertanyaan lain terkait riwayat penyakit, riwayat obstetri-ginekologi, sosial, spiritual, ekonomi, dan ADL, PS memberi jawaban normatif dan tidak mengarah ke diagnosis lain.
10	Kebutuhan manikin	- Ibu Nifas - Phantom bayi - Tempat tidur 1 set - Box bayi
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin - Mengganti lembar instruksi bila diperlukan - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa — 1 2. Phantom bayi— 1 3. Tensimeter — 1 4. Stetoskop — 1 5. Jam tangan/stopwatch — 1 6. Termometer — 1 7. Sarung tangan bersih — 1 pasang 8. Formulir rujukan — 1 lembar 9. Lembar jawaban peserta — 1 lembar 10. Pena — 1 11.Box bayi
13	Penulis	Elsarika Damanik, SST, M.Kes, Ph.D

No.	Komponen	Isi
14	Referensi	1. Maternal Newborn Nursing — Amy Giles, Regina Prusinski, Laura Wallace 2. Foundations of Maternal-Newborn and Women's Health Nursing (edisi terbaru) 3. Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui — Ignasensia D. Mirong, Hasri Yulianti 4. Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan Normal & Bayi Baru Lahir 5. Maternal and Infant Assessment for Breastfeeding and Human Lactation — Karin Cadwell 6. Mercer, R. T. (2004). Becoming a mother: Research on maternal identity. Springer Publishing.

D. Rubrik Penilaian dan Kelulusan

Stase 1: Pengkajian Terpadu Ibu dan Bayi: Anamnesis Terfokus, Pemeriksaan Fisik dan Validasi Data

Kompetensi 1

1. Pengkajian (Assessment)

No	Komponen yang Dinilai	Skor 0	Skor 1	Skor 2
1	Menggali keluhan utama ibu	Tidak dilakukan	Dilakukan tidak lengkap	Lengkap & sistematis
2	Riwayat menyusui (frekuensi, durasi, posisi)	Tidak digali	Sebagian	Lengkap
3	Pengkajian payudara (bendungan ASI, puting)	Tidak dilakukan	Dilakukan tidak lengkap	Lengkap & benar
4	Pengkajian kondisi bayi (refleks hisap, aktivitas)	Tidak dilakukan	Sebagian	Lengkap
5	Pemeriksaan tanda vital & status nifas	Tidak dilakukan	Sebagian	Lengkap
6	Interaksi ibu-bayi (bonding & attachment)	Tidak dinilai	Dinilai sebagian	Dinilai lengkap

Skor maksimal: 12

Kompetensi 2

2. Analisis/Diagnosa – Bobot 20%

No	Komponen	Skor 0	Skor 1	Skor 2
1	Mengidentifikasi masalah ibu (bendungan ASI)	Salah	Kurang tepat	Tepat
2	Mengidentifikasi masalah bayi (refleks lemah, kurang menyusui)	Salah	Kurang tepat	Tepat
3	Menyimpulkan hubungan ibu-bayi	Tidak ada	Kurang jelas	Tepat & logis

Skor maksimal: 6

Kompetensi 3

3. Penatalaksanaan (Management) – Bobot 30%

No	Komponen	Skor 0	Skor 1	Skor 2
1	Edukasi teknik menyusui yang benar	Tidak dilakukan	Kurang tepat	Tepat & jelas
2	Anjuran frekuensi menyusui (on demand)	Tidak	Sebagian	Tepat
3	Penanganan bendungan ASI (kompres, pijat)	Tidak	Sebagian	Tepat
4	Stimulasi refleks hisap bayi	Tidak	Sebagian	Tepat
5	Dukungan ASI eksklusif	Tidak	Kurang	Tepat
6	Rencana tindak lanjut/rujukan	Tidak	Kurang jelas	Jelas

Skor maksimal: 12

Kompetensi 4

4. Komunikasi & Edukasi – Bobot 10%

No	Komponen	Skor 0	Skor 1	Skor 2
1	Komunikasi efektif & empati	Tidak	Kurang	Baik
2	Bahasa mudah dipahami	Tidak	Kurang	Jelas
3	Memberi kesempatan bertanya	Tidak	Ya, terbatas	Ya, aktif

Skor maksimal: 6

Kompetensi 5

5. Profesionalisme & Keselamatan – Bobot 10%

No	Komponen	Skor 0	Skor 1	Skor 2
1	Cuci tangan & prinsip pencegahan infeksi	Tidak	Kurang	Sesuai SOP
2	Sikap profesional	Tidak	Kurang	Baik
3	Menjaga privasi pasien	Tidak	Kurang	Baik

Skor maksimal: 6

Rekap Penilaian

Komponen	Skor Maks	Skor Diperoleh
Pengkajian	12	
Analisis	6	
Penatalaksanaan	12	
Komunikasi	6	
Profesionalisme	6	
TOTAL	42	

KATEGORI NILAI

- **≥ 85% (36–42)** = Kompeten
- **70–84% (29–35)** = Cukup kompeten
- **< 70% (<29)** = Belum kompeten

E. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

**Tabel Portofolio pada Pengkajian Terpadu Ibu dan Bayi: Anamnesis
Terfokus, Pemeriksaan Fisik dan Validasi Data**

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pengkajian Terpadu Ibu dan Bayi: Anamnesis Terfokus, Pemeriksaan Fisik dan Validasi Data
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada topik kegawatdaruratan maternal dan neonatal, mahasiswa mampu melakukan pengkajian terhadap ibu yang mengalami bendungan ASI dan bayi yang lemah karena tidak dapat menyusu.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah menangani ibu nifas, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan interpretasi profession, pengenalan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, tindakan awal pra-rujukan. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan penilaian ibu nifas dengan bendungan ASI, bayi tidak dapat menyusu dan memberikan tindakan penanganan awal.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus pada ibu nifas dengan Seorang ibu, Ny. S (28 tahun), P2A0, hari ke-2 post partum payudara terasa tegang, Tanda vital dalam batas normal, TFU sesuai masa nifas, Lochea rubra normal, Bayi tampak lemah, Frekuensi menyusu 3 kali/hari dan Refleks menghisap lemah.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pengkajian Terpadu Ibu dan Bayi: Anamnesis Terfokus, Pemeriksaan Fisik dan Validasi Data
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya tidak menunda pengenalan ibu nifas dengan bendungan Asi dan bayi tidak dapat menyusu dengan baik.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam mengenali ibu nifas dengan bendungan ASI dan bayi malas menyusu, hisapan lemah.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus ibu nifas dengan bendungan ASI, dan menilai bayi malas dan tidak mau menyusu. tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu menilai bendungan ASI, mendiagnosa, dan melakukan tindakan awal secara aman.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu menggunakan profesi mengenali tanda bahaya, dan mengambil keputusan awal yang tepat pada masa nifas dan bayi.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada topik bendungan ASI dan bayi tidak dapat menyusu menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik kebidanan nyata.

**Tabel Case Report pada Pengkajian Terpadu Ibu dan Bayi: Anamnesis
Terfokus, Pemeriksaan Fisik dan Validasi Data**

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pengkajian Terpadu Ibu dan Bayi: Anamnesis Terfokus, Pemeriksaan Fisik dan Validasi Data
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang ibu nifas dan bayi dengan resiko tinggi.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data ibu dan bayi, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan awal yang diberikan, proses rujukan, dan perkembangan kondisi ibu serta bayi setelah intervensi awal.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ini, mahasiswa menuliskan Seorang ibu, Ny. S (28 tahun), P2A0, hari ke-2 post partum, keluhan ASI belum lancar dan bayi jarang menyusu. Hasil pengkajian awal: Ibu mengeluh payudara terasa tegang, Tanda vital dalam batas normal, TFU sesuai masa nifas, Lochea rubra normal, Bayi tampak lemah, Frekuensi menyusu 3 kali/hari dan Refleks menghisap lemah
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu mengkaji dan menegakkan diagnose pada ibu dan bayi pada kasus di atas, serta memberikan penanganan awal atau melakukan rujukan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pengkajian Terpadu Ibu dan Bayi: Anamnesis Terfokus, Pemeriksaan Fisik dan Validasi Data
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus partus lama, mahasiswa belajar bahwa profesi, pemantauan ibu-bayi, dan keputusan dalam memberikan penanganan awal atau rujukan.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep resiko tinggi maternal-neonatal, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan secara utuh.

**Tabel Refleksi Patient Safety pada Pengkajian Terpadu Ibu dan Bayi:
Anamnesis Terfokus, Pemeriksaan Fisik dan Validasi Data**

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pengkajian Terpadu Ibu dan Bayi: Anamnesis Terfokus, Pemeriksaan Fisik dan Validasi Data
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus Deteksi Dini Risiko Tinggi Maternal-Neonatal di Pelayanan Primer 1 mahasiswa merefleksikan bahwa keterlambatan mengenali tanda bahaya pada maternal dan neonatal dapat menyebabkan perburukan kondisi ibu dan bayi.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti salah membaca, tidak memantau tanda vital atau kemajuan pada masa nifas dan neonates berdampak

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pengkajian Terpadu Ibu dan Bayi: Anamnesis Terfokus, Pemeriksaan Fisik dan Validasi Data
	dari setiap tindakan kebidanan.	besar pada keselamatan ibu dan bayi.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah bendungan ASI yang berpotensi menuju mastitis pada ibu dan bayi tidak menyusui dengan baik dapat mengakibatkan icterus pada neonates.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain bendungan ASI dan neonatus tidak mau menyusui, isapan lemah, keterlambatan
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya penggunaan profesi secara konsisten, pemantauan tanda vital dan keadaan umum pada ibu dan neonatus dan bayi, penilaian 3P, stabilisasi awal ibu, komunikasi cepat kepada keluarga, dan rujukan tepat waktu ke fasilitas yang lebih mampu.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa ibu nifas dan neonatus dengan risiko tinggi pada pengkajian, diagnosis, pengambilan keputusan cepat, dan keberanian melakukan eskalasi adalah bagian penting dari praktik bidan yang aman.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pengkajian Terpadu Ibu dan Bayi: Anamnesis Terfokus, Pemeriksaan Fisik dan Validasi Data
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik kebidanan secara berkelanjutan.

F. Tabel Red Flags & Eskalasi

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Payudara sangat nyeri, tegang, dan tidak membaik	Curiga mastitis atau abses payudara	• Nilai cepat kondisi ibu, tangani sesuai prioritas, rujuk segera, kenali gejala mastitis • Mastitis (demam + payudara merah nyeri) Rujuk jika tidak membaik 24–48 jam • Abses payudara Rujuk segera untuk drainase
Demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$	Kenali gejala mastitis, abses payudara	• Mastitis, Abses payudara Rujuk segera untuk dilakukan drainase
Menggigil, lemas (tanda infeksi sistemik)	Kenali gejala mastitis, abses payudara	Rujuk jika tidak membaik 24–48 jam
ASI tidak keluar sama sekali	• Dehidrasi sedang–berat • Hipoglikemia (bayi sangat lemah)	Lanjutkan menyusui / perah ASI

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Payudara sangat nyeri, tegang, dan tidak membaik	Curiga mastitis atau abses payudara	• Nilai cepat kondisi ibu, tangani sesuai prioritas, rujuk segera, kenali gejala mastitis • Mastitis (demam + payudara merah nyeri) Rujuk jika tidak membaik 24–48 jam • Abses payudara Rujuk segera untuk drainase
Riwayat menyusui tidak efektif / bayi jarang menyusu	• Ikterus patologis • Rujuk segera • Stabilkan suhu (kangaroo mother care) • Evaluasi kebutuhan cairan/ASI perah	• Rujuk segera • Stabilkan suhu (kangaroo mother care) • Evaluasi kebutuhan cairan/ASI perah

Form Checklist “Saya sudah bisa...”

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan Pengkajian Terpadu pada Ibu nifas	☐	☐	
2	Saya sudah bisa melakukan anamnesis terfokus pada ibu nifas	☐	☐	
3	Saya sudah bisa melakukan pemeriksaan fisik pada ibu nifas secara sistematis dan aman.	☐	☐	
4	Saya sudah bisa mengenali gejala patologi pada ibu nifas	☐	☐	
5	Saya sudah bisa memvalidasi data pada ibu nifas	☐	☐	
6	Saya sudah bisa melakukan pertolongan pertama pada ibu nifas dengan patologi.	☐	☐	
7	Saya sudah bisa melakukan rujukan pada ibu nifas dengan patologi			
8	Saya sudah bisa menjelaskan Pengkajian Terpadu pada bayi	☐	☐	
9	Saya sudah bisa melakukan anamnesis terfokus pada bayi	☐	☐	
10	Saya sudah bisa melakukan pemeriksaan fisik pada bayi secara sistematis dan aman.	☐	☐	
11	Saya sudah bisa memvalidasi data pada bayi	☐	☐	
12	Saya sudah bisa mengenali gejala patologi pada bayi	☐	☐	
13	Saya sudah bisa melakukan pertolongan pertama pada bayi dengan patologi.	☐	☐	
14	Saya sudah bisa melakukan rujukan pada bayi	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

G. Rangkuman Materi

Pengkajian terpadu ibu dan bayi merupakan proses penting dalam asuhan kebidanan yang dilakukan secara menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan untuk memperoleh gambaran kondisi kesehatan ibu dan bayi secara utuh. Inti dari pengkajian ini meliputi tiga komponen utama: Anamnesis terfokus Digunakan untuk menggali informasi spesifik sesuai keluhan ibu dan kondisi bayi, sehingga membantu mengarahkan pemeriksaan dan identifikasi masalah secara lebih cepat dan tepat. Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis (*head to toe*) untuk memperoleh data objektif mengenai kondisi ibu dan bayi, serta mendeteksi tanda-tanda normal maupun penyimpangan sejak dini. Validasi data Merupakan tahap memastikan bahwa seluruh data yang dikumpulkan akurat, konsisten, dan relevan melalui cross check, observasi ulang, dan konfirmasi dengan sumber lain. Ketiga komponen ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hasil pengkajian harus dianalisis secara terintegrasi antara ibu dan bayi, karena kondisi keduanya saling memengaruhi, terutama dalam masa nifas dan neonatal (misalnya dalam proses menyusui). Dengan demikian, pengkajian terpadu menjadi dasar utama dalam: menetapkan diagnosis/masalah kebidanan, menyusun rencana asuhan yang tepat, mencegah komplikasi dan meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan ibu serta bayi. Pengkajian yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan asuhan kebidanan yang tepat, aman, dan berkualitas.

H. Daftar Pustaka

- Maternal Newborn Nursing — Amy Giles, Regina Prusinski, Laura Wallace
- Foundations of Maternal-Newborn and Women's Health Nursing (edisi terbaru)
- Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui — Ignasensia D. Mirong, Hasri Yulianti
- Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan Normal & Bayi Baru Lahir
- Maternal and Infant Assessment for Breastfeeding and Human Lactation — Karin Cadwell
- Mercer, R. T. (2004). *Becoming a mother: Research on maternal identity*. Springer Publishing.
- Roy, C. (2009). *The Roy adaptation model* (3rd ed.). Pearson.
- Varney, H., Kriebs, J. M., & Gegor, C. L. (2015). *Varney's midwifery* (5th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- World Health Organization. (2013). *WHO recommendations on postnatal care of the mother and newborn*. WHO Press.
- World Health Organization. *WHO Recommendations on Antenatal Care for a Positive Pregnancy Experience*.
- World Health Organization. *Postnatal Care of the Mother and Newborn*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak*.
- Varney, H. *Varney's Midwifery*.
- Lowdermilk, Perry & Cashion. *Maternity and Women's Health Care*.
- World Health Organization. *WHO Recommendations on Antenatal Care for a Positive Pregnancy Experience*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak*.
- Varney, H. *Varney's Midwifery*.
- Lowdermilk, Perry & Cashion. *Maternity and Women's Health Care*.

BAB 3

SKRINING RISIKO KEHAMILAN: FAKTOR RISIKO, SKOR RISIKO, DAN PENENTUAN RENCANA ASUHAN

Capaian Pembelajaran

Daftar CPL (Program Learning Outcomes)

Kode	CPL (capaian Pembelajaranana Lulusan)
CPL 1	Menunjukkan profesionalisme, etika–legal, dan Respectful Maternity Care (RMC) dalam pelayanan kebidanan.
CPL 3	Menerapkan keselamatan ibu–janin, PPI, serta K3 dalam pelayanan kebidanan.
CPL 5	Melakukan keterampilan inti ANC sesuai SOP secara aman dan bermutu.
CPL 6	Melaksanakan KIE/promosi kesehatan kehamilan & kesiapsiagaan komplikasi.

CPMK (Course Learning Outcomes)

- CPMK-3 Keselamatan ibu–janin, PPI, dan K3 dalam pelayanan ANC
- CPMK-7 Perilaku profesional: RMC, empati, tanggung jawab, kolaborasi, refleksi

A. Pengertian Skrining Resiko Kehamilan

Skrining resiko kehamilan merupakan proses penilaian awal yang dilakukan secara sistematis oleh bidan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kondisi atau faktor yang dapat meningkatkan resiko komplikasi pada ibu maupun janin selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas.

Skrining dilakukan sedini mungkin pada kunjungan antenatal (ANC) pertama dan dilanjutkan secara berkala selama kehamilan yaitu minimal 6 kali kunjungan yang dirincikan dalam trimester 1 2 kali, trimester 2 1 kali dan trimester 3 3 kali. Melalui skrining ini, tenaga kesehatan terutama bidan dapat menentukan tingkat resiko kehamilan sehingga dapat merencanakan asuhan yang tepat, termasuk pemantauan, intervensi, maupun rujukan apabila diperlukan.

B. Faktor Resiko Kehamilan

Faktor resiko kehamilan adalah kondisi atau karakteristik tertentu pada ibu yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi selama kehamilan, persalinan, maupun masa nifas.

Identifikasi faktor resiko merupakan langkah awal dalam skrining resiko kehamilan. Faktor resiko dapat berasal dari kondisi ibu sebelum hamil, selama kehamilan, maupun dari riwayat obstetri sebelumnya.

Secara umum faktor resiko kehamilan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori berikut:

1. Faktor resiko berdasarkan karakteristik Ibu

Beberapa karakteristik ibu yang dapat meningkatkan risiko kehamilan antara lain:

- a) Usia ibu kurang dari 20 tahun
- b) Usia ibu lebih dari 35 tahun
- c) Paritas tinggi (melahirkan lebih dari tiga atau empat kali)
- d) Jarak kehamilan terlalu dekat (<2 tahun)

2. Faktor resiko berdasarkan riwayat Obstetri

Riwayat kehamilan dan persalinan sebelumnya dapat menjadi indikator penting dalam menilai risiko kehamilan saat ini, seperti:

- a) Riwayat abortus berulang
- b) Riwayat persalinan prematur
- c) Riwayat bayi lahir dengan berat badan lahir rendah
- d) Riwayat preeklamsia atau eklamsia

- e) Riwayat persalinan dengan tindakan operasi sesar
- 3. Faktor resiko berdasarkan kondisi Kesehatan ibu
Kondisi kesehatan ibu sebelum atau selama kehamilan juga dapat memengaruhi jalannya kehamilan, misalnya:
 - a) Anemia
 - b) Hipertensi
 - c) Diabetes melitus
 - d) Penyakit jantung
 - e) Infeksi tertentu
- 4. Faktor resiko social dan lingkungan
Selain faktor medis, kondisi sosial dan lingkungan juga dapat memengaruhi kesehatan ibu hamil, seperti:
 - a) Status gizi yang kurang
 - b) Akses terhadap pelayanan kesehatan yang terbatas
 - c) Dukungan keluarga yang kurang
 - d) Kondisi sosial ekonomi rendah

Penelitian-penelitian yang mendeteksi adanya faktor resiko kehamilan yang dapat mempengaruhi Kesehatan ibu hamil dan Janinnya yaitu antara lain:

1. Setiawati 2026, pada jurnal Oksitosin yang berjudul "Correlation of Stunting Determinants Among Children Under Five". Menjelaskan dengan Faktor-faktor resiko kehamilan yang mempengaruhi Kesehatan balita (Kejadian stunting pada balita). Dari hasil penelitian faktor resiko kehamilan yang mempunyai pengaruh Adalah Riwayat Anemia pada ibu hamil, Riwayat KEK (Kekurangan energi Kronis) pada ibu hamil sedangkan faktor resiko pada bayi Adalah Jenis kelami, Riwayat BBLR dan Status Gizi balita
2. Setiawati 2026, pada jurnal Keperawatan Soedirman yang berjudul "Early Detection of Maternal Risk Factors for Stunting in Infants". Menjelaskan Faktor resiko ibu hamil yang mempengaruhi Kesehatan balita (kejadian Stunting pada balita) menggunakan Kartu Skor Dhiana Setyorini (deteksi dini keracunan kehamilan dan preeklamsia) dan Kartu Skor Deteksi dini Resiko BBLR dan hasilnya menunjukkan paritas, riwayat anemia saat kehamilan, riwayat preeklamsi saat kehamilan mempunyai pengaruh terhadap kejadian stunting pada balita.
3. Setiawati, 2024, pada jurnal Faletahan yang berjudul "Relationship Between History of Anemia and Chronic Energy Deficiency (CED) in Pregnant Women with Stunting Incidence". Menjelaskan bahwa ada korelasi antara riwayat kurang energi kronis (KEK) dengan terjadinya stunting, namun untuk riwayat anemia pada kehamilan tidak berhubungan dengan kejadian stunting.

4. Zainiyah, 2020. Melakukan pengabdian Masyarakat dengan melakukan deteksi dini pada ibu hamil menggunakan KSPR (Kartu Skor pudji Rochyati).

FAKTOR RESIKO & RESIKO TINGGI PADA IBU HAMIL

FAKTOR RESIKO

Kel. FR. I Ada Potensi Risiko / Potensi Gawat
(Yang Perlu di Waspadai)

1. Tertalu muda, hamil pertama umur 16 th atau kurang PRIMI MUDA Skor : 4	2a. Tertalu lambat hamil setelah kawin 4 tahun lebih PRIMI TUA Skor : 4	2b. Tertalu tua, hamil pertama umur 35 th ke atas PRIMI TUA Skor : 4
3. Tertalu cepat punya anak lagi, terkecil < 2th ANAK TERKECIL < 2 TH Skor : 4	4. Tertalu lama punya anak lagi, terkecil 10 th lebih PRIMI TUA SEKUNDER Skor : 4	5. Tertalu banyak punya anak, 4 atau lebih GRANDE MULTI Skor : 4
6. Tertalu tua, hamil umur 35 th atau lebih UMUR 35 TH / LEBIH Skor : 4	7. Tertalu pendek - Hasil Potensi Hamil Kadu atau lebih belum pernah melahirkan normal, cukup besar tidak TINGGI BADAN 145 CM ATAU KURANG Skor : 4	8. Pernah gagal kehamilan Hamil Ke-II yang I Gagal Hamil Ke-III atau lebih gagal 2 kali / berakhir mati RIWAYAT OBSTETRIK JELEK Skor : 4
9a. Pernah melahirkan dengan tarikan tang / vakum Skor : 4	9b. Pernah melahirkan dengan - Uti dihogip / Uti Manu / - Perdarahan PP & beri infus Skor : 4	10. Pernah melahirkan bayi dengan operasi sesar sebelumnya Skor : 4

IBU RESIKO TINGGI

Kel. FR. II Ada Risiko / Ada Gawat / ada Tanda Bahaya

11a. ANEMIA Pucat, lemas badan, letas lelah, lesu Skor : 4	11b. MALARIA Panas tinggi menggigil, letas keringat, sakit kepala, muntah-muntah Skor : 4	11c. TUBERKULOSA PARU Batuk lama tidak sembuh-sembuh, batuk darah, badan lemas, kurus Skor : 4
12. KERACUNAN KEHAMILAN PRE EKLAMPSIA Bengkak pada muka, dan tungkai terutama daerah tungkai, albumin terdapat dalam air seni Skor : 4	13. HAMIL KEMBAR Pertumbuhan sangat membesar gerakan anak terasa di banyak tempat Skor : 4	14. HYDRAMNION / KEMBAR AIR Pertumbuhan sangat membesar gerakan dari anak tidak terbagi sama Skor : 4
15. JANIN MATI DALAM KANDUNGAN Ibu hamil tidak merasakan gerakan anak lagi Skor : 4	16. HAMIL LEBIH BULAN (POST DATE / SEROTNUS) Ibu hamil 9 bulan lebih 2 minggu belum melahirkan Skor : 4	17. LETAK Sungsang Skor : 8
		18. LETAK Lintang Skor : 8

Kel. FR. III : Ada Gawat Darurat

19. PERDARAHAN Mengeluarkan darah pada waktu hamil ini Skor : 8	20. EKLAMPSIA Terdapat kejang-kejang pada hamil 7 bulan lebih pada ibu dengan keracunan kehamilan Skor : 8
---	--

PERIKSA KEHAMILAN ANDA SEDINI MUNGKIN

Gambar 3.1: Faktor resiko dan Resiko tinggi pada kehamilan

C. Alat yang digunakan untuk penentuan Skor Resiko kehamilan

1. Kartu Skor Poedji Rochyati (KSPR)

SKRINING / DETEKSI DINI IBU RISIKO TINGGI

Nama : Alamat :

Umur Ibu : Kec/Kab :

Pendidikan : Pekerjaan :

Hamil Ke Haid Terakhir Tgl. Perkiraan Persalinan Tgl.

Periksa I

Umur Kehamilan : bln Di :

KEL	NO.	Masalah/Faktor Risiko	SKOR	Tribulan			
				I	II	III.1	III.2
		Skor awal ibu hamil	2				
I	1	Terlalu muda, hamil ≤ 16 th	4				
	2	Terlalu tua, hamil ≥ 35 th	4				
		Terlalu lambat hamil I, kawin ≥ 4 th	4				
	3	Terlalu lama, hamil lagi (≥ 10 th)	4				
	4	Terlalu cepat hamil lagi (< 2 th)	4				
	5	Terlalu banyak anak, 4 / lebih	4				
	6	Terlalu tua, umur ≥ 35 th	4				
	7	Terlalu pendek ≤ 145 cm	4				
	8	Pernah gagal kehamilan	4				
	9	Pernah melahirkan dengan :					
	a. Tarikan tang / vakum	4					
	b. Uri dirogo	4					
	c. Diberi infus / Transfusi	4					
	10	Pernah Operasi Sesar	8				
II	11	Penyakit pada ibu hamil :					
		a. Kurang Darah b. Malaria	4				
		c. TBC Paru d. Payah Jantung	4				
		e. Kencing Manis (Diabetes)	4				
		f. Penyakit Menular Seksual	4				
	12	Bengkak pada muka/tungkai dan tekanan darah tinggi	4				
	13	Hamil kembar 2 atau lebih	4				
	14	Hamil kembar air (Hydramnion)	4				
	15	Bayi mati dalam kandungan	4				
	16	Kehamilan lebih bulan	4				
	17	Letak sungsang	8				
	18	Letak lintang	8				
	19	Perdarahan dalam kehamilan ini	8				
	20	Preeklampsia Berat / Kejang-2	8				
JUMLAH SKOR							

PENYULUHAN KEHAMILAN/PERSALINAN AMAN – RUJUKAN TERENCANA

KEHAMILAN			KEHAMILAN DENGAN RISIKO				
JML SKOR	JML SKOR	PERAWA TAN	RUJUKAN	TEMPAT	PENOLONG	RUJUKAN	
						RDB	RTW
2	KRH	BIDAN	TIDAK DIRUJUK	TIDAK DIRUJUK	BIDAN		
6 – 10	KRT	BIDAN DOKTER	BIDAN PKM	POLINDES PKM / RS	BIDAN DOKTER		
≥ 12	KRST	DOKTER	RUMAH SAKIT	RUMAH SAKIT	DOKTER		

KARTU SKOR 'POEDJI ROCHJATI' PERENCANAAN PERSALINAN AMAN

Persalinan Melahirkan tanggal :/...../.....

RUJUK DARI : 1. Sendiri 2. Dukun 3. Bidan 4. Puskesmas

RUJUK KE : 1. Bidan 2. Puskesmas 3. RS

RUJUKAN : 1. Rujukan Dini Berencana (RDB) 2. Rujukan Tepat Waktu (RTW)

Gawat Obstetrik :
Kel. Faktor Resiko I & II

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Gawat Obstetrik :
Kel. Faktor Resiko I & II

1. Perdarahan antepartum

Komplikasi Obstetrik

3. Perdarahan postpartum

4. Uri tertinggal

5. Persalinan Lama

TEMPAT :

1. Rumah Ibu

2. Rumah Bidan

3. Polindes

4. Puskesmas

5. Rumah Sakit

6. Perjalanan

PENOLONG :

1. Dukun

2. Bidan

3. Dokter

4. Lain-lain

MACAM PERSALINAN

1. Normal

2. Tindakan Pervaginam

3. Operasi Sesar

PASCA PERSALINAN :

IBU :

1. Hidup

2. Mati, dengan penyebab

a. Perdarahan b. Preeklampsia/Eklampsia

c. Partus Lama d. Infeksi e. Lain-2....

TEMPAT KEMATIAN IBU

1. Rumah Ibu

2. Rumah Bidan

3. Polindes

4. Puskesmas

5. Rumah Sakit

6. Perjalanan

BAYI :

1. Berat lahir : gram, Laki-2 / Perempuan

2. Lahir hidup : APGAR Skor

3. Lahir mati, penyebab

4. Mati kemudian, umur hr, penyebab

5. Kelainan bawaan : tidak ada / ada

KEADAAN IBU SELAMA MASA NIFAS (42 Hari Pasca Salin)

1. Sehat 2. Sakit 3. Mati, penyebab

Keluarga Berencana 1. Ya/Sterilisasi

Kategori Keluarga Miskin 1. Ya 2. Tidak

Gambar 3.2: Kartu skor Poedji Rochyati

2. Kartu Skor Dhiana Setyorini (KSDS)

KARTU SKOR DHIANA SETYORINI (DETEKSI DINI RISIKO KERACUNAN KEHAMILAN/ PREEKLAMPSI)						
Nama :						
NIK :						
No reg :						
Nakes/Kader :						
Dx :						
No	Tanggal pemeriksaan					
	Faktor risiko		Skor			
1	Penghasilan < UMR	1				
2	Hamil lebih dari 1 kali	1				
3	Ada Keturunan Keracunan Kehamilan	2				
4	Usia < 20 th atau > 35 th	2				
5	Ada Riwayat tekanan darah tinggi	5				
6	Gemuk (IMT > 25)	6				
7	Ada Riwayat Keracunan Kehamilan	8				
8	Ada Riwayat kencing manis (DM)	8				
TOTAL SKOR						
KATEGORI: Risiko rendah						
Risiko Tinggi						
KET: Risiko Rendah		Skor: < 8				
Risiko Tinggi		Skor: ≥ 8				
REKOMENDASI/SARAN:						
1. Risiko Rendah		: Perawatan di faskes tk I dan KIE				
2. Risiko Tinggi		: Rujuk ke faskes tk II dan KIE				

Gambar 3.3: Kartu Skor Dhiana Setyorini

D. Skor Resiko Kehamilan

Skor resiko merupakan metode kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat resiko kehamilan berdasarkan jumlah dan jenis faktor resiko yang dimiliki oleh ibu hamil.

Setiap faktor resiko diberikan nilai skor tertentu. Total skor yang diperoleh kemudian digunakan untuk mengelompokkan ibu hamil ke dalam kategori resiko tertentu. Pendekatan ini membantu tenaga kesehatan dalam menentukan tingkat kewaspadaan serta kebutuhan pelayanan yang sesuai.

Dalam praktik pelayanan kebidanan di Indonesia, salah satu sistem penilaian risiko yang sering digunakan adalah sistem skor yang diterapkan pada kartu skrining resiko kehamilan.

Secara umum klasifikasi tingkat resiko kehamilan berdasarkan skor dapat dibagi menjadi:

1. Kehamilan resiko rendah

Kehamilan resiko rendah adalah kehamilan tanpa faktor resiko atau dengan skor yang sangat minimal. Ibu hamil dalam kategori ini dapat menjalani pemeriksaan antenatal secara rutin sesuai standar pelayanan.

2. Kehamilan resiko tinggi

Kehamilan resiko tinggi terjadi apabila ibu memiliki satu atau lebih faktor resiko yang berpotensi menyebabkan komplikasi. Kondisi ini memerlukan pemantauan yang lebih intensif oleh tenaga kesehatan.

3. Kehamilan resiko sangat tinggi

Kehamilan resiko sangat tinggi menunjukkan adanya beberapa faktor resiko serius yang dapat mengancam keselamatan ibu dan janin. Pada kondisi ini biasanya diperlukan pengawasan ketat serta kemungkinan rujukan ke fasilitas kesehatan yang memiliki kemampuan penanganan obstetri yang lebih lengkap.

E. Penentuan Rencana Asuhan

Setelah dilakukan identifikasi faktor resiko dan penilaian skor resiko, langkah berikutnya adalah menentukan rencana asuhan yang sesuai dengan tingkat resiko kehamilan.

Rencana asuhan merupakan perencanaan tindakan yang bertujuan untuk mencegah atau meminimalkan komplikasi yang mungkin terjadi selama kehamilan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penentuan rencana asuhan meliputi:

1. Pemantauan kehamilan

Ibu hamil perlu mendapatkan pemeriksaan antenatal secara berkala untuk memantau kondisi kesehatan ibu dan perkembangan janin

2. Edukasi dan konseling

Tenaga kesehatan memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai:

- a. Tanda bahaya kehamilan
- b. Pentingnya kunjungan antenatal
- c. Pola makan dan gaya hidup sehat selama kehamilan.

Penatalaksanaan faktor resiko

Apabila ditemukan faktor resiko tertentu, maka dilakukan intervensi yang sesuai, seperti:

- a. Pemberian suplemen zat besi pada anemia
 - b. Pengawasan tekanan darah pada hipertensi
 - c. Pengaturan diet pada diabetes dalam kehamilan.
3. Perencanaan persalinan dan rujukan
- Pada ibu dengan resiko tinggi, perlu dilakukan perencanaan persalinan di fasilitas kesehatan yang memiliki kemampuan penanganan komplikasi serta sistem rujukan yang jelas.

F. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Identifikasi Skrining resiko kehamilan

Contoh kasus:

Seorang Perempuan berusia 37 tahun G4P30003 usia kehamilan 28 minggu datang ke Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kehamilan ditemani oleh suaminya. Hasil Anamnesis: mengaku baru melakukan pemeriksaan kehamilan sebanyak dua kali selama kehamilan ini , sedang hamil anak keempat, Jarak kehamilan dengan anak sebelumnya adalah 1 tahun 6 bulan, riwayat kehamilan sebelumnya pernah mengalami tekanan darah tinggi menjelang persalinan, tinggal di daerah pedesaan dengan jarak sekitar 15 km dari fasilitas kesehatan rujukan. Hasil pemeriksaan K/U baik, Kesadaran composmentis, Tekanan darah 100/70 mmHg, pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar hemoglobin ibu sebesar 9,5 g/dL.

Pertanyaan Diskusi:

1. Apa saja yang menjadi faktor resiko pada kasus tersebut?
2. Berapa skor yang dimiliki pada kasus tersebut?
3. Apa rencana asuhan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan skor kasus tersebut?

G. Aktivitas 2 — Shows How

Simulasi/skill lab Skrining resiko kehamilan

Fokus urutan Skrining + Tindakan + Komunikasi

Template Soal Osce Kebidanan

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	2
2	Judul	Kehamilan. Normal
3	Kasus	Skrining resiko pada ibu hamil
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam:
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Pendokumentasian 8. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang Perempuan berusia 40 tahun G3P20002 usia kehamilan 38 minggu datang ke Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kehamilan ditemani oleh mertuanya. Hasil Anamnesis: mengaku baru melakukan pemeriksaan kehamilan sebanyak tiga kali selama kehamilan ini. Hasil pemeriksaan K/U baik, Kesadaran composmentis, BB : 60 kg, TB : 150 cm, Tekanan darah 120/80 mmHg, pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar hemoglobin ibu sebesar 11 g/dL. TUGAS 1. Lakukan Anamnesis sesuai KSPR tersebut. 2. Lakukan total skor KSPR pada kasus 3. Lakukan analisis total skor KSPR pada kasus 4. Berikan KIE singkat kepada ibu/keluarga dan jelaskan rencana asuhan selanjutnya.
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut:

No.	Komponen	Isi
		a. Ujian institusi-2digit jika peserta berjumlah 01–99-3digit jika peserta berjumlah 100–999-4digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4digit terakhir bila nomor mengikuti kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 2. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah penilaian yang sesuai. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 1. PS berperan sebagai ibu hamil trimester 3 2. PS memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang disusun, jika tidak ada. Maka PS menjawab “tidak ada data”
9	Dialog PS	Peserta : Selamat pagi/siang ibu PS : selamat pagi/siang bu Peserta : saya dengan ibu bidan akan melakukan anamnesis. Apakah ibu berkenan? PS : iya bu, saya bersedia Peserta : hamil pertama saat usia berapa? PS : 36 tahun Peserta : berapa lama menunggu saat hamil pertama? PS : 3 bulan Peserta: Jarak antar anak berapa tahun bu?

No.	Komponen	Isi
		PS : 2 tahun Peserta : Apakah Ibu pernah mengalami keguguran? PS : tidak pernah Peserta : apakah ibu pernah Riwayat persalinan dengan SC? PS : iya Peserta : Apakah ibu ada Riwayat anemia, kencing manis, penyakit jantung? PS : tidak ada Peserta : apakah ibu ada Riwayat kehamilan kembar PS : tidak ada Peserta : apakah ibu hamil kembar air? PS : Tidak Peserta : Apakah ibu pernah mengalami bayi mati dalam kandungan? PS : tidak Peserta : apakah ibu pernah hamil lewat bulan? PS : tidak Peserta : Apakah ibu pernah hamil dengan letak sungsang/ lintang? PS : Tidak Peserta : Apakah ibu pernah mengalami perdarahan selama kehamilan ini? PS : Tidak Peserta : Apakah ibu pernah mengalami kejang? PS : Tidak Peserta : baik terima kasih untuk jawabannya ibu PS : sama-sama ibu
10	Kebutuhan manikin	- Lembar KSPR
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Mengganti lembar KSPR/lembar instruksi bila diperlukan - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	Tidak ada
13	Penulis	Iin Setiawati, S.Keb., Bd., M.Kes
14	Referensi	1. Hastuti, p., suparmi, s., sumiyati, s., widiastuti, a., & yuliani, d. R. (2018). Kartu skor poedji rochjati untuk skrining antenatal. Link, 14(2), 110–113. https://doi.org/10.31983/link.v14i2.3710.

No.	Komponen	Isi
		2. Kemenkes ri. (2021). Buku saku merencanakan kehamilan sehat. kementrian kesehatan RI.
		3. Rochjati, P. (2011). <i>Skrining Antenatal pada Ibu Hamil Edisi 2</i> (Referensi Utama Skor Poedji Rochjati)

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE Asuhan kehamilan normal

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

- 1 Menentukan Skor Tepat
- 2 Menjumlahkan Skor KSPR benar
- 3 Analisis Skor KSPR
- 4 Rencana asuhan kebidanan tepat

H. Rubrik Penilaian Dan Kelulusan

Stase 2: Kehamilan, Normal

KOMPETENSI 1. Anamnesis

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Terlalu muda hamil I $\leq$ 16 Tahun		
2. Terlalu tua hamil I $\geq$ 35 Tahun		
3. Terlalu lambat hamil I kawin $\geq$ 4 Tahun		
4. Terlalu lama hamil lagi $\geq$ 10 Tahun		
5. Terlalu cepat hamil lagi $\leq$ 2 Tahun		
6. Terlalu banyak anak, 4 atau lebih		
7. Terlalu tua umur $\geq$ 35 Tahun		
8. Terlalu pendek $\leq$ 145 cm		
9. Pernah gagal kehamilan		
Pernah melahirkan dengan		
10. a. tarikan tang/vakum		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
b. uri dorogoh		
c. diberi infus/transfuse		
11.Pernah operasi sesar*		
Penyakit pada ibu hamil a. Kurang darah b. Malaria		
c. TBC Paru d. Payah Jantung		
e. Kencing Manis (Diabetes)		
f. Penyakit Menular Seksual		
12.Bengkak pada muka/ tungkai dan tekanan darah tinggi		
13.Hamil kembar		
14.Hydramion		
15 Bayi mati dalam kandunga		
16.Kehamilan lebih bulan		
17.Letak sungsang*		
18.Letak lintang*		
19.Perdarahan dalam kehamilan ini*		
20.Preeklamsia/kejang-kejang		

Skoring KOMPETENSI 1

3 = Jika peserta melakukan semua 20 langkah dengan benar

2 = Jika peserta melakukan 10-19 dari Langkah dengan benar

1 = Jika peserta melakukan 1-9 dari Langkah dengan benar

0 = jika peserta tidak melakukan apapun

KOMPETENSI 2: perumusan diagnosis dan / masalah

Komponen yang di nilai	Skoring	Skor
1. Memberikan skor pada KSPR sesuai dengan hasil anamnesis		
2. Memasukkan skor pada KSPR sesuai dengan tabel usia kehamilan		
3. Mentotal skor pada KSPR		
4. Menetapkan diagnose ibu hamil masuk kriteria di KSPR		

Skoring KOMPETENSI 2

- 3 = Jika peserta melakukan semua 4 langkah dengan benar
 2 = Jika peserta melakukan 2-3 langkah dengan benar
 1 = Jika peserta melakukan 1 langkah dengan benar
 0 = Jika peserta tidak melakukan Langkah apapun, atau dilakukan tetapi tidak tepat

KOMPETENSI 3. Kie/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Menjelaskan hasil pemeriksaan dan kondisi ibu/janin dengan Bahasa sederhana		
2. Menjelaskan bahwa ibu harus rutin melakukan pemeriksaan ANC di tenaga Kesehatan (dokter)		
3. Memberikan kesempatan bertanya dan menjawab pertanyaan dengan jelas		

Skoring KOMPITENSI 3

- 3 = Jika peserta melakukan semua 3 langkah dengan benar
 2 = Jika peserta melakukan 2 langkah dengan benar
 1 = Jika peserta melakukan 1 langkah saja dengan benar
 0 = Jika peserta tidak melakukan apapun

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Melaksanakan secara sistematis		
2. Menjaga privasi dan keselamatan klien		
3. Memberikan perhatian terhadap respon klien selama anamnesis		
4. Menggunakan suara yang jelas, sederhana dan informatif		
5. Percaya diri dan tidak ragu-ragu		

Skoring KOMPETENSI 4

3 = jika peserta melakukan semua 5 langkah dengan benar

2 = Jika peserta melakukan 3-4 langkah dengan benar

1 = Jika peserta melakukan 1-2 langkah dengan benar

0 = Jika peserta tidak melakukan apa pun

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3

(dicatat di rubrik penilaian)

Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = ----- x 100 =

30

(Kota),

.....

Penguji :

I. DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

1. Asuhan Kebidanan Kehamilan di sertakan dengan KSPR
2. Checklist + umpan balik singkat
3. Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

J. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan Asuhan kebidanan pada kehamilan bentuk SOAP
- Feedback CI/dosen

K. Rangkuman Materi

Isi ringkasan bab:

1. CP Bab

Setelah mempelajari bab ini, Mahasiswa diharapkan mampu:

- a. Memahami konsep skrining resiko dalam kehamilan sebagai bagian dari pelayanan antenatal care (ANC).
- b. Mengidentifikasi faktor resiko kehamilan berdasarkan hasil anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang.
- c. Menggunakan instrumen skrining (seperti KSPR) secara tepat.
- d. Mengklasifikasikan ibu hamil ke dalam kelompok resiko rendah, tinggi, dan sangat tinggi.
- e. Menentukan rencana asuhan kehamilan sesuai tingkat resiko kehamilan.
- f. Melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan komplikasi kehamilan.
- g. Melakukan rujukan secara tepat berdasarkan hasil skrining resiko kehamilan

2. Alur asuhan kehamilan dalam skrining resiko (flow)

Alur skrining risiko dalam pelayanan antenatal:

a. Kontak Awal (Kunjungan ANC pertama)

- 1) Registrasi ibu hamil
- 2) Anamnesis lengkap:
 - 1) Riwayat obstetri
 - 2) Riwayat penyakit baik keluarga, Kesehatan yang lalu maupun sekarang
 - 3) Riwayat psikososial spiritual
- 3) Identifikasi faktor resiko awal kehamilan

b. Pemeriksaan Dasar

- 1) Pemeriksaan fisik umum (Tekanan Darah, nadi, suhu, Pernafasan dan Antropometri (Berat badan sebelum dan selama hamil, Tinggi badan serta lingkar lengan atas)
- 2) Pemeriksaan obstetri:
 - a) Tinggi Fundus Uteri
 - b) Detak Jantung Janin
- 3) Pemeriksaan penunjang:
 - a) Hb
 - b) Urine (protein, glukosa)
 - c) Golongan darah (jika perlu)

c. Skrining Risiko

- 1) Pengisian instrumen skrining (misalnya KSPR)
- 2) Identifikasi skor risiko:
 - a) Faktor risiko ringan
 - b) Faktor risiko sedang
 - c) Faktor risiko berat

d. Klasifikasi Risiko

- 1) Risiko Rendah
- 2) Risiko Tinggi
- 3) Risiko Sangat Tinggi

e. Penentuan Rencana Asuhan**1) Risiko Rendah:**

- a) ANC rutin sesuai standar minimal 6 kali
- b) Edukasi tentang Kesehatan kehamilan

2) Risiko Tinggi:

- a) ANC lebih sering
- b) Pemantauan ketat
- c) Konsultasi/kolaborasi

3) Risiko Sangat Tinggi:

- a) Rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap
- b) Penanganan spesialistik

f. Edukasi & Konseling

- 1) Tanda bahaya kehamilan
- 2) Persiapan persalinan dan komplikasi (P4K)
- 3) Nutrisi dan gaya hidup sehat

g. Tindak Lanjut (Follow-up)

- 1) Kunjungan ulang sesuai jadwal

- 2) Reskrining resiko pada setiap kunjungan
- 3) Evaluasi perkembangan kondisi ibu dan janin

3. Checklist “Saya sudah bisa...”

Gunakan checklist berikut untuk evaluasi kompetensi:

- a. Pengetahuan
 - 1) Menjelaskan konsep skrining resiko kehamilan
 - 2) Menyebutkan faktor resiko kehamilan
 - 3) Menjelaskan tujuan skrining resiko
 - 4) Menjelaskan klasifikasi resiko kehamilan
- b. Keterampilan
 - 1) Melakukan anamnesis komprehensif pada ibu hamil
 - 2) Melakukan pemeriksaan fisik kehamilan
 - 3) Menggunakan alat skrining (KSPR) dengan benar
 - 4) Menginterpretasi hasil skrining risiko
 - 5) Mengklasifikasikan tingkat resiko kehamilan
 - 6) Menyusun rencana asuhan sesuai tingkat resiko kehamilan
 - 7) Memberikan edukasi kepada ibu hamil dan keluarga
- c. Sikap Profesional
 - 1) Teliti dalam melakukan skrining Resiko
 - 2) Responsif terhadap faktor resiko kehamilan
 - 3) Komunikatif dan empatik kepada ibu hamil dan keluarga
 - 4) Bekerja sama dalam tim Kesehatan lain

L. Daftar Pustaka

-
- Hastuti, p., suparmi, s., sumiyati, s., widiastuti, a., & yuliani, d. R. (2018). Kartu skor poedji rochjati untuk skrining antenatal. *Link*, 14(2), 110–113. <https://doi.org/10.31983/link.v14i2.3710>.
- Kemendes RI. (2021). Buku saku merencanakan kehamilan sehat. kementerian kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Pedoman Pelayanan Antenatal, Persalinan, Nifas dan Bayi Baru Lahir di Era Adaptasi Kebiasaan Baru*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Profil Kesehatan Indonesia 2020*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Rochjati, P. (2011). *Skrining Antenatal pada Ibu Hamil Edisi 2* (Referensi Utama Skor Poedji Rochjati)

- Setiawati, I., & Maulana, T. (2024). Effect of hemoglobin levels and upper arm circumference of pregnant on stunting in toddlers. *MEDIA ILMU KESEHATAN: Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta*, 13(2), 199-205.
- Setiawati, I., & Maulana, T. (2024). Hubungan Riwayat Anemia dan Kurang Energi Kronis (KEK) pada Ibu Hamil dengan Kejadian Stunting. *Faletehan Health Journal*, 11(01), 8-15.
- Setiawati, I., Daniati, D., & Qomari, S. N. (2025). Analysis of Factors Affecting Stunting Incidence in Toddlers. *Faletehan Health Journal*, 12(02), 213-218. <https://doi.org/10.33746/fhj.v12i02.693>
- Setiawati, I., Daniati, D., & Qomari, S. N. (2026). Correlation of Stunting Determinants Among Children Under Five. *Oksitosin: Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 13(1), 65-78.
- Setiawati, I., Qomari, S., & Daniati, D. (2026). Early Detection of Maternal Risk Factors for Stunting in Infants. *Jurnal Keperawatan Soedirman*, 21(1), 21-26. doi:10.20884/1.jks.2026.21.1.17983
- Setyorini, D., & Cahyono, D. I. (2022). Modul deteksi dini resiko preeklamsia [Module for early detection of preeclampsia risk]. PT Mahakarya Cipta Utama Grup
- Tyastuti & Wahyuningsih. (2022). *Asuhan Kebidanan pada Kehamilan Buku Pintar Ibu Hamil*
- Zainiyah, Z., Setiawati, I., Susanti, E., & Madura, N. H. (2020). Pregnancy Danger Screening With Kartu Skor Poedji Rochjati (Kspr). *Jurnal Paradigma*, 2(2), 30-38.

BAB 4

DETEKSI DINI TANDA BAHAYA KEHAMILAN: PERDARAHAN, NYERI HEBAT, DEMAM, DAN GERAK JANIN BERKURANG

CPL – 4	Menggunakan clinical reasoning untuk pengkajian, skrining, dan deteksi dini risiko maternal–neonatal
CPMK – 4 (Utama)	Menilai dan mendeteksi dini tanda bahaya maternal sepanjang kehamilan–intrapartum–postpartum serta menentukan tindakan awal sesuai kewenangan dan kebutuhan rujukan.
CPMK – 2 (Penguat)	Melaksanakan pengkajian terpadu ibu dan bayi (anamnesis terfokus, pemeriksaan fisik, validasi data) secara sistematis dan aman.
CPMK – 6 (Penguat)	Melaksanakan stabilisasi awal dan proses rujukan maternal–neonatal (indikasi, persiapan, komunikasi rujukan, transport aman) sesuai standar pelayanan primer.
BAB 4	Deteksi Dini Tanda Bahaya Kehamilan: Perdarahan, Nyeri Hebat, Demam, dan Gerak Janin Berkurang
Sub – CPMK 1	Membedakan tanda bahaya kehamilan berdasarkan data klinis dan tingkat urgensi
Sub – CPMK 2	Menetapkan tindakan awal, pemantauan, dan keputusan rujukan menggunakan algoritme layanan primer.

A. Konsep Dasar Tentang Tanda Bahaya Kehamilan

1. Pengertian Tanda Bahaya Kehamilan

Menurut *World Health Organization* (WHO), tanda bahaya kehamilan adalah Gejala atau tanda yang muncul selama masa kehamilan yang menunjukkan adanya kemungkinan komplikasi serius pada ibu atau janin yang memerlukan perhatian dan penanganan medis segera untuk mencegah kesakitan atau kematian ibu dan bayi. WHO menekankan bahwa pengenalan dini tanda bahaya oleh ibu hamil, keluarga, dan tenaga kesehatan sangat penting untuk mencegah komplikasi obstetri dan menurunkan AKI (WHO, 2019).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendefinisikan tanda bahaya kehamilan adalah tanda atau gejala yang terjadi selama kehamilan yang menunjukkan adanya gangguan atau komplikasi yang dapat membahayakan kesehatan ibu maupun janin sehingga memerlukan pemeriksaan dan penanganan segera oleh tenaga kesehatan. Kemenkes juga menekankan bahwa ibu hamil perlu mengenali tanda bahaya sejak dini agar dapat segera mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan (Kemenkes RI, 2020).

Tanda bahaya kehamilan adalah tanda atau gejala yang muncul selama masa kehamilan yang menunjukkan adanya kemungkinan komplikasi atau gangguan pada ibu maupun janin yang dapat mengancam kesehatan atau keselamatan keduanya sehingga memerlukan penanganan medis segera (Kusumawati, P. D., dkk, 2023). Tanda bahaya ini merupakan indikator awal adanya masalah dalam kehamilan. Jika tanda tersebut tidak dikenali dan ditangani dengan cepat, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi komplikasi serius bahkan menyebabkan kematian ibu maupun janin. Oleh karena itu, ibu hamil dan keluarga perlu mengetahui tanda bahaya kehamilan agar dapat segera mencari pertolongan ke tenaga kesehatan (Wahyuningsih, E., dkk., 2023).

Menurut literatur kesehatan ibu, beberapa kondisi yang termasuk tanda bahaya kehamilan antara lain perdarahan dari jalan lahir, nyeri perut hebat, sakit kepala berat disertai gangguan penglihatan, pembengkakan pada wajah atau tangan, demam tinggi, berkurangnya gerakan janin, serta keluarnya cairan ketuban sebelum waktunya. Kondisi tersebut menandakan adanya kemungkinan komplikasi yang membutuhkan penanganan segera oleh tenaga kesehatan (Puskesmas Pelangan, 2026).

Kesimpulan yang diambil dari beberapa definisi diatas adalah tanda bahaya kehamilan sebagai gejala atau kondisi abnormal selama kehamilan yang menandakan kemungkinan komplikasi serius dan membutuhkan penanganan medis segera.

2. Tujuan Mengenali Tanda Bahaya Kehamilan

- a. Meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang tanda dan gejala bahaya selama kehamilan sehingga ibu mampu memahami kondisi yang berisiko bagi dirinya maupun janin (Sari, R., & Handayani, L. 2023).
- b. Mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya komplikasi kehamilan agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat oleh tenaga kesehatan (Putra, A., & Rahmawati, D. (2022).
- c. Mendorong ibu hamil untuk segera mencari pertolongan medis apabila muncul tanda bahaya, sehingga dapat mencegah keterlambatan penanganan (Nurhayati, S., & Fitriani, R., 2023).
- d. Mencegah terjadinya komplikasi serius pada ibu dan janin yang dapat menyebabkan kesakitan maupun kematian ibu dan bayi (Maros, Z., & Kurniawati, N., 2022).
- e. Meningkatkan kepatuhan ibu hamil dalam melakukan pemeriksaan antenatal care (ANC) sebagai upaya pemantauan kesehatan selama kehamilan (Hidayah, N., & Lestari, P., 2024).
- f. Menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) melalui peningkatan kesadaran serta kemampuan deteksi dini terhadap masalah kehamilan (Wulandari, D., & Sari, M., 2022).

Tujuan Mengenali Tanda Bahaya Kehamilan menurut Kemenkes RI tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengetahuan ibu hamil mengenai tanda dan gejala bahaya selama kehamilan, sehingga ibu dapat memahami kondisi yang berisiko bagi kesehatan dirinya dan janin.
- b. Melakukan deteksi dini terhadap komplikasi kehamilan, karena setiap kehamilan berpotensi mengalami masalah yang dapat berkembang menjadi kondisi berbahaya apabila tidak dikenali sejak awal.
- c. Mendorong ibu hamil untuk segera mencari pertolongan ke tenaga kesehatan apabila muncul tanda bahaya, sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

- d. Mencegah terjadinya komplikasi serius pada ibu dan janin, karena sebagian besar kematian ibu berkaitan dengan komplikasi obstetri yang sebenarnya dapat dikenali melalui tanda bahaya kehamilan.
- e. Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui peningkatan kesadaran, edukasi, dan deteksi dini terhadap masalah selama masa kehamilan.

B. Tanda Bahaya Kehamilan

Konsep teori perdarahan kehamilan saat ini menekankan bahwa perdarahan merupakan salah satu tanda bahaya obstetri yang dapat terjadi pada semua trimester, dengan penyebab utama seperti keguguran, kehamilan ektopik, mola hidatidosa, plasenta previa, dan solusio plasenta. Perdarahan tetap menjadi penyumbang besar morbiditas dan mortalitas ibu serta janin, sehingga teori terbaru menekankan deteksi dini, klasifikasi berdasarkan trimester, serta intervensi cepat.

1. Perdarahan dalam Kehamilan

Perdarahan dalam kehamilan adalah keluarnya darah dari jalan lahir selama masa gestasi yang bersifat abnormal, baik sedikit maupun banyak, yang dapat terjadi pada trimester awal, pertengahan, maupun akhir. Kondisi ini merupakan tanda bahaya obstetri karena berpotensi mengancam keselamatan ibu dan janin.

a. Pengertian Perdarahan

Menurut Kementerian Kesehatan RI (2024), perdarahan pada ibu hamil maupun pasca melahirkan adalah kondisi abnormal yang dapat bervariasi dari ringan hingga mengancam jiwa, dan memerlukan perhatian medis segera karena dapat menimbulkan komplikasi serius bagi ibu dan bayi.

World Health Organization (WHO, 2023), perdarahan obstetri, terutama perdarahan pasca-salin, masih menjadi penyebab utama kematian ibu di dunia. WHO menekankan pentingnya deteksi dini dan active management of third stage of labor untuk mencegah perdarahan postpartum. Dalam Sarwono Prawirohardjo (2014) mendefinisikan perdarahan antepartum sebagai perdarahan yang terjadi setelah kehamilan mencapai 22 minggu hingga sebelum persalinan, dengan penyebab utama plasenta previa dan solusio plasenta.

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa definisi diatas bahwa Perdarahan kehamilan adalah kondisi patologis yang ditandai keluarnya darah dari vagina selama kehamilan, bukan bagian dari proses fisiologis normal, dan harus dianggap sebagai emergency obstetri.

b. Karakteristik Perdarahan Klinis

1) Trimester I (0–12 minggu)

- a) Keguguran (abortus) Adalah perdarahan disertai nyeri perut bawah, kadang keluar jaringan. Jenis-jenis abortus yaitu Abortus imminens (keguguran mengancam), Abortus insipiens (keguguran berlangsung), Abortus inkomplet (keguguran tidak lengkap), Abortus komplet (keguguran lengkap), Missed abortion (abortus tertunda), Abortus habituais (keguguran berulang), Abortus septik (keguguran dengan infeksi),
- b) Kehamilan ektopik menurut WHO, 2023 adalah kehamilan abnormal di mana embrio berkembang di luar endometrium uterus, sehingga tidak dapat bertahan hidup dan berisiko tinggi menimbulkan komplikasi serius bagi ibu. Dalam Kemenkes RI, 2024 kehamilan ektopik merupakan salah satu penyebab perdarahan trimester pertama yang berpotensi mengancam jiwa, ditandai dengan nyeri perut hebat, perdarahan pervaginam, dan kadang disertai syok akibat ruptur tuba.
- c) Mola hidatidosa adalah salah satu bentuk kehamilan abnormal yang ditandai dengan pertumbuhan jaringan trofoblas yang berlebihan dan degenerasi hidropik pada vili korionik, sehingga terbentuk gelembung-gelembung menyerupai buah anggur di dalam rahim. Kondisi ini termasuk dalam kelompok penyakit trofoblast gestasional (gestational trophoblastic disease/GTD) (Kemenkes RI, 2024).

2) Trimester II–III (13–40 minggu)

- a) Plasenta previa adalah kondisi kehamilan di mana plasenta berimplantasi di segmen bawah rahim sehingga menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Ini merupakan salah satu penyebab utama perdarahan pada trimester kedua dan ketiga. Klasifikasi Plasenta Previa yaitu Plasenta previa totalis, Plasenta previa parsialis, Plasenta previa marginalis, Plasenta letak rendah (Kemenkes RI, 2024).
- b) Solusio plasenta Adalah kondisi obstetri di mana plasenta terlepas sebagian atau seluruhnya dari dinding rahim sebelum janin lahir. Ini merupakan salah satu penyebab utama perdarahan pada trimester kedua dan ketiga, dan termasuk keadaan gawat darurat karena dapat mengancam nyawa ibu maupun janin (Kemenkes RI, 2024).

c. Etiologi

- 1) Trimester I (0–12 minggu)
 - a) Perdarahan implantasi terjadi saat embrio menempel pada endometrium, biasanya ringan dan berhenti sendiri.
 - b) Abortus (keguguran) akibat kelainan kromosom, gangguan hormonal, atau faktor maternal.
 - c) Kehamilan ektopik karena implantasi di luar rahim (tuba falopi paling sering), menyebabkan perdarahan intraabdominal.
 - d) Mola hidatidosa karena proliferasi abnormal trofoblas, ditandai perdarahan disertai keluarnya jaringan berbentuk gelembung.
- 2) Trimester II–III (13–40 minggu)
 - a) Plasenta previa terjadi karena Implantasi abnormal blastokista di segmen bawah rahim, dekat ostium uteri internum. Endometrium yang rusak atau kurang subur (atrofi, inflamasi, vaskularisasi buruk) membuat zigot mencari tempat implantasi lebih rendah. Plasenta yang tumbuh terlalu luas (misalnya pada kehamilan ganda atau eritroblastosis fetalis) dapat meluas hingga menutupi jalan lahir.
 - b) Solusio plasenta yaitu Perdarahan pada desidua basalis sehingga terbentuk hematoma retroplasenter yang mendorong plasenta terlepas. Gangguan vaskularisasi rahim akibat hipertensi atau preeklamsia sehingga meningkatkan kerentanan pelepasan plasenta. Trauma abdomen (jatuh, kecelakaan, pukulan) memicu robekan pembuluh darah plasenta. Ketuban pecah dini atau polihidramnion menyebabkan perubahan tekanan intrauterin mendadak menyebabkan plasenta terlepas. Kelainan plasenta akreta/inkreta/perkreta: plasenta menempel terlalu dalam ke myometrium sehingga sulit lepas, perdarahan hebat. Intrapartum (saat persalinan)
 - c) Ruptur uteri yaitu Robekan pada bekas luka operasi rahim (terutama seksio sesarea) sehingga jaringan parut lebih rapuh dibandingkan jaringan normal. Adanya Tekanan berlebihan saat persalinan Dimana kontraksi kuat atau lama, bayi besar, atau persalinan sulit. Induksi persalinan dengan oksitosin/prostaglandin maka kontraksi terlalu sering dan kuat, meningkatkan risiko robekan. Trauma abdomen akibat kecelakaan, jatuh, atau tindakan medis yang tidak tepat. Rahim terlalu meregang karena kehamilan ganda, polihidramnion, atau janin besar (makrosomia).

- d) Trauma jalan lahir yaitu robekan serviks, vagina, atau perineum saat bayi lahir.

d. Faktor Risiko

1) Trimester I

a) Keguguran spontan (miscarriage)

Risiko perdarahan trimester pertama meningkat pada ibu dengan usia lebih dari 35 tahun, riwayat keguguran berulang, adanya kelainan kromosom, maupun penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Kondisi-kondisi tersebut dapat memengaruhi stabilitas kehamilan sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya komplikasi. Secara epidemiologis, sekitar 15–20% kasus perdarahan pada trimester pertama berakhir dengan keguguran, sehingga faktor risiko ini perlu diwaspadai dan ditangani secara dini untuk menjaga keberlangsungan kehamilan.

b) Kehamilan Ektopik

Faktor risiko kehamilan ektopik meliputi riwayat infeksi panggul (pelvic inflammatory disease/PID), operasi pada tuba falopi, penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD), serta riwayat kehamilan ektopik sebelumnya. Kondisi-kondisi tersebut dapat menyebabkan kerusakan atau perubahan pada struktur tuba falopi sehingga meningkatkan kemungkinan implantasi abnormal di luar rahim. Secara epidemiologis, kehamilan ektopik memiliki insidensi sekitar 2% dari seluruh kehamilan, menjadikannya salah satu penyebab penting perdarahan trimester pertama yang perlu diwaspadai.

c) Kehamilan mola (molar pregnancy)

Risiko kehamilan mola meningkat pada ibu dengan riwayat mola sebelumnya, usia ekstrem yaitu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 40 tahun, serta adanya defisiensi nutrisi tertentu seperti kekurangan vitamin A. Kondisi ini dapat menyebabkan pertumbuhan jaringan plasenta yang abnormal dan berpotensi menimbulkan perdarahan pada trimester pertama. Jika tidak ditangani dengan baik, kehamilan mola dapat berkembang menjadi komplikasi serius seperti koriokarsinoma, sehingga deteksi dini dan penanganan segera sangat penting untuk mencegah dampak yang lebih berat bagi kesehatan ibu.

d) Perdarahan Implantasi

Perdarahan implantasi biasanya terjadi 6–12 hari setelah pembuahan, ditandai dengan keluarnya darah ringan yang umumnya tidak berbahaya. Kondisi ini sering kali disalahartikan sebagai menstruasi karena kemunculannya berdekatan dengan waktu haid, meskipun sebenarnya merupakan bagian dari proses normal ketika embrio menempel pada dinding rahim.

e) Faktor Serviks dan Uterus

Polip serviks, infeksi pada serviks atau vagina, serta kelainan anatomi rahim seperti adanya septum atau mioma submukosa dapat meningkatkan risiko terjadinya perdarahan pada trimester pertama kehamilan. Faktor-faktor ini dapat mengganggu integritas jaringan reproduksi dan menimbulkan perdarahan berulang, sehingga penting untuk dilakukan pemeriksaan dan penanganan yang tepat agar tidak menimbulkan komplikasi lebih lanjut.

2) Trimester 2

a) Plasenta Previa

Plasenta previa memiliki sejumlah faktor risiko yang berperan dalam terjadinya implantasi abnormal di segmen bawah rahim. Usia ibu ≥ 35 tahun dapat menyebabkan penurunan aliran darah endometrium, sementara multiparitas menimbulkan perubahan inflamasi dan atrofi endometrium. Riwayat seksio sesarea atau operasi rahim lain sering meninggalkan jaringan parut yang mengganggu proses implantasi normal, sedangkan riwayat kuretase atau abortus berulang dapat merusak endometrium. Kebiasaan merokok atau penggunaan kokain juga berkontribusi dengan menyebabkan atrofi endometrium dan gangguan vaskularisasi. Selain itu, kehamilan ganda atau plasenta yang berukuran besar meningkatkan kebutuhan nutrisi sehingga plasenta cenderung meluas ke bawah. Riwayat plasenta previa sebelumnya pun menjadi faktor penting karena dapat meningkatkan risiko kejadian berulang.

b) Solutio Plasenta

Solutio plasenta memiliki berbagai faktor risiko yang dapat memicu terjadinya pelepasan plasenta sebelum waktunya. Hipertensi kronis, preeklamsia, dan eklampsia menyebabkan kerusakan pembuluh darah sehingga memicu perdarahan pada desidua basalis.

Trauma perut akibat kecelakaan, jatuh, atau benturan juga dapat merobek pembuluh darah plasenta. Riwayat solusio plasenta sebelumnya meningkatkan kemungkinan kejadian berulang, sementara usia ibu yang ekstrem (<20 tahun atau >35 tahun) serta multiparitas membuat endometrium dan rahim lebih rentan. Kondisi polihidramnion atau kehamilan ganda menambah tekanan intrauterin, dan adanya leiomioma uteri dapat mengganggu implantasi plasenta. Ketuban pecah dini, defisiensi nutrisi seperti kekurangan asam folat atau anemia, serta gaya hidup tidak sehat seperti merokok, konsumsi alkohol, dan penggunaan kokain juga berkontribusi terhadap terjadinya solusio plasenta.

c) Ruptura Uteri

Ruptura uteri dapat terjadi akibat berbagai faktor risiko yang melemahkan atau menekan dinding rahim. Riwayat operasi caesar maupun operasi rahim lain seperti miomektomi atau kuretase sering meninggalkan jaringan parut yang lebih rapuh dibandingkan jaringan normal. Kondisi grandemultipara (≥ 5 kali melahirkan) menyebabkan dinding rahim menipis dan melemah, sedangkan usia ibu lanjut (>35 tahun) menurunkan elastisitas jaringan. Induksi atau augmentasi persalinan dengan obat-obatan dapat memicu kontraksi berlebihan yang meningkatkan tekanan intrauterin. Plasenta akreta atau perlengketan plasenta juga melemahkan struktur rahim, sementara kehamilan postterm (>40 minggu) membuat rahim teregang lebih lama. Selain itu, kelainan kongenital rahim menjadikan struktur abnormal lebih mudah robek, dan trauma perut akibat kecelakaan, kekerasan, atau tindakan medis dapat langsung memicu terjadinya ruptura uteri.

d) Trauma Jalan Lahir

Trauma jalan lahir adalah cedera yang terjadi pada jaringan saluran reproduksi wanita (vulva, vagina, serviks, hingga perineum) selama proses persalinan. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh persalinan yang sulit atau penggunaan intervensi obstetri. Faktor penyebab utama meliputi persalinan dengan bayi besar (makrosomia), persalinan cepat atau sebaliknya yang berlangsung lama, penggunaan alat bantu seperti forceps atau vakum ekstraktor, episiotomi yang melebar, serta kelenturan jaringan yang berkurang pada ibu dengan usia lanjut atau primipara. Trauma dapat berupa robekan perineum, laserasi vagina, robekan serviks, hingga ruptur

uteri bila tekanan sangat besar. Dampaknya bisa berupa perdarahan hebat, nyeri, gangguan fungsi dasar panggul, bahkan komplikasi jangka panjang seperti inkontinensia atau prolaps organ panggul.

e. Patofisiologi

1) Trimester Pertama (0–12 minggu)

Abortus atau keguguran pada trimester pertama terjadi akibat kelainan kromosom atau pertumbuhan abnormal yang menyebabkan degenerasi trofoblas, sehingga hasil konsepsi terlepas dan pembuluh darah desidua pecah menimbulkan perdarahan. Kehamilan ektopik, yang biasanya berimplantasi di tuba falopi, tidak mampu menopang pertumbuhan embrio sehingga pembuluh darah tuba mengalami ruptur dan menyebabkan hemoperitoneum. Pada mola hidatidosa, proliferasi abnormal vili korialis dengan degenerasi hidropik merusak endometrium dan menimbulkan perdarahan intermiten. Sementara itu, implantasi yang tidak sempurna dapat menyebabkan disrupsi pembuluh darah endometrium saat proses nidasi, sehingga muncul perdarahan ringan yang sering kali disalahartikan sebagai menstruasi (Cunningham, dkk, 2018).

2) Trimester Kedua (13–28 minggu)

Plasenta previa terjadi ketika plasenta berimplantasi di segmen bawah uterus, sehingga saat segmen bawah meregang dan serviks mulai membuka, sinus uteroplacenta dapat robek dan menimbulkan perdarahan yang khas tanpa disertai nyeri. Berbeda dengan itu, solusio plasenta diawali oleh perdarahan di desidua basalis yang membentuk hematoma retroplasenta, menyebabkan pemisahan plasenta dari dinding uterus, gangguan oksigenasi janin, serta perdarahan masif yang biasanya disertai nyeri hebat. Infeksi pada serviks atau uterus juga dapat menimbulkan perdarahan karena proses inflamasi membuat jaringan menjadi rapuh dan mudah pecah. Selain itu, trauma akibat hubungan seksual atau manipulasi serviks dapat memicu perdarahan karena meningkatnya vaskularisasi pada area tersebut selama kehamilan (Cunningham, dkk, 2018).

3) Trimester Ketiga (29–40 minggu)

Plasenta previa lanjut terjadi ketika plasenta tetap berimplantasi di segmen bawah uterus, sehingga semakin besar pelebaran segmen bawah dan pembukaan serviks akan menyebabkan robekan sinus marginalis yang menimbulkan perdarahan berulang dengan darah merah segar

tanpa nyeri. Solusio plasenta ditandai oleh perdarahan yang bermula di desidua basalis, membentuk hematoma retroplasental yang semakin luas hingga menyebabkan uterus tegang seperti papan, nyeri hebat, serta perdarahan berwarna hitam akibat darah yang terperangkap. Ruptur uteri biasanya terjadi akibat persalinan lama atau adanya bekas operasi pada rahim, yang menyebabkan robekan miometrium dan perdarahan intraabdominal masif. Vasa previa merupakan kondisi di mana pembuluh darah janin melintasi ostium uteri internum dan dapat pecah saat ketuban pecah, sehingga perdarahan berasal dari sirkulasi janin dan sangat berbahaya. Sementara itu, pada plasenta akreta, inkreta, atau perkreta, jonjot korialis menembus terlalu dalam hingga ke miometrium atau peritoneum, sehingga plasenta sulit dilepaskan saat persalinan dan menimbulkan perdarahan hebat yang berisiko tinggi terhadap keselamatan ibu (Cunningham, dkk, 2018).

f. Klasifikasi

1) Trimester Pertama (0–12 minggu)

Abortus merupakan salah satu penyebab perdarahan trimester pertama yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti abortus spontan, imminens, insipiens, inkomplet, komplet, maupun missed abortion. Selain itu, kehamilan ektopik, yaitu implantasi embrio di luar kavum uteri umumnya di tuba falopi juga menjadi faktor penting yang dapat menimbulkan perdarahan serius. Mola hidatidosa, yang ditandai dengan proliferasi abnormal trofoblas, dapat menyebabkan perdarahan intermiten dan komplikasi lebih lanjut bila tidak ditangani. Perdarahan implantasi, meskipun biasanya ringan dan fisiologis, sering kali disalahartikan sebagai menstruasi. Di samping itu, kelainan serviks atau uterus seperti polip, infeksi, maupun mioma submukosa juga dapat meningkatkan risiko perdarahan pada trimester pertama kehamilan.

2) Trimester Kedua (13–28 minggu)

Plasenta previa merupakan kondisi di mana plasenta menutupi ostium uteri internum, sehingga saat segmen bawah uterus meregang dan serviks membuka dapat terjadi robekan pembuluh darah yang menimbulkan perdarahan tanpa nyeri. Solusio plasenta terjadi ketika plasenta terlepas sebagian atau seluruhnya dari dinding uterus sebelum waktunya, diawali oleh perdarahan di desidua basalis yang membentuk hematoma retroplasental dan berlanjut dengan pemisahan plasenta, sehingga menyebabkan gangguan oksigenasi janin serta perdarahan

masif. Infeksi pada serviks atau uterus dapat menimbulkan perdarahan karena proses inflamasi membuat jaringan lebih rapuh dan mudah pecah. Selain itu, trauma akibat hubungan seksual atau manipulasi serviks juga dapat memicu perdarahan karena meningkatnya vaskularisasi pada area tersebut selama kehamilan. Pada kasus keguguran lanjut (late miscarriage), perdarahan terjadi akibat kegagalan mempertahankan kehamilan setelah trimester pertama, biasanya disertai keluarnya jaringan konsepsi dan nyeri perut bawah.

3) Trimester Ketiga (29–40 minggu)

Plasenta previa lanjut merupakan kondisi di mana plasenta tetap menutupi segmen bawah uterus sehingga saat terjadi pelebaran segmen bawah dan pembukaan serviks, sinus marginalis dapat robek dan menimbulkan perdarahan berulang dengan darah segar tanpa disertai nyeri. Solusio plasenta ditandai oleh terbentuknya hematoma retroplasenter akibat perdarahan di desidua basalis, yang semakin meluas hingga menyebabkan pemisahan plasenta dari dinding uterus, gangguan oksigenasi janin, serta perdarahan kehitaman yang biasanya disertai nyeri hebat dan uterus tegang seperti papan. Ruptur uteri terjadi akibat persalinan lama atau adanya bekas operasi pada rahim, yang menyebabkan robekan miometrium dan perdarahan intraabdominal masif. Vasa previa merupakan keadaan di mana pembuluh darah janin melintasi ostium uteri internum dan dapat pecah saat ketuban pecah, sehingga perdarahan berasal dari sirkulasi janin dan sangat berbahaya. Sementara itu, pada plasenta akreta, inkreta, atau perkreta, jonjot korialis menembus terlalu dalam hingga ke miometrium atau peritoneum, sehingga plasenta sulit dilepaskan saat persalinan dan menimbulkan perdarahan hebat yang berisiko tinggi terhadap keselamatan ibu.

g. Tanda dan Gejala

Deteksi dini bahaya kehamilan dengan perdarahan sangat penting karena perdarahan bisa menjadi tanda awal komplikasi serius. Tanda dan gejala perdarahan berbeda menurut trimester, namun semuanya harus segera diperiksa.

1) Trimester Pertama (0–12 minggu)

- a) Flek atau perdarahan ringan berwarna merah muda/kecokelatan.
- b) Perdarahan pervaginam disertai nyeri perut bawah (abortus imminens/insipiens).

- c) Perdarahan banyak dengan jaringan keluar dari vagina (abortus inkomplet/komplet).
 - d) Nyeri perut unilateral, pusing, pucat, tanda syok (kehamilan ektopik).
 - e) Perdarahan intermiten, mual muntah berlebihan, uterus membesar tidak sesuai usia (mola hidatidosa).
- 2) Trimester Kedua (13–28 minggu)
- a) Perdarahan segar tanpa nyeri, berulang (plasenta previa).
 - b) Perdarahan kehitaman disertai nyeri hebat, uterus tegang seperti papan (solusio plasenta).
 - c) Demam, keputihan abnormal, perdarahan berulang (infeksi serviks/uterus).
 - d) Perdarahan setelah hubungan seksual atau trauma serviks
 - e) Keguguran lanjut: perdarahan sedang–berat, nyeri perut, keluarnya jaringan konsepsi.
- 3) Trimester Ketiga (29–40 minggu)
- a) Perdarahan segar tanpa nyeri, berulang (plasenta previa lanjut).
 - b) Perdarahan kehitaman, nyeri hebat, uterus tegang, janin distress (solusio plasenta).
 - c) Nyeri hebat, perdarahan intraabdominal, tanda syok (ruptur uteri).
 - d) Perdarahan mendadak saat ketuban pecah, berasal dari sirkulasi janin (vasa previa).
 - e) Perdarahan hebat saat persalinan karena plasenta sulit lepas (akreta/inkreta/perkreta).

h. Pemeriksaan Penunjang

- 1) Pemeriksaan Fisik
- a) Evaluasi tanda vital yaitu tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan.
 - b) Pemeriksaan obstetric yaitu tinggi fundus uteri, kontraksi, nyeri tekan
 - c) Pemeriksaan spekulum untuk menilai perdarahan dari serviks/vagina.
 - d) Catatan pemeriksaan vaginal toucher harus dihindari bila dicurigai plasenta previa.
- 2) Ultrasonografi (USG)
- a) USG transvaginal paling akurat untuk mendeteksi plasenta previa, kehamilan ektopik, dan mola hidatidosa.
 - b) USG transabdominal digunakan untuk menilai letak plasenta, hematom retroplasenter (solusio), dan kondisi janin.
 - c) USG Doppler menilai aliran darah janin, mendeteksi vasa previa.

3) Tes Laboratorium

- a) Hemoglobin dan hematokrit: menilai derajat anemia akibat perdarahan.
- b) Tes koagulasi (PT, aPTT, fibrinogen, D-dimer) untuk mendeteksi gangguan pembekuan darah.
- c) Tes β -hCG membantu diagnosis kehamilan ektopik atau mola hidatidosa.
- d) Tes darah lengkap untuk memantau leukosit (infeksi), trombosit (koagulopati).

4) Pemeriksaan Tambahan

- a) MRI pelvis bila USG tidak cukup jelas, terutama untuk plasenta akreta/inkreta/perkreta.
- b) CT scan abdomen jarang digunakan, hanya bila ada komplikasi ruptur uteri atau trauma.
- c) Kardiotokografi (CTG) memantau kesejahteraan janin, mendeteksi distress janin akibat solusio plasenta.

i. Komplikasi

1) Komplikasi pada Ibu

- a) Syok hipovolemik akibat kehilangan darah masif.
- b) Anemia karena perdarahan berulang yang tidak tertangani.
- c) Infeksi/sepsis bila ada jaringan konsepsi tertinggal atau trauma jalan lahir.
- d) Gangguan koagulasi/DIC (Disseminated Intravascular Coagulation) terutama pada solusio plasenta berat.
- e) Ruptur uteri yang dapat mengancam nyawa ibu.
- f) Kebutuhan histerektomi pada kasus plasenta akreta/inkreta/perkreta.

2) Komplikasi pada Janin

- a) Abortus spontan yaitu kehilangan kehamilan pada trimester pertama.
- b) Kematian janin intrauterin (IUFD) akibat solusio plasenta atau perdarahan masif.
- c) Hipoksia janin karena gangguan suplai oksigen (solusio, vasa previa).
- d) Prematuritas akibat persalinan dini yang dipicu perdarahan.
- e) Pertumbuhan janin terhambat (IUGR) akibat gangguan perfusi plasenta.
- f) Kematian neonatus bila perdarahan tidak segera ditangani.

j. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan perdarahan pada kehamilan harus segera dilakukan karena dapat mengancam nyawa ibu dan janin. Prinsip utama adalah stabilisasi kondisi ibu, identifikasi penyebab perdarahan, serta intervensi sesuai etiologi.

Prinsip Umum Penatalaksanaan deteksi dini perdarahan pada kehamilan Adalah:

- 1) Stabilisasi ibu artinya pasang infus besar, cairan kristaloid, oksigen, monitor tanda vital.
- 2) Evaluasi perdarahan dengan cara periksa jumlah darah keluar, status hemodinamik, pemeriksaan laboratorium (Hb, hematokrit, koagulasi).
- 3) Resusitasi yaitu transfusi darah bila kehilangan darah signifikan.
- 4) Monitoring janin dilakukan dengan USG atau CTG bila usia kehamilan sudah lanjut.
- 5) Melakukan rujukan segera ke fasilitas kesehatan dengan kemampuan obstetri emergensi bila perdarahan berat.

Penatalaksanaan Deteksi dini pada kehamilan dengan perdarahan berdasarkan Trimester

1) Trimester Pertama

- a) Abortus imminens dengan cara istirahat, observasi, pemberian progesteron bila perlu.
- b) Abortus insipiens/inkomplet dengan cara evakuasi hasil konsepsi dengan kuretase atau aspirasi vakum.
- c) Kehamilan ektopik dengan cara operasi salpingektomi/salpingostomi atau terapi metotreksat pada kasus terpilih.
- d) Mola hidatidosa dengan cara evakuasi uterus dengan kuretase hisap, monitor β -hCG pasca-evakuasi.

2) Trimester Kedua

- a) Plasenta previa dengan cara rawat inap, tirah baring, transfusi bila perlu, persalinan dengan seksio sesarea bila perdarahan berulang atau masif.
- b) Solusio plasenta dengan cara stabilisasi ibu, koreksi koagulasi, segera lakukan persalinan (biasanya seksio sesarea bila janin masih hidup).
- c) Infeksi serviks/uterus dengan cara antibiotik sesuai hasil kultur, evakuasi bila ada jaringan tertinggal.

3) Trimester Ketiga

- a) Plasenta previa lanjut dengan cara seksio sesarea elektif atau emergensi bila perdarahan masif.

- b) Solusio plasenta dengan cara resusitasi cairan dan darah, persalinan segera, koreksi DIC.
- c) Ruptur uteri dengan cara laparotomi segera, perbaikan uterus atau histerektomi bila perlu.
- d) Vasa previa dengan cara seksio sesarea emergensi bila perdarahan terjadi.
- e) Plasenta akreta/inkreta/perkreta dengan cara histerektomi sering diperlukan karena plasenta sulit dilepas.

k. Asuhan Kebidanan

Asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan perdarahan bertujuan untuk menjaga keselamatan ibu dan janin, mencegah komplikasi, serta memberikan dukungan fisik dan emosional. Asuhan Kebidanan yang dapat dilakukan yaitu

1) Pengkajian

- a) Kaji riwayat obstetri (abortus, operasi, perdarahan sebelumnya).
- b) Observasi tanda vital seperti tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan.
- c) Kaji jumlah, warna, dan sifat perdarahan (merah segar, kehitaman, bercampur jaringan).
- d) Kaji nyeri perut, kontraksi, dan gerakan janin.
- e) Pemeriksaan fisik utamanya tinggi fundus uteri, palpasi abdomen, pemeriksaan spekulum bila perlu.

2) Tindakan Segera

- a) Pastikan jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi ibu stabil.
- b) Pasang infus besar, berikan cairan intravena.
- c) Siapkan darah untuk transfusi bila perdarahan banyak.
- d) Berikan oksigen bila ada tanda hipoksia.
- e) Hindari pemeriksaan vaginal toucher bila dicurigai plasenta previa.

3) Pemeriksaan Penunjang

- a) USG transvaginal/transabdominal untuk menilai letak plasenta, kondisi janin, dan hematoma.
- b) Pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan Hb, hematokrit, koagulasi, β -hCG.
- c) CTG untuk memantau kesejahteraan janin.

4) Asuhan Khusus Sesuai Trimester

- a) Trimester I yaitu observasi abortus imminens, evakuasi hasil konsepsi bila inkomplet, penanganan ektopik/mola.
- b) Trimester II yaitu tirah baring pada plasenta previa, stabilisasi solusio plasenta, antibiotik bila infeksi.

- c) Trimester III yaitu persiapan seksio sesarea pada plasenta previa, laparotomi pada ruptur uteri, histerektomi bila plasenta akreta.
- 5) Dukungan Psikologis
 - a) Berikan penjelasan yang jelas dan jujur tentang kondisi ibu dan janin.
 - b) Dukung ibu dan keluarga dalam pengambilan keputusan.
 - c) Kurangi kecemasan dengan komunikasi empatik.
- 6) Rujukan

Rujuk segera ke fasilitas kesehatan dengan layanan obstetri emergensi bila perdarahan berat. Pastikan ibu dalam kondisi stabil sebelum transportasi.

I. Red Flags

Red flags dalam kehamilan dengan perdarahan adalah tanda bahaya yang harus segera dikenali karena dapat mengancam keselamatan ibu maupun janin. Deteksi dini red flags membantu tenaga kesehatan melakukan intervensi cepat. Red Flags Perdarahan pada Kehamilan adalah

- 1) Trimester Pertama
 - a) Perdarahan banyak disertai nyeri perut bawah hebat.
 - b) Perdarahan dengan keluarnya jaringan konsepsi.
 - c) Nyeri perut unilateral disertai tanda syok (pucat, lemah, hipotensi) maka curiga kehamilan ektopik.
 - d) Mual muntah berlebihan, uterus membesar tidak sesuai usia maka curiga mola hidatidosa.
- 2) Trimester Kedua
 - a) Perdarahan segar berulang tanpa nyeri maka curiga plasenta previa.
 - b) Perdarahan kehitaman disertai nyeri hebat, uterus tegang seperti papan maka curiga solusio plasenta.
 - c) Penurunan gerakan janin.
 - d) Tanda preeklampsia: sakit kepala berat, pandangan kabur, edema wajah/tangan.
- 3) Trimester Ketiga
 - a) Perdarahan masif mendadak, darah segar atau kehitaman.
 - b) Nyeri perut hebat dengan uterus tegang (solusio plasenta).
 - c) Perdarahan tanpa nyeri berulang (plasenta previa lanjut).
 - d) Nyeri hebat, perdarahan intraabdominal, tanda syok (ruptur uteri).
 - e) Perdarahan saat ketuban pecah, berasal dari janin (vasa previa).
 - f) Perdarahan hebat saat persalinan karena plasenta sulit lepas (plasenta akreta/inkreta/perkreta).

m. Dokumentasi

Dokumentasi asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan perdarahan sangat penting untuk memastikan kontinuitas pelayanan, memudahkan evaluasi, serta menjadi bukti legal dan profesional. Dokumentasi harus dilakukan secara sistematis, lengkap, dan akurat. Komponen Dokumentasi Asuhan Kebidanan

1) Data Subjektif

- a) Keluhan utama: perdarahan, nyeri perut, pusing, lemas.
- b) Riwayat obstetri: jumlah kehamilan, persalinan, abortus, riwayat perdarahan sebelumnya.
- c) Riwayat penyakit: hipertensi, diabetes, operasi ginekologi.
- d) Riwayat kehamilan saat ini: usia kehamilan, gerakan janin, pemeriksaan antenatal.

2) Data Objektif

- a) Tanda vital: tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan.
- b) Observasi perdarahan: jumlah, warna, ada/tidaknya jaringan.
- c) Pemeriksaan fisik: tinggi fundus uteri, kontraksi, nyeri tekan, kondisi serviks.
- d) Pemeriksaan penunjang: USG, Hb/Ht, koagulasi, CTG.

3) Analisis (Diagnosa Kebidanan)

- a) Identifikasi masalah: misalnya perdarahan trimester I akibat abortus imminens atau perdarahan trimester III akibat plasenta previa.
- b) Tentukan kebutuhan ibu: stabilisasi, rujukan, dukungan psikologis.

4) Rencana Asuhan

- a) Stabilisasi ibu (infus, cairan, oksigen).
- b) Observasi perdarahan dan tanda vital.
- c) Persiapan rujukan bila perdarahan berat.
- d) Edukasi ibu dan keluarga mengenai tanda bahaya.

5) Implementasi

- a) Catat tindakan yang dilakukan: pemasangan infus, pemberian cairan, transfusi, pemeriksaan USG, pemberian obat.
- b) Catat waktu dan respon ibu terhadap tindakan.

6) Evaluasi

- a) Perkembangan kondisi ibu (tanda vital stabil/tidak).
- b) Perdarahan berkurang atau bertambah.
- c) Kondisi janin (gerakan janin, hasil CTG/USG).
- d) Keputusan rujukan bila diperlukan.

7) Catatan Rujukan

- a) Waktu rujukan, alasan rujukan, kondisi ibu saat dirujuk.
- b) Fasilitas tujuan rujukan.
- c) Tindakan yang sudah dilakukan sebelum rujukan.

3. Nyeri Hebat

Nyeri hebat saat kehamilan adalah salah satu tanda bahaya yang harus segera dikenali karena dapat mengancam keselamatan ibu maupun janin. Deteksi dini melalui pemeriksaan rutin dan pemahaman gejala sangat penting untuk mencegah komplikasi serius seperti preeklampsia, kehamilan ektopik, atau keguguran.

a. Definisi

Menurut Pakar Kesehatan Maternal tahun 2026 deteksi dini tanda bahaya kehamilan adalah upaya mengenali gejala kritis yang muncul secara tiba-tiba (misalnya perdarahan, nyeri hebat, kejang, infeksi) yang dapat mengancam keselamatan ibu dan janin. Nyeri hebat termasuk salah satu tanda bahaya yang harus segera ditangani karena bisa menandakan kegawatdaruratan maternal. Menurut Artikel Edukasi Kesehatan tanda bahaya kehamilan adalah gejala yang menunjukkan ibu hamil dan janin berada pada risiko tinggi. Nyeri perut hebat, perdarahan, demam tinggi, atau gerakan janin berkurang merupakan contoh tanda bahaya yang harus segera diperiksakan. Deteksi dini berarti ibu hamil mampu membedakan keluhan ringan dengan gejala berbahaya.

Menurut Hello Sehat (2022, diperbarui 2025) Nyeri perut hebat yang tidak hilang, tajam, menusuk, atau disertai perdarahan adalah indikasi masalah serius seperti kehamilan ektopik, persalinan prematur, atau abrupsi plasenta. Deteksi dini dilakukan dengan memantau intensitas nyeri dan gejala penyerta (misalnya sakit kepala parah, bengkak wajah/tangan, pandangan kabur). Menurut Alodokter (2024) Deteksi dini tanda bahaya kehamilan adalah kemampuan ibu mengenali keluhan yang tampak biasa tetapi berintensitas berat. Nyeri hebat disertai perdarahan pada trimester awal dapat menandakan kehamilan ektopik atau keguguran, sedangkan pada trimester lanjut bisa berarti abrupsi plasenta.

Jadi, Inti dari beberapa definisi diatas Adalah

- 1) Deteksi dini artinya mengenali gejala abnormal sejak awal.
- 2) Tanda bahaya artinya kondisi yang mengancam nyawa ibu/anak.

- 3) Nyeri hebat artinya salah satu indikator utama, terutama bila disertai perdarahan, demam, atau gejala sistemik.
- 4) Tujuan Adalah mencegah komplikasi serius melalui pemeriksaan segera ke tenaga kesehatan.

b. Klasifikasi

1) Trimester 1 (0–12 minggu)

Nyeri perut hebat pada trimester awal sering kali berkaitan dengan:

- a) Kehamilan ektopik. Embrio berkembang di luar rahim (biasanya di tuba falopi). Gejala adalah nyeri perut hebat unilateral, perdarahan pervaginam, pusing, bahkan syok bila terjadi ruptur. Patofisiologinya adalah pertumbuhan embrio di dalam tuba falopi yang menyebabkan peregangan berlebihan, sehingga terjadi ruptur dan perdarahan intraabdominal yang akhirnya menimbulkan nyeri hebat.
- b) Keguguran (abortus). Pelepasan hasil konsepsi dari rahim. Gejala adalah nyeri perut hebat seperti kram, perdarahan, keluarnya jaringan. Komplikasi yang ditimbulkan adalah perdarahan masif, infeksi, anemia. Deteksi dini yang dapat dilakukan pada ibu hamil harus segera memeriksakan diri bila mengalami nyeri perut hebat disertai perdarahan pada trimester awal.

2) Trimester 2 (13–27 minggu)

Nyeri hebat di trimester pertengahan dapat mengindikasikan:

- a) Kontraksi dini / persalinan premature. Gejala nya adalah perut kencang terus-menerus, nyeri punggung, keluar lendir bercampur darah. Patofisiologinya adalah stimulasi uterus yang terjadi sebelum waktunya sehingga memicu kontraksi, dan kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya kelahiran prematur.
- b) Preeklampsia (awal muncul di trimester 2). Gejalanya berupa nyeri perut hebat terutama di ulu hati yang disertai hipertensi, edema, dan sakit kepala, sedangkan patofisiologinya adalah gangguan vaskular pada plasenta yang menimbulkan spasme pembuluh darah sehingga terjadi hipertensi dan nyeri epigastrium akibat peregangan kapsul hati. Deteksi dini: pemeriksaan tekanan darah, proteinuria, dan pemantauan kontraksi sangat penting.

3) Trimester 3 (28 minggu–lahir)

Nyeri hebat di trimester akhir lebih berbahaya karena risiko komplikasi tinggi:

- a) Preeklampsia berat atau eklampsia merupakan salah satu tanda bahaya kehamilan yang sangat serius. Kondisi ini ditandai dengan gejala berupa nyeri ulu hati hebat, sakit kepala parah, pandangan kabur, serta edema pada wajah dan tangan. Apabila tidak segera ditangani, preeklampsia berat dapat berkembang menjadi eklampsia yang berisiko menimbulkan komplikasi berbahaya seperti kejang, koma, hingga gangguan fungsi hati dan ginjal. Oleh karena itu, deteksi dini melalui pemeriksaan rutin dan kewaspadaan terhadap gejala tersebut sangat penting untuk mencegah dampak fatal bagi ibu maupun janin.
- b) Abruptio plasenta atau pelepasan plasenta sebelum waktunya merupakan salah satu kondisi gawat darurat dalam kehamilan. Gejalanya ditandai dengan nyeri perut mendadak, perdarahan pervaginam, rahim yang terasa tegang, serta adanya tanda distress pada janin. Secara patofisiologi, abruptio plasenta terjadi ketika plasenta terlepas dari dinding rahim sehingga menimbulkan perdarahan retroplasenta, yang berakibat pada hipoksia janin dan dapat menyebabkan syok pada ibu. Kondisi ini sangat berbahaya karena dapat mengancam keselamatan ibu maupun janin, sehingga deteksi dini dan penanganan segera di fasilitas kesehatan sangatlah penting untuk mencegah komplikasi fatal. Deteksi dini: segera ke fasilitas kesehatan bila muncul nyeri hebat disertai perdarahan atau gejala neurologis.

c. Etiologi

Etiologi nyeri hebat pada kehamilan sebagai tanda bahaya umumnya berkaitan dengan gangguan obstetri serius seperti kehamilan ektopik, keguguran, preeklampsia/eklampsia, abruptio plasenta, maupun infeksi intrauterin. Faktor hormonal, perubahan anatomi, dan kondisi patologis pada ibu juga berperan besar dalam memunculkan nyeri hebat yang harus segera dikenali.

1) Kehamilan Ektopik

Etiologi nyeri hebat sebagai tanda bahaya kehamilan terutama berkaitan dengan kelainan obstetri yang mengganggu proses kehamilan normal. Salah satu penyebab utama adalah implantasi embrio di luar kavum uteri, biasanya di tuba falopi (kehamilan ektopik). Pertumbuhan embrio di lokasi yang tidak semestinya menyebabkan peregangan berlebihan pada tuba falopi, sehingga berisiko mengalami ruptur. Ruptur

ini menimbulkan perdarahan intraabdominal yang signifikan dan memicu nyeri hebat pada ibu hamil. Kondisi tersebut merupakan keadaan gawat darurat yang harus segera dikenali melalui deteksi dini agar tidak berlanjut menjadi komplikasi fatal bagi ibu maupun janin (Kemenkes RI, 2024).

2) Keguguran (Abortus)

Etiologi nyeri hebat pada kehamilan yang berhubungan dengan keguguran umumnya disebabkan oleh kelainan kromosom, infeksi, trauma, atau gangguan hormonal yang mengganggu keberlangsungan kehamilan. Faktor-faktor tersebut memicu kontraksi uterus berlebihan sehingga terjadi pelepasan hasil konsepsi dari rahim. Proses ini menimbulkan nyeri perut hebat yang biasanya disertai perdarahan pervaginam. Kondisi ini merupakan tanda bahaya kehamilan yang harus segera dikenali melalui deteksi dini agar ibu hamil dapat memperoleh penanganan medis tepat waktu dan terhindar dari komplikasi serius seperti perdarahan masif atau infeksi (Kemenkes RI, 2024).

3) Preeklampsia/Eklampsia

Etiologi nyeri hebat pada kehamilan yang berhubungan dengan preeklampsia/eklampsia bersifat multifaktor, meliputi gangguan vaskular plasenta, faktor genetik, imunologi, serta nutrisi yang tidak seimbang. Kombinasi faktor tersebut menyebabkan spasme pembuluh darah yang berujung pada peningkatan tekanan darah (hipertensi). Hipertensi yang terjadi kemudian menimbulkan nyeri epigastrium akibat peregangan kapsul hati, sehingga gejala klinis yang muncul berupa nyeri ulu hati hebat, sakit kepala, dan gangguan penglihatan. Kondisi ini merupakan tanda bahaya kehamilan yang harus segera dikenali melalui deteksi dini agar tidak berkembang menjadi komplikasi berat seperti eklampsia, gangguan fungsi hati, maupun ginjal (Kemenkes RI, 2024).

4) Abruptio Plasenta

Abruptio plasenta atau pelepasan plasenta sebelum waktunya memiliki etiologi yang beragam, antara lain hipertensi dalam kehamilan, trauma abdomen, usia ibu yang lanjut, serta riwayat plasenta previa. Faktor-faktor tersebut meningkatkan risiko terjadinya pelepasan plasenta dari dinding rahim sebelum proses persalinan dimulai. Dampaknya, plasenta yang terlepas menimbulkan perdarahan retroplasenta yang dapat menyebabkan hipoksia pada janin dan berujung pada syok pada ibu. Kondisi ini merupakan keadaan gawat darurat obstetri yang harus

segera dikenali melalui deteksi dini agar penanganan cepat dapat dilakukan untuk menyelamatkan ibu dan janin (Kemenkes RI, 2024).

5) Infeksi Intrauterine

Etiologi nyeri hebat pada kehamilan yang disebabkan oleh infeksi intrauterin umumnya berasal dari masuknya bakteri atau virus ke dalam rahim yang kemudian memicu proses inflamasi. Peradangan yang terjadi menyebabkan iritasi jaringan dan kontraksi abnormal sehingga menimbulkan nyeri hebat. Selain itu, infeksi yang tidak segera ditangani dapat disertai demam dan berisiko berkembang menjadi sepsis, suatu kondisi gawat darurat yang mengancam keselamatan ibu dan janin. Oleh karena itu, deteksi dini terhadap gejala nyeri hebat yang disertai demam sangat penting agar penanganan medis dapat segera diberikan untuk mencegah komplikasi serius (Kemenkes RI, 2024).

d. Faktor Risiko

Faktor risiko nyeri hebat sebagai tanda bahaya kehamilan mencakup kondisi medis ibu (hipertensi, riwayat keguguran, infeksi), faktor obstetri (usia ibu lanjut, multiparitas, riwayat plasenta previa), serta gaya hidup dan status gizi. Deteksi dini faktor risiko ini sangat penting agar ibu hamil segera mendapat pemeriksaan dan penanganan yang tepat.

1) Faktor Medis

- a) Hipertensi kronis atau hipertensi dalam kehamilan akan meningkatkan risiko preeklampsia dan abruptio plasenta.
- b) Riwayat penyakit kronis (diabetes, penyakit ginjal, autoimun) akan memperburuk kondisi vaskular dan meningkatkan risiko nyeri hebat.
- c) Infeksi intrauterin (bakteri/virus) akan memicu inflamasi, nyeri hebat, demam, dan risiko sepsis.

2) Faktor Obstetri

- a) Usia ibu lanjut (>35 tahun) akan lebih rentan terhadap komplikasi obstetri.
- b) Multiparitas (melahirkan banyak anak sebelumnya) akan kelemahan otot rahim dan risiko kontraksi abnormal.
- c) Riwayat kehamilan bermasalah (keguguran, plasenta previa, ektopik) akan meningkatkan kemungkinan nyeri hebat pada kehamilan berikutnya.

3) Faktor Gaya Hidup & Nutrisi

- a) Status gizi buruk atau anemia akan memperburuk daya tahan tubuh dan meningkatkan risiko komplikasi.

- b) Kurang aktivitas fisik atau aktivitas berlebihan akan memicu kontraksi dini atau nyeri muskuloskeletal.
 - c) Paparan stres berlebihan akan dapat memengaruhi keseimbangan hormonal dan memperburuk gejala nyeri.
- 4) Faktor Lingkungan & Sosial
- a) Akses terbatas ke layanan kesehatan akan keterlambatan deteksi dini tanda bahaya.
 - b) Kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya akan sering mengabaikan nyeri hebat hingga terlambat ditangani.

Catatan:

Nyeri hebat pada kehamilan bukan sekadar keluhan fisiologis, melainkan tanda bahaya yang sering dipicu oleh hipertensi, infeksi, usia ibu lanjut, riwayat obstetri buruk, dan status gizi rendah. Deteksi dini faktor risiko ini melalui pemeriksaan antenatal care (ANC) rutin sangat penting untuk mencegah komplikasi serius.

e. Patofisiologi

Patofisiologi nyeri hebat pada kehamilan sebagai tanda bahaya terjadi akibat gangguan patologis seperti kehamilan ektopik, keguguran, preeklampsia/eklampsia, abruptio plasenta, maupun infeksi intrauterin. Mekanisme utamanya melibatkan ruptur jaringan, spasme pembuluh darah, perdarahan, inflamasi, dan hipoksia yang memicu nyeri hebat serta komplikasi serius.

1) Kehamilan Ektopik

Patofisiologi nyeri hebat pada kehamilan sebagai tanda bahaya dapat dijelaskan melalui mekanisme kehamilan ektopik, yaitu implantasi embrio di luar kavum uteri, umumnya di tuba falopi. Pertumbuhan embrio pada lokasi yang tidak semestinya menyebabkan peregangan berlebihan pada tuba, sehingga berisiko mengalami ruptur. Ruptur ini menimbulkan perdarahan intraabdominal yang kemudian menstimulasi nociceptor dan memicu timbulnya nyeri hebat. Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut dapat berlanjut menjadi syok hipovolemik yang mengancam keselamatan ibu, bahkan berpotensi menyebabkan kematian. Oleh karena itu, deteksi dini terhadap nyeri hebat pada trimester awal sangat penting untuk mencegah komplikasi fatal.

2) Keguguran (Abortus)

Patofisiologi nyeri hebat pada kehamilan yang berhubungan dengan keguguran dapat dijelaskan melalui mekanisme kelainan

kromosom, infeksi, trauma, atau gangguan hormonal yang mengganggu keberlangsungan kehamilan. Faktor-faktor tersebut memicu kontraksi uterus berlebihan yang menyebabkan pelepasan hasil konsepsi dari rahim. Proses pelepasan ini menimbulkan perdarahan yang kemudian mengaktifkan mediator inflamasi seperti prostaglandin dan bradikinin. Aktivasi mediator tersebut merangsang reseptor nyeri sehingga muncul nyeri perut hebat yang sering disertai perdarahan pervaginam. Kondisi ini merupakan tanda bahaya kehamilan yang harus segera dikenali melalui deteksi dini agar ibu hamil dapat memperoleh penanganan medis tepat waktu dan terhindar dari komplikasi serius.

3) Preeklampsia/Eklampsia

Patofisiologi nyeri hebat pada kehamilan yang berhubungan dengan preeklampsia/eklampsia terjadi melalui mekanisme multifaktor, meliputi gangguan vaskular plasenta, faktor genetik, imunologi, dan nutrisi. Kombinasi faktor tersebut memicu spasme pembuluh darah yang menyebabkan hipertensi sistemik. Peningkatan tekanan darah ini menimbulkan iskemia organ, termasuk hati, sehingga terjadi peregangan kapsul hati yang memunculkan nyeri epigastrium hebat. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan gejala nyeri, tetapi juga berisiko berkembang menjadi komplikasi berat berupa kejang, koma, serta gangguan fungsi hati dan ginjal. Oleh karena itu, deteksi dini terhadap nyeri hebat pada kehamilan sangat penting untuk mencegah progresi ke arah eklampsia yang dapat mengancam keselamatan ibu dan janin.

4) Abruptio Plasenta

Patofisiologi nyeri hebat pada kehamilan yang berhubungan dengan abruptio plasenta terjadi melalui mekanisme faktor risiko seperti hipertensi, trauma abdomen, usia ibu yang lanjut, serta riwayat plasenta previa. Kondisi ini memicu pelepasan plasenta dari dinding rahim sebelum waktunya, sehingga menimbulkan perdarahan retroplasenta. Akumulasi darah di belakang plasenta menyebabkan gangguan suplai oksigen ke janin (hipoksia) yang ditandai dengan distress janin. Pada ibu, perdarahan yang terjadi memicu nyeri perut mendadak dan berisiko menimbulkan syok akibat kehilangan darah dalam jumlah besar. Oleh karena itu, deteksi dini terhadap nyeri hebat yang disertai perdarahan sangat penting untuk mencegah komplikasi fatal bagi ibu maupun janin.

5) Infeksi Intrauterin

Patofisiologi nyeri hebat pada kehamilan akibat infeksi intrauterin berawal dari mekanisme masuknya bakteri atau virus ke dalam rahim

yang kemudian memicu inflamasi jaringan uterus. Proses peradangan ini menyebabkan pelepasan mediator nyeri seperti histamin dan prostaglandin yang merangsang reseptor nyeri sehingga timbul keluhan nyeri hebat. Selain itu, inflamasi yang berkelanjutan sering disertai demam sebagai respons sistemik tubuh. Jika tidak segera ditangani, infeksi dapat berkembang menjadi sepsis yang berisiko tinggi mengancam keselamatan ibu maupun janin. Oleh karena itu, deteksi dini terhadap nyeri hebat yang disertai demam sangat penting untuk mencegah komplikasi fatal.

f. Tanda dan Gejala

Tanda dan gejala nyeri hebat pada kehamilan sebagai tanda bahaya meliputi nyeri perut mendadak yang tidak membaik dengan istirahat, perdarahan pervaginam, sakit kepala parah, pandangan kabur, edema wajah/tangan, demam tinggi, serta penurunan gerakan janin. Gejala ini harus segera dikenali karena dapat mengindikasikan kondisi gawat darurat seperti kehamilan ektopik, keguguran, preeklampsia, abruptio plasenta, atau infeksi intrauterin.

- 1) Nyeri Perut Hebat
 - a) Nyeri mendadak, menetap, atau semakin parah.
 - b) Nyeri unilateral (satu sisi) pada trimester awal dengan indikasi kehamilan ektopik.
 - c) Nyeri epigastrium hebat tanda preeklampsia/eklampsia.
- 2) Perdarahan Pervaginam
 - a) Perdarahan disertai nyeri perut hebat artinya keguguran atau abruptio plasenta.
 - b) Perdarahan tanpa nyeri artinya plasenta previa.
- 3) Gejala Sistemik
 - a) Sakit kepala parah, pandangan kabur, edema wajah/tangan artinya tanda preeklampsia.
 - b) Demam tinggi disertai nyeri perut artinya infeksi intrauterin, risiko sepsis.
- 4) Gangguan Janin

Penurunan atau hilangnya gerakan janin artinya distress janin akibat hipoksia (misalnya pada abruptio plasenta).
- 5) Gejala Tambahan
 - a) Pusing, lemas, hingga tanda syok (tekanan darah turun, nadi cepat) artinya perdarahan masif intraabdominal.

- b) Perut terasa sangat kaku artinya indikasi solusio plasenta.

Nyeri hebat pada kehamilan tidak boleh dianggap normal bila disertai perdarahan, demam, sakit kepala parah, gangguan penglihatan, edema, atau penurunan gerakan janin. Deteksi dini gejala ini sangat penting untuk mencegah komplikasi fatal bagi ibu dan janin.

g. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang untuk deteksi dini tanda bahaya kehamilan dengan nyeri hebat meliputi pemeriksaan laboratorium, ultrasonografi (USG), pemeriksaan tekanan darah, serta evaluasi fungsi organ ibu. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab nyeri hebat seperti kehamilan ektopik, keguguran, preeklampsia, abrupcio plasenta, maupun infeksi intrauterin sehingga penanganan dapat dilakukan segera.

1) Pemeriksaan Laboratorium

- a) Tes darah lengkap untuk mendeteksi anemia, infeksi, atau perdarahan.
- b) Tes fungsi hati dan ginjal penting pada kasus preeklampsia/eklampsia.
- c) Tes koagulasi untuk menilai risiko perdarahan pada abrupcio plasenta.
- d) Tes infeksi (HIV, Hepatitis, Sifilis, TORCH) mendeteksi infeksi intrauterin.
- e) Tes urin untuk proteinuria sebagai tanda preeklampsia.

2) Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)

- a) USG transvaginal untuk mendeteksi kehamilan ektopik pada trimester awal.
- b) USG abdomen untuk menilai kondisi plasenta, perdarahan retroplasenta, dan kesejahteraan janin.
- c) Doppler USG untuk menilai aliran darah uteroplasenta dan janin.

3) Pemeriksaan Tekanan Darah & Fisik

- a) Pengukuran tekanan darah untuk deteksi dini hipertensi pada preeklampsia.
- b) Pemeriksaan Leopold dan DJJ (denyut jantung janin) untuk menilai posisi janin dan tanda distress janin.

4) Pemeriksaan Tambahan

- a) CTG (Cardiotocography) untuk memantau kesejahteraan janin dan kontraksi uterus.
- b) EKG untuk bila ada indikasi gangguan jantung pada ibu.
- c) Pemeriksaan suhu tubuh untuk mendeteksi demam akibat infeksi intrauterin.

Deteksi dini tanda bahaya kehamilan dengan nyeri hebat harus dilakukan melalui kombinasi pemeriksaan laboratorium, USG, tekanan darah, dan evaluasi fungsi organ. Pemeriksaan ini membantu membedakan apakah nyeri hebat disebabkan oleh kehamilan ektopik, keguguran, preeklampsia, abruptio plasenta, atau infeksi intrauterin, sehingga intervensi cepat dapat menyelamatkan ibu dan janin.

h. Komplikasi

Komplikasi dari tanda bahaya kehamilan dengan nyeri hebat sangat bergantung pada penyebab dasarnya, namun secara umum dapat mengancam keselamatan ibu dan janin. Nyeri hebat yang tidak segera ditangani dapat berujung pada perdarahan masif, syok hipovolemik, infeksi sistemik (sepsis), gangguan fungsi organ, hingga kematian ibu. Pada janin, komplikasi yang sering muncul adalah hipoksia, pertumbuhan terhambat, kelahiran prematur, hingga kematian intrauterin.

- 1) Kehamilan ektopik dapat menimbulkan komplikasi serius berupa ruptur tuba falopi yang menyebabkan perdarahan intraabdominal. Kondisi ini memicu syok hipovolemik dan bila tidak segera ditangani dapat berujung pada kematian ibu.
- 2) Keguguran (abortus) sering disertai perdarahan masif yang berisiko menimbulkan anemia. Selain itu, dapat terjadi infeksi sekunder akibat sisa jaringan yang tertinggal di rahim, serta gangguan psikologis pada ibu karena kehilangan kehamilan.
- 3) Preeklampsia/eklampsia dapat berkembang menjadi komplikasi berat berupa kejang, koma, gagal ginjal, gangguan fungsi hati, hingga sindrom HELLP. Kondisi ini sangat berbahaya karena berisiko tinggi menyebabkan kematian ibu maupun janin.
- 4) Abruptio plasenta ditandai dengan perdarahan retroplasenta yang mengganggu suplai oksigen ke janin sehingga menimbulkan hipoksia. Akibatnya, janin berisiko lahir prematur atau meninggal, sementara ibu dapat mengalami syok akibat perdarahan hebat.
- 5) Infeksi intrauterin dapat berkembang menjadi sepsis maternal yang mengancam nyawa ibu. Selain itu, infeksi dapat memicu kelahiran prematur, menimbulkan infeksi kongenital pada janin, dan meningkatkan risiko kematian perinatal.

i. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan tanda bahaya kehamilan dengan nyeri hebat berfokus pada stabilisasi ibu, identifikasi penyebab, dan pencegahan

komplikasi. Langkah utama meliputi resusitasi cairan bila ada perdarahan, pemberian obat sesuai indikasi (misalnya antihipertensi pada preeklampsia), tindakan operatif bila terjadi ruptur atau abruptio plasenta, serta antibiotik pada infeksi intrauterin. Deteksi dini melalui pemeriksaan antenatal rutin sangat penting agar intervensi cepat dapat menyelamatkan ibu dan janin.

1) Kehamilan Ektopik

- a) Stabilisasi hemodinamik dengan cairan intravena dan transfusi darah bila ada perdarahan.
- b) Tindakan operatif seperti salpingektomi atau salpingostomi untuk mengatasi ruptur tuba.
- c) Monitoring ketat tanda vital ibu.

2) Keguguran (Abortus)

- a) Evakuasi hasil konsepsi dengan kuretase atau aspirasi vakum manual.
- b) Pemberian uterotonika untuk menghentikan perdarahan.
- c) Antibiotik profilaksis bila ada risiko infeksi.
- d) Konseling psikologis untuk mendukung kondisi mental ibu.

3) Preeklampsia/Eklampsia

- a) Antihipertensi (misalnya nifedipin, labetalol) untuk menurunkan tekanan darah.
- b) Magnesium sulfat sebagai profilaksis kejang.
- c) Monitoring fungsi organ (hati, ginjal).
- d) Terminasi kehamilan bila kondisi ibu/ janin memburuk.

4) Abruptio Plasenta

- a) Resusitasi cairan dan transfusi darah untuk mengatasi syok.
- b) Monitoring janin dengan CTG.
- c) Persalinan segera (induksi atau seksio sesarea) bila janin distress atau perdarahan masif.

5) Infeksi Intrauterin

- a) Antibiotik spektrum luas sesuai hasil kultur.
- b) Monitoring suhu tubuh dan tanda vital
- c) Terminasi kehamilan bila infeksi berat atau risiko sepsis tinggi.

Penatalaksanaan nyeri hebat pada kehamilan harus individual sesuai etiologi, namun prinsip utamanya adalah stabilisasi ibu, kontrol perdarahan/infeksi, monitoring janin, dan terminasi kehamilan bila diperlukan. Deteksi dini melalui ANC rutin dan edukasi ibu hamil sangat krusial untuk mencegah komplikasi fatal.

j. Asuhan Kebidanan

Asuhan kebidanan pada deteksi dini tanda bahaya kehamilan dengan nyeri hebat berfokus pada upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk menjaga keselamatan ibu dan janin. Bidan berperan penting dalam melakukan skrining faktor risiko, mengenali tanda bahaya, memberikan pertolongan pertama, serta melakukan rujukan tepat waktu.

1) Promotif

- a) Edukasi ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan (nyeri hebat, perdarahan, demam, penurunan gerakan janin).
- b) Penyuluhan mengenai pentingnya pemeriksaan antenatal care (ANC) rutin.
- c) Peningkatan pengetahuan keluarga agar mampu mendukung ibu hamil dalam mengenali gejala bahaya.

2) Preventif

- a) Pemantauan tekanan darah, berat badan, dan status gizi ibu secara berkala.
- b) Pemeriksaan laboratorium (Hb, proteinuria, fungsi hati/ ginjal) untuk deteksi dini komplikasi.
- c) Pemberian suplemen zat besi, asam folat, dan nutrisi seimbang untuk mencegah anemia dan komplikasi.

3) Kuratif

Penanganan awal sesuai kondisi:

- a) Perdarahan penanganan awal dengan cara stabilisasi cairan, kompresi uterus, segera rujuk.
- b) Preeklampsia penanganan awal dengan cara istirahat, monitoring tekanan darah, pemberian obat sesuai indikasi medis.
- c) Infeksi penanganan awal dengan cara observasi suhu tubuh, pemberian antibiotik sesuai protokol medis.
- d) Dokumentasi lengkap hasil pemeriksaan dan tindakan.

4) Rehabilitatif

- a) Dukungan psikologis bagi ibu yang mengalami keguguran atau komplikasi.
- b) Konseling keluarga untuk mencegah kejadian berulang pada kehamilan berikutnya.
- c) Pemantauan pasca persalinan untuk memastikan pemulihan ibu dan bayi.

k. Red Flags dan Rujukan

Red Flags dan Rujukan pada Deteksi Dini Tanda Bahaya Kehamilan dengan Nyeri Hebat sangat penting untuk mencegah komplikasi fatal. Red flags adalah tanda klinis yang menunjukkan kondisi gawat darurat, sedangkan rujukan merupakan langkah cepat untuk membawa ibu hamil ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.

1) Red Flags Nyeri Hebat pada Kehamilan

Red flags nyeri hebat pada kehamilan yang harus segera dikenali meliputi nyeri perut mendadak dan menetap yang tidak membaik dengan istirahat, perdarahan pervaginam disertai nyeri hebat, sakit kepala parah dengan pandangan kabur serta edema wajah atau tangan yang mengindikasikan preeklampsia/eklampsia, demam tinggi disertai nyeri perut sebagai tanda infeksi intrauterin dengan risiko sepsis, penurunan atau hilangnya gerakan janin yang menunjukkan distress akibat hipoksia, serta tanda syok berupa tekanan darah menurun, nadi cepat, dan kulit pucat atau dingin. Semua kondisi ini merupakan tanda bahaya yang membutuhkan deteksi dini dan rujukan segera ke fasilitas kesehatan rujukan agar ibu dan janin dapat diselamatkan.

2) Prinsip Rujukan

- a) Segera rujuk ke fasilitas kesehatan rujukan (RS dengan layanan obstetri emergensi) bila ditemukan red flags.
- b) Stabilisasi awal sebelum rujukan: cairan intravena, transfusi darah bila perlu, monitoring tanda vital.
- c) Dokumentasi lengkap hasil pemeriksaan dan tindakan awal untuk memudahkan tim medis lanjutan.
- d) Komunikasi efektif dengan keluarga agar memahami urgensi rujukan.
- e) Transportasi aman dengan pendampingan tenaga kesehatan bila memungkinkan.

I. Dokumentasi

1) Data Subjektif

- a) Keluhan utama yaitu nyeri perut hebat, mendadak, menetap.
- b) Keluhan tambahan yaitu perdarahan pervaginam, sakit kepala, pandangan kabur, demam, penurunan gerakan janin.
- c) Riwayat obstetric yaitu kehamilan sebelumnya, riwayat keguguran, hipertensi, trauma, atau infeksi.

2) Data Objektif

- a) Hasil pemeriksaan fisik: tekanan darah, nadi, suhu, edema, tanda syok.

- b) Pemeriksaan obstetri: DJJ (denyut jantung janin), kontraksi uterus, pemeriksaan Leopold.
- c) Pemeriksaan penunjang: USG, laboratorium (Hb, fungsi hati/ ginjal, proteinuria), CTG.
- 3) Analisis
 - a) Identifikasi masalah: nyeri hebat sebagai tanda bahaya kehamilan.
 - b) Diagnosa kebidanan: kemungkinan kehamilan ektopik, abortus, preeklampsia/eklampsia, abruptio plasenta, atau infeksi intrauterin.
- 4) Rencana
 - a) Stabilisasi kondisi ibu (cairan intravena, monitoring tanda vital).
 - b) Edukasi ibu dan keluarga tentang tanda bahaya.
 - c) Persiapan rujukan ke fasilitas kesehatan rujukan.
- 5) Tindakan
 - a) Pertolongan pertama sesuai kondisi (misalnya pemberian uterotonika, antihipertensi, antibiotik).
 - b) Dokumentasi tindakan yang dilakukan secara rinci.
 - c) Rujukan segera bila ditemukan red flags.
- 6) Evaluasi
 - a) Menilai respon ibu terhadap tindakan.
 - b) Monitoring kondisi janin.
 - c) Evaluasi keberhasilan rujukan dan tindak lanjut.

4. Demam

Deteksi dini tanda bahaya kehamilan dengan demam adalah upaya mengenali peningkatan suhu tubuh ibu hamil ($>38^{\circ}\text{C}$) sebagai gejala infeksi atau kondisi patologis yang dapat mengancam keselamatan ibu dan janin. Demam pada kehamilan bukan sekadar keluhan umum, melainkan indikator adanya gangguan serius seperti infeksi intrauterin, ISK, influenza, atau penyakit sistemik yang dapat meningkatkan risiko keguguran, kelahiran prematur, cacat lahir, hingga sepsis.

a. Definisi

Deteksi dini tanda bahaya kehamilan dengan demam adalah proses identifikasi cepat terhadap peningkatan suhu tubuh ibu hamil yang mencapai $\geq 38^{\circ}\text{C}$ dan berlangsung lebih dari 24 jam, terutama bila disertai gejala lain seperti nyeri perut, keputihan berbau, penurunan gerakan janin, atau tanda syok. Demam pada kehamilan dianggap sebagai red flag karena dapat menandakan adanya infeksi bakteri (misalnya ISK, pneumonia, infeksi

ketuban), infeksi virus (TORCH, influenza, COVID-19), maupun kondisi sistemik lain yang berisiko menyebabkan komplikasi serius.

Deteksi dini dilakukan melalui pemeriksaan antenatal care (ANC) rutin, pengukuran suhu tubuh, anamnesis keluhan ibu, serta pemeriksaan penunjang bila diperlukan. Tujuannya adalah mencegah progresi penyakit, melindungi janin dari hipoksia atau cacat lahir, serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

b. Klasifikasi

Klasifikasi deteksi dini tanda bahaya kehamilan dengan demam dilakukan untuk memudahkan tenaga kesehatan mengenali tingkat keparahan dan penyebab demam pada ibu hamil. Demam pada kehamilan dapat dikategorikan berdasarkan derajat suhu tubuh, durasi, dan etiologi.

- 1) Berdasarkan Derajat Suhu
 - a) Demam ringan: 38–38,5°C artinya sering terkait infeksi ringan (misalnya ISK).
 - b) Demam sedang: 38,6–39°C artinya dapat mengindikasikan infeksi intrauterin atau pneumonia.
 - c) Demam tinggi: $\geq 39^{\circ}\text{C}$ artinya berisiko menyebabkan hipoksia janin, kelahiran prematur, bahkan sepsis.
- 2) Berdasarkan Durasi
 - a) Akut (<7 hari) artinya biasanya akibat infeksi bakteri atau virus yang baru terjadi.
 - b) Kronis (>7 hari) artinya dapat mengindikasikan tuberkulosis, malaria, atau infeksi sistemik lain.
- 3) Berdasarkan Etiologi
 - a) Infeksi bakteri seperti ISK, pneumonia, endometritis, infeksi intrauterin.
 - b) Infeksi virus seperti TORCH (Toxoplasma, Rubella, CMV, Herpes), influenza, COVID-19.
 - c) Infeksi parasite seperti malaria, toksoplasmosis.
 - d) Non-infeksi seperti reaksi obat, penyakit autoimun, atau gangguan metabolik (WHO, 2023).

c. Etiologi

Etiologi deteksi dini tanda bahaya kehamilan dengan demam berkaitan dengan berbagai faktor yang dapat memicu peningkatan suhu

tubuh ibu hamil. Demam pada kehamilan umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri (misalnya infeksi saluran kemih, pneumonia, endometritis, atau infeksi intrauterin), infeksi virus (TORCH: Toxoplasma, Rubella, CMV, Herpes; influenza; COVID-19), serta infeksi parasit (malaria, toksoplasmosis). Selain itu, terdapat etiologi non-infeksi seperti reaksi obat, penyakit autoimun, atau gangguan metabolik yang juga dapat menimbulkan demam. Deteksi dini terhadap etiologi ini sangat penting karena demam pada kehamilan dapat meningkatkan risiko keguguran, kelahiran prematur, cacat lahir, hingga sepsis maternal.

d. Faktor Risiko

Faktor risiko deteksi dini tanda bahaya kehamilan dengan demam mencakup kondisi ibu maupun lingkungan yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap infeksi atau gangguan sistemik. Demam pada kehamilan sering kali berhubungan dengan status imun ibu yang menurun, sehingga lebih mudah terinfeksi bakteri, virus, atau parasit. Faktor risiko lain meliputi riwayat penyakit kronis (misalnya diabetes, hipertensi, HIV/AIDS), status gizi buruk atau anemia, riwayat infeksi berulang (seperti ISK atau pneumonia), paparan lingkungan tidak higienis, serta usia ibu ekstrem (<20 tahun atau >35 tahun). Selain itu, riwayat obstetri buruk (abortus berulang, ketuban pecah dini, atau riwayat infeksi intrauterin sebelumnya) juga meningkatkan risiko demam sebagai tanda bahaya. Deteksi dini faktor risiko ini penting agar tenaga kesehatan dapat melakukan pencegahan melalui pemeriksaan antenatal rutin, edukasi, dan intervensi cepat bila muncul gejala.

e. Patofisiologi

Patofisiologi deteksi dini tanda bahaya kehamilan dengan demam berawal dari masuknya mikroorganisme (bakteri, virus, atau parasit) ke dalam tubuh ibu hamil yang memicu respon imun. Aktivasi sistem imun menyebabkan pelepasan mediator inflamasi seperti interleukin, prostaglandin, dan TNF- α yang bekerja pada hipotalamus sehingga terjadi peningkatan suhu tubuh (demam). Pada ibu hamil, perubahan fisiologis berupa penurunan imunitas seluler membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi. Demam yang menetap dapat mengganggu homeostasis, meningkatkan metabolisme, dan menimbulkan hipoksia janin akibat gangguan suplai oksigen. Bila inflamasi berlanjut, risiko komplikasi seperti sepsis maternal, kelahiran prematur, gangguan pertumbuhan janin, hingga

kematian perinatal semakin tinggi. Oleh karena itu, deteksi dini demam pada kehamilan sangat penting untuk mencegah progresi penyakit dan komplikasi fatal.

f. Tanda dan Gejala

Tanda dan gejala deteksi dini tanda bahaya kehamilan dengan demam meliputi peningkatan suhu tubuh $\geq 38^{\circ}\text{C}$ yang menetap, disertai gejala sistemik seperti menggigil, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga gejala obstetri seperti nyeri perut, keputihan berbau, perdarahan, atau penurunan gerakan janin. Kondisi ini harus segera diwaspadai karena dapat menandakan infeksi intrauterin, ISK, pneumonia, atau penyakit sistemik yang berisiko tinggi bagi ibu dan janin.

- 1) Gejala Umum
 - a) Suhu tubuh $\geq 38^{\circ}\text{C}$ yang berlangsung lebih dari 24 jam.
 - b) Menggigil, berkeringat berlebihan, sakit kepala, nyeri otot, dan lemas.
 - c) Hilang nafsu makan, dehidrasi, dan rasa panas di tubuh.
- 2) Gejala Obstetri
 - a) Nyeri perut hebat indikasi infeksi intrauterin atau komplikasi obstetri.
 - b) Keputihan berbau atau perdarahan pervaginam sebagai tanda infeksi ketuban (korioamnionitis).
 - c) Penurunan atau hilangnya gerakan janin disebabkan oleh distress janin akibat hipoksia.
- 3) Gejala Sistemik Tambahan
 - a) Sesak napas atau batuk berarti pneumonia atau infeksi saluran pernapasan.
 - b) Nyeri punggung atau nyeri saat berkemih berarti infeksi saluran kemih.
 - c) Ruam kulit dan nyeri sendi berarti infeksi virus TORCH (CMV, Rubella, Parvovirus).

g. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang deteksi dini tanda bahaya kehamilan dengan demam mencakup pemeriksaan laboratorium, pencitraan, serta pemantauan klinis untuk mengidentifikasi penyebab infeksi dan dampaknya pada ibu maupun janin. Pemeriksaan ini penting karena demam pada

kehamilan dapat menandakan kondisi serius seperti infeksi intrauterin, ISK, pneumonia, atau penyakit sistemik.

1) Pemeriksaan Laboratorium

a) Darah lengkap (Hb, leukosit, trombosit)

- Hemoglobin (Hb): menilai adanya anemia yang dapat memperburuk kondisi ibu hamil dengan demam.
- Leukosit: peningkatan leukosit menunjukkan adanya infeksi bakteri atau inflamasi.
- Trombosit: penurunan trombosit dapat mengarah pada komplikasi seperti sepsis atau sindrom HELLP.

b) CRP/Prokalsitonin

- C-Reactive Protein (CRP): marker inflamasi yang meningkat pada infeksi bakteri maupun inflamasi sistemik.
- Prokalsitonin: lebih spesifik untuk mendeteksi infeksi bakteri sistemik dan sepsis maternal.

c) Fungsi hati dan ginjal

- SGOT/SGPT, bilirubin: menilai kerusakan hati, terutama pada preeklampsia/eklampsia dengan demam.
- Ureum, kreatinin: menilai fungsi ginjal, penting karena demam dapat memperburuk gangguan ginjal pada ibu hamil.

d) Urin lengkap & kultur urin

- Urin lengkap: mendeteksi proteinuria (indikasi preeklampsia) atau leukosituria (infeksi saluran kemih).
- Kultur urin: mengidentifikasi jenis bakteri penyebab ISK untuk menentukan terapi antibiotik yang tepat.

e) Serologi TORCH, HIV, Hepatitis, Sifilis

- TORCH (Toxoplasma, Rubella, CMV, Herpes): mendeteksi infeksi virus yang dapat menyebabkan kelainan kongenital.
- HIV, Hepatitis B/C, Sifilis: skrining infeksi menular yang berisiko ditularkan ke janin.

f) Tes malaria (daerah endemis)

Rapid test malaria atau pemeriksaan mikroskopis darah tepi: mendeteksi infeksi parasit malaria yang sering menyebabkan demam menetap pada ibu hamil dan berisiko tinggi menimbulkan anemia berat serta komplikasi obstetri.

2) Pemeriksaan Pencitraan

a) USG Obstetri

Digunakan untuk menilai kondisi janin, plasenta, dan cairan ketuban. Membantu mendeteksi adanya infeksi intrauterin (korioamnionitis) melalui tanda-tanda seperti perubahan volume cairan ketuban atau gangguan pertumbuhan janin. Menilai kesejahteraan janin dengan pemeriksaan biometri janin, gerakan janin, dan denyut jantung janin.

b) USG Abdomen/Pelvis

Bertujuan mendeteksi adanya abses intraabdominal atau pelvis yang dapat menjadi sumber demam. Menilai organ reproduksi (rahim, ovarium, tuba falopi) bila dicurigai adanya komplikasi infeksi. Membantu mengidentifikasi komplikasi obstetri seperti hematoma atau perdarahan internal yang disertai demam.

c) Foto Toraks (X-ray dengan proteksi abdomen)

Dilakukan bila ada kecurigaan pneumonia atau infeksi saluran pernapasan sebagai penyebab demam. Proteksi abdomen wajib diberikan untuk melindungi janin dari paparan radiasi. Memberikan gambaran kondisi paru-paru, misalnya adanya infiltrat, efusi pleura, atau tanda infeksi lain.

3) Pemeriksaan Obstetri

a) Pemantauan Suhu Tubuh Secara Berkala

Dilakukan untuk memastikan apakah demam bersifat menetap atau fluktuatif. Membantu menentukan pola demam (intermiten, remiten, atau kontinyu) yang dapat mengarahkan pada etiologi (misalnya malaria, infeksi bakteri, atau virus). Penting untuk mendeteksi dini risiko komplikasi seperti sepsis maternal atau hipoksia janin akibat demam tinggi.

b) CTG (Cardiotocography)

Digunakan untuk menilai kesejahteraan janin bila ibu mengalami demam tinggi. Merekam denyut jantung janin (DJJ) dan kontraksi uterus secara simultan. Demam ibu dapat menyebabkan takikardia janin atau pola DJJ abnormal yang menunjukkan distress janin. Hasil CTG membantu menentukan apakah perlu dilakukan intervensi segera (misalnya terminasi kehamilan).

c) Leopold & DJJ (Denyut Jantung Janin)

Palpasi Leopold digunakan untuk menilai posisi, presentasi, dan letak janin. Auskultasi DJJ dilakukan untuk mendeteksi adanya distress janin akibat hipoksia yang sering terjadi bila ibu mengalami demam tinggi. DJJ normal berkisar 110–160 bpm; takikardia atau bradikardia dapat

menjadi tanda bahaya. Pemeriksaan ini sederhana, cepat, dan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan primer untuk deteksi dini.

4) Pemeriksaan Tambahan

a) Kultur Darah

Dilakukan bila ada kecurigaan sepsis maternal. Bertujuan mengidentifikasi jenis mikroorganisme penyebab infeksi sistemik. Hasil kultur darah membantu menentukan terapi antibiotik yang tepat dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Penting karena sepsis pada ibu hamil dapat menyebabkan syok septik, keguguran, kelahiran prematur, hingga kematian maternal.

b) Swab Serviks/Vagina

Dilakukan bila ibu hamil mengalami keputihan berbau, nyeri perut, atau demam tinggi. Bertujuan mendeteksi adanya infeksi intrauterin (korioamnionitis) atau infeksi saluran genital. Hasil swab dapat menunjukkan adanya bakteri patogen seperti *E. coli*, Group B Streptococcus, atau Chlamydia. Pemeriksaan ini penting untuk mencegah infeksi ketuban, kelahiran prematur, dan sepsis neonatal.

c) EKG (Elektrokardiografi)

Dilakukan bila ada indikasi gangguan jantung akibat infeksi sistemik atau sepsis. Bertujuan menilai fungsi jantung ibu, karena demam tinggi dan infeksi berat dapat memicu takikardia, aritmia, atau gagal jantung akut. Pemeriksaan EKG membantu memastikan apakah gejala sistemik (misalnya sesak napas, palpitasi) berkaitan dengan komplikasi kardiovaskular.

h. Komplikasi

1) Komplikasi Pada Ibu

a) Sepsis Maternal

Demam dapat menjadi manifestasi awal infeksi sistemik. Bila tidak ditangani, infeksi dapat berkembang menjadi sepsis, ditandai dengan hipotensi, takikardia, dan gangguan organ multipel. Sepsis maternal berisiko tinggi menyebabkan syok septik dan kematian ibu.

b) Preeklampsia/Eklampsia

Demam dapat memperburuk kondisi hipertensi dalam kehamilan. Inflamasi sistemik meningkatkan stres oksidatif dan kerusakan endotel, memperparah preeklampsia. Pada kasus berat, dapat berkembang menjadi eklampsia dengan kejang, yang meningkatkan risiko kematian maternal dan janin.

c) Gangguan Organ

Kerusakan hati (sindrom HELLP): hemolisis, peningkatan enzim hati, dan trombositopenia. Gagal ginjal akut: akibat hipoperfusi ginjal pada sepsis atau preeklampsia. Gangguan jantung: infeksi sistemik dapat memicu takikardia, aritmia, atau gagal jantung akut.

d) Anemia Berat

Demam akibat malaria atau infeksi kronis dapat menyebabkan hemolisis dan penurunan Hb signifikan. Anemia berat memperburuk hipoksia ibu dan janin, meningkatkan risiko kematian perinatal dan komplikasi obstetri.

2) Komplikasi Pada janin

a) Hipoksia Janin

Demam meningkatkan metabolisme ibu sehingga kebutuhan oksigen meningkat. Gangguan perfusi plasenta akibat inflamasi menyebabkan suplai oksigen ke janin berkurang. Akibatnya janin mengalami distress yang ditandai dengan takikardia atau bradikardia, berisiko pada pertumbuhan terhambat hingga kematian janin.

b) Keguguran Spontan

Demam tinggi pada trimester awal dapat memicu kontraksi uterus dan meningkatkan risiko keguguran. Infeksi sistemik (misalnya TORCH atau malaria) juga dapat menyebabkan kerusakan embrio sehingga kehamilan tidak dapat dipertahankan.

c) Kelahiran Prematur

Infeksi intrauterin seperti korioamnionitis memicu pelepasan prostaglandin yang menstimulasi kontraksi dini. Hal ini meningkatkan risiko persalinan sebelum usia kehamilan cukup bulan, dengan dampak bayi lahir prematur dan rentan komplikasi pernapasan maupun infeksi.

d) Kelainan Kongenital

Infeksi TORCH (Toxoplasma, Rubella, CMV, Herpes) yang disertai demam dapat menyebabkan cacat lahir. Manifestasi yang sering muncul: mikrosefali, gangguan pendengaran, kelainan jantung bawaan, retardasi mental. Risiko lebih tinggi bila infeksi terjadi pada trimester pertama saat organogenesis janin berlangsung.

e) Kematian Perinatal

Distress janin yang tidak tertangani dapat berujung pada kematian intrauterin. Demam tinggi yang menetap meningkatkan risiko stillbirth atau kematian neonatal segera setelah lahir.

i. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan deteksi dini tanda bahaya kehamilan dengan demam berfokus pada identifikasi penyebab, stabilisasi kondisi ibu, serta perlindungan janin. Prinsip utama adalah segera menurunkan suhu tubuh, mengatasi etiologi (infeksi bakteri, virus, atau parasit), dan melakukan monitoring ketat terhadap ibu dan janin.

1) Penatalaksanaan Umum

- a) Pemantauan suhu tubuh secara berkala untuk menilai progresi demam.
- b) Istirahat cukup dan pembatasan aktivitas fisik untuk mendukung sistem imun.
- c) Hidrasi optimal dengan minum air putih atau cairan sehat untuk mencegah dehidrasi.
- d) Nutrisi bergizi seimbang untuk memperkuat daya tahan tubuh.
- e) Kompres hangat atau mandi air suam-suam kuku untuk membantu menurunkan suhu tubuh.

2) Farmakologis

- a) Parasetamol adalah obat antipiretik yang relatif aman untuk ibu hamil, digunakan sesuai dosis dokter.
- b) Antibiotik diberikan bila penyebab demam adalah infeksi bakteri (misalnya ISK, pneumonia).
- c) Antivirus atau antiparasit sesuai indikasi (misalnya malaria, influenza, atau TORCH).
- d) Hindari obat NSAID (aspirin, ibuprofen) tanpa rekomendasi dokter karena berisiko pada janin.

3) Monitoring Obstetri

- a) CTG (Cardiotocography) untuk menilai kesejahteraan janin bila ibu mengalami demam tinggi.
- b) USG obstetri untuk memantau kondisi plasenta, cairan ketuban, dan pertumbuhan janin.
- c) DJJ (denyut jantung janin) dipantau secara berkala untuk mendeteksi distress janin.

4) Indikasi Rujukan

- a) Suhu tubuh $\geq 38,9^{\circ}\text{C}$ yang menetap >24 jam.
- b) Disertai gejala bahaya: perdarahan, nyeri perut hebat, keputihan berbau, penurunan gerakan janin.

- c) Adanya tanda sepsis maternal (hipotensi, takikardia, gangguan organ multipel).

5) Pencegahan

- a) ANC rutin dengan pemeriksaan laboratorium dan pencitraan bila perlu.
- b) Edukasi ibu hamil untuk segera melapor bila mengalami demam tinggi.
- c) Kebersihan diri dan lingkungan untuk mencegah infeksi.
- d) Imunisasi (misalnya influenza, hepatitis B) sesuai rekomendasi dokter.

j. Asuhan Kebidanan

Teori Asuhan Kebidanan Deteksi Dini Tanda Bahaya Kehamilan dengan Demam menekankan pada pendekatan komprehensif yang melibatkan pengkajian, diagnosa kebidanan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Tujuannya adalah menjaga keselamatan ibu dan janin dengan intervensi cepat serta pencegahan komplikasi.

1) Pengkajian

- a) Identitas ibu: usia, paritas, riwayat obstetri.
- b) Keluhan utama: demam, nyeri perut, keputihan berbau, perdarahan, penurunan gerakan janin.
- c) Riwayat kesehatan: penyakit kronis (diabetes, hipertensi, HIV), riwayat infeksi berulang.
- d) Pemeriksaan fisik: suhu tubuh, tanda vital, pemeriksaan obstetri (Leopold, DJJ).
- e) Pemeriksaan penunjang: laboratorium (darah lengkap, urin, serologi), USG, CTG.

2) Diagnosa Kebidanan

- a) Ibu hamil dengan demam akibat infeksi (bakteri, virus, parasit).
- b) Risiko tinggi terhadap komplikasi maternal (sepsis, preeklampsia) dan janin (hipoksia, prematuritas).

3) Perencanaan

- a) Tujuan jangka pendek: menurunkan suhu tubuh, mengurangi gejala, memastikan kondisi janin stabil.
- b) Tujuan jangka panjang: mencegah komplikasi ibu dan janin, menjaga kehamilan hingga aterm.
- c) Rencana tindakan: pemantauan suhu, pemberian antipiretik sesuai indikasi, hidrasi, nutrisi, pemeriksaan penunjang, rujukan bila ada tanda bahaya.

4) Implementasi

- a) Non-farmakologis: kompres hangat, istirahat, hidrasi, edukasi tanda bahaya.
- b) Farmakologis: pemberian antipiretik (parasetamol), antibiotik/antiparasit sesuai hasil pemeriksaan.
- c) Monitoring obstetri: CTG, DJJ, USG untuk menilai kesejahteraan janin.
- d) Rujukan: bila demam tinggi menetap, ada tanda sepsis, atau distress janin.

5) Evaluasi

- a) Suhu tubuh ibu kembali normal.
- b) Tidak ada tanda sepsis atau komplikasi organ.
- c) Janin dalam kondisi baik (DJJ normal, gerakan janin ada).
- d) Ibu memahami tanda bahaya dan pentingnya pemeriksaan antenatal rutin.

k. Red Flags dan Rujukan

Teori Red Flags dan Rujukan Deteksi Dini Tanda Bahaya Kehamilan dengan Demam menekankan pada tanda-tanda klinis yang harus segera dikenali oleh tenaga kesehatan maupun ibu hamil, karena berhubungan dengan risiko tinggi komplikasi maternal dan janin. Red flags ini menjadi dasar untuk menentukan indikasi rujukan segera ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.

1) Red Flags pada Ibu

- a) Suhu tubuh $\geq 38,9^{\circ}\text{C}$ yang menetap lebih dari 24 jam
- b) Disertai nyeri perut hebat atau kontraksi dini.
- c) Perdarahan pervaginam yang tidak normal.
- d) Keputihan berbau atau cairan ketuban keruh merupakan indikasi korioamnionitis.
- e) Tanda sepsis maternal: hipotensi, takikardia, napas cepat, penurunan kesadaran.
- f) Gangguan organ: ikterus, oliguria, edema berat, kejang.

2) Red Flags pada Janin

- a) Penurunan atau hilangnya gerakan janin.
- b) DJJ abnormal (takikardia > 160 bpm atau bradikardia < 110 bpm).
- c) Distress janin pada CTG (decelerasi berulang, variabilitas menurun).
- d) Pertumbuhan janin terhambat atau tanda hipoksia intrauterin.

3) Teori Rujukan

- a) Rujukan segera dilakukan bila ibu hamil dengan demam menunjukkan red flags di atas.
- b) Prinsip rujukan: stabilisasi terlebih dahulu (hidrasi, antipiretik, oksigen bila perlu) sebelum transportasi.
- c) Rujukan ke RS dengan fasilitas obstetri dan neonatal lengkap (NICU, ICU maternal).
- d) Komunikasi antar fasilitas harus jelas: diagnosis sementara, tindakan yang sudah dilakukan, kondisi ibu dan janin saat dirujuk.

I. Dokumentasi

1) S (Subjective)

- a) Ibu hamil mengeluh demam sejak 2 hari terakhir.
- b) Keluhan tambahan: nyeri perut, keputihan berbau, penurunan gerakan janin.
- c) Riwayat obstetri: G2P1A0, usia kehamilan 28 minggu.
- d) Riwayat penyakit: tidak ada hipertensi/diabetes, namun pernah ISK sebelumnya.

2) O (Objective)

- a) Suhu tubuh: 38,9°C.
- b) Tekanan darah: 110/70 mmHg, nadi: 110x/menit, RR: 24x/menit.
- c) DJJ: 170 bpm (takikardia janin).
- d) Pemeriksaan laboratorium: leukositosis, proteinuria (+), kultur urin positif E. coli.
- e) USG obstetri: janin hidup, cairan ketuban normal, plasenta tampak baik.

3) A (Assessment)

- a) Ibu hamil trimester II dengan demam akibat infeksi saluran kemih.
- b) Risiko tinggi terhadap sepsis maternal dan distress janin.
- c) Tanda bahaya: demam tinggi menetap, keputihan berbau, DJJ abnormal.

4) P (Plan)

- a) Tindakan segera: kompres hangat, hidrasi oral/intravena, pemberian antipiretik (parasetamol).
- b) Terapi etiologi: antibiotik sesuai hasil kultur urin.
- c) Monitoring obstetri: CTG, DJJ, USG serial.
- d) Edukasi ibu: tanda bahaya kehamilan (perdarahan, nyeri perut hebat, penurunan gerakan janin).

- e) Rujukan: ke RS dengan fasilitas obstetri dan neonatal lengkap bila suhu tidak turun atau janin menunjukkan distress berulang.
- f) Evaluasi: suhu tubuh turun, DJJ kembali normal, ibu memahami tanda bahaya (Kemenkes RI, 2024).

5. Gerak Janin Berkurang

a. Definisi

Deteksi dini tanda bahaya kehamilan dengan gerakan janin berkurang adalah upaya mengenali secara cepat perubahan pola aktivitas janin yang dirasakan ibu. Gerakan janin merupakan indikator kesejahteraan janin, dan penurunan gerakan dapat menjadi tanda adanya hipoksia intrauterin, gangguan plasenta, atau risiko kematian janin.

b. Klasifikasi

- 1) Berdasarkan Etiologi
 - a) Fisiologis (Normal)
 - Janin sedang tidur (20–40 menit, kadang hingga 90 menit).
 - Posisi plasenta anterior atau ibu dengan obesitas sehingga gerakan sulit dirasakan.
 - Aktivitas ibu tinggi sehingga tidak fokus merasakan gerakan.
 - b) Patologis (Abnormal/Tanda Bahaya)
 - Hipoksia janin akibat insufisiensi plasenta atau lilitan tali pusat.
 - Gangguan cairan ketuban (oligohidramnion) yang membatasi gerakan.
 - IUGR (Intrauterine Growth Restriction) atau janin tumbuh tidak sesuai usia kehamilan.
 - Infeksi intrauterin (korioamnionitis, TORCH).
 - Stillbirth (kematian janin dalam kandungan).
- 2) Berdasarkan Derajat Keparahan
 - a) Ringan artinya gerakan janin berkurang sesekali, masih dalam batas normal setelah stimulasi (misalnya ibu makan/minum manis atau berbaring miring).
 - b) Sedang artinya gerakan janin berkurang signifikan dibanding pola biasanya, meski sudah dilakukan stimulasi.
 - c) Berat artinya gerakan janin hilang sama sekali dalam periode waktu tertentu, disertai tanda distress janin pada CTG atau DJJ abnormal.
- 3) Berdasarkan Waktu Kejadian

- a) Trimester II artinya biasanya mulai dirasakan, penurunan gerakan bisa menandakan gangguan awal pertumbuhan janin.
- b) Trimester III artinya penurunan gerakan lebih berbahaya karena terkait hipoksia, insufisiensi plasenta, atau risiko kematian perinatal.

c. Etiologi

1) Faktor Maternal

- a) Hipoksia maternal seperti anemia berat, penyakit jantung, atau gangguan pernapasan menurunkan suplai oksigen ke janin.
- b) Infeksi sistemik (misalnya sepsis, malaria, TORCH) yang memengaruhi kesejahteraan janin.
- c) Hipoglikemia atau malnutrisi artinya energi janin berkurang sehingga aktivitas menurun.
- d) Obat-obatan sedatif atau alkohol yang menekan aktivitas janin.

2) Faktor Plasenta

- a) Insufisiensi plasenta adalah aliran darah dan nutrisi ke janin tidak adekuat.
- b) Abruptio plasenta adalah pelepasan sebagian plasenta menyebabkan hipoksia janin.
- c) Trombosis atau infark plasenta adalah mengurangi perfusi ke janin.

3) Faktor Janin

- a) Hipoksia janin akibat lilitan tali pusat atau gangguan aliran darah.
- b) IUGR (Intrauterine Growth Restriction) janin tumbuh tidak sesuai usia kehamilan, aktivitas berkurang.
- c) Kelainan kongenital misalnya gangguan neuromuskular yang membatasi gerakan.
- d) Oligohidramnion cairan ketuban sedikit sehingga ruang gerak janin terbatas.
- e) Stillbirth (kematian janin intrauterin) ditandai dengan hilangnya gerakan sama sekali.

4) Faktor Fisiologis (Normal)

- a) Janin dalam fase tidur (20–40 menit, kadang hingga 90 menit).
- b) Posisi plasenta anterior atau ibu dengan obesitas sehingga gerakan sulit dirasakan.
- c) Aktivitas ibu tinggi sehingga tidak fokus merasakan gerakan.

d. Faktor Risiko

1) Faktor Maternal

- a) Usia ibu ekstrem (<20 tahun atau >35 tahun).
- b) Penyakit kronis: hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, anemia berat.
- c) Infeksi maternal: malaria, TORCH, sepsis.
- d) Kebiasaan buruk: merokok, konsumsi alkohol, atau obat-obatan terlarang.
- e) Malnutrisi atau status gizi buruk untuk menurunkan suplai energi dan oksigen ke janin.

2) Faktor Plasenta

- a) Insufisiensi plasenta artinya gangguan aliran darah dan nutrisi ke janin.
- b) Abruptio plasenta artinya pelepasan sebagian plasenta menyebabkan hipoksia janin.
- c) Kelainan vaskular plasenta artinya trombosis atau infark yang mengurangi perfusi.

3) Faktor Janin

- a) IUGR (Intrauterine Growth Restriction) artinya janin tumbuh tidak sesuai usia kehamilan.
- b) Kelainan kongenital artinya gangguan neuromuskular atau sistem saraf janin.
- c) Oligohidramnion artinya cairan ketuban sedikit sehingga ruang gerak janin terbatas.
- d) Hipoksia janin artinya akibat lilitan tali pusat atau gangguan aliran darah.
- e) Stillbirth artinya kematian janin dalam kandungan, biasanya didahului penurunan gerakan.

4) Faktor Kehamilan

- a) Kehamilan ganda Dimana ruang gerak janin terbatas.
- b) Riwayat obstetri buruk yaitu keguguran berulang, IUFD (Intrauterine Fetal Death), atau preeklampsia.
- c) Trimester lanjut (III) yaitu gerakan janin berkurang lebih berisiko karena terkait hipoksia atau insufisiensi plasenta.

e. Patofisiologi

1) Gangguan Oksigenasi

Penurunan gerakan janin sering kali merupakan respon adaptif terhadap hipoksia intrauterin. Ketika suplai oksigen dari ibu ke janin berkurang, janin akan menurunkan aktivitas motoriknya sebagai

mekanisme protektif untuk menghemat energi. Pada tahap awal, gerakan janin berkurang menjadi tanda peringatan dini adanya gangguan kesejahteraan janin. Namun, bila hipoksia berlangsung terus-menerus, akan terjadi asidosis metabolik akibat akumulasi laktat. Kondisi ini memicu distress janin, ditandai dengan denyut jantung janin abnormal dan pola gerakan yang semakin menurun. Jika tidak segera ditangani, hipoksia dan asidosis dapat berlanjut hingga menyebabkan kematian intrauterin (stillbirth).

2) Insufisiensi Plasenta

Plasenta yang tidak mampu menyalurkan oksigen dan nutrisi dengan baik akan menyebabkan gangguan perfusi janin. Kondisi ini dikenal sebagai insufisiensi plasenta, di mana aliran darah dari ibu ke janin tidak optimal sehingga suplai oksigen dan zat gizi berkurang. Mekanisme yang terjadi adalah insufisiensi plasenta menimbulkan hipoksia kronis pada janin. Hipoksia ini menghambat pertumbuhan janin sehingga terjadi Intrauterine Growth Restriction (IUGR). Akibatnya, janin mengalami penurunan aktivitas motorik sebagai bentuk adaptasi untuk menghemat energi, yang secara klinis tampak sebagai gerakan janin berkurang. Bila tidak segera ditangani, kondisi ini dapat berkembang menjadi distress janin hingga meningkatkan risiko kematian perinatal.

3) Gangguan air Ketuban

Oligohidramnion, yaitu berkurangnya volume cairan ketuban, dapat membatasi ruang gerak janin di dalam rahim. Cairan ketuban berfungsi sebagai bantalan yang melindungi janin sekaligus memberikan ruang untuk bergerak bebas. Ketika jumlah cairan ketuban berkurang, gerakan janin menjadi lebih sedikit dan sering kali sulit dirasakan oleh ibu. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi persepsi ibu terhadap aktivitas janin, tetapi juga dapat menandakan adanya gangguan kesejahteraan janin, seperti insufisiensi plasenta atau hipoksia intrauterin. Oleh karena itu, penurunan gerakan janin pada kasus oligohidramnion harus dianggap sebagai tanda bahaya yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mencegah komplikasi serius seperti pertumbuhan janin terhambat (IUGR) atau distress janin.

4) Kelainan Tali Pusat

Lilitan tali pusat atau kompresi tali pusat dapat menghambat aliran darah dan oksigen yang masuk ke janin. Kondisi ini menyebabkan suplai oksigen menjadi tidak stabil sehingga janin mengalami hipoksia intermiten. Sebagai respon adaptif terhadap kekurangan oksigen, janin

akan menurunkan aktivitas motoriknya untuk menghemat energi. Akibatnya, gerakan janin tampak berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Bila hipoksia berlangsung terus-menerus tanpa intervensi, janin berisiko mengalami distress, asidosis metabolik, hingga kematian intrauterin. Oleh karena itu, penurunan gerakan janin akibat lilitan atau kompresi tali pusat harus dianggap sebagai tanda bahaya yang memerlukan deteksi dini dan pemeriksaan lanjutan dengan USG atau CTG.

5) Kelaianan janin

Kelainan neuromuskular atau kongenital, seperti gangguan pada sistem saraf pusat, dapat menyebabkan janin tidak mampu bergerak secara normal. Hal ini terjadi karena adanya gangguan pada sistem saraf yang menghambat penghantaran impuls motorik dari otak ke otot janin. Akibatnya, impuls motorik yang dihasilkan tidak adekuat sehingga aktivitas motorik janin menjadi minimal. Kondisi ini tampak secara klinis sebagai penurunan gerakan janin yang signifikan, yang harus dianggap sebagai tanda bahaya kehamilan. Deteksi dini melalui pemantauan gerakan janin, pemeriksaan USG, dan evaluasi lanjutan sangat penting untuk memastikan kesejahteraan janin serta mencegah komplikasi lebih lanjut.

6) Kematian Janin

Bila hipoksia dan asidosis yang dialami janin tidak segera tertangani, kondisi tersebut dapat berlanjut menjadi kematian intrauterin (stillbirth). Hipoksia yang berkepanjangan menyebabkan gangguan metabolisme dan akumulasi asam laktat, sehingga janin mengalami asidosis metabolik yang merusak fungsi organ vital. Dalam keadaan ini, janin kehilangan kemampuan untuk mempertahankan aktivitas motoriknya sehingga gerakan janin hilang sama sekali. Hilangnya gerakan janin menjadi tanda klinis utama yang menunjukkan bahwa janin tidak lagi hidup di dalam kandungan, dan hal ini harus segera diidentifikasi melalui pemeriksaan obstetri seperti USG atau CTG untuk memastikan diagnosis serta menentukan langkah penatalaksanaan selanjutnya.

f. Tanda dan Gejala

Penurunan gerakan janin merupakan tanda bahaya kehamilan yang harus segera dikenali. Gejala utamanya adalah berkurangnya frekuensi tendangan atau aktivitas janin dibanding pola biasanya, bahkan bisa hilang sama sekali. Kondisi ini sering menandakan hipoksia, insufisiensi plasenta, atau risiko stillbirth sehingga deteksi dini sangat penting.

- 1) Tanda Subjektif (dirasakan ibu)
 - a) Gerakan janin berkurang drastis dibanding hari-hari sebelumnya.
 - b) Tidak ada gerakan sama sekali dalam 2 jam meski ibu sudah beristirahat atau melakukan stimulasi (misalnya makan/minum manis, berbaring miring).
 - c) Perubahan pola gerakan janin yang berbeda dari biasanya (misalnya janin biasanya aktif malam hari, tetapi tiba-tiba tidak bergerak).
 - d) Ibu merasa ada sesuatu yang tidak biasa atau berbeda dari pola gerakan janin sebelumnya.
- 2) Tanda Objektif (hasil pemeriksaan)
 - a) Kick count <10 gerakan dalam 2 jam saat ibu fokus menghitung.
 - b) CTG (Cardiotocography) menunjukkan pola denyut jantung janin abnormal (misalnya deselerasi berulang).
 - c) USG obstetri memperlihatkan aktivitas janin minimal, cairan ketuban berkurang, atau aliran darah tali pusat terganggu.
 - d) DJJ (Denyut Jantung Janin) abnormal: takikardia, bradikardia, atau variabilitas rendah.
- 3) Gejala Klinis yang Perlu Waspada
 - a) Penurunan gerakan janin yang persisten meski sudah dilakukan stimulasi.
 - b) Gerakan janin yang semakin lemah atau hanya berupa getaran kecil.
 - c) Tidak ada gerakan sama sekali dalam periode waktu tertentu artinya tanda kemungkinan distress janin atau stillbirth.

g. Pemeriksaan Penunjang

- 1) Kick Count (Perhitungan Gerakan Janin)

Ibu menghitung gerakan janin secara mandiri, biasanya ≥ 10 gerakan dalam 2 jam dianggap normal. Bila hasil kurang dari standar, perlu pemeriksaan lanjutan. Merupakan metode sederhana, murah, dan efektif untuk deteksi dini.

- 2) USG Obstetri

USG 2D/3D/4D dapat menilai aktivitas janin, posisi, dan gerakan. USG Doppler menilai aliran darah pada arteri uterina, umbilikalis, dan serebri media janin. Digunakan untuk mendeteksi insufisiensi plasenta, IUGR, oligohidramnion, atau lilitan tali pusat.

3) CTG (Cardiotocography)

Memantau denyut jantung janin (DJJ) dan kontraksi uterus. Pola DJJ abnormal (deselerasi berulang, variabilitas rendah) menunjukkan distress janin. CTG sangat penting untuk evaluasi kesejahteraan janin pada kasus gerakan berkurang.

4) Biophysical Profile (BPP)

Kombinasi USG dan CTG untuk menilai kesejahteraan janin. Parameter Adalah gerakan janin, tonus janin, pernapasan janin, volume cairan ketuban, dan reaktivitas DJJ. Skor rendah menunjukkan risiko tinggi hipoksia dan kematian janin.

5) Laboratorium

Pemeriksaan darah ibu (Hb, gula darah, tanda infeksi) untuk mencari faktor maternal yang memengaruhi gerakan janin. Kultur urin bila dicurigai infeksi saluran kemih yang dapat memengaruhi kesejahteraan janin.

h. Komplikasi

1) Hipoksia Janin

Penurunan gerakan janin merupakan tanda awal hipoksia intrauterin. Bila tidak segera ditangani, hipoksia dapat berkembang menjadi asidosis metabolik yang membahayakan fungsi organ vital janin.

2) IUGR (Intrauterine Growth Restriction)

Gangguan suplai oksigen dan nutrisi akibat insufisiensi plasenta atau hipoksia kronis menyebabkan janin tumbuh tidak sesuai usia kehamilan. IUGR meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas perinatal.

3) Distress Janin

Ditandai dengan denyut jantung janin abnormal (takikardia, bradikardia, atau variabilitas rendah pada CTG). Distress janin dapat berujung pada tindakan emergensi seperti persalinan segera atau operasi sesar.

4) Oligohidramnion\

Penurunan cairan ketuban membatasi ruang gerak janin dan meningkatkan risiko kompresi tali pusat. Dapat menyebabkan hipoksia intermiten dan penurunan gerakan janin.

5) Stillbirth (Kematian Intrauterin)

Komplikasi paling fatal bila hipoksia dan asidosis tidak tertangani. Ditandai dengan hilangnya gerakan janin sama sekali.

6) Komplikasi Maternal

Penurunan gerakan janin sering berkaitan dengan kondisi maternal seperti preeklampsia, diabetes, atau infeksi. Bila tidak terdeteksi dini, dapat meningkatkan risiko komplikasi obstetri pada ibu.

i. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan deteksi dini tanda bahaya kehamilan dengan gerakan janin berkurang berfokus pada stimulasi awal oleh ibu, pemantauan gerakan dengan kick count, serta pemeriksaan medis lanjutan seperti USG, CTG, dan Biophysical Profile. Bila hasil menunjukkan distress janin, tindakan segera seperti induksi persalinan atau operasi sesar dapat menjadi pilihan untuk menyelamatkan janin.

1) Langkah Awal oleh Ibu

- a) Posisi miring ke kiri untuk meningkatkan aliran darah ke plasenta.
- b) Kick count untuk menghitung gerakan janin, normalnya ≥ 10 gerakan dalam 2 jam.
- c) Stimulasi sederhana adalah makan/minum manis, berbicara dengan janin, mengusap perut, atau memperdengarkan musik.
- d) Observasi pola gerakan untuk mengenali perubahan dibanding kebiasaan janin.

2) Evaluasi Klinis

- a) Pemeriksaan DJJ (Denyut Jantung Janin) dengan Doppler atau CTG.
- b) USG obstetri untuk menilai aktivitas janin, volume cairan ketuban, dan aliran darah plasenta.
- c) Biophysical Profile (BPP) untuk menilai gerakan tubuh, tonus otot, pernapasan janin, cairan ketuban, dan reaktivitas DJJ.
- d) Laboratorium ibu seperti Hb, gula darah, tanda infeksi untuk mencari faktor maternal.

3) Tindakan Medis

- a) Observasi intensif bila hasil pemeriksaan masih dalam batas aman.

- b) Rawat inap untuk pemantauan bila gerakan janin tetap berkurang atau ada tanda distress.
 - c) Induksi persalinan atau operasi sesar bila janin menunjukkan tanda hipoksia berat atau BPP rendah.
 - d) Penanganan faktor maternal seperti koreksi anemia, kontrol gula darah, terapi infeksi, dan manajemen hipertensi.
- 4) Edukasi dan Pencegahan
- a) Edukasi ibu untuk rutin melakukan kick count sejak usia kehamilan 28 minggu.
 - b) Menekankan pentingnya segera melapor bila gerakan janin berkurang.
 - c) Konseling tentang pola hidup sehat: nutrisi, hidrasi, menghindari rokok/alkohol, dan kontrol penyakit kronis.

j. Asuhan Kebidanan

- 1) Pengkajian
 - a) Anamnesis: menanyakan pola gerakan janin, kapan terakhir dirasakan, frekuensi, dan perubahan dibanding biasanya.
 - b) Faktor risiko ibu: usia, riwayat obstetri, penyakit kronis (hipertensi, diabetes, anemia), kebiasaan merokok/alkohol.
 - c) Pemeriksaan fisik: tanda vital ibu, tinggi fundus uteri, DJJ (Denyut Jantung Janin).
- 2) Deteksi Dini
 - a) Kick count: ibu menghitung gerakan janin minimal 10 kali dalam 2 jam.
 - b) Observasi pola gerakan: apakah berkurang, melemah, atau hilang sama sekali.
 - c) Pemeriksaan penunjang: USG, CTG, Biophysical Profile (BPP).
- 3) Intervensi Kebidanan
 - a) Posisi miring kiri untuk meningkatkan perfusi uteroplacenta.
 - b) Stimulasi gerakan janin: makan/minum manis, beristirahat, atau memperdengarkan suara.
 - c) Rujukan segera bila gerakan tetap berkurang atau hasil pemeriksaan menunjukkan distress janin.
 - d) Kolaborasi dengan dokter untuk tindakan obstetri (induksi persalinan atau operasi sesar bila diperlukan).
- 4) Edukasi
 - a) Mengajarkan ibu cara melakukan kick count sejak usia kehamilan 28 minggu.

- b) Memberikan informasi tentang tanda bahaya kehamilan, termasuk penurunan gerakan janin.
- c) Menekankan pentingnya segera melapor bila gerakan janin berkurang.
- d) Konseling gizi, istirahat cukup, dan menghindari faktor risiko (rokok, alkohol, obat terlarang).

5) Evaluasi

- a) Menilai apakah gerakan janin kembali normal setelah intervensi.
- b) Memantau kesejahteraan janin dengan pemeriksaan lanjutan.
- c) Mengevaluasi pemahaman ibu tentang tanda bahaya kehamilan.

Asuhan kebidanan pada kasus gerakan janin berkurang mencakup pengkajian menyeluruh, deteksi dini dengan kick count dan pemeriksaan penunjang, intervensi kebidanan, edukasi ibu, serta evaluasi berkelanjutan. Tujuannya adalah mencegah komplikasi serius seperti hipoksia, IUGR, distress janin, hingga stillbirth (Kemenkes RI, 2024).

k. Red Flags dan Rujukan

Red flags pada kehamilan dengan gerakan janin berkurang adalah tanda bahaya yang harus segera diwaspadai, seperti hilangnya gerakan janin sama sekali, penurunan drastis dibanding pola biasanya, atau kick count <10 dalam 2 jam. Kondisi ini memerlukan rujukan segera ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan USG, CTG, atau Biophysical Profile demi mencegah hipoksia, distress janin, hingga stillbirth (Kemenkes RI, 2024).

Teori Red Flags Gerakan Janin Berkurang yaitu:

- 1) Tidak ada gerakan janin sama sekali dalam 2 jam meski ibu sudah beristirahat atau melakukan stimulasi.
- 2) Penurunan drastis frekuensi gerakan dibanding pola normal janin sebelumnya.
- 3) Kick count <10 gerakan dalam 2 jam setelah stimulasi.
- 4) Gerakan janin melemah atau hanya berupa getaran kecil yang berbeda dari biasanya.
- 5) Gerakan janin tiba-tiba berlebihan dan tidak teratur (lonjakan abnormal) → tanda stres janin.
- 6) Disertai gejala lain: perdarahan pervaginam, nyeri perut hebat, pecah ketuban dini, atau tanda preeklampsia.

Teori Rujukan yaitu

- 1) Indikasi Rujukan Segera

Gerakan janin hilang sama sekali. Kick count abnormal meski sudah dilakukan stimulasi. Hasil pemeriksaan DJJ menunjukkan bradikardia/takikardia atau variabilitas rendah. USG/CTG menunjukkan tanda distress janin. Disertai komplikasi maternal (preeklampsia, diabetes tidak terkontrol, perdarahan).

2) Tujuan Rujukan

Evaluasi lanjutan dengan USG, CTG, dan Biophysical Profile. Pemantauan intensif kesejahteraan janin di fasilitas rujukan. Intervensi obstetri segera: induksi persalinan atau operasi sesar bila janin dalam distress.

3) Peran Bidan

Melakukan deteksi dini dengan anamnesis, pemeriksaan DJJ, dan kick count. Memberikan edukasi kepada ibu tentang tanda bahaya gerakan janin berkurang. Segera merujuk ke dokter spesialis kandungan bila ditemukan red flags (WHO, 2023).

I. Dokumentasi

1) Data Subjektif

- a) Keluhan ibu: penurunan frekuensi gerakan janin, perubahan pola gerakan, atau tidak ada gerakan sama sekali.
- b) Riwayat obstetri: kehamilan sebelumnya, komplikasi, keguguran, IUFD.
- c) Faktor risiko maternal: usia, penyakit kronis, kebiasaan merokok/alkohol.

2) Data Objektif

- a) Pemeriksaan fisik: tanda vital ibu, tinggi fundus uteri, DJJ (Denyut Jantung Janin).
- b) Kick count: jumlah gerakan janin dalam 2 jam.
- c) Pemeriksaan penunjang: USG, CTG, Biophysical Profile (BPP).

3) Assessment (Analisis)

- a) Identifikasi masalah: gerakan janin berkurang, risiko hipoksia, risiko IUGR, risiko distress janin.
- b) Diagnosis kebidanan: "Kehamilan dengan tanda bahaya berupa penurunan gerakan janin."

4) Planning (Rencana Asuhan)

- a) Edukasi ibu untuk melakukan kick count rutin.
- b) Posisi miring kiri untuk meningkatkan perfusi uteroplacenta.
- c) Observasi DJJ dan gerakan janin.
- d) Rujukan segera bila ditemukan red flags (gerakan hilang, DJJ abnormal, hasil CTG/USG menunjukkan distress janin).

- 5) Implementation (Tindakan)
 - a) Melakukan pemeriksaan DJJ dengan Doppler.
 - b) Memberikan edukasi tentang tanda bahaya kehamilan.
 - c) Kolaborasi dengan dokter untuk pemeriksaan lanjutan.
 - d) Dokumentasi tindakan rujukan bila diperlukan.
- 6) Evaluation (Evaluasi)
 - a) Menilai apakah gerakan janin kembali normal.
 - b) Mengevaluasi hasil pemeriksaan penunjang.
 - c) Menilai pemahaman ibu tentang tanda bahaya kehamilan (WHO, 2023).

C. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Contoh Kasus

Seorang Perempuan usia 32 tahun, G3P2A0, usia kehamilan 32 minggu datang ke IGD Kebidanan bersama suami dengan keluhan perdarahan pervaginam berupa darah segar sejak 2 jam yang lalu dengan riwayat perdarahan berulang sejak 28 minggu. Perdarahan terjadi tiba-tiba, tanpa nyeri perut. Hasil Pemeriksaan, KU baik, Kesadaran compos mentis (sadar penuh), namun tampak lemah. TD: 100/70 mmHg, Nadi: 110 x/menit, RR: 22 x/menit. Tampak klinis: wajah pucat, konjungtiva anemis, tampak cemas. Hasil Pemeriksaan Abdomen: tinggi fundus uteri sesuai usia kehamilan, janin masih hidup, tidak ada nyeri tekan, uterus tidak tegang.

Pertanyaan Diskusi:

1. Apa diagnosa kebidanan yang paling mungkin pada kasus ini?
2. Sebutkan 3 tindakan segera yang harus dilakukan pada ibu dengan perdarahan akibat kasus diatas.
3. Pemeriksaan penunjang apa yang paling tepat untuk memastikan diagnosis kasus diatas?
4. Kapan ibu dengan kasus diatas harus segera dirujuk ke rumah sakit rujukan?
5. Edukasi apa yang harus diberikan kepada ibu dan keluarga terkait kondisi ini?

Template Soal Osce Kebidanan

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Deteksi Dini Tanda Bahaya Kehamilan: Perdarahan Trimester III
3	Kasus	Plasenta Previa Totalis
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam mengidentifikasi tanda bahaya (red flags), melakukan pengkajian komprehensif, menentukan diagnosa kebidanan, merencanakan dan melaksanakan asuhan kebidanan, serta menentukan rujukan tepat waktu.
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang Perempuan usia 32 tahun, G3P2A0, usia kehamilan 32 minggu datang ke IGD Kebidanan bersama suami dengan keluhan perdarahan pervaginam berupa darah segar sejak 2 jam yang lalu dengan riwayat perdarahan berulang sejak 28 minggu. Perdarahan terjadi tiba-tiba, tanpa nyeri perut. Hasil Pemeriksaan, KU baik, Kesadaran compos mentis (sadar penuh), namun tampak lemah. TD: 100/70 mmHg, Nadi: 110 x/menit, RR: 22 x/menit. Tampak klinis: wajah pucat, konjungtiva anemis, tampak cemas. Hasil Pemeriksaan Abdomen: tinggi fundus uteri sesuai usia kehamilan, janin masih hidup, tidak ada nyeri tekan, uterus tidak tegang. TUGAS 1. Apa diagnosa kebidanan yang paling mungkin pada kasus ini?

No.	Komponen	Isi
		2. Sebutkan 3 tindakan segera yang harus dilakukan pada ibu dengan perdarahan akibat kasus diatas. 3. Pemeriksaan penunjang apa yang paling tepat untuk memastikan diagnosis kasus diatas? 4. Kapan ibu dengan kasus diatas harus segera dirujuk ke rumah sakit rujukan? 5. Edukasi apa yang harus diberikan kepada ibu dan keluarga terkait kondisi ini?
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikuti kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog PS. 2. Jika peserta menyatakan akan melakukan palpasi abdomen/Leopold, penguji memberikan data:- TFU 34 cm- Punggung kiri- Presentasi kepala- Kepala 4/5 di atas PAP 3. Jika peserta meminta hasil pemeriksaan dalam atau interpretasi partograf, penguji memberikan data:-

No.	Komponen	Isi
		Pembukaan serviks 6 cm menetap selama 4 jam- Serviks edema ringan- Ketuban pecah- Air ketuban bercampur mekonium tipis- Kepala masih tinggi/Hodge II- Moulage ++ 4. Tindakan awal yang diharapkan dari peserta meliputi:- Menilai ulang kondisi ibu dan janin secara cepat- Menjelaskan kondisi ibu secara singkat dan jelas- Memposisikan ibu miring kiri- Menyiapkan/memasang infus cairan sesuai kewenangan dan fasilitas- Menganjurkan atau menyiapkan pengosongan kandung kemih- Melakukan pemantauan DJJ dan tanda vital- Menyiapkan kolaborasi/rujukan segera- Memberikan dukungan emosional dan KIE singkat 5. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 6. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 1. PS berperan sebagai ibu hamil trimester III dengan perdarahan. 2. PS wajah pucat, konjungtiva anemis, tampak cemas. 3. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif. 4. Bila peserta menyampaikan bahwa ibu perlu dirujuk, PS tampak khawatir tetapi bersedia mengikuti arahan.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu.

No.	Komponen	Isi
		PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa ibu. Apakah ibu bersedia? PS: Iya, Bu, saya bersedia. Peserta: Apa keluhan utama ibu? PS: Saya keluhan perdarahan pervaginam berupa darah segar yang tiba-tiba dengan riwayat perdarahan berulang sejak 28 minggu. Peserta: Sejak kapan keluar darah segar? PS: sejak 2 jam lalu, Bu. Peserta: Apakah ada keluhan lain? PS: iya ada. Nyeri perut Peserta: sejak kapan nyeri perut dirasakan? PS: sekitar 2 jam yang lalu. Peserta: Apakah ibu merasa pusing, mual? PS: tidak, Bu. Peserta: Bagaimana gerakan bayi? PS: Sejak tadi terasa berkurang, Bu. Peserta: BAK terakhir kapan? PS: Tadi pagi, sedikit sekali. Peserta: Ini kehamilan yang ke berapa? PS: Ini kehamilan ketiga saya, Bu. Peserta: Ada riwayat darah tinggi, operasi, atau penyakit lain? PS: Tidak ada, Bu. Peserta: Saya akan melakukan tindakan awal dan menyiapkan rujukan. PS: Iya, Bu. Catatan: Jika ada pertanyaan lain terkait riwayat penyakit, riwayat obstetri-ginekologi, sosial, spiritual, ekonomi, dan ADL, PS memberi jawaban normatif dan tidak mengarah ke diagnosis lain.
10	Kebutuhan manikin	- Phantom abdomen hamil/manekin Leopold - Lembar partograf kasus

No.	Komponen	Isi
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin - Mengganti lembar partograf/lembar instruksi bila diperlukan - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa — 1 2. Phantom abdomen hamil/manekin Leopold — 1 3. Oksigen dan Masker Oksigen — 1 4. Peralatan Transfusi Darah — 1 5. Tensimeter — 1 6. Stetoskop — 1 7. Doppler/Pinard — 1 8. Jam tangan/stopwatch — 1 9. Termometer — 1 10. Sarung tangan bersih — 1 pasang 11. Handrub — 1 botol 12. Kain penutup/selimut — 1 13. Tisu — 1 pack 14. Infus set dummy — 1 set 15. Cairan RL/NaCl dummy — 1 16. Abocath dummy — 1 17. Formulir rujukan — 1 lembar 18. Lembar jawaban peserta — 1 lembar 19. Pena — 1 20. Lembar Partograf — 1
13	Penulis	Niluh Nita Silfia SST.,M.Keb
14	Referensi	1. Cunningham, F.G., Leveno, K.J., Bloom, S.L., Spong, C.Y., & Dashe, J.S. (2018). Williams Obstetrics (25th ed.). New York: McGraw-Hill Education. 2. Sarwono, Prawirohardjo. (2014). Ilmu Kebidanan. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. 3. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2021). Bleeding During Pregnancy: Practice Bulletin. Washington DC: ACOG.

No.	Komponen	Isi
		4. World Health Organization (WHO). (2023). Maternal and Perinatal Health: Updated Guidelines on Management of Pregnancy Complications. Geneva: WHO. 5. Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI). (2016). Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Perdarahan Pasca-Salin. Jakarta: POG

D. Rubrik Penilaian dan Kelulusan

Stase 1: Deteksi Dini Tanda Bahaya Kehamilan

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama		
2. Riwayat Keluhan yaitu mulai terjadinya perdararahan segar		
3. Riwayat pengeluaran pervaginam (perdarahan)		
4. tanpa Nyeri Perut		
5. lemah dan cemas		
6. Riwayat obstetri (GPA, usia kehamilan, ANC, persalinan sebelumnya bila ada)		
7. Riwayat kesehatan/komplikasi kehamilan/operasi/alergi/obat-obatan		
8. Aktivitas harian yang relevan dengan kondisi saat ini (asupan makan-minum, BAK terakhir, kelelahan, dukungan keluarga)		

Skoring KOMPETENSI 1

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **8 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **5–7 dari 8 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–4 dari 8 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Persiapan		
a. Menyapa klien dengan sopan dan ramah		
b. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan tindakan		
c. Memastikan klien memahami prosedur dan meminta persetujuan		
d. Menjaga privasi ibu		
e. Mencuci tangan/hand hygiene		
f. Menyiapkan alat yang diperlukan		
2. Langkah-langkah		
a. Menilai keadaan umum dan kesadaran ibu		
b. Menilai tanda vital ibu		
c. Menilai perdarahan segar / pengeluaran darah pervaginam		
d. Menilai DJJ		
e. Menilai kecemasan		
f. Melakukan pemeriksaan obstetri terfokus atau meminta data yang relevan sesuai kewenangan station		
g. Menilai banyaknya darah, warna dan nyeri perut		
h. Menyimpulkan adanya plasenta Previa dan kecurigaan kondisi janin/ibu yang memburuk		
i. Memposisikan ibu miring kiri		
j. Menyiapkan/memasang infus cairan sesuai kewenangan dan fasilitas		
k. Menganjurkan atau menyiapkan pengosongan kandung kemih		
l. Melakukan pemantauan ulang kondisi ibu dan janin		
m. Menyiapkan kolaborasi/rujukan segera dan aman		
3. Pasca tindakan		
a. Menjelaskan hasil tindakan awal dan rencana lanjutan		
b. Mencatat temuan penting pada catatan medis/form rujukan		
c. Mencuci tangan kembali dan merapikan alat/ibu		

Skoring KOMPETENSI 2

- **3** = Jika peserta ujian melakukan **15–19 langkah** dengan tepat dan sistematis.
- **2** = Jika peserta melakukan **10–14 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–9 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam		
2. Menjelaskan hasil pemeriksaan dan kondisi ibu/janin dengan bahasa sederhana		
3. Menjelaskan tindakan awal yang sedang/akan dilakukan		
4. Menjelaskan perlunya kolaborasi/rujukan segera		
5. Menenangkan ibu dan melibatkan keluarga/pendamping		
6. Memberi kesempatan bertanya dan menjawab pertanyaan dengan jelas		

Skoring KOMPETENSI 3

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **6 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4–5 dari 6 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 6 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Melaksanakan secara sistematis		
2. Menjaga privasi dan keselamatan pasien		
3. Memberikan perhatian terhadap respons ibu sangat lemah		
4. Suara lantang, jelas, tenang, dan informatif		
5. Percaya diri dan tidak ragu-ragu		

Skoring KOMPETENSI 4

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **5 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4 dari 5 langkah** dengan benar.

- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 5 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3

(dicatat di rubrik penilaian)

Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$

(Kota),

.....

Penguji:

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Deteksi Dini Tanda Bahaya Kehamilan : Plasenta Previa

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Plasenta Previa
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural. Penilai mengamati tindakan yang dilakukan peserta, lalu memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. Domain yang lazim dinilai mencakup informed consent, persiapan pra-tindakan, kemampuan teknis, komunikasi, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan penilaian awal pada ibu inpartu dengan kemajuan persalinan tidak memuaskan, lalu menilai keterampilan mahasiswa saat melakukan tindakan awal kegawatdaruratan dan menyiapkan rujukan.
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa melakukan tindakan awal yang aman, cepat, dan sistematis pada kasus perdarahan trimester II dan III, dengan tetap berpusat pada keselamatan ibu dan janin serta penghormatan pada asuhan yang bermartabat. WHO menekankan pentingnya asuhan Antepartum yang evidence-based, woman-centred, dan pemantauan kemajuan persalinan yang baik.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang partus lama dan distosia, tetapi dari kemampuannya menilai kondisi ibu-janin, membaca data kemajuan persalinan, melakukan stabilisasi awal, dan menjelaskan kebutuhan kolaborasi atau rujukan.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang sesuai dengan capaian pembelajaran profesi bidan, khususnya pengenalan prolonged atau obstructed labour, identifikasi tanda bahaya, dan pengambilan keputusan awal. KemenKes RI, 2024 Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu untuk standar pelayanan antenatal.	Seorang Perempuan usia 32 tahun, G3P2A0, usia kehamilan 32 minggu datang ke IGD Kebidanan bersama suami dengan keluhan perdarahan pervaginam berupa darah segar sejak 2 jam yang lalu dengan riwayat perdarahan berulang sejak 28 minggu. Perdarahan terjadi tiba-tiba, tanpa nyeri perut. Hasil Pemeriksaan, KU baik, Kesadaran compos mentis

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Plasenta Previa
		(sadar penuh), namun tampak lemah. TD: 100/70 mmHg, Nadi: 110 x/menit, RR: 22 x/menit. Tampak klinis: wajah pucat, konjungtiva anemis, tampak cemas. Hasil Pemeriksaan Abdomen: tinggi fundus uteri sesuai usia kehamilan, janin masih hidup, tidak ada nyeri tekan, uterus tidak tegang..
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pada DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan prosedur atau rangkaian tindakan klinik tertentu, bukan sekadar berdiskusi tentang kasus. Pada topik ini, keterampilan yang relevan antara lain menilai keadaan umum ibu, analisis keluhan ibu, tanda vital, DJJ, pemeriksaan abdomen serta melakukan tindakan awal seperti posisi miring kiri, menyiapkan infus, menjaga keseimbangan cairan, dan menyiapkan rujukan. KemenKes RI, 2024 Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu untuk standar pelayanan antenatal.	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menilai kondisi ibu dan janin, menilai keluhan ibu, menyimpulkan adanya Plasenta Previa dengan kecurigaan gawat janin, memposisikan ibu miring kiri, menyiapkan cairan intravena, menganjurkan pengosongan kandung kemih, lalu menjelaskan perlunya rujukan segera.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi pemahaman indikasi tindakan, persetujuan tindakan, persiapan pra-prosedur, kemampuan teknis, komunikasi, kemampuan mencari bantuan ketika diperlukan, rencana pascatindakan, dan profesionalisme. Pada konteks obstetri, aspek ini juga mencakup ketepatan mengenali tanda kasus perdarahan pada Trimester II atau III dan ketepatan keputusan eskalasi.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan hasil pemeriksaan abdomen, kelelahan ibu, kecemasan ibu dan DJJ sebagai tanda bahwa tidak lagi Kehamilan aman untuk ditunggu di fasilitas awal.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Plasenta Previa
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah mutu performa nyata mahasiswa saat melakukan tindakan awal. Pada kasus perdarahan trimester II atau III	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa cepat mengenali kondisi gawat, melakukan prioritas tindakan dengan urutan yang benar, menghindari intervensi yang tidak aman, serta segera meminta bantuan atau menyiapkan rujukan.
Umpan balik	Umpan balik dalam DOPS diberikan segera setelah observasi dan berisi apa yang sudah efektif serta apa yang perlu diperbaiki. Form DOPS juga menekankan komentar assessor mengenai kekuatan, area yang perlu ditingkatkan, dan rencana perbaikan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan membaca partograf, tetapi masih perlu meningkatkan ketegasan saat memutuskan eskalasi, ketelitian dalam menilai hasil pemeriksaan abdomen, menilai perdarahan dan keluhan ibu atau kelengkapan penjelasan kepada keluarga.
Keputusan penilaian	Dalam buku ajar ini, hasil DOPS dapat diringkas menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Keputusan ditetapkan berdasarkan ketepatan langkah, keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan mengambil keputusan awal.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan tindakan awal secara runtut, aman, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila langkah utama sudah benar tetapi masih memerlukan arahan. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila gagal mengenali kegawatan, salah menentukan prioritas, atau tidak menyiapkan eskalasi dengan benar.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does karena performanya diamati langsung saat melakukan tindakan klinik. Observasi langsung	Pada kasus partus lama dan distosia, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan tindakan awal kegawatdaruratan kehamilan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Plasenta Previa
	pada pasien nyata dan umpan balik segera menjadikan DOPS sangat sesuai untuk pembelajaran berbasis kompetensi.	secara langsung, aman, cepat, dan profesional di lahan praktik.

E. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel Portofolio pada Deteksi Dini Tanda Bahaya Kehamilan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Plasenta Previa
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada topik Deteksi dini pada kehamilan dengan kasus plasenta previa, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian persalinan, menilai kemajuan persalinan dengan profession, mengenali tanda bahaya ibu dan janin, melakukan tindakan awal, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah menangani ibu hamil perdarahan karena Plasenta Previa, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Plasenta Previa
		setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan interpretasi profession, pengenalan plasenta previa, dan tindakan awal pra-rujukan. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan penilaian ibu hamil kasus perdarahan, stabilisasi awal, dan persiapan rujukan pada kasus plasenta previa di IGD.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus ibu G3P2A0 usia kehamilan 32 minggu dengan perdarahan pervaginam berupa darah segar sejak 2 jam yang lalu secara tiba-tiba, tanpa nyeri perut, keadaan lemah dan cemas, tindakan awal yang dilakukan, dan keputusan rujukan.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya tidak menunda pengenalan deteksi dini kehamilan dengan kasus perdarahan, ketelitian membaca profession, pemantauan DJJ, pencegahan keterlambatan rujukan, dan komunikasi cepat dengan keluarga pada kasus plasenta previa.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam mengenali deteksi dini kehamilan kasus perdarahan dan menjelaskan rujukan, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Plasenta Previa
		melakukan pemeriksaan perdarahan, pemeriksaan abdomen
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus plasenta previa, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu menilai deteksi dini kehamilan dengan kasus perdarahan dan melakukan tindakan awal secara aman.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu menggunakan profession, melakukan deteksi dini, dan mengambil keputusan awal yang tepat pada kehamilan bermasalah.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada topik deteksi dini pada kehamilan kasus perdarahan, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik kebidanan nyata.

Tabel Case Report pada Deteksi Dini Tanda Bahaya Kehamilan: Plasenta Previa

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus plasenta previa
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang ibu hamil multipara dengan perdarahan trimester III, perdarahan tiba-tiba, tanpa nyeri perut, lemah, cemas.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data ibu, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan awal yang diberikan, proses rujukan, dan perkembangan kondisi ibu serta janin setelah intervensi awal.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ini, mahasiswa menuliskan ibu hamil trimester III perdarahan tiba-tiba sejak 2 jam yang lalu, tanpa nyeri perut, lemas, cemas, analisis Plasenta Previa dengan kecurigaan gawat janin, tindakan awal stabilisasi, dan keputusan rujukan.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu melakukan deteksi dini pada kehamilan kasus perdarahan trimester III meningkat sebagai kondisi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus plasenta previa
		yang memerlukan tindakan awal dan rujukan segera.

F. Tabel Red Flags & Eskalasi

Deteksi Dini Tanda Bahaya Kehamilan : Plasenta Previa

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Perdarahan pervaginam berupa darah segar tanpa nyeri	Ciri khas plasenta previa, perdarahan berasal dari segmen bawah rahim	Segera stabilisasi ibu (infus, cairan, observasi tanda vital), hindari pemeriksaan dalam
Perdarahan berulang sejak trimester ketiga	Risiko tinggi anemia, hipovolemia, dan komplikasi obstetri	Rawat inap untuk pemantauan intensif, pemeriksaan USG untuk konfirmasi lokasi plasenta
Tekanan darah menurun (hipotensi) dan nadi meningkat (takikardi)	Tanda syok hipovolemik akibat perdarahan	Resusitasi cairan, transfusi darah bila perlu, monitoring ketat
Wajah pucat, konjungtiva anemis	Anemia akibat perdarahan kronis	Pemberian zat besi, transfusi bila Hb rendah, evaluasi status hematologi
Janin masih hidup, fundus sesuai usia kehamilan	Janin berisiko distress bila perdarahan berlanjut	Monitoring DJJ dengan CTG, persiapan tindakan obstetri bila kondisi memburuk
Perdarahan tidak berhenti dengan tindakan konservatif	Risiko kematian ibu dan janin	Rujukan segera ke fasilitas obstetri lengkap, persiapan operasi sesar emergensi

Form Checklist “Saya sudah bisa...”**Bab: Deteksi Dini Tanda Bahaya Kehamilan – Plasenta Previa**

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa mengidentifikasi perdarahan antepartum sebagai tanda bahaya kehamilan	☐	☐	
2	Saya sudah bisa membedakan perdarahan plasenta previa dengan perdarahan akibat solusio plasenta.	☐	☐	
3	Saya sudah bisa melakukan anamnesis pada ibu hamil dengan keluhan perdarahan pervaginam.	☐	☐	
4	Saya sudah bisa menilai tanda vital ibu untuk mendeteksi adanya syok hipovolemik.	☐	☐	
5	Saya sudah bisa mengenali ciri khas plasenta previa yaitu perdarahan segar tanpa nyeri.	☐	☐	
6	Saya sudah bisa melakukan pemeriksaan abdomen untuk menilai kondisi uterus dan janin.	☐	☐	
7	Saya sudah bisa mendeteksi tanda anemia melalui wajah pucat dan konjungtiva anemis.	☐	☐	
8	Saya sudah bisa melakukan monitoring denyut jantung janin (DJJ) sebagai bagian dari deteksi dini.	☐	☐	
9	Saya sudah bisa memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga tentang tanda bahaya kehamilan.	☐	☐	
10	Saya sudah bisa melakukan tindakan awal stabilisasi ibu dengan pemasangan infus dan cairan intravena.	☐	☐	
11	Saya sudah bisa mengobservasi perdarahan dan mencatat jumlah serta karakteristik darah yang keluar.	☐	☐	
12	Saya sudah bisa menghindari pemeriksaan dalam pada kasus perdarahan antepartum.	☐	☐	
13	Saya sudah bisa mengidentifikasi kebutuhan rujukan segera ke fasilitas obstetri lengkap.	☐	☐	
14	Saya sudah bisa berkolaborasi dengan dokter untuk pemeriksaan lanjutan seperti USG dan CTG.	☐	☐	

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
15	Saya sudah bisa menyusun rencana asuhan kebidanan sesuai kondisi ibu dan janin.	☐	☐	
16	Saya sudah bisa mendokumentasikan kasus secara lengkap dalam format SOAP untuk keperluan klinis.	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

G. Rangkuman Materi

Kasus ini termasuk dalam kategori perdarahan antepartum pada ibu hamil usia 32 tahun, G3P2A0, dengan usia kehamilan 32 minggu. Ciri khas kasus adalah perdarahan pervaginam berupa darah segar yang terjadi tiba-tiba tanpa disertai nyeri perut, dengan riwayat perdarahan berulang sejak usia kehamilan 28 minggu. Pemeriksaan menunjukkan ibu dalam keadaan sadar penuh namun tampak lemah, tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 110 x/menit, wajah pucat, konjungtiva anemis, serta janin masih hidup dengan tinggi fundus uteri sesuai usia kehamilan. Gambaran klinis ini mengarah pada plasenta previa, ditandai dengan perdarahan berulang, tanpa nyeri, dan uterus tidak tegang.

Alur kasus menunjukkan adanya perdarahan berulang yang semakin membahayakan ibu dan janin. Kondisi ibu tampak lemah dengan tanda anemia, sementara janin masih hidup. Perdarahan yang terjadi tanpa nyeri dan berulang sejak trimester ketiga memperkuat dugaan plasenta previa. Situasi ini menuntut kewaspadaan tinggi karena risiko komplikasi seperti syok hipovolemik, anemia berat, hingga kematian janin dapat terjadi bila tidak segera ditangani.

Penanganan awal meliputi stabilisasi kondisi ibu dengan observasi tanda vital, pemberian cairan intravena, pemeriksaan DJJ, serta larangan pemeriksaan dalam untuk mencegah perdarahan lebih lanjut. Rekomendasi utama adalah rujukan segera ke fasilitas kesehatan rujukan dengan layanan obstetri lengkap untuk evaluasi lanjutan menggunakan USG, CTG, serta persiapan tindakan obstetri (induksi persalinan atau operasi sesar) bila kondisi ibu atau janin memburuk. Edukasi kepada keluarga mengenai tanda bahaya kehamilan dan pentingnya pemantauan intensif juga menjadi bagian integral dari asuhan kebidanan.

Alur asuhan singkat:

Ibu multipara trimester III dengan perdarahan segar sejak 2 jam → nilai cepat keadaan ibu dan janin → nilai perdarahan → identifikasi kemungkinan Plasenta Previa → lakukan stabilisasi awal dan dukungan → tentukan kebutuhan kolaborasi/rujukan → dokumentasi dan handover yang jelas.

H. Daftar Pustaka

- Agustin, A. D., & Afrika, E. (2022). *Pengaruh Anemia Ibu Hamil terhadap Berat Bayi Lahir Rendah: Studi Meta Analisis Beberapa Negara Tahun 2015–2019*. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 11(2), 163–177.
- Alodokter. (2025). *Gerakan Janin Berkurang: Penyebab dan Penanganan*. Jakarta: Alodokter Media.
- American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2025). *Practice Bulletin: Fetal Surveillance and Reduced Fetal Movement*. Washington DC: ACOG.
- Battula, D., et al. (2021). *Antepartum Haemorrhage*. *Journal of Obstetrics, Gynaecology & Reproductive Medicine*, 31(4). (Artikel ini banyak dikutip dalam penelitian kebidanan terbaru mengenai perdarahan kehamilan).
- BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology. (2025). *Pathophysiology and Clinical Outcomes of Reduced Fetal Movement*. Wiley-Blackwell.
- Chasanah, U., Novita, A., & Fatimah, J. (2023). *Pengaruh Teknik Massage Counterpressure dengan Aromaterapi terhadap Pengurangan Nyeri Persalinan pada Ibu Bersalin Kala I di Kota Depok Tahun 2022*. *Journal of Midwifery Science and Women's Health*, 3(2), 49–57.
- Ciputra Hospital. (2025). *Mengenal Gerakan Janin yang Tidak Normal*. Jakarta: Ciputra Healthcare.
- Cleveland Clinic. (2024). *Fetal Movement and Pregnancy Monitoring*. Ohio: Cleveland Clinic.
- Dewi, K., & ST, S. (2022). *Kesehatan Ibu dan Anak: Konsep Dasar Teori Perspektif Akademis dan Praktik*. Bandung: Urita Press.
- FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics). (2024). *Fetal Monitoring and Reduced Fetal Movement Guidelines*. London: FIGO.
- Hello Sehat. (2025). *Penyebab Gerakan Janin Berkurang yang Perlu Diperhatikan*. Jakarta: Hello Sehat.
- Hidayah, N., & Lestari, P. (2024). *Meningkatkan kepatuhan ibu hamil dalam melakukan pemeriksaan antenatal care (ANC) sebagai upaya pemantauan kesehatan selama kehamilan*. *Jurnal Pelayanan Kesehatan*, 9(2), 77–85.
- Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. (2025). *Clinical Management of Reduced Fetal Movement Cases*. Taylor & Francis.
- Journal of Obstetrics and Gynecology Research. (2025). *Risk Factors and Outcomes of Reduced Fetal Movement*. Japan Society of Obstetrics and Gynecology.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu. Jakarta: Kemenkes RI.
- March of Dimes. (2024). Fetal Movement and Pregnancy Complications. Washington DC: March of Dimes Foundation.
- Maros, Z., & Kurniawati, N. (2022). Mencegah terjadinya komplikasi serius pada ibu dan janin yang dapat menyebabkan kesakitan maupun kematian ibu dan bayi. *Jurnal Obstetri dan Ginekologi*, 15(1), 25–32.
- Mayo Clinic. (2024). Fetal Movement: What to Expect and When to Seek Help. Minnesota: Mayo Clinic Press.
- Medscape. (2025). Reduced Fetal Movement: Clinical Approach and Management. New York: Medscape.
- Mother & Beyond. (2025). Kenali Tanda Gerakan Janin yang Tidak Normal dan Kapan Harus ke Dokter. Jakarta: Mother & Beyond.
- National Health Service (NHS). (2024). Your Baby's Movements in Pregnancy. London: NHS UK.
- Nurhayati, S., & Fitriani, R. (2023). Mendorong ibu hamil untuk segera mencari pertolongan medis apabila muncul tanda bahaya, sehingga dapat mencegah keterlambatan penanganan. *Jurnal Ilmu Kebidanan*, 8(3), 101–108.
- POGI (Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia). (2024). Pedoman Praktik Klinis: Pemantauan Gerakan Janin. Jakarta: POGI.
- Putra, A., & Rahmawati, D. (2022). Mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya komplikasi kehamilan agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat oleh tenaga kesehatan. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 10(1), 33–40.
- Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG). (2024). Reduced Fetal Movements: Clinical Guideline. London: RCOG.
- RSIA Melinda DHAI. (2025). Red Flag Pada Kehamilan: Gerakan Janin Berkurang. Bandung: RSIA Melinda.
- Sari, R., & Handayani, L. (2023). Meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang tanda dan gejala bahaya selama kehamilan sehingga ibu mampu memahami kondisi yang berisiko bagi dirinya maupun janin. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 12(2), 45–52.
- UNICEF. (2023). Maternal and Child Health: Early Warning Signs in Pregnancy. New York: UNICEF.
- WHO. (2023). *Maternal and Perinatal Health: Updated Guidelines on Management of Pregnancy Complications*. Geneva: World Health Organization. (Edisi terbaru dengan fokus pada perdarahan antepartum dan postpartum).
- World Health Organization. (2023). Maternal and Perinatal Health: Early Warning Signs in Pregnancy. Geneva: WHO Press.
- Wulandari, D., & Sari, M. (2022). Menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) melalui peningkatan kesadaran serta kemampuan deteksi dini terhadap masalah kehamilan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 14(4), 211–219.

BAB 5

DETEKSI DINI GANGGUAN HIPERTENSI KEHAMILAN: PREEKLAMPSIA, EKLAMPSIA, DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI

Capaian Pembelajaran (CPL)	CPL 3	Lulusan mampu menerapkan keselamatan pasien, PPI, dan K3 dalam pelayanan maternal–neonatal di layanan primer.
	CPL 4	Lulusan mampu menggunakan clinical reasoning untuk pengkajian, skrining, dan deteksi dini risiko maternal-neonatal.
	CPL 5	Lulusan mampu melaksanakan keterampilan klinis dasar untuk tindakan awal, stabilisasi, dan rujukan sesuai kewenangan dan SOP.
	CPL 6	Lulusan mampu menerapkan Evidence Based Practice (EBP) dasar, edukasi kesehatan, dokumentasi, serta perbaikan mutu program pelayanan maternal–neonatal.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK 3	Mahasiswa mampu menerapkan skrining risiko maternal-neonatal (faktor risiko, skor/algoritme) untuk menetapkan rencana asuhan dan tindak lanjut berbasis bukti. (CPMK Penguat)
	CPMK 4	Mahasiswa mampu menilai dan mendeteksi dini tanda bahaya maternal sepanjang kehamilan intrapartum postpartum serta menentukan tindakan awal sesuai kewenangan dan kebutuhan rujukan. (CPMK Utama)
	CPMK 6	Mahasiswa mampu melaksanakan stabilisasi awal dan proses rujukan maternal–neonatal (indikasi,

		persiapan, komunikasi rujukan, transport aman) sesuai standar pelayanan primer. (CPMK Penguat)																									
Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)	Sub-CPMK 1	Mahasiswa mampu menginterpretasi parameter skrining hipertensi kehamilan (TD, gejala, temuan pendukung) untuk klasifikasi risiko.																									
	Sub-CPMK 2	Mahasiswa mampu merancang pencegahan komplikasi dan menentukan kriteria rujukan pada preeklamsia/ eklamsia.																									
Bahan Ajar	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.	Definisi Etiologi Faktor Risiko Gangguan Hipertensi dalam Kehamilan Patofisiologi Gangguan Hipertensi dalam Kehamilan Klasifikasi Tanda Dan Gejala (Red Flags) Skrining Dan Deteksi Dini Secara Tepat Intervensi Pencegahan Komplikasi Penatalaksanaan Asuhan Kebidanan Rujukan Edukasi Kepada Ibu Hamil Dan Keluarga Dokumentasi																									
Korelasi CPL Terhadap CPMK	:Korelasi CPL Terhadap CPMK																										
	<table><tr><td rowspan="2">CPL</td><td colspan="3">CPMK</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>6</td></tr><tr><td>CPL 3</td><td></td><td></td><td>√</td></tr><tr><td>CPL 4</td><td>√</td><td>√</td><td></td></tr><tr><td>CPL 5</td><td></td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td>CPL 6</td><td>√</td><td></td><td></td></tr></table>				CPL	CPMK			3	4	6	CPL 3			√	CPL 4	√	√		CPL 5		√	√	CPL 6	√		
CPL	CPMK																										
	3	4	6																								
CPL 3			√																								
CPL 4	√	√																									
CPL 5		√	√																								
CPL 6	√																										
Korelasi CPMK Terhadap Sub-CPMK	Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK																										
	<table><tr><td rowspan="2">CPL</td><td rowspan="2">CPMK</td><td colspan="2">Sub-CPMK</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>CPL 3</td><td>CMPK 4</td><td>√</td><td></td></tr></table>				CPL	CPMK	Sub-CPMK		1	2	CPL 3	CMPK 4	√														
CPL	CPMK	Sub-CPMK																									
		1	2																								
CPL 3	CMPK 4	√																									

		CPMK 6		√	
	CPL 4	CPMK 3		√	
		CPMK 4	√		
	CPL 5	CPMK 4	√		
		CPMK 6		√	
	CPL 6	CPMK 3		√	
Asesmen	Asesmen				
	Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
	CPMK 3	Tugas berbasis kasus (form skor + care plan)	Skor/klasifikasi risiko akurat (≥85%); rencana tindak lanjut sesuai kategori risiko dan realistis	15	Form skor/algoritme; rencana asuhan & jadwal follow-up
	CPMK 4	Simulasi skenario maternal (OSCE) + analisis kasus singkat	Identifikasi tanda bahaya & urgensi tepat (≥85%); tindakan awal sesuai SOP; keputusan rujukan tepat waktu	20	Checklist tindakan; keputusan rujukan; catatan komunikasi rujukan
	CPMK 6	Simulasi stabilisasi & rujukan (team-based) + rubrik handover	Persiapan rujukan lengkap (≥90% item kritis); handover terstruktur; rencana transport aman memadai	15	Form rujukan; checklist logistik; naskah/rekaman handover

Pendahuluan

Hypertensive Disorders of Pregnancy (HDP) atau Gangguan hipertensi dalam kehamilan tetap menjadi salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas ibu dan janin terkait kehamilan di seluruh dunia. Wanita yang terkena juga berisiko lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskular di kemudian hari, terlepas dari risiko penyakit kardiovaskular jangka pendek dan jangka Panjang (Garovic et al., 2022).

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia tercatat tertinggi ketiga di negara-negara ASEAN. Berdasarkan *Long Form Survey* Penduduk (LFSP) tahun 2020 AKI di Indonesia 189 per 100.000 kelahiran hidup. Target penurunan AKI sebesar 77 per 100.000 kelahiran hidup telah ditetapkan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, untuk mengejar target SDG's yaitu kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Kondisi ini mengisyaratkan perlunya upaya yang lebih strategis dan komprehensif, diperlukan paling tidak penurunan kematian ibu sebesar 5,5% per tahun. Jumlah Kematian Ibu tahun 2022 sebanyak 4005 orang dengan penyebab langsung kematian ibu adalah penyebab lain (44%), eklampsia (23%), perdarahan (20%), infeksi (5%), COVID-19 (2%), dan belum diketahui (6%). Penyebab kematian ibu ini menunjukkan bahwa kematian maternal dapat dicegah apabila cakupan pelayanan disertai dengan mutu pelayanan yang baik (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/560/2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif Di Rumah Sakit, n.d.).

Preeklampsia merupakan gangguan hipertensi yang mempengaruhi 3-8% wanita yang melahirkan di seluruh dunia. Preeklampsia dapat berkembang menjadi eklampsia yang melibatkan kejang dan dapat mengancam jiwa. Preeklampsia dan eklampsia memberikan kontribusi signifikan terhadap morbiditas dan mortalitas ibu dan perinatal. Gangguan hipertensi bertanggung jawab atas sekitar 16% kematian ibu secara global, pada tahun 2023 ini setara dengan sekitar 42.000 kematian (Cresswell et al., 2025; World Health Organization, 2025b). Pada wanita dengan preeklampsia, suntikan magnesium sulfat dapat diberikan untuk mengurangi risiko eklampsia lebih dari setengahnya. Meskipun magnesium sulfat tersedia, penggunaannya masih terbatas di banyak daerah dengan sumber daya terbatas (World Health Organization, 2020).

Preeklampsia termasuk sindrom spesifik kehamilan yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah setelah usia kehamilan 20 minggu disertai proteinuria atau disfungsi organ akibat gangguan perfusi plasenta dan disfungsi endotel. Kondisi ini dapat berkembang menjadi eklampsia yang ditandai kejang dan menjadi kegawatdaruratan obstetri yang mengancam jiwa ibu dan janin, serta berisiko menimbulkan komplikasi serius seperti gagal organ, solusio plasenta, kelahiran

prematur, hingga kematian maternal dan perinatal. Secara patofisiologis, kondisi ini berkaitan dengan abnormalitas plasenta yang memicu hipoperfusi, inflamasi, dan vasokonstriksi sistemik, sehingga sering berkembang tanpa gejala awal yang khas. Oleh karena itu, deteksi dini di pelayanan primer menjadi sangat penting melalui pengkajian terintegrasi, interpretasi parameter klinis, serta penggunaan *clinical reasoning* oleh bidan dalam menentukan tindakan dan rujukan yang tepat (Lee & Lee, 2025).

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *Outcome-Based Education* (OBE) yang menekankan pencapaian kompetensi nyata mahasiswa dalam praktik klinis, khususnya dalam kemampuan menilai, menginterpretasi, dan mengambil keputusan terhadap kondisi kegawatdaruratan maternal. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai deteksi dini gangguan hipertensi kehamilan menjadi sangat penting sebagai upaya preventif dalam menurunkan angka komplikasi serta meningkatkan keselamatan ibu dan bayi.

Bab ini akan membahas secara sistematis mengenai konsep, parameter skrining, interpretasi klinis, serta strategi pencegahan komplikasi pada preeklamsia dan eklampsia, dengan penekanan pada kemampuan deteksi dini dan pengambilan keputusan berbasis bukti di pelayanan primer.

Uraian Materi

Uraian materi dalam Bab ini terdiri dari definisi, etiologi, faktor risiko gangguan hipertensi dalam kehamilan, patofisiologi gangguan hipertensi dalam kehamilan, klasifikasi, tanda dan gejala (*red flags*), skrining dan deteksi dini secara tepat, intervensi pencegahan komplikasi, penatalaksanaan, asuhan kebidanan dan rujukan, edukasi kepada ibu hamil dan keluarga, dokumentasi.

A. Definisi Hipertensi dalam Kehamilan

ACOG mendefinisikan hipertensi kronis sebagai tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg atau tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg dalam dua pengukuran yang diperoleh dengan jarak empat jam sebelum usia kehamilan 20 minggu. Jika sBP ≥ 160 dan/atau dBP ≥ 110 mmHg (HT berat), disarankan untuk mengulang pengukuran dalam waktu 15 menit. Pengukuran harus diulang dalam waktu minimal empat jam atau dalam dua kunjungan klinik rawat jalan berturut-turut. Data tentang efek hipertensi sebagaimana didefinisikan oleh ACC/AHA selama kehamilan masih terbatas. Oleh karena itu, manajemen kehamilan kemungkinan akan terus berkembang (American College of Obstetricians and Gynecologists, 2013).

Pada tahun 2017, *American College of Cardiology* (ACC) dan *American Heart Association* (AHA) merilis pedoman baru untuk evaluasi tekanan darah tinggi. Mereka menurunkan definisi hipertensi sebagai berikut (Garovic et al., 2022):

1. Normal: $< 120/80$ mmHg
2. Tekanan darah tinggi: 120 hingga $129/< 80$ mmHg)
3. Hipertensi stadium 1: 130 hingga $139/80$ hingga 89 mmHg
4. Hipertensi stadium 2: $\geq 140/90$ mmHg

B. Etiologi

Kondisi yang mengurangi aliran darah uteroplasenta dan insufisiensi vaskular, termasuk hipertensi yang sudah ada sebelumnya, penyakit ginjal, diabetes melitus, OSA, trombofilia, dan penyakit autoimun, telah menunjukkan peningkatan risiko penyakit hipertensi pada kehamilan. Selain itu, wanita dengan riwayat preeklampsia sebelumnya, riwayat sindrom HELLP sebelumnya, kehamilan kembar atau kehamilan ganda lainnya, BMI >30 , penyakit autoimun, wanita yang berusia lebih dari 35 tahun, ibu pertama kali, atau memiliki ibu atau saudara perempuan yang pernah mengalami hipertensi gestasional berisiko lebih tinggi untuk

mengembangkan hipertensi gestasional dan berisiko lebih tinggi untuk berkembang menjadi preeklampsia (American College of Obstetricians and Gynecologists, 2020; Dymara-Konopka et al., 2018; Miller et al., 2020).

C. Faktor Risiko Gangguan Hipertensi dalam Kehamilan

Faktor resiko terjadinya hipertensi dalam kehamilan (Kemenkes Ditjen Keslan, 2024):

1. Primigravida (Wanita yang pertama kali hamil). Primiternitas (Kehamilan pertama dengan suami kedua)
2. Kehamilan kembar.
3. Ibu dengan Diabetes Melitus (Kencing manis).
4. Umur yang ekstrim (> 35 tahun).
5. Riwayat preeklamsia pada kehamilan sebelumnya.
6. Riwayat Keluarga yang pernah preeklamsia atau eklamsia.
7. Penyakit-penyakit ginjal dan hipertensi yang sudah ada sebelum kehamilan.
8. Memiliki penyakit autoimun.
9. Obesitas.

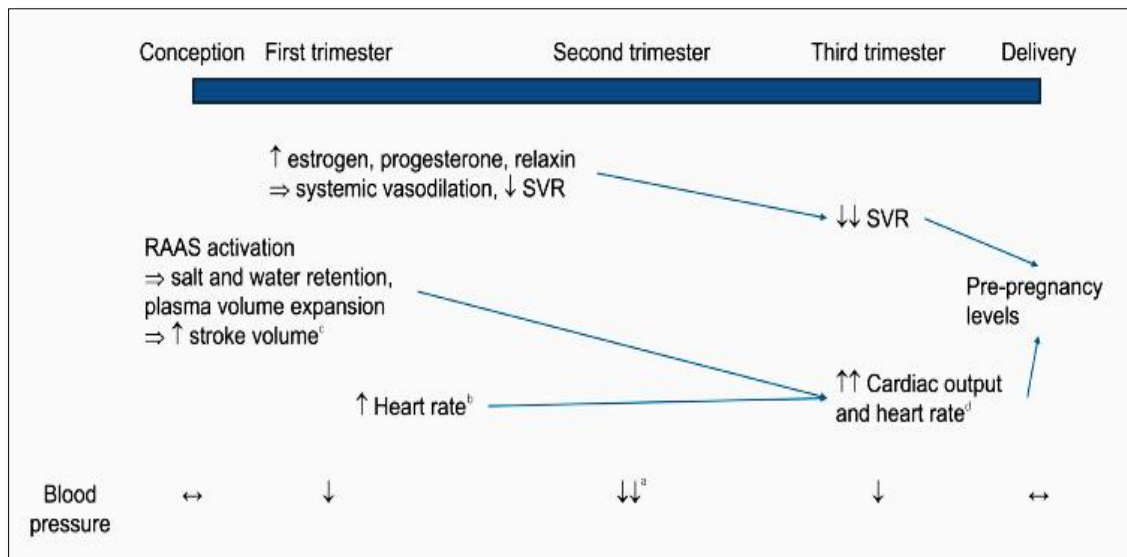
Faktor resiko menurut (Garovic et al., 2022) terbagi 2 yaitu:

1. Faktor Risiko Tinggi
 - a. Riwayat preeklamsia sebelumnya
 - b. Hipertensi kronis stadium 2 + ($\geq 140/90$ mm Hg)
 - c. Diabetes pra-kehamilan
 - d. Kehamilan kembar
 - e. Sindrom antifosfolipid
 - f. Lupus eritematosus sistemik
 - g. Penyakit ginjal kronis
2. Faktor Risiko Sedang
 - a. Usia ibu >35 tahun
 - b. Indeks Massa Tubuh (BMI) sebelum kehamilan $> 30 \text{ kg/m}^2$
 - c. Riwayat keluarga (kerabat tingkat pertama)
 - d. Ras (Kulit Hitam)
 - e. Status sosial ekonomi rendah
 - f. Nulliparitas
 - g. Riwayat hasil kehamilan yang buruk:
 - h. Kelahiran mati
 - i. Abrupsio plasenta
 - j. Lainnya
 - 1) Hipertensi kronis (130–134/80–84 mm Hg)

- 2) Hipertensi kronis (135–139/85–90 mm Hg)
- 3) Hipertensi berat
- 4) Hipertensi jas putih (*white coat hypertension*)
- 5) Indeks Massa Tubuh sebelum kehamilan $>25 \text{ kg/ m}^2$
- 6) Resistensi insulin $>$ persentil ke-75
- 7) Diabetes gestasional
- 8) Pulih dari cedera ginjal akut
- 9) Hipertiroidisme
- 10) Mola hidatiform
- 11) Janin dengan trisomi 13
- 12) Kerentanan genetik 88 , 89
- 13) Teknologi reproduksi berbantuan
- 14) Donasi sel telur
- 15) Ayah baru
- 16) Jarak kehamilan >4 tahun
- 17) Migrain

D. Patofisiologi Gangguan Hipertensi Kehamilan

Pada awal trimester pertama, kadar estrogen, progesteron, dan relaksin (hormon yang mengatur pelepasan oksida nitrat) meningkat dengan cepat dan tetap tinggi sepanjang kehamilan, mengakibatkan vasodilatasi sistemik dan penurunan resistensi vaskular sistemik. Pada saat yang sama, sistem renin-angiotensin-aldosteron (RAAS) diaktifkan mulai dari pembuahan dan berlanjut selama kehamilan, menahan garam dan air, memperluas volume plasma, dan mengakibatkan peningkatan volume stroke. Denyut jantung mulai meningkat sejak minggu kelima kehamilan dan secara bertahap meningkat sepanjang kehamilan, sebagian disebabkan oleh anemia fisiologis yang disebabkan oleh perluasan volume plasma. Takikardia yang dikombinasikan dengan peningkatan volume stroke menyebabkan peningkatan curah jantung. Curah jantung dan denyut jantung tertinggi, sedangkan resistensi vaskular sistemik terendah pada awal trimester ketiga, dan cenderung kembali ke tingkat sebelum kehamilan saat mendekati waktu persalinan (Gambar 5.1). Sebagai hasil dari efek gabungan tersebut, tekanan darah selama kehamilan normal umumnya lebih rendah daripada sebelum kehamilan. Tekanan darah mulai menurun sangat dini dalam kehamilan, mencapai titik terendah pada trimester kedua, mulai meningkat pada trimester ketiga, dan kembali mendekati tingkat sebelum kehamilan setelah melahirkan.



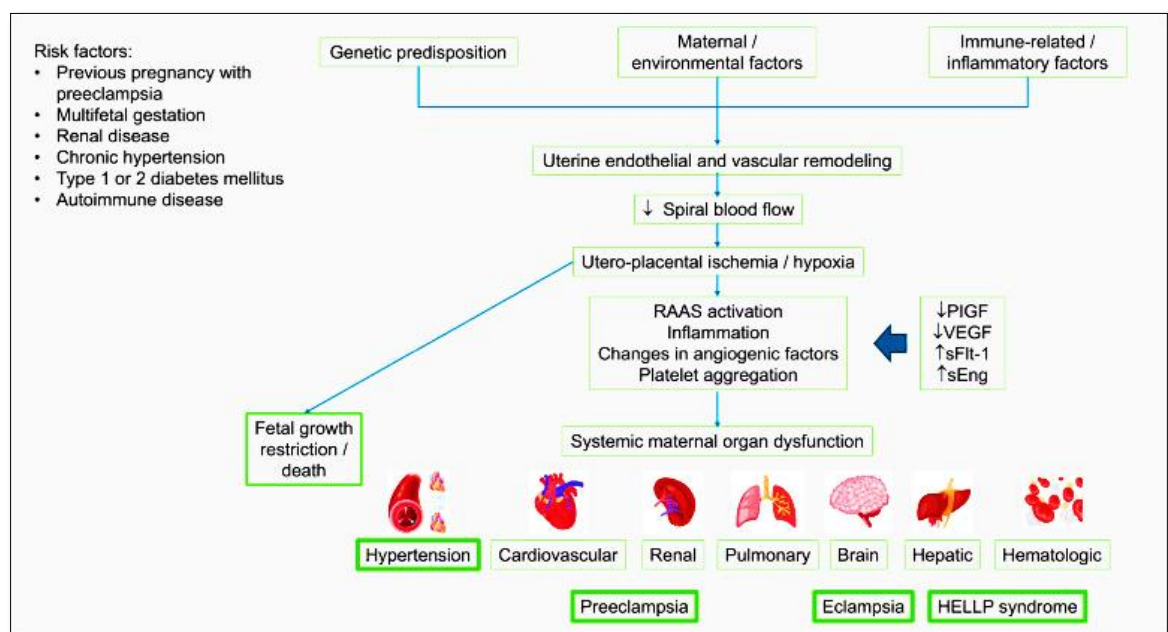
Gambar 5.1: Perubahan hemodinamik selama kehamilan normal.

Tabel 5.4: Perubahan hemodinamik pada kehamilan (Cífková, 2023)

Parameter	Mengubah	Pengaturan waktu
Tekanan darah sistolik	↓ 4–6 mmHg	Nilai terendah pada usia kehamilan 20–24 minggu, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai nilai sebelum kehamilan pada saat kehamilan cukup bulan.
Tekanan darah diastolik	↓ 8–15 mmHg	
Tekanan arteri rata-rata	↓ 6–10 mmHg	
Detak jantung	↑ 12–18 denyut/menit	Awal trimester kedua, kemudian stabil.
Volume stroke	↑ 10–30%	Awal trimester kedua, kemudian stabil.
Curah jantung	↑ 33–45%	Nilai puncak pada awal trimester kedua, kemudian hingga akhir kehamilan

Patofisiologi HDP diakibatkan predisposisi genetik, faktor lingkungan/ibu, dan respons imun/inflamasi (Gambar 5.2). Besarnya perubahan tekanan darah selama kehamilan sangat bervariasi dan faktor kesehatan ibu yang sudah ada sebelumnya seperti hipertensi kronis atau indeks massa tubuh berkontribusi

terhadap tekanan darah. Selama kehamilan normal, remodeling endotel dan otot polos vaskular secara signifikan meningkatkan diameter arteri spiral uterus. Namun, kegagalan dalam remodeling arteri spiral (yaitu, retensi otot polos) menyebabkan perfusi utero-plasenta yang tidak mencukupi. Retensi otot polos dan hipoksia plasenta mengakibatkan respons inflamasi, aktivasi RAAS, perubahan faktor angiogenik, dan agregasi trombosit, yang semuanya menyebabkan disfungsi endotel, yang pada gilirannya menyebabkan disfungsi organ maternal sistemik, yang dapat bermanifestasi secara klinis sebagai preeklampsia dan, dalam beberapa kasus, eklampsia atau sindrom hemolisis, peningkatan enzim hati, dan trombosit rendah (HELLP).



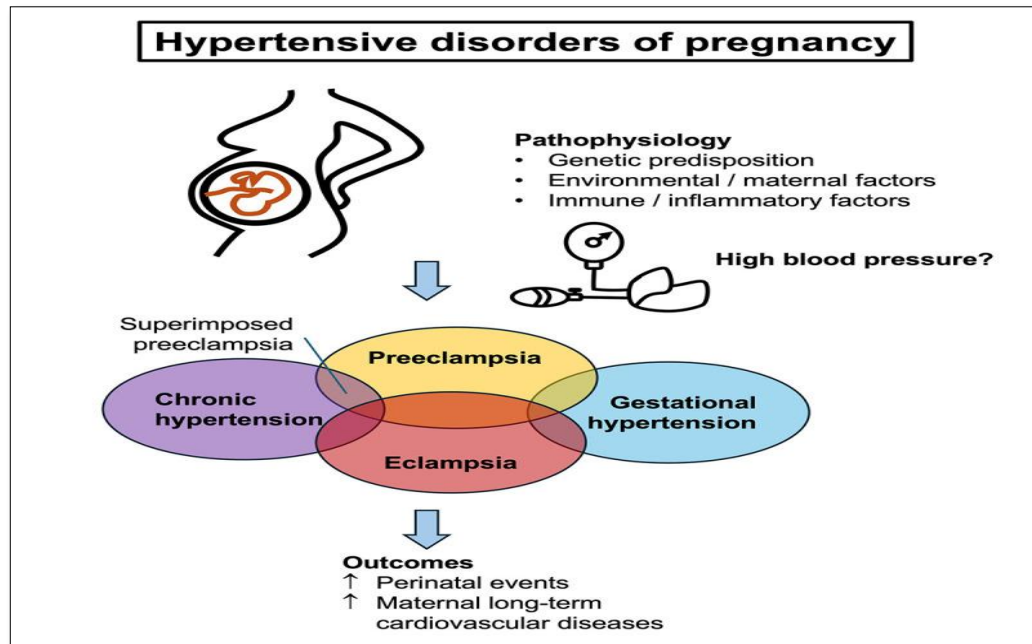
Gambar 5.2: Patofisiologi Gangguan Hipertensi Pada Kehamilan.

E. Klasifikasi dan Definisi Penegakan Diagnosis Gangguan Hipertensi Pada Kehamilan

Tabel 5.5: Klasifikasi Gangguan Hipertasi pada Kehamilan

Klasifikasi	Definisi
Hipertensi Berat	Hipertensi berat pada kehamilan didefinisikan sebagai setidaknya 2 pembacaan tekanan darah yang diambil dengan jarak 4 jam yang berada pada atau di atas ambang batas SBP atau DBP masing-masing 160 atau 110 mmHg
Hipertensi kronis	Peningkatan tekanan darah 140 mmHg dan atau 90 mmHg sebelum kehamilan, atau sebelum 20 minggu, penggunaan

	obat antihipertensi sebelum hamil atau menetap setelah 12 minggu persalinan
Superimposed preeklampsia	Kombinasi hipertensi kronis yang sudah ada sebelumnya dengan tanda-tanda preeklampsia
Hipertensi gestasional	Hipertensi yang berkembang setelah usia kehamilan 20 minggu tanpa proteinuria atau tanda-tanda sistemik lainnya.
Preeklampsia	Hipertensi dengan tekanan darah Sistolik >140 atau diastolik >90 mmHg setelah 2 kali pengukuran dengan jarak minimal 4 jam pada usia kehamilan >20 Minggu pada Wanita yang sebelumnya memiliki tekanan darah normal. Sistolik >160 mmHg atau diastolik >110 mmHg, hipertensi dapat ditegakkan dalam waktu singkat (menit) untuk pemberian anti hipertensi. Pada pemeriksaan Proteinuria Dipstik hasil +1 atau lebih.
Preeklampsia dengan Gejala Berat	1. Hipertensi dengan Sistolik >160 atau diastolik >110 (2 kali pengukuran dengan jarak pengukuran minimal 4 jam - pasien bed rest (kecuali terapi antihipertensi sudah dimulai sebelum pengukuran). 2. Thrombositopenia >> (trombosit < 100>3). Kerusakan fungsi liver >> kenaikan transaminase darah 2 kali normal), nyeri epigastrium (uluhati) yang tidak respon pengobatan dan tidak ada diagnosa alternatif atau keduanya. 3. Insufisiensi renal progresif >> (kenaikan serum kreatinin >1,1 mg/dl, atau kenaikan 2X lipat serum kreatinin tanpa penyakit ginjal lainnya. 4. Oedema Paru.
Eklampsia	Preeklampsia berat yang disertai dengan kejang tonik-klonik umum yang disebabkan ketiadaan penyebab lainnya seperti epilepsy, perdarahan kepala, atau trauma lainnya.
Sindrom HELLP	Preeklampsia berat yang ditandai dengan hemolisis, peningkatan enzim hati, dan trombosit rendah.
Preeklampsia yang terjadi bersamaan dengan hipertensi kronis	Hipertensi kronis yang disertai tanda dan gejala preeklampsia atau eklampsia setelah usia kehamilan 20 minggu.



Gambar 5.3: Hypertensive Disorders Of Pregnancy (HDP)

F. Tanda Dan Gejala Dini Gangguan Hipertensi Dalam Kehamilan (Red Flags)

Gangguan tekanan darah tinggi yang biasanya berkembang setelah usia kehamilan 20 minggu. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko serius bagi ibu dan bayi. Deteksi dan penanganan dini sangat penting untuk mencegah perkembangan menjadi eklampsia, yang melibatkan kejang. Kedua kondisi ini dapat mengancam jiwa. Gejala preeklampsia dapat sangat bervariasi antar individu. Meskipun beberapa orang mungkin mengalami berbagai gejala yang terlihat, yang lain mungkin tetap tanpa gejala. Penting untuk menyadari potensi indikator dan mencari perhatian medis jika timbul kekhawatiran selama kehamilan atau setelah melahirkan.

Gejala umum preeklampsia meliputi:

1. Tekanan Darah Tinggi Yang Terus-Menerus
2. Proteinuria
3. Sakit Kepala Parah
4. Gangguan Penglihatan (Misalnya, Penglihatan Kabur, Melihat Bintik-Bintik)
5. Nyeri Perut Bagian Atas
6. Mual Dan Muntah (Setelah Trimester Pertama)
7. Pembengkakan Pada Tangan Dan Wajah.

G. Skrining Dan Deteksi Dini Secara Tepat

Deteksi dini HDP dilakukan dengan Pengukuran tekanan darah yang akurat untuk mengklasifikasikan hipertensi dan memulai pengobatan, terlepas dari status kehamilan. Karena *sphygmomanometer* merkuri kurang tersedia, perangkat *aneroid* umum digunakan, meskipun memerlukan kalibrasi dan kurang akurat. Beberapa perangkat otomatis osilometrik telah divalidasi pada wanita hamil, termasuk mereka yang mengalami hipertensi gestasional dan preeklampsia (Bello et al., 2018).

ACOG dan *International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy* merekomendasikan penggunaan pengukuran tekanan darah sendiri pada wanita dengan hipertensi kronis atau gestasional, terutama jika tidak terkontrol (American College of Obstetricians and Gynecologists, 2013; Brown et al., 2018). ACOG menekankan pentingnya mendapatkan riwayat medis yang lengkap untuk menilai faktor risiko skrining preeklampsia. Pedoman tersebut mendesak agar semua wanita hamil diukur tekanan darahnya pada setiap kunjungan rutin untuk perawatan prenatal. Skrining dasar untuk proteinuria direkomendasikan; namun, jika tidak ada faktor risiko preeklampsia, pengujian urin rutin dengan strip uji tidak direkomendasikan karena tidak memberikan manfaat. Wanita dengan hipertensi gestasional atau preeklampsia yang tidak memiliki gejala berat harus dipantau secara ketat dengan pengukuran tekanan darah serial (dua kali seminggu) dan jumlah trombosit serta tes enzim hati (mingguan) (Lee & Lee, 2025).

Permenkes Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan Peraturan ini menekankan pentingnya pemeriksaan ANC terpadu, di mana skrining faktor risiko kehamilan (termasuk preeklampsia/hipertensi) wajib dilakukan. Pemeriksaan proteinuria adalah bagian dari skrining dini preeklampsia pada trimester II dan III (Permenkes Nomor 21 Tahun 2021, n.d.). Standar pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan mewajibkan setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (10T) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), yang meliputi pengukuran tekanan darah dan pemeriksaan protein urine, yang menjadi hak pelayanan dasar dan umumnya gratis di Puskesmas bagi peserta JKN/BPJS atau program pemerintah (Permenkes Nomor 6 Tahun 2024, n.d.).

Setiap HDP dapat berkembang menjadi preeklampsia, yang mempengaruhi hingga 35% wanita dengan hipertensi gestasional dan 25% wanita dengan hipertensi kronis. ACOG menganjurkan pengukuran tekanan darah serial dan penilaian gejala, serta pemantauan tekanan darah di klinik dan di luar klinik. Untuk mencegah preeklampsia, aspirin dosis rendah diindikasikan untuk wanita dengan salah satu faktor risiko tinggi preeklampsia, termasuk kehamilan sebelumnya

dengan preeklampsia, kehamilan kembar, penyakit ginjal, hipertensi kronis, diabetes melitus tipe 1 atau 2, atau penyakit autoimun (Lee & Lee, 2025).

Pengukuran auskultasi dengan sphygmomanometer adalah standar. Pengukuran tekanan darah di luar klinik masih berguna untuk wanita dengan dugaan hipertensi jas putih atau hipertensi terselubung, yang lebih umum terjadi pada kehamilan, meskipun nilai pengukuran tekanan darah di rumah pada HDP belum jelas dan hanya beberapa alat pemantauan tekanan darah ambulatori yang direkomendasikan untuk digunakan selama kehamilan (McEvoy et al., 2024; Metoki et al., 2022). Proteinuria didefinisikan sebagai ekskresi proteinuria ≥ 300 mg dalam 24 jam. Tes urin 24 jam dilakukan untuk memastikan apakah tes strip urin skrining $\geq 1+$. Rasio albumin-kreatinin (ACR) berkontribusi untuk mengatasi keterlambatan diagnosis tes urin 24 jam. $ACR \geq 30$ mg/mmol ($\geq 0,3$ mg/mg) menunjukkan proteinuria yang signifikan, sedangkan $ACR < 30$ mg/mol dapat menyingkirkan kemungkinan proteinuria (McEvoy et al., 2024).

H. Komplikasi

Preeklampsia, jika tidak diobati, dapat menyebabkan komplikasi serius bagi ibu dan bayi. Komplikasi ini dapat berupa masalah jangka pendek hingga masalah kesehatan jangka panjang. Intervensi medis yang cepat sangat penting untuk meminimalkan risiko ini.

Komplikasi yang dapat terjadi bersifat serius dan meliputi:

1. Eklampsia (Kejang)
2. Sindrom Hellp (Hemolisis, Peningkatan Enzim Hati, Jumlah Trombosit Rendah)
3. Kerusakan Organ (Ginjal, Hati, Otak)
4. Abrupsi Plasenta
5. Kelahiran Prematur
6. Pembatasan Pertumbuhan Janin
7. Kematian Ibu dan Janin.

I. Penatalaksanaan

Tindakan pencegahan berfokus pada perawatan prenatal rutin untuk memantau tanda-tanda awal preeklampsia. Rekomendasi meliputi (World Health Organization, 2025a):

1. Pemeriksaan Tekanan Darah Secara Teratur
2. Tes Urine Untuk Protein
3. Memantau Gejala Seperti Sakit Kepala Dan Gangguan Penglihatan.

4. Pertimbangan Gaya Hidup, Seperti Menjaga Berat Badan Yang Sehat Dan Aktivitas Fisik (Bila Diizinkan)
5. Mengelola Kondisi Kesehatan Yang Sudah Ada Sebelumnya, Terutama Tekanan Darah Tinggi Yang Sudah Ada Sebelumnya.

Langkah-langkah pencegahan tambahan meliputi:

1. Dosis rendah aspirin pada usia kehamilan 20 minggu atau saat perawatan antenatal dimulai.
2. suplementasi kalsium selama kehamilan di lingkungan dengan asupan makanan rendah
3. Pengobatan tekanan darah tinggi yang sudah ada sebelumnya dengan obat antihipertensi.

Pengobatan utama untuk preeklampsia adalah pemberian magnesium sulfat untuk mencegah kejang. Penanganan dan pengelolaan preeklampsia bergantung pada tingkat keparahan kondisi dan usia kehamilan. Tujuannya adalah untuk mencegah komplikasi (World Health Organization, 2020).

Strategi manajemen lainnya meliputi (World Health Organization, 2025a):

1. Obat antihipertensi untuk mengontrol tekanan darah
2. Kortikosteroid untuk mempercepat pematangan paru-paru janin jika persalinan prematur diperkirakan akan terjadi.
3. Pemantauan ketat terhadap kesehatan ibu dan janin.

Pengobatan non-farmakologis (Lee & Lee, 2025):

Wanita dengan hipertensi kronis harus mematuhi rekomendasi umum untuk pedoman manajemen non-obat selama kehamilan, yang meliputi makan sehat, pembatasan garam, manajemen berat badan, olahraga, dan bekerja. Pembatasan garam tidak diindikasikan pada wanita dengan HDP selain hipertensi kronis yang sudah ada sebelumnya atau untuk pencegahan HDP, terutama di akhir kehamilan, karena potensi penurunan volume intravaskular. Aktivitas fisik intensitas sedang selama 150 menit atau lebih per minggu mengurangi risiko preeklampsia atau hipertensi gestasional sebesar 30–40% dibandingkan dengan tidak melakukan aktivitas fisik. Olahraga intensitas ringan hingga sedang dianjurkan selama kehamilan kecuali ada kontraindikasi absolut, seperti hipertensi yang tidak terkontrol, setelah berkonsultasi dengan dokter kandungan. Kenaikan berat badan selama awal kehamilan dikaitkan dengan perkembangan dan prognosis HDP. Wanita obesitas (indeks massa tubuh [BMI] > 30 kg/m²) dan wanita kelebihan berat

badan (BMI 25,0–29,9 kg/m²) sebaiknya membatasi penambahan berat badan selama kehamilan masing-masing hingga 6,8 kg dan 6,8–11,2 kg.

Pengobatan farmakologis (Lee & Lee, 2025):

Wanita dengan hipertensi kronis yang terkontrol dengan baik dan telah mengonsumsi obat antihipertensi sebelum kehamilan dianjurkan untuk tetap mengonsumsi obat mereka selama kehamilan, kecuali penghambat sistem renin-angiotensin. Pada kasus hipertensi ringan, penghentian atau pengurangan obat mungkin diperlukan karena penurunan tekanan darah fisiologis pada awal dan pertengahan kehamilan.

Obat antihipertensi yang paling umum direkomendasikan untuk hipertensi non-berat dan non-akut adalah nifedipine, methyldopa, dan labetalol. Nifedipine oral kerja panjang adalah agen oral lini pertama yang paling banyak dipelajari dan paling populer. Methyldopa, yang ditemukan kurang efektif dibandingkan dengan penghambat saluran kalsium dan penghambat beta untuk pencegahan hipertensi berat dalam pembaruan terbaru dari tinjauan Cochrane, adalah agen yang kurang disukai dalam pedoman ACOG dan NICE dan saat ini tidak tersedia di Korea.

Amlodipine adalah penghambat saluran kalsium lain yang umum diresepkan, tetapi buktinya sangat terbatas. Tiga seri kasus dan sebuah studi retrospektif terhadap 231 wanita dengan hipertensi kronis pada awal kehamilan menyimpulkan bahwa amlodipine tidak bersifat teratogenik. Sebuah meta-analisis terbaru dari 17 uji coba terkontrol secara acak menemukan bahwa amlodipine dapat menjadi pengobatan yang efektif dan aman untuk HDP. Obat penghambat beta selain labetalol jarang dipelajari dan hasilnya saling bertentangan; namun, beberapa dianggap sebagai agen lini pertama di beberapa negara seperti Kanada, Australia, dan Selandia Baru, dan umumnya tidak direkomendasikan untuk digunakan pada awal kehamilan karena kekhawatiran tentang keterlambatan pertumbuhan janin. Atenolol diketahui menyebabkan pembatasan pertumbuhan janin, terutama bila diberikan dalam jangka waktu yang lama, dan pedoman merekomendasikan untuk tidak menggunakannya.

Hydralazine dan clonidine dapat dianggap sebagai pengobatan lini kedua karena belum terbukti menyebabkan kelainan bawaan atau membahayakan janin. Diuretik tiazid dapat dilanjutkan selama kehamilan jika digunakan sebelum pembuahan, tetapi memulai resep baru selama kehamilan harus didekati dengan hati-hati karena dapat menyebabkan penurunan volume plasma dan peningkatan risiko oligohidramnios, meskipun tidak ada risiko teratogenisitas. Obat ini tidak direkomendasikan untuk preeklampsia. Beberapa pedoman merekomendasikan prazosin sebagai pengobatan lini kedua untuk hipertensi gestasional atau kronis. Data mengenai doxazosin sebagian besar terbatas pada pengalaman

dengan feokromositoma, namun, belum ada laporan mengenai hasil buruk pada ibu atau janin, yang menunjukkan bahwa obat ini merupakan agen potensial. Inhibitor enzim pengubah angiotensin (ACEI) dan penghambat reseptor angiotensin II (ARB) sangat dikontraindikasikan pada wanita hamil karena risiko kerusakan ginjal janin pada trimester kedua dan ketiga dan kematian janin selama kehamilan.

Prosedur Penatalaksanaan

1. Pengelolaan umum

- a. Jika tekanan diastolik > 110 mmHg, berikan antihipertensi (nifedipin 5 10 mg oral) sampai tekanan diastolik antara 90-100 mmHg
- b. Pasang infus ringer laktat dengan jarum besar no. 16 atau lebih
- c. Ukur keseimbangan cairan, jangan sampai terjadi overload
- d. Kateterisasi urin untuk pengukuran volume dan pemeriksaan proteinuria
- e. Infus cairan dipertahankan 1,5-2 liter/24 jam
- f. Jangan tinggalkan pasien sendirian, kejang disertai aspirasi dapat mengakibatkan kematian ibu dan janin
- g. Observasi tanda-tanda vital, refleks dan denyut jantung janin setiap 1 jam
- h. Auskultasi paru untuk mencari tanda edema paru, jika ada edema paru hentikan pemberian cairan dan berikan diuretic
- i. Nilai pembekuan darah dengan uji pembekuan, jika pembekuan tidak terjadi setelah 7 menit, kemungkinan terjadi koagulopati
- j. Anti konvulsan, Magnesium Sulfat merupakan obat pilihan untuk mencegah dan mengatasi kejang pada preeklamsia dan eklamsia.

2. Manajemen Ekspektatif atau Konservatif Pertimbangan persalinan/terminasi kehamilan:

- a. Pada ibu dengan eklamsia, bayi harus segera dilahirkan dalam 6 jam sejak terjadinya kejang.
- b. Induksi persalinan dianjurkan bagi ibu dengan preeklamsia berat dengan janin yang belum viabel atau tidak akan viable dalam 1-2 minggu.
- c. Pada ibu dengan preeklamsia berat, dimana janin sudah viabel namun usia kehamilan belum mencapai 34 minggu, manajemen ekspektatif dianjurkan, asalkan tidak terdapat kontraindikasi. Lakukan pengawasan ketat.
- d. Pada ibu dengan preeklamsia berat, dimana usia kehamilan antara 34-37 minggu, manajemen ekspektatif boleh dianjurkan, asalkan tidak terdapat hipertensi yang tidak terkontrol, disfungsi organ ibu dan gawat janin.

3. Pemberian MgSO₄

Pemberian MgSO₄ pada preeklampsia berat berguna untuk mencegah terjadinya kejang/eklampsia atau kejang berulang. Rute administrasi magnesium sulfat yang dianjurkan adalah intravena untuk mengurangi nyeri pada lokasi suntikan. Magnesium sulfat merupakan pilihan utama pada pasien preeklampsia berat dibandingkan diazepam atau fenitoin, untuk mencegah terjadinya kejang/eklampsia atau kejang berulang.

Waktu, durasi, dosis dan rute administrasi pedoman The Royal College of Obstetrician Gynecologist (RCOG) untuk tatalaksana preeklampsia berat merekomendasikan dosis loading MgSO₄ 4-gram selama 20 menit dilanjutkan dengan dosis pemeliharaan 1gr/jam selama 24 jam postpartum atau setelah kejang terakhir, kecuali terdapat alasan tertentu untuk melanjutkan pemberian MgSO₄. Pemantauan produksi urin, refleks patella, frekuensi napas dan saturasi oksigen penting dilakukan saat memberikan MgSO₄, Pemberian ulang 2 gr bolus dapat dilakukan apabila terjadi kejang berulang.

Lakukan pemeriksaan fisik tiap jam meliputi tekanan darah, frekuensi nadi, pernafasan, refleks patella dan produksi urine. Bila frekuensi napas < 16x/menit, dan atau tidak didapatkan refleks patella dan atau oliguria (produksi urine < 30ml/jam) segera hentikan pemberian MgSO₄. Suntikkan calcium glukonas 1 gr intravena (10 ml larutan 10%) bolus dalam 10 menit.

Selama ibu dengan preeklampsia dan eklampsia dirujuk, pantau dan nilai adanya perburukan preeklampsia. Apabila terjadi eklampsia lakukan penilaian awal dan tatalaksana kegawatdaruratan. Berikan kembali MgSO₄ 2gr iv perlahan (15-20 menit). Bila setelah pemberian MgSO₄ ulangan masih terdapat kejang, dapat dipertimbangkan pemberian diazepam 10-mg iv selama 2-menit

Sediaan MgSO₄ yang ada terdiri dari konsentrasi 40% dan 20%. Apabila dikonversikan dalam kadar gr MgSO₄, untuk sediaan 40% MgSO₄ mengandung makna bahwa 1 gr setara dengan 2.5 ml. Sedangkan untuk sediaan 20% MgSO₄ mengandung makna bahwa 1 gr setara dengan 5 ml Perlu diperhatikan selama pemberian MgSO₄ lakukan pengawasan terhadap pasien. Apabila terjadi tanda-tanda toksisitas, maka segera berikan antidotum calcium glukonas 10%.

4. Pemberian Obat Antihipertensi

Keuntungan dan risiko pemberian antihipertensi pada hipertensi ringan-sedang (tekanan darah 140-169 mmHg/90-109 mmHg) masih kontroversial. Nifedipin sebagai penghambat kanal kalsium digunakan untuk mencegah

persalinan preterm (tokolisis) dan sebagai antihipertensi. Regimen yang direkomendasikan adalah 10 mg kapsul oral, diulang tiap 15-30 menit, dengan dosis maksimum 30 mg. Penggunaan berlebihan penghambat kanal kalsium dilaporkan dapat menyebabkan hipoksia janin dan asidosis. Hal ini disebabkan akibat hipotensi relatif setelah pemberian penghambat kanal kalsium.

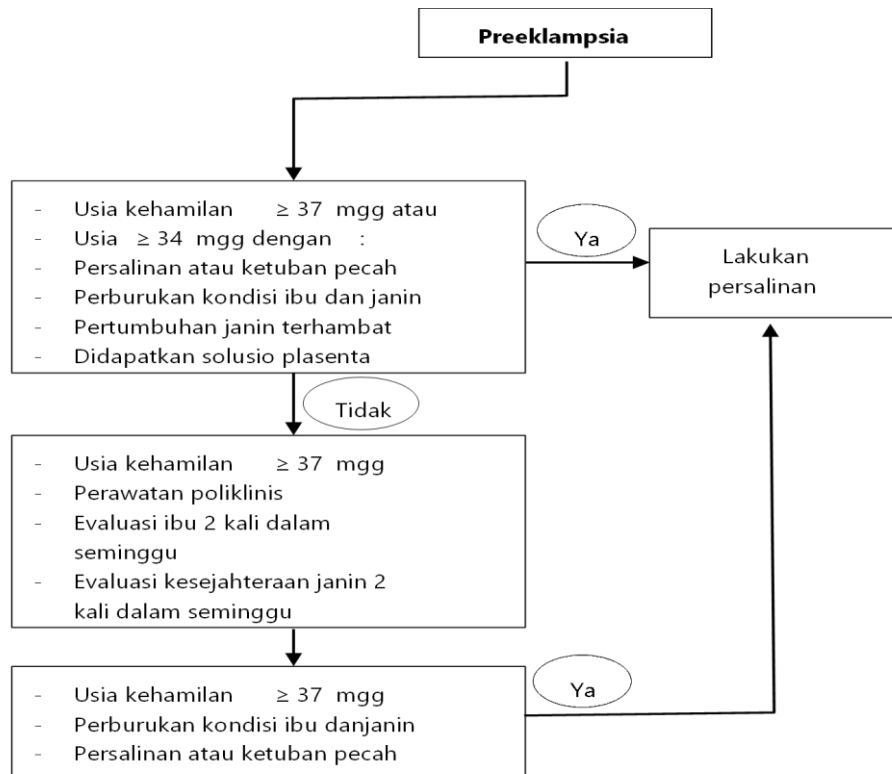
Nikardipin merupakan penghambat kanal kalsium parenteral, yang mulai bekerja setelah 10 menit pemberian dan menurunkan tekanan darah dengan efektif dalam 20 menit (lama kerja 4-6 jam). Antihipertensi diberikan pada tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg atau diastolik ≥ 90 mmHg

5. Pemberian Kortikosteroid

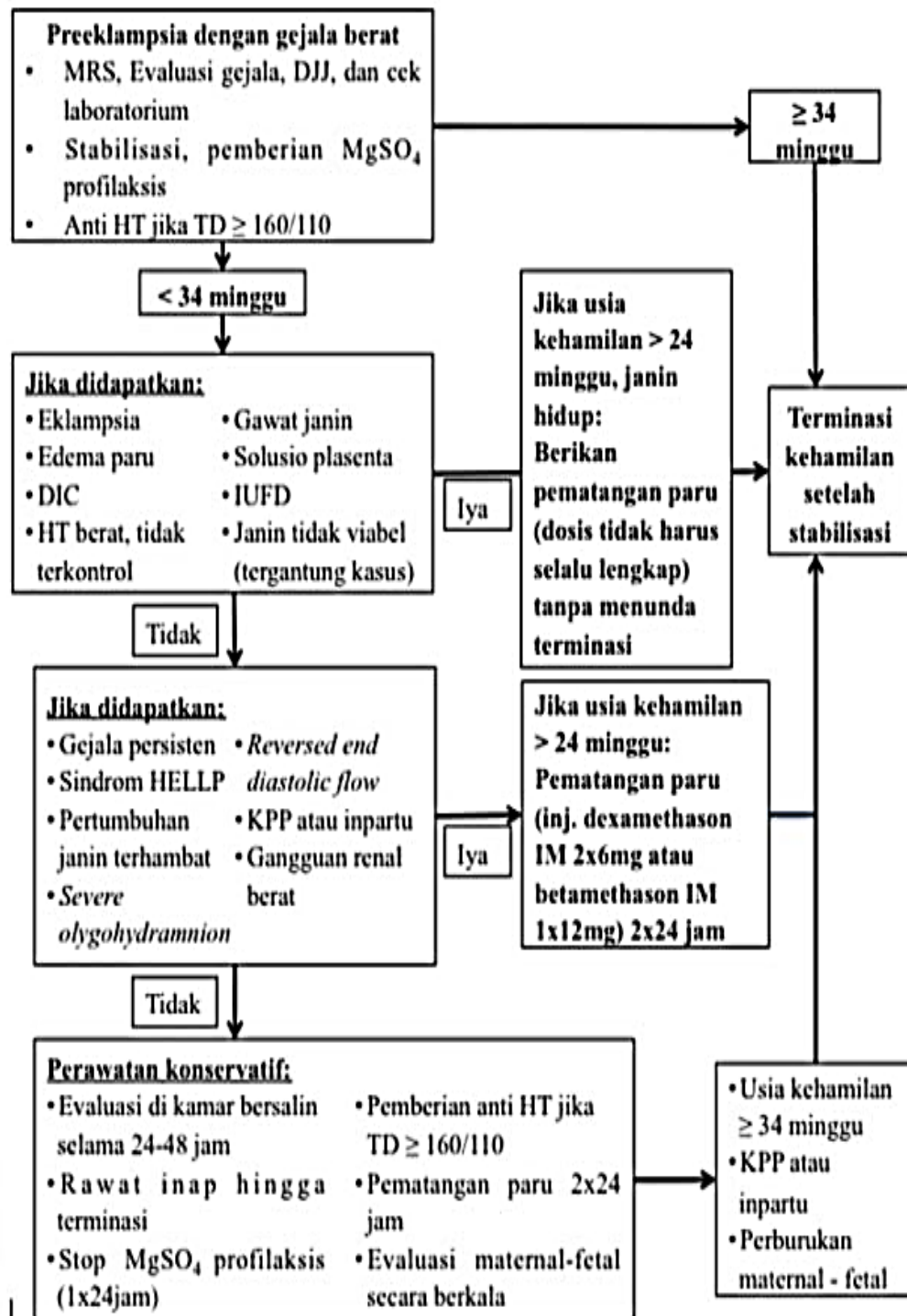
- a. Pemberian kortikosteroid pada sindrom HELLP dapat memperbaiki kadar trombosit, SGOT, SGPT, LDH, tekanan darah arteri rata-rata dan produksi urin.
- b. Pemberian kortikosteroid post partum tidak berpengaruh pada kadar trombosit.
- c. Deksametason lebih cepat meningkatkan kadar trombosit dibandingkan betametason.
- d. Kortikosteroid diberikan pada usia kehamilan 28-36 minggu untuk menurunkan risiko RDS dan mortalitas janin serta neonatal, dengan interval waktu pemberian hingga persalinan: 48 jam-7 hari.
- e. Pemberian ulangan kortikosteroid dapat dipertimbangkan, jika kortikosteroid diberikan minimal 7 hari sebelumnya.

6. Pemeriksaan Penunjang

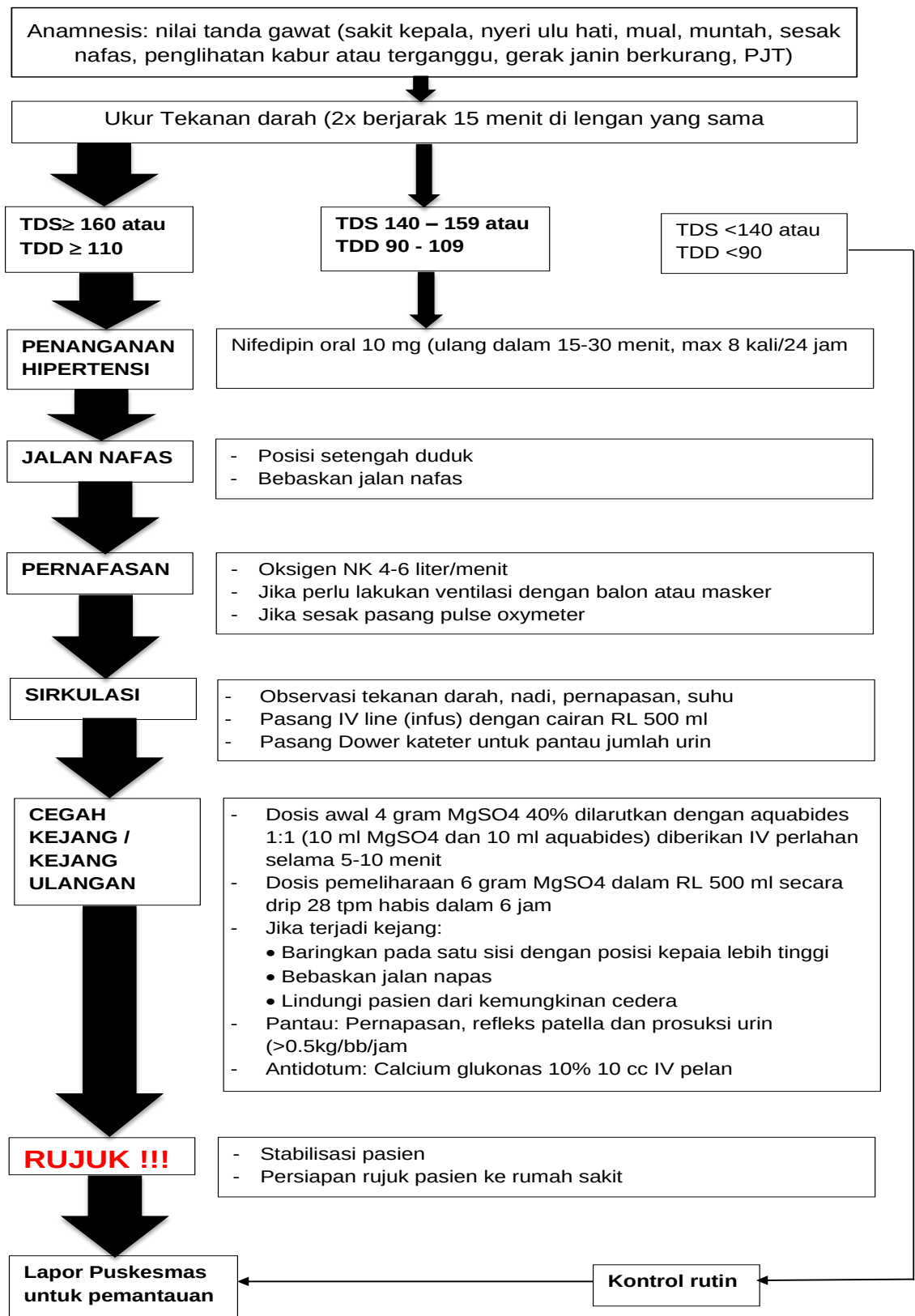
- a. Hitung darah perifer lengkap (DPL).
- b. Golongan darah ABO, Rh dan uji pencocokkan silang.
- c. Fungsi hati (LDH, SGOT, SGPT)
- d. Fungsi ginjal (ureum, kreatinin serum)
- e. Profil koagulasi (PT, APTT, fibrinogen).
- f. USG (terutama jika ada indikasi gawat janin/pertumbuhan janin terhambat).



Gambar 5.4: Clinical Pathway Preeklampsia



Gambar 5.5: Manajemen Ekspektatif Preeklamsi Berat



Gambar 5.6: Alur Penatalaksanaan Preeklamsia Berat/Eklampsia

J. Asuhan Kebidanan

Asuhan yang diberikan bisa dilakukan secara individu ataupun kolaborasi dengan dokter dan tenaga Kesehatan lainnya dalam bentuk Tindakan ataupun edukasi.

1. Penanganan emergensi

Pada eklamsia, perlu dilakukan stabilisasi airway, breathing, dan circulation.

2. Non Medikamentosa

a. Asupan garam

Anjuran untuk mengurangi asupan garam berhubungan dengan luaran yang serupa, termasuk kejadian preeklamsia karena tidak adanya bukti bahwa mengubah asupan garam selama kehamilan memiliki efek menguntungkan untuk pencegahan preeklamsia atau hasil lainnya.

b. Tirah baring

Tirah baring tidak direkomendasikan untuk memperbaiki luaran kehamilan pada wanita dengan hipertensi (dengan atau tanpa proteinuria) dalam kehamilan. Istirahat di tempat tidur atau pembatasan aktivitas fisik lainnya tidak boleh digunakan untuk pencegahan primer preeklamsia dan komplikasinya.

c. Istirahat

Terdapat cukup bukti yang mendukung rekomendasi istirahat atau mengurangi aktivitas pada wanita untuk mencegah preeklamsia dan komplikasinya.

d. Olahraga

Olahraga dapat membantu mencegah preeklamsia pada wanita dengan risiko sedang hingga tinggi tetapi bukti saat ini tidak cukup untuk menarik kesimpulan yang dapat diandalkan tentang efek ini.

e. Pemberian cairan

Pada pasien dengan preeklamsia berat, pemberian cairan dibatasi

80 ml/jam kecuali terdapat kehilangan cairan yang sedang berlangsung (contohnya, perdarahan). Pada kasus edema paru, cairan perlu direstriksi menjadi 2100 cc selama periode post partum. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan balans cairan yang ketat.

f. Minyak ikan

Penggunaan asam lemak omega-3 yang terkandung dalam minyak ikan tidak terkait dengan pencegahan preeklamsia yang signifikan dalam meta-analisis dari empat penelitian.

g. Bawang putih

Tidak terdapat cukup bukti untuk merekomendasikan peningkatan asupan bawang putih untuk mencegah preeklamsia dan komplikasinya.

h. Ventilasi mekanik

Pada kasus edema paru dengan ancaman gagal nafas, ventilasi mekanik diperlukan. Ventilasi non invasif bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi oksigen inspirasi, menurunkan cairan dari alveolus ke sirkulasi pulmonal, menurunkan kerja pernafasan, dan menurunkan risiko intubasi trakea.

3. Medikamentosa

a. Kalsium

Suplementasi kalsium dikaitkan dengan 35% penurunan kejadian hipertensi dan 55% penurunan risiko preeklamsia. Efek ini paling besar pada wanita dengan asupan kalsium awal rendah atau risiko tinggi preeklamsia, suplementasi kalsium (1,5–2 g/ hari) dapat direkomendasikan.

b. Asam folat

Asam folat tidak direkomendasikan untuk mencegah hipertensi dalam kehamilan.

c. Antioksidan

Terapi antioksidan dengan vitamin C 1000 mg/hari dan vitamin E 400 IU/hari yang dimulai pada awal trimester kedua tidak terkait dengan penurunan risiko preeklamsia. Terapi antioksidan tidak dianjurkan untuk pencegahan preeklamsia.

d. Vitamin D

Asupan vitamin D tidak direkomendasikan untuk mencegah preeklamsia selama kehamilan.

e. Aspirin

Lima percobaan membandingkan agen antiplatelet dengan plasebo atau tanpa agen antiplatelet untuk pengobatan preeklamsia. Tidak terdapat data yang cukup tentang kemungkinan efek dari agen ini ketika digunakan untuk pengobatan preeklamsia. Aspirin bertindak untuk menghambat sintesis tromboksan dan mempertahankan sintesis prostasiklin dinding pembuluh darah, yang dapat meningkatkan aliran darah uteroplasenta dan pertumbuhan janin. Aspirin dosis rendah (75–150 mg/ hari) diberikan kepada wanita dengan faktor risiko preeklamsia dikaitkan dengan penurunan 17% risiko preeklamsia, penurunan kecil (8%) risiko persalinan preterm < 37 minggu, penurunan 10% pada bayi KMK, dan penurunan 14% kematian perinatal.

Jika aspirin dosis rendah tetap diberikan karena Riwayat preeklamsia, skrining Doppler arteri uterina mungkin tidak diperlukan atau bermanfaat. Dianjurkan untuk memulai aspirin dosis rendah lebih awal ($\leq$ 16 minggu) pada wanita dengan risiko tinggi untuk preeklamsia karena dikaitkan dengan

penurunan 90% pada preeklamsia berat, penurunan 69% pada hipertensi gestasional, dan penurunan PJT sebesar 49%.

American Heart Association and American Stroke Association merekomendasikan penggunaan aspirin dosis rendah pada >12 minggu kehamilan hingga persalinan untuk wanita dengan hipertensi kronik atau dengan riwayat preeklamsia. Sementara itu, *World Health Organization* (WHO) merekomendasikan aspirin dosis rendah (75 mg) untuk mencegah preeklamsia dan komplikasinya, sebaiknya dimulai sebelum usia kehamilan 20 minggu.

Aspirin dosis rendah tampaknya sedikit atau tidak bermanfaat bagi wanita yang sudah mengalami preeklamsia. Aspirin tidak mencegah perkembangan ke yang berat dan dapat meningkatkan risiko perdarahan pada pasien dengan sindrom HELLP. Profilaksis aspirin harus dihentikan sebelum melahirkan pada usia kehamilan 37 hingga 38 minggu.¹

f. Diuretik

Diuretik seperti furosemid bermanfaat sebagai venodilasi dan diuresis. Diuretik selama kehamilan tidak terkait dengan penurunan kejadian preeklamsia. Pasien preeklamsia dengan komplikasi edema paru, sebaiknya diberikan furosemid intravena 80 mg. Pada penelitian lain, furosemide intravena 20-40 mg selama 2 menit dan diulang 40-60 mg setelah 30 menit (maksimum 120 mg/jam).

g. Magnesium sulfat

Magnesium tidak direkomendasikan untuk pencegahan preeklamsia. Akan tetapi, magnesium sulfat merupakan obat pilihan untuk pencegahan eklamsia karena lebih unggul dari fenitoin dan diazepam. Magnesium dikaitkan dengan penurunan 59% risiko eklamsia, penurunan solusio sebesar 36%, dan penurunan kematian ibu sebesar 46% yang tidak signifikan secara statistik tetapi penting secara klinis. Penurunan serupa terlepas dari tingkat keparahan preeklamsia dengan sekitar 400 wanita yang perlu dirawat untuk mencegah eklamsia untuk preeklamsia ringan, 71 untuk preeklamsia berat, dan 36 untuk preeklamsia dengan gejala sistem saraf pusat (SSP). Magnesium direkomendasikan pada wanita dengan preeklamsia dengan gejala berat. Rute intravena direkomendasikan dimulai dengan dosis awal 4–6 g diikuti dengan dosis pemeliharaan 1–2 g/jam, biasanya diberikan setidaknya pada persalinan aktif dan 24 jam postpartum tanpa pemantauan serum wajib. Selain intravena, magnesium sulfat dapat diberikan intramuscular dengan dosis awal 10 gram, diikuti 5 gram setiap 4 jam. Pada pasien dengan sindrom HELLP sebaiknya diberikan MgSO₄ dari awal dirawat hingga 24–48 jam

postpartum. Ketika operasi sesar diindikasikan, dianjurkan untuk melanjutkan magnesium selama prosedur karena penghentian magnesium dapat meningkatkan risiko eklamsia postpartum. Selain itu, risiko eklamsia akan menurun 60% jika diberikan magnesium sulfat sehingga harus dilanjutkan selama seksio sesaria karena bermanfaat untuk mencegah kejang tanpa risiko perdarahan yang meningkat. Pemberian magnesium harus berhati-hati karena berisiko toksik. Oleh karena itu, magnesium sulfat digunakan sesuai dengan konsentrasi magnesium serum maternal.

Infus $MgSO_4$ harus dihentikan dan kadar magnesium serum segera diperiksa jika refleks tendon dalam hilang, laju pernapasan menurun hingga kurang dari 12 napas per menit, atau urine kurang dari 30 mL per jam. Overdosis dan kematian ibu disebabkan oleh ketidaksesuaian pemberian $MgSO_4$. Antidotum overdosis $MgSO_4$ adalah 10 ml kalsium glukonas 10% yang diberikan secara intravena selama 10-20 menit.

h. Kortikosteroid

Tidak terdapat cukup bukti untuk merekomendasikan penggunaan deksametason atau steroid lain untuk terapi khusus untuk sindrom HELLP. Ketika kortikosteroid diberikan, trombosit ibu membaik tetapi tidak terdapat bukti perbaikan mortalitas ibu, morbiditas ibu yang berat atau kematian perinatal. Pemberian kortikosteroid untuk mengakselerasi maturitas paru janin antara 24 dan 33 6/7 minggu.

Deksametason dapat digunakan pada pasien dengan sindrom HELLP dengan dosis 12 mg IV setiap 6 hingga 12 jam untuk 2-3 dosis, diikuti dengan dosis 5-6 mg IV 6 hingga 12 jam kemudian, 2 hingga 3 dosis.

i. Antihipertensi

Obat antihipertensi untuk pengobatan preeklamsia dengan gejala berat ($TDS \geq 160$ dan/ atau $TDD \geq 110$ mmHg) biasanya berupa labetalol, nifedipin, atau hidralazin. Terapi antihipertensi dapat menurunkan progresivitas menjadi hipertensi berat hingga 50% tetapi tidak terdapat efek pada risiko terjadinya preeklamsia dengan gejala berat dan juga dapat dikaitkan dengan pertumbuhan janin terhambat. Target terapi tekanan darah yaitu sistolik 140-150 mmHg dan diastolik 90 mmHg. Inhibitor ACE kontraindikasi selama kehamilan. Beberapa obat antihipertensi untuk manajemen hipertensi yaitu:

- 1) Labetalol: bolus IV 20 mg, lalu 40, 80 mg sesuai kebutuhan, setiap 10 menit (dosis total maksimum 220 mg).
- 2) Labetalol oral 200 mg setiap 12 jam dan dapat ditingkatkan hingga 800 mg per oral setiap 8-12 jam (maksimum 2400 mg/ hari).

- 3) Hidralazin: 5 sampai 10 mg IV (atau IM) setiap 20 menit. Ganti ke obat lain jika tidak berhasil dengan 30 mg (dosis maksimal). Hidralazin dapat dikaitkan dengan lebih banyak efek samping pada ibu dan NRFHT (Non Reassuring Fetal Heart Tracing) daripada labetalol IV atau nifedipin oral.
- 4) Nifedipin: 10 sampai 20 mg secara oral, dapat berulang dalam 30 menit. Dosis awal 10 mg per oral setiap 6 jam dan ditingkatkan hingga 20 mg setiap 4 jam (40 -120 mg/ hari). Obat ini dikaitkan dengan diuresis bila digunakan setelah melahirkan. Dosis nifedipin maksimum yaitu 120 mg/hari. Nifedipin dan magnesium sulfat mungkin dapat digunakan secara bersamaan. Alternatif regimen ini adalah nifedipine long acting hingga 30 – 60 mg/ hari.
- 5) Natrium nitroprusside (jarang diperlukan): mulai dengan 0,25 μ /kg/menit hingga maksimum 5 μ /kg/menit. Obat ini dapat diberikan pada kasus gagal jantung berat, edema paru, dan hipertensi kritis. Pada kasus edema paru, antihipertensi yang dapat diberikan yaitu CCB (nikardipin, nifedipin), hidralazin, dan prazosin.
- 6) Heparin

Uji coba lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi potensi manfaat heparin dalam mencegah preeklamsia. Oleh karena itu, Low Molecular Weight Heparin (LMWH) saat ini tidak direkomendasikan sebagai profilaksis untuk frekuensi bagi wanita dengan riwayat preeklamsia.
- 7) Progesteron

Tidak terdapat cukup bukti tentang efek progesteron untuk mencegah preeklamsia dan komplikasinya.
- 8) Nitrit Oksida

Tidak terdapat cukup bukti tentang apakah donor dan prekursor nitrit oksida mencegah preeklamsia atau komplikasinya.
- 9) Nitrogliserin

Pada hipertensi berat dengan komplikasi edema paru, nitrat seperti nitrogliserin (gliseril tinitrat) merupakan terapi pilihan. Hal ini juga serupa of Cardiology.
- 10) Ekspansi volume

Ganzevoort dkk. menemukan bahwa ekspansi volume tidak memberikan manfaat tambahan pada wanita yang ditangani dengan preeklamsia dengan gejala berat pada 24–33 minggu 6 hari. Pada pasien preeklamsia dengan gejala berat, pemberian ekspansi volume tidak diindikasikan kecuali terapi antihipertensi antenatal berupa hidralazin.

National Institute for Clinical Excellence menyarankan ekspansi volume (loading cairan) hanya dapat dipakai jika hidralazin sebagai antihipertensi antenatal untuk mencegah hipertensi berat.

K. Rujukan

Rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap (RS PONEK). Prinsip saat merujuk adalah lebih cepat dirujuk, lebih baik, keterlambatan rujukan bisa meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi dan gunakan sistem rujukan berjenjang (Puskesmas → RS). Rujuk apabila ditemukan:

1. Tekanan Darah Tinggi Berat: TD $\geq$ 160/110 mmHg (dua kali pemeriksaan)
2. Diagnosis atau Kecurigaan: Preeklamsia berat/ Eklamsia/ HELLP syndrome (Hemolysis, Elevated Liver Enzyme, Low Platelet)
3. Adanya Red Flags: Kejang, Gangguan penglihatan, Nyeri epigastrium hebat, Sesak napas, Penurunan kesadaran
4. Gangguan Janin: DJJ tidak normal, Gerakan janin berkurang, IUGR berat
5. Tidak Respon Terhadap Terapi: TD tidak turun setelah terapi awal dan Kondisi ibu memburuk

Tatalaksana Pra-Rujukan (Sangat Penting):

Sebelum merujuk, bidan WAJIB melakukan stabilisasi:

1. Posisi: Miring kiri (meningkatkan perfusi uteroplasenta)
2. Pemberian Obat (sesuai kewenangan & protokol): antihipertensi: nifedipine, pencegahan kejang: magnesium sulfate
3. Monitoring: tekanan darah, kesadaran, DJJ dan tanda vital lainnya
4. Persiapan Rujukan: pasang infus (RL/NaCl), bawa catatan medis lengkap, edukasi keluarga dan dampingi pasien selama rujukan

L. Edukasi Kepada Ibu Hamil Dan Keluarga

Tujuan edukasi: meningkatkan pemahaman ibu & keluarga tentang kondisi hipertensi, mendeteksi dini tanda bahaya, mencegah komplikasi seperti preeklamsia dan eklamsia dan meningkatkan kepatuhan kontrol kehamilan

1. Edukasi tentang Penyakit
 - a. Hipertensi dalam kehamilan adalah tekanan darah tinggi saat hamil
 - b. Jika tidak terkontrol dapat berkembang menjadi Preeklamsia
 - c. Kondisi ini bisa membahayakan ibu dan bayi
2. Edukasi Tanda Bahaya (WAJIB DIINGAT)

Ibu dan keluarga harus segera ke fasilitas kesehatan jika muncul:

 - a. Sakit kepala hebat

- b. Penglihatan kabur
 - c. Nyeri ulu hati
 - d. Bengkak mendadak pada wajah/tangan
 - e. Gerakan janin berkurang
 - f. Kejang (tanda Eklamsia)
3. Edukasi Pola Makan
 - a. Konsumsi makanan: tinggi protein (telur, ikan, daging, kacang-kacangan, sayur dan buah)
 - b. Batasi: garam berlebih (tidak perlu diet ekstrem) dan makanan instan/tinggi natrium
 - c. Minum air cukup ($\pm$ 2 liter/hari)
 4. Edukasi Istirahat & Aktivitas
 - a. Istirahat cukup (tidur 7–8 jam/hari)
 - b. Posisi tidur miring kiri
 - c. Hindari kelelahan
 - d. Aktivitas ringan tetap dianjurkan (jalan santai)
 5. Edukasi Kepatuhan Pengobatan

Jika mendapat terapi:

 - a. Minum obat secara teratur sesuai anjuran: methyldopa, nifedipine
 - b. Jangan menghentikan obat tanpa konsultasi
 6. Edukasi Kunjungan ANC
 - a. Periksa kehamilan minimal sesuai standar ($\geq$ 6 kali)
 - b. Pantau tekanan darah secara rutin
 - c. Lakukan pemeriksaan urin bila dianjurkan
 - d. Ikuti semua anjuran tenaga Kesehatan
 7. Peran Keluarga

Keluarga harus:

 - a. Mengingatkan jadwal kontrol
 - b. Membantu pekerjaan rumah ibu
 - c. Mengawasi tanda bahaya
 - d. Menyiapkan transportasi untuk rujukan darurat
 - e. Memberikan dukungan emosional
 8. Edukasi Persiapan Rujukan
 - a. Ketahui fasilitas rujukan terdekat
 - b. Siapkan: Biaya / BPJS, transportasi dan pendamping
 - c. Jangan menunda jika ada tanda bahaya
 9. Edukasi Pencegahan Komplikasi
 - a. Deteksi dini adalah kunci

- b. Kontrol rutin dapat mencegah Preeklamsia berat
- c. Kepatuhan ibu menentukan keselamatan ibu & bayi

M. Dokumentasi

Dokumentasi kebidanan adalah pencatatan lengkap, akurat, dan sistematis mengenai asuhan yang diberikan kepada klien, sebagai bukti pelayanan profesional dan tanggung jawab hukum. Pada kasus HDK seperti Preeklamsia dan Eklamsia, dokumentasi menjadi sangat penting karena kondisi dapat berkembang cepat, risiko komplikasi tinggi, membutuhkan pemantauan ketat dan kolaborasi

1. Tujuan Dokumentasi

- a. Aspek Klinis
- b. Menjamin kesinambungan asuhan
- c. Memudahkan pemantauan kondisi ibu dan janin
- d. Aspek Hukum
- e. Sebagai bukti legal pelayanan kebidanan
- f. Aspek Komunikasi
- g. Antar tenaga kesehatan (bidan, dokter)
- h. Aspek Pendidikan & Penelitian
- i. Sumber pembelajaran kasus HDK

2. Prinsip dokumentasi

Dokumentasi harus memenuhi prinsip:

- a. Lengkap: semua data dicatat
- b. Akurat: sesuai kondisi nyata
- c. Objektif: tidak berdasarkan asumsi
- d. Tepat waktu: segera setelah tindakan
- e. Jelas & sistematis
- f. Bersifat rahasia (confidentiality)

Berikut adalah contoh Dokumentasi Asuhan Kebidanan pada Ibu Hamil dengan Gangguan Hipertensi dalam Kehamilan (HDK) yang dapat Anda gunakan untuk pembelajaran, laporan praktik, maupun referensi klinik berbasis standar (mengacu pada WHO, Kemenkes, dan praktik kebidanan terkini).

1. PENGKAJIAN

- a. Data Subjektif
 - 1) Identitas ibu (nama, usia, gravida, usia kehamilan)
 - 2) Keluhan utama:
 - Sakit kepala hebat
 - Penglihatan kabur

- Nyeri epigastrium
 - Mual muntah
 - Bengkak pada wajah dan tangan
- 3) Riwayat kesehatan:
- Riwayat hipertensi sebelum hamil
 - Riwayat preeklamsia pada kehamilan sebelumnya
 - Riwayat penyakit ginjal, diabetes
- 4) Riwayat obstetri:
- Primigravida (faktor risiko)
 - Pola aktivitas dan istirahat
- b. Data Objektif
- 1) Tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg (diukur 2 kali)
 - 2) Edema (wajah, tangan, kaki)
 - 3) Proteinuria (+1 atau lebih, jika tersedia pemeriksaan urin)
 - 4) Refleks meningkat (hiperrefleksia)
 - 5) Berat badan meningkat cepat
 - 6) Pemeriksaan janin:
 - DJJ
 - TFU
 - Gerakan janin

2. DIAGNOSA KEBIDANAN

G1P0A0 usia kehamilan 32 minggu dengan Hipertensi dalam kehamilan / Preeklamsia ringan/berat

3. MASALAH POTENSIAL

- a. Preeklamsia berat
- b. Eklamsia
- c. Solusio plasenta
- d. Pertumbuhan janin terhambat (IUGR)
- e. Kematian ibu dan janin

4. KEBUTUHAN SEGERA

Rujukan jika:

- a. TD $\geq 160/110$ mmHg
- b. Proteinuria berat
- c. Tanda bahaya (nyeri epigastrium, gangguan penglihatan)
- d. Kolaborasi dengan dokter

5. INTERVENSI KEBIDANAN

- a. Pemantauan
 - 1) Monitor tekanan darah secara rutin
 - 2) Observasi tanda-tanda bahaya preeklamsia:
 - a) Sakit kepala hebat
 - b) Penglihatan kabur
 - c) Nyeri ulu hati
 - 3) Pantau DJJ dan gerakan janin
 - 4) Pantau edema dan kenaikan berat badan
- b. Edukasi
 - 1) Istirahat cukup (posisi miring kiri)
 - 2) Diet:
 - a) Tinggi protein
 - b) Rendah garam (tidak ekstrem)
 - 3) Minum cukup
 - 4) Edukasi tanda bahaya:
 - a) Kejang
 - b) Penurunan gerak janin
 - c) Perdarahan
 - 5) Kepatuhan ANC rutin
- c. Tindakan Mandiri Bidan
 - 1) Pencatatan partograf jika persalinan
 - 2) Observasi ketat kondisi ibu dan janin
 - 3) Persiapan rujukan
- d. Kolaborasi
 - 1) Pemberian obat sesuai advis dokter:
 - a) Methyldopa
 - b) Nifedipine
 - c) Magnesium Sulfate
 - 2) Pemeriksaan laboratorium:
 - a) Protein urin
 - b) Fungsi hati & ginjal

6. IMPLEMENTASI

Dilakukan sesuai intervensi:

1. Mengukur TD secara berkala
2. Memberikan edukasi
3. Observasi tanda bahaya

4. Kolaborasi terapi
5. Dokumentasi

7. EVALUASI

Ibu mengatakan sakit kepala berkurang, tidak ada pandangan kabur

N. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Seorang perempuan usia 26 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 32 minggu, datang ke Puskesmas dengan keluhan sakit kepala sejak 2 hari yang lalu. Ibu juga mengeluh pandangan kabur dan bengkak pada wajah serta tangan.

Hasil pemeriksaan:

TD 160/110 mmHg, nadi 92 x/menit, RR 22 x/menit, suhu 36,8°C, edema (+) pada wajah dan ekstremitas, refleks patella meningkat, protein urin (+2), DJJ 148 x/menit.

Pertanyaan Diskusi

1. Apa masalah utama pada kasus di atas?
2. Data apa saja yang mendukung diagnosis?
3. Apakah kasus ini termasuk Preeklamsia berat? Jelaskan!
4. Tanda bahaya apa yang muncul pada ibu?
5. Apa risiko komplikasi menjadi Eklamsia?
6. Apa tindakan awal yang harus dilakukan bidan?
7. Apakah perlu rujukan? Jelaskan alasan klinisnya!
8. Edukasi apa yang harus diberikan kepada ibu dan keluarga?

TEMPLATE SOAL OSCE KEBIDANAN

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Kehamilan: Deteksi Dini Hipertensi Kehamilan (Preeklamsia)
3	Kasus	Preeklamsia berat dengan deteksi dini dan tindakan awal serta rujukan
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menilai deteksi dini HDK, pengambilan keputusan klinis dan tindakan awal dan rujukan
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik 3. Diagnosis kebidanan 4. Tindakan klinis awal 5. KIE/konseling

		6. Kolaborasi/rujukan 7. Profesionalisme
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan hamil 32 minggu datang dengan keluhan sakit kepala hebat, pandangan kabur, dan bengkak pada wajah. Hasil pemeriksaan: TD 160/110 mmHg, Nadi: 92 x/menit, RR: 22 x/menit, Suhu: 36,8°C, Edema: (+) pada wajah dan ekstremitas, Refleks patella: meningkat, DJJ: 148 x/menit, TFU: sesuai usia kehamilan dan protein urin +2 TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. 2. Lakukan pemeriksaan fisik/obstetri terfokus sesuai kasus. 3. Sampaikan diagnosis/masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh. 4. Lakukan tindakan awal yang tepat pada kasus tersebut. 5. Berikan KIE singkat kepada ibu/keluarga dan jelaskan rencana kolaborasi/rujukan.
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikutkan kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: a. Actual mark (0/1/2/3) b. Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dengan dialog PS yang telah disediakan. 2. Jika peserta menyatakan akan melakukan pemeriksaan fisik umum dan obstetri, penguji memberikan data berikut:

		a. Tekanan darah: 160/110 mmHg b. Nadi: 92 x/menit c. RR: 22 x/menit d. Suhu: 36,8°C e. Edema: (+) pada wajah dan ekstremitas f. Refleks patella: meningkat g. DJJ: 148 x/menit h. TFU: sesuai usia kehamilan 3. Jika peserta meminta hasil pemeriksaan penunjang, penguji memberikan data: a. Protein urin: +2 b. Hemoglobin: normal c. Fungsi ginjal/hati: dalam batas normal (jika ditanyakan) 4. Tindakan awal yang diharapkan dari peserta meliputi: a. Menilai kondisi ibu secara cepat dan sistematis b. Mengidentifikasi tanda bahaya Preeklamsia berat c. Menjelaskan kondisi ibu dengan bahasa sederhana d. Memposisikan ibu miring kiri e. Melakukan pemantauan tekanan darah dan tanda vital f. Menilai kesejahteraan janin (DJJ) g. Menyiapkan tindakan kolaborasi (antihipertensi / MgSO₄ sesuai kewenangan) h. Menentukan kebutuhan rujukan segera i. Memberikan KIE singkat dan dukungan emosional 5. Jika peserta menyebutkan komplikasi, penguji dapat mengonfirmasi bahwa kondisi berisiko berkembang menjadi Eklamsia. 6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang telah ditentukan. 7. Penguji hanya memberikan data tambahan jika: a. Peserta secara aktif meminta data, atau b. Peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai dan tepat 8. Jika peserta menyatakan akan melakukan rujukan, penguji mengonfirmasi bahwa: a. Fasilitas rujukan tersedia b. Peserta diharapkan menjelaskan alasan rujukan dan langkah persiapan rujukan dengan benar 9. Penilaian difokuskan pada: a. Ketepatan deteksi dini Preeklamsia b. Identifikasi tanda bahaya
--	--	--

		c. Ketepatan tindakan awal d. Keputusan rujukan e. Komunikasi dan profesionalisme INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 5. PS PS berperan sebagai ibu hamil usia 32 minggu yang mengalami tanda-tanda Preeklamsia. 6. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif. 7. Bila peserta menyampaikan bahwa ibu perlu dirujuk, PS tampak khawatir tetapi bersedia mengikuti arahan. 8. Tidak memberikan jawaban di luar skenario 9. Tidak membantu peserta (misalnya memberi petunjuk diagnosis) 10. Tidak bertanya kecuali diarahkan skenario
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu PS: Pagi/siang, Bu Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa ibu, apakah ibu bersedia? PS: Iya, Bu Peserta: Selamat pagi/siang, Bu PS: Pagi/siang, Bu Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa ibu, apakah ibu bersedia? PS: Iya, Bu Peserta: Sejak kapan sakit kepala? PS: Sejak 2 hari yang lalu Peserta: Apakah ada keluhan lain? PS: Kadang pandangan saya kabur, Bu Peserta: Ada bengkak? PS: Iya, di wajah sama tangan Peserta: Sejak kapan sakit kepala? PS: Sejak 2 hari yang lalu Peserta: Apakah ada keluhan lain? PS: Kadang pandangan saya kabur, Bu

		Peserta: Ada bengkak? PS: Iya, di wajah sama tangan Peserta: Sejak kapan sakit kepala? PS: Sejak 2 hari yang lalu Peserta: Apakah ada keluhan lain? PS: Kadang pandangan saya kabur, Bu Peserta: Ada bengkak? PS: Iya, di wajah sama tangan Peserta: Bagaimana gerakan bayi? PS: Masih terasa, Bu Jika peserta menjelaskan kondisi: PS: Apakah kondisi saya berbahaya, Bu? Jika peserta menjelaskan perlunya rujukan: PS: Saya harus dirujuk ya, Bu? Baik, saya ikut saran bidan Jika peserta menjelaskan kondisi: PS: Apakah kondisi saya berbahaya, Bu? Jika peserta menjelaskan perlunya rujukan: PS: Saya harus dirujuk ya, Bu? Baik, saya ikut saran bidan Catatan: Jika ada pertanyaan lain terkait riwayat penyakit, riwayat obstetri-ginekologi, sosial, spiritual, ekonomi, dan ADL, PS memberi jawaban normatif dan tidak mengarah ke diagnosis lain.
10	Kebutuhan manikin	1. Phantom abdomen hamil / manekin Leopold 2. Manekin ibu hamil (opsional, untuk simulasi pemeriksaan umum) 3. Phantom lengan untuk simulasi pengukuran tekanan darah (opsional)
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: 1. Menyiapkan dan memastikan seluruh alat dan manekin dalam kondisi siap pakai 2. Mengatur setting ruangan sesuai skenario (ruang ANC / Puskesmas) 3. Menyiapkan lembar instruksi peserta, penguji, dan pasien standar 4. Mengganti lembar penilaian setiap pergantian peserta 5. Memastikan alat seperti tensimeter dan doppler berfungsi dengan baik 6. Membantu menjaga kelancaran jalannya OSCE tanpa intervensi terhadap peserta
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa 2. Tensimeter (manual/digital)

		3. Stetoskop 4. Doppler/Pinard 5. Termometer 6. Jam tangan/stopwatch 7. Timbangan (opsional) 8. Alat ukur tinggi badan (opsional) 9. Sarung tangan bersih 1 pasang 10. Handrub / sabun cuci tangan 11. Kain penutup/selimut 12. Tisu 1 pack 13. Alat pemeriksaan urin (dipstick protein urin) 1 set 14. Formulir hasil pemeriksaan / rekam medis 1 lembar 15. Formulir rujukan 1 lembar 16. Pena
13	Penulis	Bdn. Nur Afifah Harahap, S.Tr.Keb., M.Keb
14	Referensi	1. American College of Obstetricians and Gynecologists. (2013). Hypertension in pregnancy. Report of the American College of Obstetricians and Gynecologists' Task Force on Hypertension in Pregnancy. <i>Obstetrics and Gynecology</i> , 122(5), 1122–1131. https://doi.org/10.1097/01.AOG.0000437382.03963.88 2. American College of Obstetricians and Gynecologists. (2020). Gestational Hypertension and Preeclampsia: ACOG Practice Bulletin Summary, Number 222. <i>Obstetrics and Gynecology</i> , 135(6), 1492–1495. https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003892 3. World Health Organization. (2025a). <i>Pre-eclampsia</i> . World Health Organization. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/pre-eclampsia

O. Rubrik Penilaian dan Kelulusan

Stase 1: Kehamilan: Deteksi Dini Hipertensi Kehamilan (Preeklamsia)

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama		
2. Gerakan janin		
3. Riwayat obstetri (GPA, usia kehamilan, ANC, persalinan sebelumnya bila ada)		
4. Riwayat kesehatan/komplikasi kehamilan/operasi/alergi/obat-obatan		
5. Tanda bahaya yang dialami		

6. Aktivitas harian yang relevan dengan kondisi saat ini (asupan makan-minum, BAK terakhir, kelelahan, dukungan keluarga)		
7. Tanda bahaya yang dialami		

Skoring KOMPETENSI 1

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **7 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4–6 dari 7 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 7 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
A. Persiapan		
1. Menyapa pasien dengan sopan dan ramah		
2. Memperkenalkan diri		
3. Menjelaskan tujuan pemeriksaan		
4. Meminta persetujuan tindakan (informed consent)		
5. Menjaga privasi pasien		
6. Melakukan cuci tangan/hand hygiene		
B. Langkah-langkah		
1. Persiapan Alat a. Tensimeter b. Stetoskop c. Doppler/Pinard d. Termometer e. Alat pemeriksaan urin (dipstick protein) f. Jam/stopwatch g. Sarung tangan bersih		
2. Persiapan Pasien a. Ibu dalam posisi nyaman (duduk/berbaring) b. Lengan sejajar dengan jantung saat pengukuran TD c. Ibu dalam kondisi tenang		
3. Menanyakan keluhan utama: a. Sakit kepala b. Penglihatan kabur c. Nyeri epigastrium d. Bengkak pada wajah/tangan		

e. dll		
4. Cuci Tangan		
5. Melakukan Pemeriksaan Fisik Umum a. Tekanan darah b. Nadi c. RR d. Suhu e. Edema f. Refleks patella g. DJJ h. TFU		
6. Melakukan Pemeriksaan Fisik Khusus a. Observasi edema (wajah, tangan, kaki) b. Pemeriksaan refleks (hiperrefleksia) c. Palpasi abdomen (Leopold) d. Auskultasi DJJ		
7. Melakukan Pemeriksaan Penunjang: Pemeriksaan protein urin (dipstick)		
8. Menganalisis dan Mendiagnosa dengan tepat		
9. Menilai kondisi ibu dan janin secara cepat		
10. Memposisikan ibu miring kiri		
11. Monitoring kesejahteraan ibu dan janin (TD, DJJ dan TTV)		
12. Memberikan edukasi singkat		
13. Kolaborasi dan Rujukan a. Menentukan indikasi rujukan b. Menyiapkan rujukan jika: 1) $TD \geq 160/110$ mmHg 2) Tanda bahaya muncul c. Kolaborasi pemberian terapi: 1) Magnesium Sulfate 2) Antihipertensi sesuai kewenangan		
C. Pasca tindakan		
1. Evaluasi a. Menilai respon ibu terhadap tindakan b. Memastikan kondisi stabil sebelum rujukan		
2. Edukasi (KIE) a. Menjelaskan kondisi ibu		

b. Menjelaskan tanda bahaya: c. Kejang (Eklamsia) d. Penglihatan kabur e. Nyeri ulu hati f. Anjurkan kontrol rutin		
3. Dokumentasi		
4. Rapikan Alat		
5. Mencuci tangan kembali		

Skoring KOMPETENSI 2

- **3** = Jika peserta ujian melakukan **20–24 langkah** dengan tepat dan sistematis.
- **2** = Jika peserta melakukan **15– 19 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–14 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam		
2. Menjelaskan hasil pemeriksaan dan kondisi ibu/janin dengan bahasa sederhana		
3. Menjelaskan tindakan awal yang sedang/akan dilakukan		
4. Menjelaskan perlunya kolaborasi/rujukan segera		
5. Menenangkan ibu dan melibatkan keluarga/pendamping		
6. Memberi kesempatan bertanya dan menjawab pertanyaan dengan jelas		

Skoring KOMPETENSI 3

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **6 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4–5 dari 6 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 6 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Melaksanakan secara sistematis		
2. Menjaga privasi dan keselamatan pasien		

3. Memberikan perhatian terhadap respons ibu		
4. Suara lantang, jelas, tenang, dan informatif		
5. Percaya diri dan tidak ragu-ragu		

Skoring KOMPETENSI 4

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **5 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4 dari 5 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 5 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3

(dicatat di rubrik penilaian)

Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$

(Kota),

.....

Penguji :

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada

Kehamilan: Deteksi Dini Hipertensi Kehamilan (Preeklamsia)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Preeklamsia
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural. Penilai mengamati tindakan yang dilakukan peserta, lalu memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. Domain yang lazim dinilai mencakup informed consent, persiapan pra-tindakan, kemampuan teknis, komunikasi, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan penilaian awal pada ibu hamil. Lalu menilai keterampilan mahasiswa saat melakukan tindakan awal kegawatdaruratan dan menyiapkan rujukan.
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa melakukan tindakan awal yang aman, cepat, dan sistematis pada deteksi dini HDK, pengambilan keputusan klinis dan tindakan awal dan rujukan	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang pemeriksaan ibu hamil dengan preeklamsia tetapi dari kemampuannya menilai kondisi ibu-janin, membaca data kemajuan persalinan, melakukan stabilisasi awal, dan menjelaskan kebutuhan kolaborasi atau rujukan.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang sesuai dengan capaian pembelajaran profesi bidan, khususnya deteksi dini gangguan hiperensi dalam kehamilan	Seorang perempuan hamil 32 minggu datang dengan keluhan sakit kepala hebat, pandangan kabur, dan bengkak pada wajah. Hasil pemeriksaan: TD 160/110 mmHg, Nadi: 92 x/menit, RR: 22 x/menit, Suhu: 36,8°C, Edema: (+) pada wajah dan ekstremitas, Refleks patella: meningkat, DJJ: 148 x/menit, TFU: sesuai usia kehamilan dan protein urin +2
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pada DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan prosedur atau rangkaian tindakan klinik tertentu,	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menilai kondisi ibu dan janin,

	bukan sekadar berdiskusi tentang kasus. Pada topik ini, keterampilan yang relevan antara lain menilai keadaan umum ibu, tanda vital, DJJ, his, pemeriksaan fisik dan penunjang, serta melakukan tindakan awal seperti posisi miring kiri, menyiapkan infus, menjaga keseimbangan cairan, dan menyiapkan rujukan.	menyimpulkan adanya preeklamsi dan kecurigaan gawat janin, menentukan indikasi rujukan, menyiapkan rujukan jika TD $\geq 160/110$ mmHg, Tanda bahaya muncul, segera kolaborasi pemberian terapi magnesium Sulfate dan antihipertensi sesuai kewenangan
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi pemahaman indikasi tindakan, persetujuan tindakan, persiapan pra-prosedur, kemampuan teknis, komunikasi, kemampuan dalam menganalisis, mengidentifikasi, rencana pascatindakan, dan profesionalisme.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu mendiagnosa dan melakukan penatalaksanaan yang tepat sampai pasien di rujuk dan diberikan edukasi
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah mutu performa nyata mahasiswa saat melakukan tindakan awal.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa cepat mengenali kondisi gawat, melakukan prioritas tindakan dengan urutan yang benar, menghindari intervensi yang tidak aman, serta segera meminta bantuan atau menyiapkan rujukan.
Umpan balik	Umpan balik dalam DOPS diberikan segera setelah observasi dan berisi apa yang sudah efektif serta apa yang perlu diperbaiki. Form DOPS juga menekankan komentar assessor mengenai kekuatan, area yang perlu ditingkatkan, dan rencana perbaikan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam menganalisis dan menginterpretasikan hingga memberikan edukasi yang tepat, tetapi masih perlu meningkatkan sistematika dalam memberikan tindakan
Keputusan penilaian	Dalam buku ajar ini, hasil DOPS dapat diringkas menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Keputusan ditetapkan berdasarkan ketepatan langkah,	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan tindakan awal secara runtut, aman, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila

	keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan mengambil keputusan awal.	langkah utama sudah benar tetapi masih memerlukan arahan. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila gagal mengenali kegawatan, salah menentukan prioritas, atau tidak menyiapkan eskalasi dengan benar.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does karena performanya diamati langsung saat melakukan tindakan klinik. Observasi langsung pada pasien nyata dan umpan balik segera menjadikan DOPS sangat sesuai untuk pembelajaran berbasis kompetensi.	Pada kasus preeklamsi, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan tindakan awal kegawatdaruratan kehamilan secara langsung, aman, cepat, dan profesional di lahan praktik.

Tabel Portofolio pada Kegawatdaruratan

Kehamilan: Deteksi Dini Hipertensi Kehamilan (Preeklamsia)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Preeklamsia
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada topik Deteksi Dini Gangguan Hipertensi Kehamilan: Preeklamsia, Eklamsia, dan Pencegahan Komplikasi, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian kehamilan, melakukan deteksi dini yang akurat, melakukan pemeriksaan penunjang yang mendukung, mengenali tanda bahaya ibu dan janin, melakukan tindakan awal, serta

		memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah menangani ibu hamil dengan preeklamsi, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan interpretasi profesional, pengenalan gangguan hipertensi dalam kehamilan, dan tindakan awal pra-rujukan. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan penilaian ibu hamil, stabilisasi awal, dan persiapan rujukan pada kasus preeklamsi
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus ibu hamil 32 minggu dengan keluhan sakit kepala hebat, pandangan kabur, dan bengkak pada wajah. Hasil pemeriksaan: TD 160/110 mmHg, Nadi: 92 x/menit, RR: 22 x/menit, Suhu: 36,8°C, Edema: (+) pada wajah dan ekstremitas, Refleks patella: meningkat, DJJ: 148 x/menit, TFU: sesuai usia kehamilan dan protein urin +2, tindakan awal yang dilakukan, dan keputusan rujukan.

Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya tidak menunda mengetahui gangguan hipertensi dalam kehamilan, ketelitian membaca professional, pemantauan DJJ, pencegahan keterlambatan rujukan, dan komunikasi cepat dengan keluarga pada kasus preeklamsi
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam mengenali gangguan hipertensi dalam kehamilan dan menjelaskan rujukan, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam menilai dan menginterpretasi data
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu menilai dan mengidentifikasi klasifikasi gangguan hipertensi dalam kehamilan.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu menggunakan, mengenali tanda bahaya, dan mengambil keputusan awal yang tepat pada persalinan bermasalah.

Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada topik gangguan hipertensi dalam kehamilan, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik kebidanan nyata.
------------------------	--	---

Case Report pada Kegawatdaruratan

Kehamilan: Deteksi Dini Hipertensi Kehamilan (Preeklamsia)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Preeklamsia
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa mampu membuat laporan singkat ibu hamil 32 minggu dengan keluhan sakit kepala hebat, pandangan kabur, dan bengkak pada wajah. Hasil pemeriksaan: TD 160/110 mmHg, Nadi: 92 x/menit, RR: 22 x/menit, Suhu: 36,8°C, Edema: (+) pada wajah dan ekstremitas, Refleks patella: meningkat, DJJ: 148 x/menit, TFU: sesuai usia kehamilan dan protein urin +2 , tindakan awal yang dilakukan, dan keputusan rujukan.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan,	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data ibu, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, deteksi dini, tindakan awal yang diberikan, rujukan, dan

	rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	perkembangan kondisi ibu serta janin setelah intervensi awal.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ini mahasiswa menuliskan ibu hamil 32 minggu dengan keluhan sakit kepala hebat, pandangan kabur, dan bengkak pada wajah. Hasil pemeriksaan: TD 160/110 mmHg, Nadi: 92 x/menit, RR: 22 x/menit, Suhu: 36,8°C, Edema: (+) pada wajah dan ekstremitas, Refleks patella: meningkat, DJJ: 148 x/menit, TFU: sesuai usia kehamilan dan protein urin +2 , tindakan awal yang dilakukan, dan keputusan rujukan.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu mendeteksi dini gangguan hipertensi dalam kehamilan, menganalisis dan sebagai kondisi yang memerlukan tindakan awal dan rujukan segera.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus preeklamsia, mahasiswa belajar, pemantauan ibu-janin, deteksi dini, pemeriksaan penunjang dan edukasi serta melakukan Tindakan awal dan rujukan

Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep gangguan hipertensi dalam kehamilan, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan secara utuh.
------------------------	--	---

Refleksi Patient Safety pada Kegawatdaruratan

Kehamilan: Deteksi Dini Hipertensi Kehamilan (Preeklamsia)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Preeklamsia
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus preeklamsi, mahasiswa merefleksikan bahwa keterlambatan mengenali preeklamsi dapat menyebabkan perburukan kondisi ibu dan janin.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti salah membaca, tidak memantau DJJ dengan cermat, atau menunda rujukan, dapat berdampak besar pada keselamatan ibu dan bayi.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah, gawat janin, eklamsi, dan keterlambatan penanganan bila kemajuan persalinan

		tidak dipantau dengan benar.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain keterlambatan diagnosis preeklamsi, salah menganalisis maka akan salah penanganan sehingga bs mengalami keterlambatan rujukan dan memperburuk kondisi hingga menjadi eklamsi
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya penggunaan secara konsisten, pemantauan tanda vital dan DJJ, stabilisasi awal ibu, komunikasi cepat kepada keluarga, dan rujukan tepat waktu ke fasilitas yang lebih mampu.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada preeklamsi, pengkajian serial, pengambilan keputusan cepat, dan keberanian melakukan eskalasi adalah bagian penting dari praktik bidan yang aman.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik kebidanan secara berkelanjutan.

P. Tabel Red Flags & Eskalasi

Kegawatdaruratan Kehamilan: Deteksi Dini Hipertensi Kehamilan (Preeklamsia)

Red Flags (Tanda Bahaya)	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
TD $\geq$ 160/110 mmHg	Hipertensi berat, risiko Preeklamsia berat	Stabilisasi awal, antihipertensi, rujuk segera
Sakit kepala hebat menetap	Iritasi serebral, risiko kejang	Observasi ketat, siapkan MgSO_4 , rujuk
Penglihatan kabur / fotopsia	Gangguan neurologis (vasospasme otak)	Rujuk segera, monitoring ketat
Nyeri epigastrium / ulu hati	Iritasi kapsul hati, risiko HELLP syndrome	Kolaborasi, rujuk segera
Kejang	Tanda Eklamsia	Kegawatdaruratan: MgSO_4 , airway, rujuk segera
Penurunan kesadaran	Gangguan neurologis berat	Stabilkan ABC, rujuk segera
Oliguria (<500 ml/24 jam)	Gangguan fungsi ginjal	Monitoring cairan, rujuk
Edema paru (sesak napas)	Overload cairan / gagal jantung	Posisi semi-Fowler, O_2 , rujuk
Proteinuria $\geq$ +2	Kerusakan ginjal, indikasi Preeklamsia	Monitoring ketat, evaluasi lanjutan
Gerakan janin berkurang	Distres janin / IUGR	Evaluasi DJJ, rujuk
DJJ abnormal (<110 atau >160)	Gawat janin	Rujuk segera
Perdarahan pervaginam	Curiga solusio plasenta	Stabilkan ibu, rujuk segera

Form Checklist “Saya sudah bisa...”**Bab 5:** Kehamilan: Deteksi Dini Hipertensi Kehamilan (Preeklamsia)

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian preeklamsi	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa mengenali bahwa tanda dan gejala preeklamsi	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa melakukan anamnesis terarah pada ibu hamil dengan gangguan hipertensi dalam kehamilan	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa menilai deteksi dini HDK	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa pengambilan keputusan klinis	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa melakukan tindakan awal preeklamsi yang aman sesuai kewenangan bidan	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa menjelaskan dampak preeklamsi pada ibu hamil	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa menjelaskan dampak preeklamsi pada janin	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa melakukan pemeriksaan protein urin	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa memposisikan ibu dan memberikan dukungan yang tepat saat terjadi kegawatdaruratan pada kehamilan	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa menyiapkan pemantauan ibu dan janin secara cepat dan sistematis	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa menjelaskan kondisi ibu dan janin kepada keluarga dengan 221rofes sederhana	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa menentukan kapan kasus harus dikolaborasikan atau dirujuk segera	☐	☐	_____

14	Saya sudah bisa menyiapkan rujukan dan handover singkat dengan jelas	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa mendokumentasikan temuan dan 222rofessi awal secara ringkas dan tepat	☐	☐	_____
16	Saya sudah bisa menjaga privasi, keselamatan, dan perilaku professional selama tindakan	☐	☐	_____
17	Saya sudah bisa menjaga privasi pasien	☐	☐	_____
18	Saya sudah bisa melakukan rujukan	☐	☐	_____
19	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

Q. Rangkuman Materi

Hipertensi kronis sebagai tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg atau tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg dalam dua pengukuran yang diperoleh dengan jarak empat jam sebelum usia kehamilan 20 minggu. Jika sBP ≥ 160 dan/atau dBP ≥ 110 mmHg (HT berat), disarankan untuk mengulang pengukuran dalam waktu 15 menit. Pengukuran harus diulang dalam waktu minimal empat jam atau dalam dua kunjungan klinik rawat jalan berturut-turut. Data tentang efek hipertensi sebagaimana didefinisikan oleh ACC/AHA selama kehamilan masih terbatas. Oleh karena itu, manajemen kehamilan kemungkinan akan terus berkembang.

Deteksi dini HDP dilakukan dengan Pengukuran tekanan darah yang akurat untuk mengklasifikasikan hipertensi dan memulai pengobatan, terlepas dari status kehamilan. Karena *sphygmomanometer* merkuri kurang tersedia, perangkat *aneroid* umum digunakan, meskipun memerlukan kalibrasi dan kurang akurat. Beberapa perangkat otomatis osilometrik telah divalidasi pada wanita hamil, termasuk mereka yang mengalami hipertensi gestasional dan preeklampsia

HDP dikaitkan dengan hasil kehamilan yang tidak menguntungkan bagi ibu dan janin, serta penyakit kardiovaskular jangka panjang pada wanita di kemudian hari. Tidak ada satu pun tes yang dapat memprediksi preeklampsia secara andal, sehingga selain pengukuran tekanan darah dan protein urin pada awal kehamilan, penilaian menyeluruh terhadap faktor risiko ibu sangat penting. Selama kehamilan, semua wanita hamil harus menjalani pengukuran tekanan darah secara berkala

untuk skrining HDP. Wanita berisiko tinggi dengan HDP harus dipantau secara ketat, diberikan aspirin dosis rendah sesuai kebutuhan, dan diobati dengan obat antihipertensi yang sesuai. Sebagian besar pedoman internasional menganjurkan ambang batas tekanan darah dan target yang lebih ketat untuk terapi antihipertensi selama kehamilan daripada rekomendasi sebelumnya. Wanita dengan HDP juga memerlukan pemantauan di rumah sakit dan tindak lanjut jangka pendek setelah keluar dari rumah sakit, serta manajemen risiko kardiovaskular seumur hidup.

R. Daftar Pustaka

- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2013). Hypertension in pregnancy. Report of the American College of Obstetricians and Gynecologists' Task Force on Hypertension in Pregnancy. *Obstetrics and Gynecology*, 122(5), 1122–1131. <https://doi.org/10.1097/01.AOG.0000437382.03963.88>
- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2020). Gestational Hypertension and Preeclampsia: ACOG Practice Bulletin Summary, Number 222. *Obstetrics and Gynecology*, 135(6), 1492–1495. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003892>
- Bello, N. A., Woolley, J. J., Cleary, K. L., Falzon, L., Alpert, B. S., Oparil, S., Cutter, G., Wapner, R., Muntner, P., Tita, A. T., & Shimbo, D. (2018). Accuracy of Blood Pressure Measurement Devices in Pregnancy: A Systematic Review of Validation Studies. *Hypertension (Dallas, Tex.: 1979)*, 71(2), 326–335. <https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.10295>
- Bernolian, N., Pangemanan, W. T., Syamsuri, A. K. et. a. (2023). Update Manajemen Preeklamsia dengan Gejala Berat (Eklamsia, Edema Paru, Sindrom HELLP). *Indonesian Journal of Obstetrics & Gynecology Science*, 6(1), 7–19. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24198/obgynia.v6i1.402>
- Brown, M. A., Magee, L. A., Kenny, L. C., Karumanchi, S. A., McCarthy, F. P., Saito, S., Hall, D. R., Warren, C. E., Adoyi, G., & Ishaku, S. (2018). Hypertensive Disorders of Pregnancy: ISSHP Classification, Diagnosis, and Management Recommendations for International Practice. *Hypertension (Dallas, Tex.: 1979)*, 72(1), 24–43. <https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.10803>
- Cífková, R. (2023). Hypertension in Pregnancy: A Diagnostic and Therapeutic Overview. *High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention: The Official Journal of the Italian Society of Hypertension*, 30(4), 289–303. <https://doi.org/10.1007/s40292-023-00582-5>
- Cresswell, J. A., Alexander, M., Chong, M. Y. C., Link, H. M., Pejchinovska, M., Gazeley, U., Ahmed, S. M. A., Chou, D., Moller, A.-B., Simpson, D., Alkema, L., Villanueva, G., Sguassero, Y., Tunçalp, Ö., Long, Q., Xiao, S., & Say, L. (2025). Global and

regional causes of maternal deaths 2009-20: a WHO systematic analysis. *The Lancet Global Health*, 13(4), e626–e634. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(24\)00560-6](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(24)00560-6)

Dymara-Konopka, W., Laskowska, M., & Oleszczuk, J. (2018). Preeclampsia - Current Management and Future Approach. *Current Pharmaceutical Biotechnology*, 19(10), 786–796. <https://doi.org/10.2174/1389201019666180925120109>

Garovic, V. D., Dechend, R., Easterling, T., Karumanchi, S. A., McMurtry Baird, S., Magee, L. A., Rana, S., Vermunt, J. V., August, P., & on behalf of the American Heart Association Council on Hypertension; Council on the Kidney in Cardiovascular Disease Thrombosis and Vascular Biology; Council on Lifestyle and Cardiometabolic Health; Council on Peripheral Vascular Disease; and Stroke Coun, K. in H. D. S. C. C. on A. (2022). Hypertension in Pregnancy: Diagnosis, Blood Pressure Goals, and Pharmacotherapy: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Hypertension*, 79(2), e21–e41. <https://doi.org/10.1161/HYP.0000000000000208>

Kemenkes Ditjen Keslan. (2024). *Hipertensi Dalam Kehamilan*. Kemenkes. https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/3646/hipertensi-dalam-kehamilan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/560/2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif Di Rumah Sakit. (n.d.).

Lee, J.-Y., & Lee, S. H. (2025). Hypertensive disorders of pregnancy: advances in understanding and management. *Clinical Hypertension*, 31, e1. <https://doi.org/10.5646/ch.2025.31.e1>

McEvoy, J. W., McCarthy, C. P., Bruno, R. M., Brouwers, S., Canavan, M. D., Ceconi, C., Christodorescu, R. M., Daskalopoulou, S. S., Ferro, C. J., Gerds, E., Hanssen, H., Harris, J., Lauder, L., McManus, R. J., Molloy, G. J., Rahimi, K., Regitz-Zagrosek, V., Rossi, G. P., Sandset, E. C., ... Touyz, R. M. (2024). 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. *European Heart Journal*, 45(38), 3912–4018. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae178>

Metoki, H., Iwama, N., Hamada, H., Satoh, M., Murakami, T., Ishikuro, M., & Obara, T. (2022). Hypertensive disorders of pregnancy: definition, management, and out-of-office blood pressure measurement. *Hypertension Research: Official Journal of the Japanese Society of Hypertension*, 45(8), 1298–1309. <https://doi.org/10.1038/s41440-022-00965-6>

Miller, M. J., Butler, P., Gilchrist, J., Taylor, A., & Lutgendorf, M. A. (2020). Implementation of a standardized nurse initiated protocol to manage severe hypertension in pregnancy. *The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine: The Official Journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the*

International Society of Perinatal Obstetricians, 33(6), 1008–1014.
<https://doi.org/10.1080/14767058.2018.1514381>

Permenkes Nomor 21 Tahun 2021. (n.d.). *tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan*.

Permenkes Nomor 6 Tahun 2024. (n.d.). *tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, peraturan ini mencabut Permenkes No. 4 Tahun 2019*.

World Health Organization. (2020). *WHO recommendations on drug treatment for non-severe hypertension in pregnancy* (H. WHO (Ed.)). WHO.

World Health Organization. (2025a). *Pre-eclampsia*. World Health Organization.
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/pre-eclampsia>

World Health Organization. (2025b). *Trends in maternal mortality estimates 2000 to 2023: estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and UNDESA/Population Division*. World Health Organization.
<https://www.who.int/publications/i/item/9789240108462>

BAB 6

DETEKSI DINI INFEKSI PADA KEHAMILAN: IMS, ISK, TORCH/INFEKSI LAIN DAN PENCEGAHAN PENULARAN

Pendahuluan

Selama masa kehamilan seorang wanita, bisa saja mengalami infeksi karena kehamilan mengubah sistem kekebalan tubuh dengan cara yang kompleks sehingga meningkatkan kerentanan terhadap penyakit menular tertentu sekaligus menumpulkan tanda-tanda peringatan klinis awal. Infeksi yang sering dialami wanita hamil antara lain Infeksi menular seksual (IMS) seperti *sifilis*, *gonore*, *klamidia*, Infeksi Saluran Kemih (ISK), TORCH, (yang terdiri dari Toxoplasmosis, Rubella, Cytomegalovirus dan Herpes simplex). Juga bakteri vaginosis, kandidiasis, dan Streptococcus grup B dapat menyebabkan komplikasi serius. Penyebaran terjadi melalui jalur genital, darah, atau plasenta. Masa inkubasi bervariasi: TORCH bisa dalam minggu hingga bulan, sementara ISK cepat muncul gejala. Gejala khusus mencakup nyeri saat buang air kecil (ISK), demam, keputihan abnormal (kandidiasis), atau kelainan pada janin (TORCH). Pengaruhnya termasuk kelahiran prematur, abortus, hidrosefalus, dan keterlambatan perkembangan janin. Infeksi yang tidak diobati meningkatkan risiko kematian neonatal.

Pembahasan Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pada peserta didik agar mampu memahami asuhan kebidanan pada wanita hamil yang mengalami infeksi dengan penyebab virus, bakteri ataupun jamur yang dapat mengganggu kenyamanan diri, kestabilan emosi ataupun ancaman terhadap keberlanjutan kehamilan dan dampak pada kondisi janin. Sasaran pembaca buku ini adalah mahasiswa program studi diploma tiga kebidanan

Bab deteksi dini infeksi pada kehamilan ini, akan membahas singkat tentang Infeksi Menular Seksual (IMS), Infeksi Saluran Kemih (ISK), TORCH (Toxoplasmosis, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes), serta infeksi lainnya yang berpotensi menimbulkan komplikasi pada ibu dan janin.

Pembelajaran difokuskan pada kemampuan mahasiswa dalam menerapkan skrining risiko maternal–neonatal berbasis bukti, dengan mengidentifikasi faktor risiko, menggunakan pendekatan skor atau algoritme sederhana, serta menentukan rencana

asuhan dan tindak lanjut yang tepat sesuai kewenangan bidan. Selain itu, mahasiswa juga dibekali kemampuan dalam:

- Menyusun strategi pencegahan penularan infeksi pada ibu dan bayi
- Memberikan edukasi kesehatan yang tepat dan berbasis budaya
- Menentukan alur kolaborasi dan rujukan pada kasus terduga atau terkonfirmasi infeksi.

Dengan demikian, pembelajaran ini mendukung terpenuhinya kompetensi bidan dalam memberikan pelayanan antenatal yang holistik, aman, dan berbasis evidence-based practice.

Tujuan Pembelajaran (learning Outcomes)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan: mampu menerapkan skrining risiko infeksi pada kehamilan secara komprehensif melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan uji sederhana serta menyusun rencana pencegahan, edukasi, dan tindak lanjut/rujukan berbasis bukti sesuai kewenangan bidan

Kompetensi yang Akan dicapai

Mahasiswa mampu:

1. Melakukan pengkajian secara komprehensif pada ibu hamil dengan dugaan Infeksi.
2. Melakukan pemeriksaan fisik secara sistematis untuk mendeteksi tanda dan gejala infeksi pada ibu hamil.
3. Melaksanakan uji sederhana sesuai kewenangan bidan (pemeriksaan urin, Hb, dan rapid test) sebagai bagian dari skrining infeksi
4. merumuskan diagnosa kebidanan, masalah aktual, dan masalah potensial, yang tepat berdasarkan data pengkajian yang dikumpulkan.
5. merencanakan dan melaksanakan intervensi kebidanan pada ibu hamil dengan infeksi pada kehamilan.
6. mengevaluasi efektivitas intervensi kebidanan yang diberikan.
7. mendokumentasikan semua langkah pengkajian, intervensi, dan hasil dalam catatan perkembangan (SOAP) secara tepat dan sistematis.
8. mengedukasi pasien dan keluarga mengenai kondisi ibu hamil yang mempengaruhi kesehatan fisik dan mental, juga janinnya. .
9. Mahasiswa menunjukkan sikap empati, peduli, dan tanggung jawab dalam memberikan asuhan kebidanan kepada ibu hamil dengan infeksi pada masa kehamilan .
10. Mahasiswa bekerja secara kolaboratif dengan tim kesehatan lain, untuk melakukan pencegahan penularan, edukasi, serta alur rujukan pada kasus terduga atau terkonfirmasi infeksi sesuai standar praktik kebidanan

A. Pengertian Deteksi Dini Infeksi Pada Kehamilan

Deteksi dini infeksi pada kehamilan merupakan tindakan pemeriksaan secara komprehensif yang dilakukan pada wanita hamil selama kehamilan. Ketika wanita hamil rutin melakukan pemeriksaan antenatal (ANC), maka akan dilakukan skrining untuk menemukan sedini mungkin adanya agen infeksius ataupun gejala klinis penyakit infeksi. Deteksi dini faktor risiko merupakan upaya penting untuk menemukan ibu hamil berisiko tinggi secepat mungkin. Skrining ini dilakukan oleh bidan sebagai bagian dari pelayanan antenatal untuk mencegah komplikasi seperti abortus, persalinan prematur, infeksi intrauterin, hingga kematian ibu dan bayi (wahyuni A,2022). Skrining secara garis besar tidak dimaksudkan untuk mendiagnosis, sehingga pada hasil uji yang positif harus dilakukan pemeriksaan yang lebih intensif untuk menentukan apakah yang bersangkutan memang sakit atau tidak. Bagi yang diagnosisnya positif, dilakukan pengobatan intensif agar tidak membahayakan bagi dirinya maupun lingkungannya,

B. Tujuan Deteksi Dini Infeksi Pada Kehamilan

Tujuan dilakukannya deteksi dini infeksi kehamilan., meliputi:

1. Mencegah Kematian dan kesakitan bagi ibu) bayi akibat infeksi.
2. **Mencegah Penularan ke Janin** Khususnya pada infeksi HIV, Sifilis, dan Hepatitis B (Triple Elimination)
3. **Penanganan Segera:** Menemukan risiko tinggi lebih awal agar bisa ditangani secara memadai.
4. **Skrining Infeksi TORCH:** Mendeteksi infeksi *Toxoplasma*, *Rubella*, *Cytomegalovirus*, dan *Herpes Simplex*

C. Pelaksanaan Deteksi Dini Infeksi

Pelaksanaan deteksi Dini atau Pengkajian data tentang infeksi dalam kehamilan dilakukan melalui kunjungan antenatal yang berkualitas oleh tenaga kesehatan seperti bidan atau dokter di Puskesmas dan atau fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani pelayanan antenatal. Dengan langkah seperti berikut:

1. **Anamnesis dan Pemeriksaan Fisik:** Bidan harus mampu mengkaji dengan tepat gejala klinis dan memeriksa secara intensif tanda-tanda infeksi, terjadi pada wanita hamil seperti keputihan banyak dan berbau, demam, nyeri dan rasa panas saat buang air kecil, atau kemerahan dan gatal pada genitalia.

2. Pemeriksaan Laboratorium Tambahan: Jika diperlukan, pemeriksaan urine (untuk infeksi saluran kemih) atau pemeriksaan darah lengkap

3. Penyuluhan dan Edukasi: Memberikan pemahaman kepada ibu hamil mengenai kehamilan resiko tinggi, tanda bahaya, dan perilaku hidup bersih dan sehat.

4. Kolaborasi / Rujukan: Melakukan kolaborasi / rujukan segera jika ditemukan tanda-tanda infeksi serius yang memerlukan penanganan spesialis.

deteksi dini infeksi pada wanita hamil penting dilakukan, terutama bila kehamilan terjadi tanpa direncanakan dan terjadinya kehamilan dengan proses tidak aman seperti :

1. Perempuan yang sudah aktif secara seksual sebelum menikah.
2. Kehamilan yang dialami remaja di luar pernikahan.
3. Perempuan yang melakukan monogami serial, yaitu ada ikatan pernikahan dengan satu pasangan pada satu waktu tertentu namun sudah berganti pasangan sah beberapa kali.
4. Perempuan berganti-ganti pasangan seksual.

D. Penyakit-penyakit Infeksi yang biasa terjadi pada wanita hamil

1. HIV, Sifilis, Hepatitis B (Triple Eliminasi): Wajib dilakukan pada kunjungan antenatal pertama (trimester 1) untuk mencegah penularan ibu ke bayi. (Permenkes no 52 tahun 2017).

2. TORCH (Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes): Infeksi ini sering tanpa gejala tetapi berisiko tinggi menyebabkan cacat janin atau keguguran.

3. Infeksi Menular Seksual (IMS) Lain: Seperti Gonore atau klamidia, terutama jika berisiko, dilakukan skrining ulang pada trimester ketiga.

4. Infeksi Saluran Kemih (ISK): Sering terjadi dan dapat memicu kontraksi uterus yang berdampak kehamilan.

Langkah-langkah pelaksanaan Deteksi Dini infeksi pada kehamilan (Kemenkes,2020):

1. Anamnesis

Anamnesis merupakan langkah awal yang digunakan untuk menggali riwayat kesehatan ibu. Hal yang perlu ditanyakan meliputi:

a. keluhan saat ini

- 1) apakah ada Demam/ menggigil
- 2) apakah ada Keputihan abnormal (berbau, gatal dan berwarna kuning kehijauan)
- 3) saat berkemih apakah ada rasa nyeri (disuria)
- 4) Adakah Luka atau infeksi lain dikulit

b. Riwayat penyakit sebelumnya

- 1) Pernah infeksi menular seksual (IMS)
- 2) Pernah sakit tuberkulosis
- 3) Pernah sakit hepatitis atau HIV/AIDS
- 4) Pernah infeksi saluran kemih berulang

c. Faktor risiko

Perlu dikaji mendalam tentang hal-hal berikut ini karena merupakan faktor risiko dari infeksi dalam kehamilan, yakni:

- 1) Perilaku seksualnya
- 2) Lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat
- 3) Sering kontak dengan penderita penyakit menular

2. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan untuk mendeteksi tanda klinis infeksi:

a. Pemeriksaan tanda-tanda vital

Tanda-tanda vital merupakan indikator keadaan fisik umum dari pasien

b. Pemeriksaan spesifik. Erat kaitannya dengan keluhan yang disampaikan misalnya

- 1) **Kulit:** untuk melihat adanya ruam, abses atau luka
- 2) **Mata:** konjungtiva pucat atau kuning
- 3) **Mulut:** sariawan atau infeksi jamur
- 4) **Payudara:** tanda mastitis
- 5) **Genitalia:** (keputihan, gatal, lesi atau abses)

3. Uji Lab Sederhana

Bidan dapat melakukan beberapa pemeriksaan penunjang sederhana, antara lain:

a. Pemeriksaan laboratorium sederhana

- 1) **Tes urin:** (Protein Urin dan leukosit (Indikasi ISK)
- 2) **Tes hemoglobin (Hb):** mendeteksi anemia akibat infeksi kronis
- 3) **Tes malaria (daerah endemis)**

b. Tes cepat (rapid test)

- 1) HIV
- 2) Sifilis (VDRL/RPR)
- 3) Hepatitis B (HBsAg)

c. Pemeriksaan tambahan

pH vagina (indikasi infeksi bakteri/jamur)

4. Diagnosa Kebidanan, masalah aktual dan masalah Potensial(Varney et al., 2015; Pairman et al., 2015)

Diagnosa kebidanan adalah keputusan klinik yang ditegakkan bidan berdasarkan hasil pengkajian data subjektif dan objektif (GPA, usia kehamilan, janin hidup/mati, letak) untuk menentukan status kesehatan ibu/janin.

Masalah aktual adalah masalah yang sudah terjadi (berdasarkan data subjektif & objektif)

Masalah potensial adalah masalah yang berisiko terjadi bila tidak ditangani

a. IMS

1) Diagnosa Kebidanan

NYGPA, UK,,janin tunggal/gemeli, hidup/mati, intra uterin, dengan IMS

a) Masalah Aktual

- Keputihan patologis (bau, warna abnormal)
- Gatal/iritasi genital
- Nyeri saat berhubungan seksual
- Hasil tes IMS positif (misalnya sifilis/HIV)
- Kecemasan ibu terhadap kondisi kehamilan

b) Masalah Potensial

- Penularan infeksi ke janin (vertical transmission)
- Kelahiran prematur
- Ketuban pecah dini
- Infeksi neonatal
- Komplikasi serius (misalnya sifilis kongenital)

b. Infeksi Saluran Kemih (ISK)

1) Diagnosa Kebidanan

NY... GPA, UK,, janin tunggal/gemeli, hidup/mati, intra/ekstra uterin) dengan ISK

a) Masalah Aktual

- Disuria (nyeri saat BAK)
- Pola BAK meningkat (frekuensi/urgensi)
- Nyeri suprapubik atau pinggang
- Hasil urin menunjukkan leukosit/nitrit (+)
- Demam (pada kasus tertentu)

b) Masalah Potensial

- Pielonefritis
- Persalinan prematur
- Berat badan lahir rendah (BBLR)
- Infeksi sistemik (sepsis)

- Ketuban pecah dini

c. Infeksi TORCH (Toxoplasmosis, Rubella, CMV dan Herpes simpleks)

1) Diagnosa Kebidanan

NY ...GPA, UK,,janin tunggal/gemeli, hidup/mati, intra uterin) dengan Torch

a) Masalah Aktual

- Riwayat paparan (misalnya kontak kucing – toksoplasma)
- Gejala infeksi (demam, ruam, lemah)
- Hasil pemeriksaan serologi (jika ada)
- Kecemasan ibu terhadap kondisi janin

b) Masalah Potensial

- Kelainan kongenital (cacat bawaan)
- Keguguran (abortus)
- Kematian janin dalam kandungan
- Gangguan tumbuh kembang janin
- Infeksi neonatal berat.

E. Intervensi, Implementasi dan evaluasi Rencana Asuhan

Gambar 6.1: Intervensi, Implementasi dan evaluasi Rencana Asuhan

No	Diagnosa dan masalah kebidanan	Intervensi (Rencana)	Implementasi (Tindakan)	Evaluasi (Kriteria Hasil)
1	GPA UK, janin hidup/mati, tunggal/gemeli, intra/ekstra uteri. dengan infeksi (IMS/ISK/TORCH)	Monitor kondisi ibu dan tanda infeksi	- Mengukur TD, suhu, nadi, RR - Mengkaji keluhan (keputihan, disuria, demam) - Observasi tanda infeksi	- Tanda vital normal- Keluhan berkurang/hilang- Tidak ada tanda infeksi lanjutan
2	Gangguan rasa nyaman (demam, gatal, nyeri)	Mengurangi ketidaknyamanan	- Anjurkan istirahat cukup- Anjurkan minum air cukup (ISK)- Edukasi hygiene genital	- Nyeri berkurang- Ibu tampak nyaman- Aktivitas kembali normal
3	kurang pengetahuan tentang infeksi dalam kehamilan	Meningkatkan pengetahuan ibu	- Edukasi tentang penyakit, penyebab, dampak- Jelaskan pentingnya pengobatan- Libatkan keluarga	- Ibu mampu menjelaskan kembali- Ibu patuh pada edukasi yang diberikan

4	Kecemasan ibu	Mengurangi kecemasan	- Berikan konseling- Berikan dukungan emosional- Libatkan keluarga	- Ibu tampak tenang- Kecemasan berkurang
5	(Potensial) komplikasi kehamilan (prematur, KPD, dll)	Deteksi dini komplikasi	- Observasi kontraksi dini- Pantau tanda bahaya- Kaji kondisi ibu secara berkala	- Tidak terjadi komplikasi- Kehamilan berlangsung normal
6	Potensial komplikasi pada kehamilan (prematur, KPD, pjt dll)	Deteksi dini komplikasi	- Observasi kontraksi dini- Pantau tanda bahaya- Kaji kondisi ibu secara berkala	- Tidak terjadi komplikasi - Kehamilan berlangsung normal
7	Potensial penularan infeksi ke janin	Mencegah transmisi infeksi	- Edukasi seks aman (IMS)- Anjurkan cuci tangan- Hindari sumber infeksi (TORCH)	- Ibu memahami tentang cara pencegahan, Tidak ada tanda infeksi pada janin

F. Edukasi pada Ibu dan keluarga mengenai kondisi ibu hamil

Hal-hal yang perlu diinformasikan pada ibu hamil dengan penyakit infeksi:

1. Penjelasan kondisi ibu

Menjelaskan pada ibu terkait Jenis infeksi yang dialami, penyebab dan cara penularannya juga dampak yang dapat ditimbulkan baik pada ibu maupun janin.

2. Perawatan diri (self-care)

Ibu dianjurkan untuk selalu Menjaga kebersihan area genitalia, mandi teratur, minum sesuai kebutuhan dan mengonsumsi makanan sehat untuk menjaga stamina

3. Pencegahan penularan

Seks aman, menggunakan pelindung (kondom), hindari kontak dengan sumber infeksi, dan selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir.

4. Kepatuhan pengobatan

Rutin Minum obat sesuai anjuran dan tidak menghentikan terapi sebelum konsultasi ke dokter

5. Tanda bahaya

Informasikan pada ibu tentang tanda bahaya, seperti Demam tinggi, Nyeri hebat, Perdarahan, ataupun Penurunan gerak janin. Bila terdapat tanda-tanda diatas, maka segera lapor ke bidan

6. Peran keluarga

Informasikan pada keluarga bahwa selalu Mendukung pengobatan ibu, Membantu menjaga kebersihan lingkungan, istirahat dan asupan makanan serta ingatkan jadwal kontrol.

G. Aktivitas 1. Contoh kasus

(diskusi kelompok)

Ny. A, usia 26 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 28 minggu, datang ke Puskesmas dengan keluhan keputihan sejak 2 minggu terakhir. Keputihan berwarna kuning kehijauan, berbau tidak sedap, dan disertai rasa gatal pada area genital. Ibu juga mengeluhkan nyeri saat berhubungan seksual. Hasil pemeriksaan fisik: keadaan umum baik, TD 130/80 mmHg, nadi 84 x/menit, suhu 37°C, DJJ 146 x/menit. Anamnesa ditemukan data Tidak menggunakan alat kontrasepsi/ pengaman saat berhubungan, Suami ibu bekerja di luar kota dan jarang pulang , Ibu belum pernah melakukan pemeriksaan/ screening penyakit infeksi.

Pertanyaan Diskusi

1. Apa masalah utama pada kasus di atas?
2. tentukan data yang mendukung analisis Anda?
3. faktor mana yang paling mungkin menjadi penyebab utama?
4. Tanda bahaya apa yang mulai muncul pada ibu dan janin?
5. Apa tindakan awal yang harus dilakukan bidan pada kasus ini?
6. Apakah kasus ini masih dapat ditangani expectant di fasilitas awal, atau perlu rujukan? Jelaskan alasan Anda.
7. Informasi penting apa yang harus disampaikan bidan kepada ibu dan keluarga sebelum tindakan lanjutan atau rujukan?



Gambat 6.1: Tanda dan Gejala Infeksi pada kehamilan dan cara pencegahannya

Tabel 6.2: Soal OSCE Kebidanan

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	2
2	Judul	Kehamilan Patologi
3	Kasus	Ibu hamil triwulan ke 2 dengan gatal di area genital disertai leukorea yang berbau.
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat melakukan pelayanan kebidanan yang sesuai kompetensi
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional

No.	Komponen	Isi
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang ibu hamil usia 27 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 26 minggu datang ke Puskesmas Poned dengan keluhan keputihan berwarna kuning kehijauan, berbau tidak sedap, dan disertai gatal. Ibu mengatakan suaminya bekerja sebagai karyawan perusahaan asing di luar kota. . TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. 2. Lakukan pemeriksaan fisik/obstetri terfokus sesuai kasus. 3. Sampaikan diagnosis/masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh. 4. Lakukan tindakan awal yang tepat pada kasus tersebut. 5. Berikan KIE singkat kepada ibu/keluarga dan jelaskan rencana kolaborasi/rujukan.
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikuti kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apapun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan melaksanakan tugas sebagai penguji OSCE.

No.	Komponen	Isi
		INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik dengan benar, PS menjawab sesuai dialog PS. 2. Jika peserta menyatakan akan melakukan palpasi abdomen/Leopold, penguji memberikan data:- TFU 24 cm- Punggung kiri- Presentasi kepala- belum masuk PAP 3. Tindakan awal yang diharapkan dari peserta meliputi:- Menilai ulang kondisi ibu dan janin secara cepat- menjelaskan kondisi ibu secara singkat dan jelas- dan menjelaskan tentang rencana pemeriksaan laboratorium – memberikan botol urine utk menampung urine, menganjurkan ibu ke ruangan Lab untuk pengambilan darah. atau menyiapkan pengosongan kandung kemih- Mempersilahkan ibu menunggu hasil – menjelaskan hasil laboratorium Memberikan dukungan emosional dan KIE singkat 5. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 6. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: PS berperan sebagai ibu hamil dengan infeksi menular seksual.

No.	Komponen	Isi
		PS tampak cemas, gelisah, sesekali menggaruk selangkangannya. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespon, kooperatif. Bila peserta menyampaikan bahwa ibu perlu dirujuk untuk pemeriksaan lanjutan ke dokter spesialis kulit kelamin, PS tampak khawatir tetapi bersedia mengikuti arahan.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu. PS : Pagi/siang, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa ibu. Apakah ibu bersedia? PS : Iya, Bu, saya bersedia. Peserta: Apa keluhan utama ibu? PS : saya hamil 5 bulan dan ingin memeriksakan kehamilan saya karena saat ini ada keputihan dan gatal. Peserta: Sejak kapan mulai keluar cairan keputihan, apakah gatal? PS: Kira-kira sudah 1 bulan terakhir, Gatal dan agak berbau, juga sakit saat kencing. Peserta: Apakah sudah periksa ke dokter? PS :belum, baru hari ini ingin memeriksa ke puskesmas. Peserta:selain rasa gatal, apalagi yang dirasakan? PS :Meriang, rasa panas dan sakit saat buang air kecil. dan rasa nyeri saat berhubungan kelamin Peserta: apakah ibu diantar suami? PS : tidak, suami saya bekerja diluar kota, 3 bulan sekali pulang Bu. Peserta: apakah saat ini sedang mengonsumsi obat untuk mengurangi keputihan?

No.	Komponen	Isi
		PS : tidak. Jika gatal saya hanya cebok dengan air hangat, sesekali rendam dengan air rebusan daun sirih. Peserta: Ini kehamilan yang ke berapa? PS : Ini kehamilan kedua saya, Bu. Peserta: Apakah pada kehamilan pertama juga timbul keluhan seperti ini?. PS : Tidak. Baru pada hamil ini Bu. Peserta: setahu ibu, apakah suami juga punya keluhan gatal di selangkangan dan sakit BAK?. PS : seingat saya tidak , Bu. Peserta : baiklah bu, saya akan melakukan pemeriksaan fisik, juga pemeriksaan Laboratorium ya.... PS : Iya, baik Bu. Catatan: Jika ada pertanyaan lain terkait riwayat penyakit, riwayat obstetri-ginekologi, sosial, spiritual, ekonomi, dan ADL, PS memberi jawaban normatif dan tidak mengarah ke diagnosis lain.
10	Kebutuhan manikin	- Phantom abdomen hamil/manekin Leopold - phantom genitalia luar, untuk simulasi pemeriksaan - gambar lesi/luka/ kutilan pada genitalia
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin - Mengganti lembar/ gambar2 penyakit kelamin, jika diperlukan - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur ginekologi/periksa — 1 2. Phantom abdomen hamil/manekin Leopold — 1 3. Phantom genitalia — 1

No.	Komponen	Isi
		4. gambar kelainan² pada genetalia luar wanita — 1 set 5. Tensimeter — 1 6. Stetoskop — 1 7. Jam tangan/stopwatch — 1 8. Termometer — 1 9. Sarung tangan bersih — 1 pasang 11. Handscrub — 1 botol 12. Kain penutup/selimut — 1 13. Tissue — 1 pack 14. Botol tempat urine 15. Tabung reaksi dengan tatakannya 16. Sduit/ jarum 10 ml 17. Spekulum Vagina (Cocor Bebek): Berbagai ukuran 18. Lampu Sorot/Penlight: 19. Rapid Diagnostic Test (RDT) Kit: Alat tes cepat untuk skrining, utamanya: - RDT HIV. - RDT Sifilis (Rapid Plasma Reagin - RPR). - RDT Hepatitis B (HBsAg). 20. Tes diagnostik cepat untuk Klamidia dan Gonore (jika tersedia). 21. Kapas Lidi Steril/Swab Cotton: beberapa buah 22. Kertas Lakmus—1 set 23. Formulir rujukan — 1 lembar 24=1. Lembar jawaban peserta — 1 lembar 25. Pena — 1
13	Penulis	

No.	Komponen	Isi
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Standar profesi bidan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar kompetensi kerja bidang kebidanan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022. 3. World Health Organization. (2008). Education material for teachers of midwifery: Midwifery education modules (2nd ed.): Managing prolonged and obstructed labour. 4. https://www.kebijakanidsindonesia.net/id/dokumen-kebijakan. 5. Otero-Guerra L, Fernández-Blázquez A, Vazquez F. Diagnosis cepat infeksi menular seksual.. Klinik Mikrobiol Enferm Infecct. 2017;35:444–450.

H. Rubrik Penilaian Dan Kelulusan

Stase 2: Kehamilan Patologi

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama		
2. Riwayat kehamilan sekarang (GPA, HPHT, UK dan TP)		
3. Riwayat keluhan utama (mulai keputihan, gatal dan berbau)		
4. upaya yang dilakukan untuk mengatasi keluhan		
5. sejak hamil ini, sudah berapa kali periksa di fasilitas yankes		
6. Riwayat obstetri (masalah pada kehamilan dan persalinan sebelumnya). Bila ada		
7. Adakah obat-obatan/ ramuan yang dikonsumsi untuk mengatasi keluhan?		
8. Aktivitas harian yang relevan dengan kondisi saat ini (asupan makan-minum, BAK terakhir, kelelahan, dukungan keluarga)		

Skoring KOMPETENSI 1

- **4** = Jika peserta ujian melakukan semua **8 langkah** dengan benar.
- **3** = Jika peserta melakukan **5–7 dari 8 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **1–4 dari 8 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta ujian berpenampilan rapi dan siap ujian.

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Persiapan		
a. Menyapa klien dengan sopan dan ramah		
b. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan tindakan		
c. Memastikan klien memahami prosedur dan meminta persetujuan		
d. Menjaga privasi ibu		
e. Mencuci tangan/hand hygiene		
f. Menyiapkan alat yang diperlukan		
2. Langkah-langkah		
a. Menilai keadaan umum dan kesadaran ibu		
b. Menilai tanda vital ibu		
c. Melakukan pemeriksaan Leopold		
d. Menilai DJJ		
e. memeriksa pengeluaran pervaginam(darah, Cairan lain)		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
f. Melakukan pemeriksaan obstetri/ ginekologi terfokus pada keluhan fluor albus dan gatal (meminta data yang relevan sesuai keluhan)		
g. Menilai tingkat keparahan dari genitalia (adakah lesi atau luka)		
h. Menyimpulkan untuk tindakan medis Perlu tidaknya merujuk)		
i. Menginformasikan dan siapkan ibu untuk pemeriksaan RDT		
j. menyiapkan alat dan bahan pemeriksaan RDT		
k. Menyiapkan kolaborasi/rujukan segera dengan aman		
3. Pasca tindakan		
a. Menjelaskan hasil tindakan dan rencana tindakan lanjutan		
b. Mencatat temuan penting pada catatan medis/form rujukan		
c. Mencuci tangan kembali dan merapikan alat/ibu		

Skoring KOMPETENSI 2

- **4** = Jika peserta ujian melakukan **15–19 langkah** dengan tepat dan sistematis.
- **3** = Jika peserta melakukan **10–14 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.
- **2** = Jika peserta melakukan **1–9 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.
- **1** = Jika peserta ujian melakukan semua langkah tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam		
2. Menjelaskan hasil pemeriksaan dan kondisi ibu/janin dengan bahasa sederhana		
3. Menjelaskan tindakan awal yang sedang/akan dilakukan		
4. Menjelaskan perlunya kolaborasi/rujukan segera		
5. Menenangkan ibu dan melibatkan keluarga/pendamping		
6. Memberi kesempatan bertanya dan menjawab pertanyaan dengan jelas		

Skoring KOMPETENSI 3

- **4** = Jika peserta ujian melakukan semua **6 langkah** dengan benar.
- **3** = Jika peserta melakukan **4–5 dari 6 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 6 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta ujian hadir di tempat ujian.

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Melaksanakan secara sistematis		
2. Menjaga privasi dan keselamatan pasien		
3. Memberikan perhatian terhadap respons ibu selama kontraksi/nyeri		
4. Suara lantang, jelas, tenang, dan informatif		
5. Percaya diri dan tidak ragu-ragu		

Skoring KOMPETENSI 4

- **4** = Jika peserta ujian melakukan semua **5 langkah** dengan benar.
- **3** = Jika peserta melakukan **4 dari 5 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 5 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta ujian siap untuk mengikuti ujian.

Total Skor dan Kelulusan

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3

(dicatat di rubrik penilaian)

Global Performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skor

Nilai akhir = ----- x 100 =

30

(Kota),

Penguji :

Tabel 6.1 :Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Kehamilan Patologi : IMS, ISK dan TORCH

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Infeksi Dalam Kehamilan (IMS,ISK,TORCH)
Metode penilaian	Penilai mengamati tindakan yang dilakukan peserta, lalu memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. Domain yang dinilai meliputi : ▪ informed consent, ▪ persiapan pra-tinda ▪ kan, ▪ kemampuan teknis, ▪ komunikasi, ▪ profesionalisme, dan ▪ keselamatan pasien.	Pembimbing mengamati langsung sikap dan tindakan mahasiswa saat: ▪ melakukan penilaian awal pada ibu hamil dengan infeksi masa kehamilan. ▪ melakukan tindakan awal (keterampilan saat siapkan ibu dan alat2 untuk pemeriksaan lab sederhana, serta rujukan jika diperlukan
Tujuan penilaian	menilai kemampuan mahasiswa melakukan tindakan awal yang aman, cepat, dan sistematis pada ibu hamil dengan penyakit infeksi (IMS, ISK dan TORCH), dengan tetap fokus keselamatan ibu dan janin serta penghormatan pada asuhan yang bermartabat, berpegang teguh pada etika dan standar profesi bidan (Kepmenkes RI, Nomor: HK.01.07/Menkes/320/2020.	Menilai mahasiswa tentang: ▪ pengetahuannya mengenali tanda2 infeksi (terutama di daerah genitalia), ▪ kemampuannya menilai kondisi ibu-janin, melakukan stabilisasi awal dan menjelaskan kebutuhan kolaborasi atau rujukan.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang sesuai dengan capaian pembelajaran mhs D3 bidan, khususnya pengenalan tanda dan gejala awal, tingkat keparahan, prosedur pengambilan sampel Lab, serta pengambilan keputusan awal.	NY S, 24 tahun, G1P0A0, hamil 32 minggu, datang ke Puskesmas PONE D dengan keluhan, keputihan banyak, berbau dan, gatal di daerah selangkangan sejak 1 bulan terakhir. Belum pernah periksa ke bidan/dokter karena malu. Namun karena beberapa hari terakhir mulai timbul rasa nyeri saat BAK, barulah ke Puskesmas.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Infeksi Dalam Kehamilan (IMS,ISK,TORCH)
		Pemeriksaan Leopold, hasilnya TFU 30 cm, punggung kiri, presentasi kepala, BAP. DJJ teratur 164x/menit Tanda-tanda vital Dalam Batas normal.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pada DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan prosedur atau rangkaian tindakan klinik tertentu, bukan sekadar berdiskusi tentang kasus. Pada topik ini, keterampilan yang relevan antara lain menilai keadaan umum ibu, tanda vital, DJJ, serta keluhan utama terkait infeksi yang dialaminya, serta menelusuri tindakan apa yang sudah dilakukan, ataupun obat apa saja yang sudah dikonsumsi selama sakit. Selain itu menilai juga bagaimana cara mahasiswa menyiapkan pasien untuk pengambilan sampel	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menilai kondisi ibu dan janin, membaca partograf, menyimpulkan adanya partus lama/distosia dengan kecurigaan gawat janin, memposisikan ibu miring kiri, menyiapkan ibu, dan alat-alat yang dibutuhkan untuk pengambilan sampel. Minta ibu untuk kosongkan kandung kemih. lalu menjelaskan perlunya pemeriksaan laboratorium.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi pemahaman indikasi tindakan, persetujuan tindakan, persiapan pra-prosedur, kemampuan teknis, komunikasi, kemampuan mencari bantuan ketika diperlukan, rencana pasca tindakan, dan profesionalisme. Pada konteks obstetri, aspek ini juga mencakup ketepatan mengenali tanda dan gejala infeksi kelamin, selama hamil.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu mendeteksi tanda-tanda infeksi serta keluhan-keluhan yang mengganggu aktifitas sehari-hari. Mampu menggali riwayat awal timbulnya keluhan serta langkah penanganan yang pernah ibu lakukan. Serta mampu yakinkan ibu bahwa penyakitnya bisa disembuhkan asalkan ibu terus terang menceritakan riwayat penyakit, serta kooperatif dan mau bekerjasama dalam penanganan penyakit.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Infeksi Dalam Kehamilan (IMS,ISK,TORCH)
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah mutu performa nyata mahasiswa saat melakukan tindakan awal. Penampilan/ sikap saat melakukan pengkajian dan pemeriksaan fisik, identifikasi tanda dan gejala serta tingkat keparahan infeksi, serta langkah penanganan yang efektif.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa cepat mengenali kondisi ibu, melakukan prioritas tindakan dengan urutan yang benar, menghindari intervensi yang tidak aman, serta segera meminta bantuan atau menyiapkan rujukan. Jika diperlukan.
Umpan balik	Umpan balik dalam DOPS diberikan segera setelah observasi dan berisi apa yang sudah efektif serta apa yang perlu diperbaiki. Form DOPS juga menekankan komentar assessor mengenai kekuatan, area yang perlu ditingkatkan, dan rencana perbaikan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi saat anamnesis, inspeksi dan palpasi. Namun masih perlu meningkatkan keseriusan saat mendengarkan keluhan, ketelitian dalam menilai tanda dan gejala penyakit serta ketegasan bahwa harus bersungguh sungguh dalam melakukan tindakan penanganan penyakit. Sedapat mungkin libatkan keluarga dalam penanganan..
Keputusan penilaian	Dalam buku ajar ini, hasil DOPS dapat diringkas menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Keputusan ditetapkan berdasarkan ketepatan langkah, keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan mengambil keputusan awal.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan tindakan awal secara runtut, aman, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila langkah utama sudah benar tetapi masih memerlukan arahan. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila gagal mengenali tanda-tanda infeksi, salah menentukan prioritas, atau tidak menyiapkan eskalasi dengan benar.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Infeksi Dalam Kehamilan (IMS,ISK,TORCH)
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti otentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does karena performanya diamati langsung saat melakukan tindakan klinik. Observasi langsung pada pasien nyata dan umpan balik segera menjadikan DOPS sangat sesuai untuk pembelajaran berbasis kompetensi.	Pada kasus infeksi masa kehamilan (IMS, ISK, dan TORCH), mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan sikap profesional, tindakan awal, pemeriksaan genitalia, secara langsung, aman, cepat, dan prosedural.

Tabel 6.2: Case Report pada kehamilan dengan Infeksi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Infeksi dalam kehamilan
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang ibu hamil triwulan kedua, dengan keputihan banyak dan gatal. Sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data ibu, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan awal yang diberikan, seperti pengambilan sampel, hingga menyampaikan hasil Lab, serta kondisi kehamilan dan janin dalam kandungan.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/ masalah kebidanan, tindakan,	Pada kasus ini, mahasiswa menuliskan rasa gatal di genitalia akibat keputihan yang banyak. Belum pernah periksa ke fasyankes karena malu. Baru mau periksa

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Infeksi dalam kehamilan
	implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	setelah mulai terasa nyeri saat BAK.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan antara penyakit ibu dengan pekerjaan, gaya hidup atau personal hygiene, Serta pemeriksaan Lab sederhana pada ibu untuk menunjang Diagnosa. Juga tindakan / upaya yang dilakukan ibu ketika timbul keluhan gatal.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus infeksi dalam kehamilan, mahasiswa belajar bahwa pemantauan menyeluruh (head to toe) tidak hanya dengan bertanya tetapi perlu diperiksa (inspeksi, palpasi), sehingga kondisi ibu dan janin terpantau sedini mungkin, diberikan tindakan kebidan untuk mengobati infeksi juga mencegah penularan ke janin, atau orang serumah.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep infeksi dalam kehamilan, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan secara utuh.

Tabel 6.3: Refleksi Patient Safety pada Deteksi Dini infeksi dalam kehamilan dan pencegahan penularan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus infeksi dalam kehamilan, mahasiswa merefleksikan bahwa keterlambatan mengenali gejala dan memeriksakan diri ke puskesmas, dapat menyebabkan gangguan rasa nyaman gatal, bau, dan jika infeksi berlanjut akan mempengaruhi kondisi janin.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti salah mendiagnosis gejala dan memprioritas masalah, atau menunda rujukan ke dokter spesialis, dapat berdampak besar pada keselamatan ibu dan bayi.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah, gangguan penyakitnya berlanjut sehingga akan lama dalam proses penyembuhan dan berpengaruh pada janin, atau bayi terinfeksi saat proses kelahiran.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain tingkat keparahan infeksi, jenis infeksi yang ibu alami, sumber penularan, terapi yang dokter berikan serta kemungkinan penularan pada suami dan anak, karena tidak tau cara pencegahan penularan penyakit.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menjelaskan pentingnya penggunaan APD, kesterilan alat yang digunakan serta penyampaian kondisi ibu pada keluarga agar beri dukungan dalam proses penyembuhan, termasuk keteraturan konsumsi obat, personal

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus
		hygiene, selalu mencuci tangan setiap kontak dengan sumber infeksi (luka). Beri dukungan pada ibu dan keluarga untuk proses penyembuhannya.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada kasus infeksi dalam kehamilan, anamnesa dan pengkajian serial, pemeriksaan fisik, dan tindakan pemeriksaan Lab, perlu segera dilakukan untuk kepastian diagnosis, rujuk atau konsultasi ke dokter spesialis akan mempercepat penyembuhan ibu. melakukan eskalasi adalah bagian penting dari praktik bidan yang aman.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik kebidanan secara berkelanjutan.

I. Rangkuman Materi

Infeksi pada saat kehamilan merupakan salah satu penyebab dari sakit serta kematian ibu dan janin. Infeksi yang sering terjadi meliputi **Infeksi Menular Seksual (IMS)**, **Infeksi Saluran Kemih (ISK)**, serta kelompok **TORCH (Toxoplasmosis, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes)**. Dalam praktik kebidanan mutakhir, deteksi infeksi tidak hanya berdasarkan gejala klinis, tetapi harus melalui pendekatan **skrining komprehensif** yang mencakup anamnesis, pemeriksaan fisik, dan uji sederhana sesuai kewenangan bidan. IMS pada kehamilan dapat ditandai dengan keputihan abnormal, gatal, nyeri, atau tanpa gejala namun beresiko tinggi terhadap penularan vertikal. ISK sering muncul dengan keluhan disuria, frekuensi berkemih meningkat, atau bahkan tanpa gejala (bakteriuria asimtomatik) yang tetap berisiko menyebabkan komplikasi. Sementara itu, infeksi TORCH sering bersifat subklinis, tetapi memiliki dampak serius seperti kelainan kongenital, abortus, hingga kematian janin.

Penilaian kondisi harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan faktor risiko ibu, tanda dan gejala infeksi, hasil pemeriksaan sederhana (urin, Hb, rapid test HIV/sifilis/HBsAg), serta kondisi janin. Bidan harus mampu mengidentifikasi tanda bahaya seperti demam tinggi, nyeri, keputihan berat, hasil tes reaktif atau penurunan kondisi ibu.

Pendekatan asuhan fokuskan pada:

- **Deteksi dini lewat skrining terstruktur**
- **Antisipasi penularan ke pasangan dan janin**
- **Penatalaksanaan awal sesuai kewenangan bidan**
- **Edukasi ibu dan keluarga sesuai kebutuhan**
- **Kolaborasi dan rujukan tepat waktu**

World Health Organization (WHO) menekankan bahwa skrining infeksi dalam antenatal care harus dilakukan secara rutin dan terintegrasi, serta keputusan rujukan tidak boleh ditunda jika ditemukan kondisi yang berisiko terhadap ibu dan janin.

Tindakan awal bidan pada kasus infeksi meliputi **penilaian cepat kondisi ibu dan janin, amati gejala, pantau tanda vital, identifikasi jenis infeksi, stabilisasi kondisi fisik dan mental ibu, melalui komunikasi efektif dan edukatif, serta pengambilan keputusan klinis untuk kolaborasi atau rujukan**. Dukungan emosional pada ibu dan keluarga merupakan bagian penting dalam keberhasilan asuhan.

Alur Asuhan

Ibu hamil dengan dugaan infeksi (IMS/ISK/TORCH)

- Anamnesis dan identifikasi faktor risiko,

- lakukan pemeriksaan fisik dan uji lab sederhana
- analisis hasil dan tentukan kemungkinan infeksi
- Nilai kondisi ibu dan janin (tanda vital, DJJ, gejala)
- lakukan penatalaksanaan awal dan edukasi
- identifikasi tanda bahaya atau komplikasi
- tentukan kebutuhan kolaborasi atau rujukan
- lakukan dokumentasi dan komunikasi (handover) secara jelas



Gambar 6.2: Alur asuhan pada ibu hamil dengan infeksi.

Tabel 6.4: Red Flags & Eskalasi

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$ pada ibu hamil	Mengindikasikan infeksi aktif atau sistemik	Nilai kondisi ibu-janin, lakukan pemeriksaan lanjut, kolaborasi/rujuk bila perlu
Keputihan abnormal (bau, warna kehijauan, disertai nyeri/gatal berat)	Kecurigaan IMS yang signifikan	Lakukan skrining IMS, edukasi, kolaborasi terapi, pertimbangkan rujukan
Nyeri saat berkemih, disuria, atau urin keruh disertai demam	Kecurigaan ISK atau pielonefritis	Lakukan pemeriksaan urin, berikan terapi awal sesuai kewenangan, rujuk bila berat
Hasil rapid test (HIV, sifilis, HBsAg) reaktif	Infeksi menular yang berisiko tinggi pada janin	Konseling, kolaborasi dengan dokter, rujuk untuk terapi lanjutan
Penurunan gerak janin atau DJJ tidak normal	Kecurigaan dampak infeksi pada janin	Nilai cepat kondisi janin, lapor segera, rujuk ke fasilitas lebih tinggi
Riwayat paparan TORCH (kontak kucing, ruam, infeksi virus) + gejala	Risiko infeksi kongenital	Kolaborasi pemeriksaan lanjutan, rujuk untuk diagnosis dan pemantauan
Nyeri pinggang hebat, demam tinggi, menggigil	Kecurigaan pielonefritis	Stabilkan kondisi ibu, berikan cairan, rujuk segera
Ibu tampak lemah, takikardia, dehidrasi	Perburukan kondisi maternal akibat infeksi	Stabilisasi awal, terapi cairan, pantau ketat, kolaborasi/rujuk
Perdarahan atau kontraksi dini pada ibu hamil dengan infeksi	Risiko komplikasi kehamilan (prematurn/KPD)	Nilai cepat, stabilisasi, rujuk segera
Tanda sepsis (demam tinggi, penurunan kesadaran, hipotensi)	Kegawatdaruratan maternal	Resusitasi awal sesuai kewenangan, panggil

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
		bantuan, rujuk emergensi
Keputusan rujukan sudah jelas tetapi tertunda	Meningkatkan risiko ibu dan janin	Segera aktifkan rujukan, lakukan komunikasi efektif dan handover

Catatan Klinis

- Red flags pada infeksi kehamilan sering **tidak spesifik**, Karena itu bidan harus tanggap **terhadap perubahan kondisi ibu dan janin**
- **Deteksi dini dan respon cepat** sangat menentukan keselamatan
- **Rujukan tidak boleh ditunda** jika kondisi melebihi kewenangan

Form Checklist “Saya sudah bisa...”**Bab: Deteksi Dini Infeksi Pada Kehamilan : Ims, Isk, Torch/Infeksi Lain Dan Pencegahan Penularan**

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktek / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian infeksi pada kehamilan (IMS, ISK, TORCH) dan pencegahannya	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa menjelaskan jenis-jenis infeksi yang sering terjadi pada kehamilan	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa melakukan anamnesis terarah untuk mendeteksi faktor risiko infeksi pada kehamilan	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa menilai tanda dan gejala awal dari setiap jenis infeksi pada ibu hamil	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa mengambil sampel cairan vagina serta sampel darah untuk pemeriksaan Lab	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa melakukan dan/atau menginterpretasikan uji sederhana (urin, Hb, rapid test)	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa mengidentifikasi faktor risiko IMS, ISK, dan TORCH dari hasil pengkajian	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa menetapkan diagnosa kebidanan, masalah aktual dan masalah potensial pada kasus infeksi kehamilan	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
9	Saya sudah bisa menyusun intervensi kebidanan sesuai kewenangan pada kasus infeksi pada kehamilan	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa melakukan tindakan pencegahan penularan infeksi pada ibu dan janin	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga tentang infeksi pada kehamilan	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa mengenali tanda bahaya pada infeksi kehamilan	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa menentukan kapan kasus harus dikolaborasikan atau dirujuk	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa menyiapkan rujukan dan melakukan handover secara jelas	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa melakukan evaluasi terhadap hasil asuhan yang diberikan	☐	☐	_____
16	Saya sudah bisa mendokumentasikan hasil pengkajian dan tindakan secara sistematis	☐	☐	_____
17	Saya sudah bisa menjaga privasi dan keselamatan pasien dengan prinsip pencegahan infeksi	☐	☐	_____
18	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional dengan menjalin komunikasi efektif dalam asuhan kebidanan	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

J. Daftar Pustaka

- Abdullah, V. I., & Duhita, F. (2023). Edukasi Dan Deteksi Dini Infeksi Saluran Kemih Pada Ibu Hamil. *JMM(Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(3), 2653-2662.
- Chan, M. Y., & Smith, M. A. (2018). Infections in Pregnancy. *Comprehensive Toxicology*, 232–249. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801238-3.64293-9>
- Kementerian Kesehatan RI (2020), Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu, Jakarta
- Kementerian Kesehatan RI (2020). Keputusan Menteri Kesehatan nomor: HK.01.07/Menkes/320/2020, tentang Standar Profesi Bidan. Kemenkes RI. Jakarta
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar kompetensi kerja bidang kebidanan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022.
- Kusumaningrum (2020), Identifikasi Infeksi Yang Menyertai Kehamilan. Chairil Akbar (ed), Asuhan Kebidanan Kehamilan hlm 191-205). Media Sains Indonesia.
- Organisasi Kesehatan Dunia. (2023). Rekomendasi WHO tentang perawatan antenatal untuk pengalaman kehamilan yang positif: skrining, diagnosis, dan pengobatan penyakit tuberkulosis pada wanita hamil. Ringkasan bukti-ke-tindakan: Sorotan dan pesan utama dari rekomendasi global Organisasi Kesehatan Dunia tahun 2016. Organisasi Kesehatan Dunia.
- Organisasi Kesehatan Dunia. (2020). Rekomendasi perawatan antenatal WHO untuk pengalaman kehamilan yang positif. Pembaruan intervensi nutrisi: Suplemen mikronutrien ganda selama kehamilan . Organisasi Kesehatan Dunia
- Perdoski (2018).Pentingnya Skrining HIV dan Sifilis Untuk Deteksi Dini IMS Pada Ibu Hamil. <https://perdoski.id/article/detail/837-pentingnya-skrining-hiv-dan-sifilis-untuk-deteksi-dini-ims-pada-ibu-hamil>. Diakses, 23 Maret 2026.
- Putri, I. M., & Ismiyatun, N. (2020). Deteksi Dini Kehamilan beresiko. *JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama*, 8(1), 40-51
- Rochjati, P. (2011). *Skrining Antenatal Pada Ibu Hamil (Edisi 2): Pengenalan Faktor Risiko Deteksi Dini Ibu Hamil Risiko Tinggi*. Airlangga university press
- Sarwono P (2009) Penerapan Asuhan kebidanan pada kehamilan : https://repository.umsurabaya.ac.id/id/eprint/1640/3/BAB_2_cont..pdf. Diunduh 28 Maret 2025
- Setiono A (2018). [pemeriksaan-torch-pentingnya-deteksi-dini-infeksi-selama-kehamilan](https://rsia-anisa.co.id/article/pemeriksaan-torch-pentingnya-deteksi-dini-infeksi-selama-kehamilan): (<https://rsia-anisa.co.id/article/pemeriksaan-torch-pentingnya-deteksi-dini-infeksi-selama-kehamilan>). Diunduh pada 25 Maret 2026

- Wahyuni, A., Makiyah, S. N. N., & Sumaryani, S. (2022). Peningkatan keterampilan deteksi dini dan manajemen awal kegawatdaruratan ibu hamil. *Jurnal Empathy Pengabdian Kepada Masyarakat*, 77-86
- Widyantari, D. A., Sumarya, I. M., & Sudiartawan, I. P. (2024). Deteksi Dini Infeksi Menular Seksual Pada Ibu Hamil Melalui Pemeriksaan Hiv, Sifilis, Dan Hepatitis B Di Uptd Puskesmas Tampaksiring. *Jurnal Widya Biologi*, 15(02), 54-64.
- Alfieri A & Flandiana Y (2021)**, <https://sardjito.co.id/2021/10/13/triple-elimination-untuk-pencegahan-penyakit-menular-seksual-pada-ibu/>.
Diakses 27 Maret 2026

PROFIL PENULIS



Iin Setiawati, S.Keb., Bd., M.Kes Lahir di Lamongan, 13 Oktober 1986. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh yaitu jenjang S1 pada Program Studi Pendidikan profesi Bidan, Universitas Airlangga Surabaya tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Ilmu Kesehatan Reproduksi di Universitas Airlangga dan lulus tahun 2018. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2008 sebagai bagian laboratorium di D3 Kebidanan Ngudia Husada Madura. Pada tahun 2012 hingga sekarang menjadi tenaga pengajar (dosen) di STIKES Ngudia Husada Madura yang sekarang menjadi Universitas Noor Huda Mustofa (perubahan nama sejak tahun 2025)

Saat ini saya bekerja di Universitas Noor Huda Mustofa mengampu mata kuliah Asuhan kebidanan kehamilan, asuhan kebidanan persalinan dan BBL, Psikologi dalam praktik kebidanan, ketrampilan dasar praktik kebidanan, asuhan kebidanan kegawat daruratan maternal dan neonatal, Deteksi dini asuhan kebidanan dengan pendekatan keluarga dan manajemen dan kepemimpinan dalam asuhan kebidanan. Saya aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku dengan judul Buku "buku saku praktik dalam menulis partograf khusus mahasiswa kebidanan tahun 2023, "Buku Ajar Asuhan kebidanan Persalinan tahun 2024, "Buku Ajar Kesehatan Reproduksi tahun 2024", Buku Ajar Stunting dan solusinya tahun 2024", "Bunga Rampai Manajemen dan kepemimpinan untuk profesi bidan tahun 2024", "Buku Ketrampilan dasar Kebidanan tahun 2024", "Buku Dasar Kebidanan Tahun 2025". Publikasi artikel penelitian dengan judul "EARLY ASSESSMENT ON COMMON MENTAL DISORDERS OF PREGNANT WOMEN USING SELF-REPORTING QUESTIONNAIRE (SRQ-20)" sebagai penulis kedua di International Journal of Nursing and Midwifery Science (IJNMS) tahun 2023, "Efektifitas Murottal Qur'an dan Virtual Reality terhadap Kecemasan Ibu Hamil Trimester 3" sebagai penulis pertama di Journal of Issues in Midwifery tahun 2023, "Hubungan Riwayat Anemia dan Kurang Energi Kronis (KEK) pada Ibu Hamil dengan Kejadian Stunting" sebagai penulis pertama di Faletahan Health Journal pada tahun 2024, "Pengaruh Murottal Qur'an Muri-Q terhadap Kecemasan Ibu Hamil Trimester III Mendekati Kelahiran" sebagai penulis pertama di Oksitosin: Jurnal Ilmiah Kebidanan tahun 2023, "Partograph pocketbook application specifically for midwifery students in filling out partographs" sebagai penulis pertama di International Journal of Health Science and Technology tahun 2023, "Pengaruh kadar hemoglobin dan lingkaran atas ibu hamil terhadap kejadian stunting pada balita" sebagai penulis pertama di Media Ilmu Kesehatan tahun 2024, "Gender and nutritional status based on weight-for-age (W/A) in toddlers and its association with stunting cases" sebagai penulis pertama di International Journal of Health Science and Technology tahun 2025, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Balita" sebagai penulis pertama di Faletahan Health Journal pada tahun 2025, "EARLY DETECTION OF MATERNAL RISK FACTORS FOR STUNTING IN INFANTS" sebagai penulis pertama di Jurnal Keperawatan Soedirman tahun 2026. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: iensetia@gmail.com

Motto: "Hari ini harus lebih baik dari kemaren. Lakukanlah sesuatu semampunya, sebisanya dan sejujurnya. Hasil tidak akan membohongi ikhtiar kita yang telah dilakukan dengan sungguh-sungguh"

PROFIL PENULIS



Bdn. Lilis Suryani, SST., M. Keb. Lahir di Madiun, 09 September 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi D4 Kebidanan STIKes Karya Husada Pare Kediri lulus Tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan di Universitas Aisyiyah Yogyakarta lulus pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009 di TPMB sampai 2010, Tahun 2010 di Klinik Bersalin Flamboyan sampai Tahun 2011, Tahun 2011 masuk Akbid Muhammadiyah Madiun sampai tahun 2021, dan

Tahun 2021 sampai sekarang berhomebase di Profesi Bidan STIKes Husada Jombang. Saat ini penulis bekerja di STIKes Husada Jombang mengampu mata kuliah Kegawatdaruratan Maternal Neonatal, Komplementer Kebidanan, Teknologi Tepat Guna, Kewirausahaan Kebidanan, dan Kebidanan Komunitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi penelitian dan pengabdian, seminar dan pelatihan, pengisi webinar kebidanan dan kelas ibu hamil, dan serta mengembangkan pelayanan kebidanan komplementer dengan membuka outlet mom and baby spa Griya Sehat Bunda Madiun. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : lsuryani784@gmail.com

Motto: "Grow, Develop, Be useful"



Elsarika Damanik, SST, M.Kes, Ph.D. lahir di Dolok Marawa, Kec.Silou Kahean, Kab.Simalungun, Prov.Sumatera Utara. Pendidikan Tinggi yang telah ditempuh oleh penulis jenjang Diploma Tiga Pada Program Studi D3 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mutiara Medan Tahun 2009, Jenjang D4 Pada Program Studi D4 Bidan Pendidik Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara. Jenjang S2 pada Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Minat Studi Kesehatan Reproduksi Universitas Sumatera Utara. S3 pada Program Studi Health Sciences dengan Kepakaran Deteksi Tumbuh Kembang Pada Bayi dan Balita. Mata Kuliah yang diampu Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi dan

Balita, Pengantar Asuhan Kebidanan dan Konsep Kebidanan, Penulis aktif dalam melakukan publikasi terkait ilmu kebidanan.

Penulis saat ini aktif sebagai dosen kebidanan pada Program Studi Diploma Tiga dan Sarja Kebidanan serta mengajar di beberapa program studi kesehatan Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan Universitas Sari Mutiara Indonesia. Penulis berkomitmen untuk memajukan program studi kebidanan di seluruh Indonesia melalui berbagi pengetahuan. Penulis dapat dihubungi melalui email: elsadamanik78@yahoo.com.

Motto: "Tetap Semangat dan Maju Terus, manfaatkan waktu dengan baik.

PROFIL PENULIS



Niluh Nita Silfia SST., M.Keb. lahir di Desa Tanalanto Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, 06 November 1981. Jenjang Pendidikan Diploma III Kebidanan Poltekkes Kemenkes Manado lulus Tahun 2003, Pendidikan Diploma IV Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Bandung lulus Tahun 2005, Pendidikan Magister Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Bandung lulus Tahun 2016. Saat ini menjabat sebagai Dosen Tetap di Poltekkes Kemenkes Palu Jurusan Kebidanan Prodi D-III Kebidanan Palu. Beberapa buku yang sudah diterbitkan sejak Tahun 2013-2026.

 @Niluh Nita Silfia;  : Niluh Nita Silfia;

 [Niluh Nita Silfia](#)

 ORCID.ID: <https://orcid.org/0000-0002-3154-1075>;

 googlescholar.ID: [bz33-aAAAAAJ](#);

 SintaID: 6673901; Scopus ID : 59309309000

E-mail: niluhnita81@gmail.com

Hp. 082117119903

Motto: "Ciptakan kesempatanmu sendiri"



Bdn. Nur Afifah Harahap, S.Tr.Keb., M.Keb Lahir di Medan, 01 Oktober 1995. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 Kebidanan pada Program Studi Kebidanan di Institut Kesehatan Helvetia Medan Tahun 2016. Pendidikan S2 Kebidanan di Universitas Padjadjaran Bandung dan lulus tahun pada tahun 2021. Kemudian melanjutkan pendidikan Profesi Bidan di Poltekkes Kemenkes Medan dan lulus Tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2016 sampai tahun 2018 sebagai instruktur laboratorium dan anggota bagian evaluasi di Sarjana Terapan kebidanan Poltekkes

Kemenkes Medan. Tahun 2022 sampai tahun 2023 sebagai dosen sekaligus koordinator Prodi D-III Kebidanan di Universitas Murni Teguh Medan. Saat ini penulis bekerja menjadi Pegawai Negeri Sipil di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Banten mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Esensial Kehamilan, Persalinan, Bayi Balita dan Anak Pra Sekolah, Evidence-Based Practice (EBP) dalam Kebidanan dll. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar yang berkaitan dengan Kesehatan ibu dan anak. Penulis dapat dihubungi melalui

e-mail: afifah11095@gmail.com

Motto: "Empowering Women, Shaping Generations"

PROFIL PENULIS



Sahnawi Marsaoly, S.Kep., M.Kes. Dosen Program Studi Diploma III Kebidanan Poltekkes Kemenkes Ternate Lahir di Sanana, 02 Juli 1964. Menyelesaikan Pendidikan Diploma Tiga Keperawatan thn 1987 di Makassar, Kemudian mengajar pada SPK Depkes Ternate hingga tahun 1995 mengikuti Pendidikan Bidan B, selesai pendidikan Bidan, penulis mengajar pada Akademi Kebidanan Depkes Ternate. Pada Tahun 2001, ketika pembentukan Poltekkes Kemenkes Ternate, penulis menjadi dosen tetap di jurusan Kebidanan. Selesai Pendidikan Magister Kesehatan, selain mengajar, penulis pernah menjabat sebagai ketua Unit Jaminan Mutu Poltekkes Ternate, Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan, Ketua Jurusan Kebidanan, dan Wakil Direktur III, bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama. Saat ini kembali ke home base sebagai dosen jurusan Kebidanan. Penulis bias dihubungi pada email sahnawin64@gmail.com

Sinopsis

Buku Ajar *Deteksi Dini Risiko Tinggi Maternal–Neonatal di Pelayanan Primer* disusun sebagai sumber belajar yang komprehensif untuk membekali mahasiswa kebidanan, pendidik, dan praktisi kesehatan dengan kompetensi dalam mengenali serta menangani risiko tinggi pada ibu dan bayi sejak tahap awal. Buku ini mengawali pembahasannya dengan konsep dasar risiko tinggi maternal–neonatal yang meliputi definisi, klasifikasi, determinan, dampak terhadap luaran ibu dan bayi, serta peran, kewenangan, alur kolaborasi, dan batas rujukan bidan di pelayanan primer. Materi tersebut menjadi landasan penting dalam membangun kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan klinis yang tepat sesuai kewenangan profesi.

Selanjutnya, buku ini membahas pengkajian terpadu ibu dan bayi melalui anamnesis terfokus, pemeriksaan fisik, serta validasi data untuk menetapkan masalah dan prioritas asuhan. Pembaca juga diarahkan untuk memahami proses skrining risiko kehamilan menggunakan berbagai faktor risiko dan sistem penilaian skor risiko sebagai dasar penyusunan rencana asuhan yang tepat. Selain itu, buku mengulas secara mendalam deteksi dini tanda bahaya kehamilan, seperti perdarahan, nyeri hebat, demam, dan penurunan gerakan janin, serta gangguan hipertensi dalam kehamilan yang mencakup preeklamsia, eklamsia, pencegahan komplikasi, penatalaksanaan, edukasi, dokumentasi, hingga mekanisme rujukan yang efektif.

Sebagai buku ajar berbasis kompetensi, setiap bab dilengkapi dengan aktivitas pembelajaran *Knows How* dan *Shows How*, DOPS, portofolio, rubrik penilaian, contoh kasus, rangkuman materi, serta tabel *red flags* dan eskalasi untuk memperkuat kemampuan analisis dan keterampilan klinis. Pembahasan diakhiri dengan deteksi dini infeksi pada kehamilan, meliputi infeksi menular seksual (IMS), infeksi saluran kemih (ISK), TORCH, dan infeksi lain yang berpotensi memengaruhi kesehatan ibu maupun janin, beserta strategi pencegahan penularannya. Dengan pendekatan yang sistematis, aplikatif, dan sesuai dengan praktik pelayanan primer, buku ini diharapkan menjadi referensi yang mampu mendukung peningkatan mutu pelayanan kebidanan serta berkontribusi dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi.

Buku Ajar Deteksi Dini Risiko Tinggi Maternal-Neonatal di Pelayanan Primer disusun sebagai sumber belajar yang komprehensif untuk membekali mahasiswa kebidanan, pendidik, dan praktisi kesehatan dengan kompetensi dalam mengenali serta menangani risiko tinggi pada ibu dan bayi sejak tahap awal. Buku ini mengawali pembahasannya dengan konsep dasar risiko tinggi maternal-neonatal yang meliputi definisi, klasifikasi, determinan, dampak terhadap luaran ibu dan bayi, serta peran, kewenangan, alur kolaborasi, dan batas rujukan bidan di pelayanan primer. Materi tersebut menjadi landasan penting dalam membangun kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan klinis yang tepat sesuai kewenangan profesi.

Selanjutnya, buku ini membahas pengkajian terpadu ibu dan bayi melalui anamnesis terfokus, pemeriksaan fisik, serta validasi data untuk menetapkan masalah dan prioritas asuhan. Pembaca juga diarahkan untuk memahami proses skrining risiko kehamilan menggunakan berbagai faktor risiko dan sistem penilaian skor risiko sebagai dasar penyusunan rencana asuhan yang tepat. Selain itu, buku mengulas secara mendalam deteksi dini tanda bahaya kehamilan, seperti perdarahan, nyeri hebat, demam, dan penurunan gerakan janin, serta gangguan hipertensi dalam kehamilan yang mencakup preeklamsia, eklamsia, pencegahan komplikasi, penatalaksanaan, edukasi, dokumentasi, hingga mekanisme rujukan yang efektif.

Sebagai buku ajar berbasis kompetensi, setiap bab dilengkapi dengan aktivitas pembelajaran Knows How dan Shows How, DOPS, portofolio, rubrik penilaian, contoh kasus, rangkuman materi, serta tabel red flags dan eskalasi untuk memperkuat kemampuan analisis dan keterampilan klinis. Pembahasan diakhiri dengan deteksi dini infeksi pada kehamilan, meliputi infeksi menular seksual (IMS), infeksi saluran kemih (ISK), TORCH, dan infeksi lain yang berpotensi memengaruhi kesehatan ibu maupun janin, beserta strategi pencegahan penularannya. Dengan pendekatan yang sistematis, aplikatif, dan sesuai dengan praktik pelayanan primer, buku ini diharapkan menjadi referensi yang mampu mendukung peningkatan mutu pelayanan kebidanan serta berkontribusi dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7756-58-9 (PDF)



9

786347

756589

